

LIBRO DE BANCOS DE PREGUNTAS

TOMO II

DR: GUILLERMO GUEVARA ALIAGA

ÍNDICE PRUEBAS DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA Y PEDIATRÍA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

I) GINECOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 03
Prueba 2.....	Pág 06
Prueba 3.....	Pág 09
Prueba 4.....	Pág 12
Prueba 5.....	Pág 15
Prueba 6.....	Pág 18
Prueba 7.....	Pág 22
Prueba 8.....	Pág 25
Prueba 9.....	Pág 29
Prueba 10.....	Pág 32
Prueba 11.....	Pág 35
Respuestas.....	Pág 38

II) OBSTETRICIA

Prueba 1.....	Pág 39
Prueba 2.....	Pág 43
Prueba 3.....	Pág 46
Prueba 4.....	Pág 49
Prueba 5.....	Pág 53
Prueba 6.....	Pág 57
Prueba 7.....	Pág 60
Prueba 8.....	Pág 09
Prueba 9.....	Pág 12
Prueba 10.....	Pág 29
Respuestas.....	Pág 64

III) COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRUEBAS GRANDES

Prueba 1.....	Pág 65
Prueba 2.....	Pág 75
Prueba 3.....	Pág 85
Prueba 4.....	Pág 93
Prueba 5.....	Pág 104
Prueba 6.....	Pág 115
Prueba 7.....	Pág 126
Respuestas.....	Pág 137

PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

I) NEONATOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 139
Prueba 2.....	Pág 142
Prueba 3.....	Pág 145
Prueba 4.....	Pág 148
Prueba 5.....	Pág 151
Prueba 6.....	Pág 154
Respuestas.....	Pág 157

VII) PEDIATRÍA

Prueba 1.....	Pág 158
Prueba 2.....	Pág 162
Prueba 3.....	Pág 166
Prueba 4.....	Pág 169
Prueba 5.....	Pág 172
Prueba 6.....	Pág 175
Prueba 7.....	Pág 178
Prueba 8.....	Pág 181
Prueba 9.....	Pág 185
Prueba 10.....	Pág 189
Prueba 11.....	Pág 193
Respuestas.....	Pág 196

VIII) PEDIATRÍA POR TEMA

Prueba 1.....MED INT.....	Pág 20
Prueba 2.....MED INT.....	Pág 57
Prueba 3.....MED INT.....	Pág 124
Prueba 4.....MED INT.....	Pág 158
Prueba 5.....MED INT.....	Pág 200
Prueba 6.....MED INT.....	Pág 202
Prueba 7.....MED INT.....	Pág 235
Prueba 8.....MED INT.....	Pág 269
Prueba 9.....MED INT.....	Pág 295

IX) COMPILADO PEDIATRÍA PRUEBAS GRANDES

Prueba 1.....	Pág 198
Prueba 2.....	Pág 205
Prueba 3.....	Pág 213
Prueba 4.....	Pág 65
Prueba 5.....	Pág 75
Prueba 6.....	Pág 93
Prueba 7.....	Pág 104
Prueba 8.....	Pág 115
Prueba 9.....	Pág 126
Respuestas.....	Pág 141

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

I) GINECOLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Una mujer de 30 años consulta por mastodinia especialmente intensa durante los días previos a la menstruación y que cede con ésta. Al examen físico se constatan mamas dolorosas a la palpación, de consistencia indurada, con varios nódulos pequeños, bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Paget
- b) Cáncer de mama multicéntrico
- c) Mastopatía fibroquística
- d) Mastitis linfangítica
- e) Hiperprolactinemia

2) Una mujer de 34 años, múltipara de dos, obesa, sin otros antecedentes de importancia, presenta metrorragia abundante de 7 días de evolución, sin otros síntomas. Se solicita ecografía transvaginal que muestra 3 miomas uterinos, el mayor de ellos de 4 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos en altas dosis
- b) Realizar legrado y biopsia de endometrio
- c) Administrar ácido tranexánico
- d) Realizar legrado y derivar para histerectomía electiva
- e) Realizar histerectomía de urgencia

3) El tratamiento de elección de la tricomoniasis vaginal es:

- a) Metronidazol 2 g por vía oral, en una dosis
- b) Clindamicina en óvulos vaginales, por 7 días
- c) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 5 días
- d) Albendazol 400 mg cada 12 horas por 7 días
- e) Doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 10 días

4) Son contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal, EXCEPTO:

- a) Metrorragia de origen no precisado
- b) Cáncer de endometrio
- c) Cáncer de mama
- d) Antecedentes personales de tromboembolismo pulmonar
- e) Diabetes mellitus

5) ¿Cuál de los siguientes marcadores se encuentra elevado con más frecuencia en el cáncer de ovario?

- a) Beta-HCG
- b) Alfafetoproteína
- c) Antígeno carcinoembrionario
- d) Ca-125
- e) Ca-19.9

6) Una mujer de 35 años consulta por cuadro de dolor abdominal bajo de 2 días de evolución. Al examen físico destaca fiebre hasta 37,8°C y dolor a la palpación hipogástrica y en la fosa iliaca derecha, sin signos de irritación peritoneal. Se solicita evaluación ginecológica que demuestra dolor a la movilización cervical y a la palpación anexial derecha. La especuloscopia no demuestra alteraciones y el test de embarazo resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Apendicitis aguda
- b) Proceso inflamatorio pélvico
- c) Torsión ovárica
- d) Endometriosis
- e) Vaginositis

7) El factor pronóstico más importante en el cáncer de cuello uterino es:

- a) El tipo histológico
- b) El tamaño de la lesión
- c) La invasión de parametrios
- d) La presencia de síntomas
- e) El serotipo de virus papiloma

8) ¿Qué examen NO debe solicitarse como primera línea a una pareja con infertilidad primaria?

- a) TSH
- b) Seguimiento folicular
- c) Espermiograma
- d) Test postcoital
- e) Laparoscopia

9) Los anticonceptivos combinados orales aumentan el riesgo de:

- a) Cáncer de ovario
- b) Adenoma hepático
- c) Cáncer de cuello uterino
- d) Cáncer de endometrio
- e) Cáncer renal

10) Una adolescente de 16 años, cuya menarquia fue a los 15, presenta oligomenorrea y polimenorrea, sin otro compromiso sistémico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar un estudio endocrino de su funcionamiento reproductivo
- b) Estudiar alteraciones genéticas de su desarrollo gonadal
- c) Tratar con anticonceptivos para regularizar su ciclo
- d) Observar la evolución espontánea
- e) Realizar ecografía con seguimiento folicular

11) Una mujer de 28 años consulta por prurito vulvar y leucorrea de algunas semanas de evolución. A la especuloscopia se aprecia leucorrea blanca, grumosa, en moderada cantidad, con pared vaginal con signos inflamatorios moderados. El test de KOH resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Vaginosis bacteriana
- b) Tricomoniasis vaginal
- c) Candidiasis
- d) Gonorrea
- e) Vulvovaginitis inespecífica

12) ¿Cuál es la terapia de sustitución hormonal más adecuada para una paciente de 48 años, histerectomizada hace 8 años, con anexos conservados, que presenta síntomas climatéricos marcados y dislipidemia mixta?

- a) Estrógenos más progestágenos en esquema continuo transdérmico
- b) Estrógenos orales
- c) Estrógenos más progestágenos en esquema secuencial transdérmico
- d) Estrógenos transdérmicos
- e) Estrógenos vaginales de efecto local

13) ¿Cuál de los siguiente fármacos debe usarse como primera línea en el tratamiento de la dismenorrea funcional?

- a) Ácido mefenámico
- b) Anticonceptivos orales
- c) Ergotamínicos
- d) Antiespasmódicos
- e) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina

14) Una mujer se realiza Papanicolaou como parte de su chequeo ginecológico anual, que es informado con presencia de células escamosas atípicas, con displasia de grado intermedio. Se deriva a colposcopia, donde se visualiza zona acetoblanca, la que se biopsia, con histología compatible con neoplasia intraepitelial de tercer grado (NIE3). La conducta más adecuada es:

- a) Aplicar nitrógeno líquido sobre la lesión
- b) Seguir evolución, realizando Papanicolaou cada 3 meses
- c) Realizar cono cervical
- d) Realizar histerectomía total
- e) Aplicar podofilino y ácido tricloroacético sobre la lesión

15) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es MENOS probable de encontrar en una paciente con síndrome de ovario poliquístico?

- a) Testosterona alta
- b) Progesterona alta
- c) Resistencia insulínica
- d) Menstruaciones irregulares
- e) Acné

16) El goteo o spotting es un efecto adverso frecuentemente observado al usar:

- a) Anticonceptivos con estrógenos solos
- b) Anticonceptivos con progestágenos solos
- c) Anticonceptivos combinados, con microdosis de estrógenos
- d) Anticonceptivos combinados, con macrodosis de estrógenos
- e) Anticonceptivos inyectables

17) Una paciente en amenorrea se realiza prueba de progesterona que resulta positiva. ¿Cuál es la etiología más probable de la amenorrea?

- a) Hipofisiaria
- b) Hipoestrogenismo
- c) Anovulación
- d) Hipotalámica
- e) Uterina

18) Una mujer de 33 años, consulta por un cuadro de 9 meses de evolución de dismenorrea, la que se ha ido intensificando a lo largo del tiempo y a lo que se ha agregado dispareunia profunda y en algunas oportunidades dolor durante la defecación. Al examen ginecológico la especuloscopia es normal y en el tacto vaginal destaca cuello uterino doloroso y difícil de movilizar. El diagnóstico de más probable es:

- a) Cáncer de cuello uterino
- b) Cáncer de endometrio
- c) Endometriosis
- d) Proceso inflamatorio pélvico
- e) Dismenorrea funcional

19) Las siguientes patologías se presentan frecuentemente como hipermenorrea, EXCEPTO:

- a) Mioma submucoso
- b) Pólipo endometrial
- c) Adenomiosis
- d) Hiperplasia endometrial
- e) Útero septado

20) Una mujer de 20 años acude a su ginecólogo por algia pélvica intermitente, de algunas semanas de evolución. Al examen ginecológico se palpa un tumor anexial al lado derecho, de 5 cm. Se solicita ecografía transvaginal, que demuestra tumoración ovárica sólido-quística, de contenido heterogéneo, con tabiques e increspaciones en su interior de 6 cm de diámetro mayor. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio sin necesidad de mayor estudio
- b) Realizar nueva ecografía en 3 meses, bajo tratamiento con anticonceptivos orales
- c) Solicitar biopsia por punción bajo ecografía
- d) Realizar tumorectomía laparoscópica, con biopsia rápida
- e) Realizar anexectomía bilateral y biopsias peritoneales

Prueba 2

1) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una manifestación de la endometriosis?

- a) Metrorragia
- b) Dispareunia profunda
- c) Dismenorrea
- d) Infertilidad
- e) Dificultad para la movilización cervical

2) ¿Cuál es el mayor factor de riesgo para desarrollar un proceso inflamatorio pélvico?

- a) Multiparidad
- b) Uso de anticonceptivos
- c) Promiscuidad sexual
- d) Postmenopausia
- e) Endometriosis

3) ¿Qué anticonceptivo indicaría a una mujer de 29 años, con síndrome de ovario poliquístico y dislipidemia mixta?

- a) Anticonceptivos combinados, por vía transdérmica, con ciproterona
- b) Anticonceptivos combinados, por vía oral, con drospirenona
- c) Anticonceptivos combinados, por vía transdérmica, con levonorgestrel
- d) Anticonceptivos combinados, por vía subcutánea, con levonorgestrel
- e) Anticonceptivos transvaginales, con estrógenos solos

4) Una mujer de 25 años está preocupada porque tiene ciclos menstruales de sólo 22 días de duración. Refiere que son regulares y que la menstruación dura cerca de 3 días. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Solicitar prueba de progesterona
- c) Solicitar ecografía transvaginal
- d) Solicitar biopsia endometrial
- e) Tranquilizar, explicando la normalidad de su condición

5) ¿Cuál es la causa más frecuente de metrorragia en las pacientes en edad fértil?

- a) Miomatosis uterina
- b) Hiperplasia endometrial
- c) Atrofia endometrial
- d) Disfuncional
- e) Cáncer de cuello uterino

6) ¿Cuál de las siguientes pacientes puede utilizar anticonceptivos orales sin mayor contraindicación?

- a) Mujer con cáncer de mama
- b) Mujer diagnosticada de melanoma
- c) Mujer con daño hepático crónico por NASH
- d) Mujer con déficit de antitrombina III
- e) Mujer con antecedente de abortos a repetición

7) Escoja la asociación correcta entre el informe del PAP y la conducta a seguir:

- a) PAP insatisfactorio por atrofia – Derivar a colposcopia y biopsia
- b) PAP satisfactorio con signos inflamatorios inespecíficos – Tomar nuevo PAP en un año
- c) PAP con atipias escamosas de grado moderado – Realizar cono cervical
- d) PAP con presencia de Candida albicans – Tratar con fluconazol oral ya sea sintomática o asintomática
- e) PAP con presencia de Trichomonas – Tomar nuevo PAP en 6 meses

8) ¿Cuál de los siguientes cánceres tiene mejor pronóstico?

- a) Cáncer de endometrio
- b) Cáncer de ovario
- c) Cáncer de cuello uterino
- d) Cáncer de mama
- e) Cáncer de vejiga urinaria

9) Una mujer de 38 años, asintomática, acude a control ginecológico anual, palpándose un tumor anexial derecho. Se solicita una ecografía transvaginal, que demuestra un tumor ovárico derecho, quístico de 4 cm de diámetro. El marcador Ca-125 resulta 20 UI/ml (VN: hasta 35 UI/ml). EL diagnóstico más probable es:

- a) Cuerpo lúteo
- b) Quiste folicular
- c) Endometrioma
- d) Teratoma
- e) Cistoadenocarcinoma seroso

10) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA, respecto al prolapso genital?

- a) El principal factor de riesgo para desarrollarlo es el hipoestrogenismo
- b) Sus síntomas más frecuentes son la sensación de peso y humedad genital
- c) El rectocele es el tipo más frecuente de prolapso genital femenino
- d) La terapia de remplazo hormonal suele tener buenos resultados como tratamiento de esta patología
- e) El tratamiento quirúrgico del prolapso medio consiste en una vaginoplastia anterior

11) Una pareja consulta por infertilidad de un año de evolución, a pesar de mantener relaciones sexuales con cierta frecuencia y de no usar métodos anticonceptivos. Él es un hombre sano y tiene un hijo de 3 años con otra mujer. Ella es una mujer sana, pero refiere ciclos menstruales irregulares, que llegan cada 2 a 3 meses. El examen físico de ambos es normal. La causa más probable de esta infertilidad es:

- a) Masculina
- b) Endometriosis
- c) Tuboperitoneal
- d) Anovulación
- e) Genética

12) La importancia de la hiperplasia endometrial radica en:

- a) Su asociación a infertilidad
- b) Su potencial malignización
- c) La severidad de sus síntomas
- d) El alto riesgo de infección
- e) No tiene mayor importancia

13) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre patología cervical es FALSA?

- a) El virus papiloma humano es el principal responsable del cáncer de cuello uterino y de las neoplasias intraepiteliales
- b) Una paciente con alteraciones en el Papanicolaou, consistentes en atipías cervicales de alto grado debe ser derivada a colposcopia y biopsia
- c) La visualización de un tumor en el cuello uterino es indicación de realizar una colposcopia y biopsia de la lesión
- d) La conización cervical es la medida más importante frente al diagnóstico de una neoplasia intraepitelial grado 1
- e) La invasión de parametrios es el factor pronóstico más importante del cáncer de cuello uterino, por lo que su etapificación es predominantemente clínica

14) Una mujer de 35 años se realiza su primera mamografía, la que es informada como Birrads 0. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva mamografía en un año
- b) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
- c) Solicitar ecografía mamaria
- d) Derivar a biopsia estereotáxica o con mamótomo
- e) Resolver quirúrgicamente

15) Una mujer de 46 años inicia bochornos y oligomenorrea. ¿Qué examen orienta más al diagnóstico de climaterio?

- a) Ecografía transvaginal
- b) Estrógenos plasmáticos
- c) Progesterona plasmática
- d) Hormona folículoestimulante plasmática
- e) prueba de progesterona

16) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) La candidiasis vaginal presenta como síntoma preponderante al prurito
- b) La vaginosis bacteriana presenta marcados signos inflamatorios en la pared vaginal
- c) La tricomoniasis vaginal presenta leucorrea verdosa y disuria
- d) La vaginosis bacteriana se caracteriza por mal olor, que suele ser más intenso en los días de menstruación
- e) La cervicitis aguda suele ser causada por gonococo y clamidia

17) Una paciente de 67 años consulta por escapes de orina frecuente, especialmente al toser, reírse o realizar esfuerzos físicos mayores. En cada oportunidad sólo pierde una pequeña cantidad de orina, pero es suficiente para afectar su calidad de vida y limitar sus actividades, por miedo al ridículo. Se solicita un sedimento de orina, con urocultivo, que resultan negativos para infección urinaria. Se indican ejercicios de fortalecimiento de la musculatura pélvica, sin embargo no consiguen mejorar los síntomas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cistoscopia
- b) Solicitar nuevo urocultivo
- c) Iniciar oxibutinina
- d) Iniciar tamsulosina
- e) Derivar para resolución quirúrgica, con TVT

18) Una mujer de 48 años, multípara de 4, obesa, diabética e hipertensa, presenta metrorragia de 5 días de duración, en la mitad de su ciclo menstrual. Refiere que sus otros ciclos menstruales eran regulares y duraban 28 días. Se realiza ecografía transvaginal, que visualiza 2 miomas uterinos de hasta 3,5 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar análogos de GnRH
- b) Iniciar anticonceptivos orales
- c) Iniciar terapia de reemplazo hormonal
- d) Realizar histerectomía
- e) Solicitar biopsia endometrial

19) Una mujer de 25 años consulta porque durante los 5 días previos a la menstruación se pone muy irritable, llora con frecuencia y presenta cambios de ánimo muy marcados, que le han causado problemas con sus familiares, amigos, pareja y compañeros de trabajo. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar fluoxetina, 20 mg al día, durante la segunda mitad del ciclo menstrual
- b) Indicar risperidona en bajas dosis durante los 5 días previos a la menstruación
- c) Indicar ácido mefenámico durante los días de síntomas
- d) Solicitar estrógenos y progesterona plasmática
- e) Iniciar anticonceptivos orales combinados con 21 días de uso y 7 días de descanso (discontinuos)

20) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Las infecciones urinarias pueden simular una incontinencia urinaria de urgencia
- b) El escape continuo de orina, debe hacer sospechar la presencia de una fístula vesicovaginal
- c) El tratamiento de elección de la vejiga neurogénica es quirúrgico
- d) La incontinencia por rebalse es característica de las uropatías obstructivas bajas y de la vejiga neurogénica
- e) La incontinencia urinaria de esfuerzos y la incontinencia urinaria de urgencia son las causas más frecuentes de incontinencia urinaria crónica

Prueba 3 (GINECOLOGÍA + OBSTETRICIA)

1) Una multipara de 38 años, cursando se cuarto embarazo, de 33 semanas consulta por aparición de prurito palmoplantar intenso, mayor en las noches, asociados a ictericia. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de HELLP
- b) Hígado graso agudo del embarazo
- c) Hepatitis viral
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Isoinmunización Rh

2) Una paciente de 22 años, cursando embarazo de término inicia trabajo de parto. El registro estresante muestra desaceleraciones tardías en relación al 80% de las contracciones uterinas. La frecuencia cardíaca basal del feto es 130 lpm y la variabilidad es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar un tacto vaginal para determinar la vía de interrupción inmediata
- b) Solicitar ecodoppler umbilical
- c) Realizar perfil biofísico
- d) Esperar evolución espontánea
- e) Administrar corticoides endovenosos, antibióticos y tocolíticos

3) Paciente multipara de dos en trabajo de parto, cuyo monitoreo muestra una FC fetal basal de 130/min, buena variabilidad y presencia de aceleraciones. La rotura artificial de membranas da salida a un líquido con meconio fluido, amarillo verdoso. ¿Cuál es la conducta obstétrica a seguir?

- a) Interrupción inmediata del embarazo mediante cesárea
- b) Reanimación fetal in útero con reevaluación en 20 minutos
- c) Reanimación fetal in útero seguida de interrupción del embarazo
- d) Mantener una conducta expectante y permitir que continúe el trabajo de parto
- e) Interrupción inmediata por la vía más expedita

4) Paciente de 20 años, con menstruaciones previas irregulares, presenta atraso menstrual de 6 semanas por lo que se realiza test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza ecografía transvaginal que no muestra saco embrionario intrauterino. Sólo se observa endometrio engrosado, sin líquido libre peritoneal. Se controlan niveles de gonadotropina coriónica (HCG,) cuyo resultado es 1.000 UI/dl.

La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevos niveles de HCG y ecografía transvaginal en 2 días
- b) Indicar metotrexato
- c) Resolver quirúrgicamente, mediante laparoscopia
- d) Resolver quirúrgicamente, mediante laparotomía
- e) Dejar evolución espontánea, sin necesidad de nuevos controles ni tratamientos

5) Una paciente de 35 años presenta amenorrea de 4 meses de duración. El examen físico es normal, por lo que se solicita test de embarazo, que resulta negativo; prolactina y TSH, que resultan normales; prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógenos + progesterona, que resulta positiva; FSH y LH, que resultan elevadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Anovulación
- b) Hipogonadismo hipotalámico
- c) Amenorrea de origen uterino
- d) Insuficiencia ovárica primaria
- e) Hipopituitarismo

6) Una adolescente de 17 años, sin antecedentes de importancia, es traída por su madre ya que aún no presenta menstruación. No presenta otros síntomas y su desarrollo puberal es normal. Al examen ginecológico se observa himen perforado y el resto del examen físico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Solicitar ecografía transvaginal
- c) Solicitar TSH, hemograma, índice de andrógenos libres, prolactina, FSH, LH, cariotipo, androstenediona y 17-hidroxiprogesterona
- d) Solicitar prueba de progesterona
- e) Iniciar pulsos de agonistas de GnRH

7) Paciente de 35 años, cesarizada anterior, cursando embarazo de 36 semanas, presenta RPO de 10 horas de evolución. No se registran contracciones uterinas ni modificaciones cervicales y el registro basal no estresante es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolucionar espontáneamente, sin necesidad de fármacos
- b) Dejar evolucionar, bajo cobertura antibiótica y bajo corticoides para asegurar la maduración fetal
- c) Indicar reposo, antibióticos, corticoides e interrumpir cuando se cumplan 37 semanas de gestación
- d) Inducir el parto inmediatamente con misoprostol
- e) Realizar cesárea

8) ¿Cuál de los siguientes parámetros disminuye normalmente durante el embarazo?

- a) Frecuencia cardíaca
- b) Volemia
- c) Hematocrito
- d) Filtración glomerular
- e) Fosfatasas alcalinas

9) Una paciente multipara de 2, cursando embarazo de 33 semanas fue diagnosticada de diabetes gestacional mediante test de tolerancia a la glucosa, a las 28 semanas de gestación. Se inició dieta, sin embargo persiste con glicemias postprandiales cercanas a 150 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Proseguir con dieta y ejercicios por 4 semanas más y controlar
- b) Iniciar metformina
- c) Iniciar glibenclamida
- d) Iniciar insulina
- e) Iniciar una asociación de glibenclamida e insulina

10) Una paciente primigesta, de 30 semanas de gestación, asintomática, presenta presión arterial de 150/90 en una ocasión. El resto del examen físico es normal. Se controla proteinuria cualitativa que resulta levemente positiva. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar diuréticos, asociados a iECA
- b) Indicar dieta y ejercicios
- c) Indicar semihospitalización de 6 horas, controlando la presión arterial en varias ocasiones
- d) Iniciar alfametildopa y solicitar exámenes que determinen la gravedad del cuadro
- e) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo

11) Una mujer es diagnosticada de VIH en relación a un screening realizado en la primera consulta al obstetra. Se encuentra asintomática. ¿Cuál de las siguientes alternativas supone un MENOR riesgo para el feto, al momento del parto?:

- a) Ausencia de infecciones oportunistas
- b) Recuento de linfocitos helper CD4(+) mayor a 1.000
- c) Carga viral indetectable
- d) Tratamiento antirretroviral
- e) Cesárea

12) Una paciente obesa, con antecedente de cono cervical por una NIE 3 y de várices en las extremidades inferiores ha presentado 2 abortos espontáneos a las 19 y 17 semanas respectivamente. En ambas oportunidades presentó escaso dolor y pocas contracciones uterinas. El diagnóstico más probable es:

- a) Sana
- b) Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos
- c) Abortos de origen genético
- d) Insuficiencia lútea
- e) Incompetencia cervical

13)) Identifique la asociación incorrecta entre la historia clínica y la patología mamaria

- a) Mujer de 65 años, con nódulo mamario irregular, que ha aumentado de tamaño y se asocia a "piel de naranja" de la mama comprometida – Cáncer de mama infiltrante
- b) Mujer de 20 años con nódulo mamario de 3 cm, y consistencia gomosa, fácil de movilizar - Fibroadenoma
- c) Mujer de 45 años con mastalgia premenstrual y mamas con nódulos de pequeño tamaño, bilaterales, sensibles – Carcinoma ductal in situ
- d) Puérpera con aumento de volumen doloroso de 4 cm en la axila derecha – Glándula mamaria accesoria
- e) Puérpera con eritema y dolor mamario bilateral – Mastitis linfangítica

14) El una ecografía del primer trimestre de un embarazo gemelar se observa el signo lambda. ¿Qué tipo de embarazo gemelar es?

- a) Dicigótico
- b) Monocigótico
- c) Bicorial
- d) Monocorial
- e) Monoamniótico

15) Una paciente de 33 años, presenta una historia de dismenorrea crónica, que ha ido en aumento. Se realiza una Ecografía transvaginal que demuestra un tumor ovárico derecho de 3,5 cm, quístico, de contenido en vidrio esmerilado. Se solicita Ca-125 que resulta moderadamente aumentado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar anexectomía bilateral y biopsias peritoneales
- b) Iniciar anticonceptivos orales y realizar nueva ecografía en 3 meses
- c) Iniciar análogos de GnRH a permanencia
- d) Realizar punción percutánea
- e) Realizar tumorectomía laparoscópica

16) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 7 semanas, consulta por metrorragia y malestar hipogástrico. Al la especuloscopia se observa salida de sangre por el orificio cervical externo. El tacto vaginal no demuestra cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar ecografía transvaginal
- b) Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta de gonadotropina coriónica
- c) Realizar legrado uterino
- d) Administrar progestágenos orales
- e) Enviar a domicilio con reposo e hidratación

17) Una gestante de 41 semanas inicia trabajo de parto. Presenta 4 contracciones cada 10 minutos, con dilatación cervical de 7 cm, membranas rotas y feto en segundo plano de Hodge, con presentación de frente, en posición nasoiliaca izquierda anterior. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución espontánea
- b) Realizar prueba de parto con aceleración occitócica y anestesia epidural
- c) Girar la cabeza hasta posición nasopúbica y dejar evolucionar
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea

18) Una mujer con promiscuidad sexual presenta una lesión ulcerada, de 1,5 cm, no dolorosa, indurada, en relación al labio mayor derecho, que no sangra ni presenta exudado. El diagnóstico más probable es:

- a) Gonorrea
- b) Linfogranuloma venéreo
- c) Sífilis
- d) Chancroide
- e) Donovanosis

19) A las 34 semanas de gestación un feto pesa aproximadamente:

- a) 500 a 1.000 g
- b) 1.000 a 1.500 g
- c) 1.500 a 2.000 g
- d) 2.000 g 2.500 g
- e) 2.500 g 3.000 g

20) Una adolescente de 16 años, cuya menarquia fue a los 15, presenta oligomenorrea y polimenorrea, sin otro compromiso sistémico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar un estudio endocrino de su funcionamiento reproductivo
- b) Estudiar alteraciones genéticas de su desarrollo gonadal
- c) Tratar con anticonceptivos para regularizar su ciclo
- d) Observar la evolución espontánea
- e) Realizar ecografía con seguimiento folicular

Prueba 4 (GINECOLOGÍA +OBSTETRICIA)

1) Son causas de hipermenorrea, EXCEPTO:

- a) Miomas uterinos
- b) Alteraciones de la hemostasia primaria
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Adenomiosis
- e) Útero septado

2) Una paciente de 24 años, primigesta, cursando embarazo de 31 semanas consulta por deterioro del estado general y dolor abdominal. Al examen se aprecia adolorida y algo icterica. Sus signos vitales son FC: 96x', PA: 142/96 mmHg, FR: 15x' y el monitoreo fetal resulta normal. Se solicitan exámenes que demuestran elevación de las transaminasas y bilirrubina, asociados a anemia y trombocitopenia leves. En sus exámenes de orina presenta proteinuria de 0,5 g/24 horas. El diagnóstico más probable es:

- a) Hígado graso agudo del embarazo
- b) Colestasia intrahepática
- c) Preclamsia moderada
- d) Síndrome de HELLP
- e) Sepsis por Clostridium perfringens

3) Una paciente múltipara, cursando un embarazo de 35 semanas se realiza ecografía obstétrica, que demuestra un feto con peso estimado en percentil 5, para la edad gestacional, con relación diámetros cefálico/abdominal de 1,2. La etiología más probable del retardo del crecimiento intrauterino, en esta paciente, es

- a) Constitucional
- b) Insuficiencia placentaria
- c) Genopatía
- d) Sufrimiento fetal agudo
- e) Diabetes gestacional

4) El mejor examen para determinar el pronóstico de un embarazo gemelar es:

- a) Ecografía del primer trimestre
- b) Ecografía del segundo trimestre
- c) Ecografía del tercer trimestre
- d) Amniocentesis
- e) Biopsia corial

5) Respecto a la endometriosis es VERDADERO que:

- a) El uso de anticonceptivos orales es un factor de riesgo
- b) Habitualmente se diagnostica mediante ecografía
- c) Es causa de oligomenorrea
- d) Se asocia al uso de dispositivo intrauterino
- e) Corresponde a tejido endometrial dentro del miometrio

6) Una paciente primigesta, cursando embarazo de 34 semanas, presenta disminución de la percepción de los movimientos fetales, por lo que se realiza un test de tolerancia a las contracciones que demuestra la presencia de desaceleraciones tempranas o DIP I, sin otras alteraciones. No presenta modificaciones cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos
- b) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- c) Inducir el parto con misoprostol
- d) Solicitar registro basal no estresante
- e) Tranquilizar a la madre y enviar a domicilio

7) El elemento que más orienta a un algia pélvica crónica, de origen ginecológico es:

- a) La ciclicidad
- b) El antecedente de metrorragia
- c) El dolor al tacto vaginal
- d) El uso de anticonceptivos
- e) La asociación a distensión abdominal

8) Una mujer, multípara de 2, con ambos partos por vía vaginal, está cursando un tercer embarazo, en la semana 37 + 3 días. Inicia trabajo de parto, que se extiende por varias horas. Al examen físico presenta 3 contracciones en 10 minutos y el tacto vaginal muestra dilatación completa, con la cabeza fetal en el segundo plano de Hodge, en presentación de frente, naso-iliaca anterior. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar prueba de parto, con aceleración oxitócica y rotura artificial de membranas
- b) Girar la cabeza hasta posición naso-sacra
- c) Girar la cabeza hasta posición naso-púbica
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea

9) El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Andrógenos elevados
- b) Estrógenos disminuidos
- c) Progesterona disminuida
- d) Hormona luteinizante aumentada
- e) Acné

10) Identifique la asociación correcta entre edad gestacional y hallazgo:

- a) 12 semanas – fondo uterino a la altura del ombligo
- b) 15 semanas – multípara inicia la percepción de los movimientos fetales
- c) 4 semanas – beta-HCG detectable en suero y orina
- d) 6 semanas – ausencia de saco gestacional en la ecografía transvaginal
- e) 30 semanas – altura uterina de 15 centímetros

11) Una paciente de 24 años, consulta por dolor abdominal. Al examen se constata paciente subfebril, con dolor a la palpación hipogástrica, palpación anexial derecha y movilización cervical. No hay signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometriosis
- b) Proceso inflamatorio pélvico
- c) Apendicitis aguda
- d) Absceso tuboovárico roto
- e) Embarazo tubario

12) Una paciente de 40 años, multípara de 3, cursando un embarazo de 38 semanas, se realiza un registro basal no estresante que muestra una frecuencia cardíaca fetal basal de 130x', con una variabilidad de cerca de 10x', sin presencia de aceleraciones ni de desaceleraciones durante un tiempo de observación de 20 minutos. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar una ecografía-Doppler de arterias umbilicales
- b) Realizar un perfil biofísico
- c) Extender el monitoreo por 20 minutos adicionales
- d) Interrumpir el embarazo de inmediato
- e) Tranquilizar a la madre y dar de alta

13) Una paciente presenta amenorrea de 6 meses de evolución, que inició luego de un aborto espontáneo. Se solicita test de embarazo que resulta negativo, por lo que se decide solicitar varios exámenes que demuestran: TSH normal, prolactinemia normal, prueba de progesterona negativa, ecografía TV con endometrio muy delgado, prueba de estrógenos más progesterona negativa. El origen más probable de la amenorrea es:

- a) Anovulación
- b) Hipotalámico
- c) Hipofisiario
- d) Ovárico
- e) Uterino

14) ¿Cuál de las siguientes situaciones tiene opción de parto vaginal?

- a) Embarazo gemelar con el primer gemelo en presentación cefálica y el segundo en presentación podálica
- b) Mujer en trabajo de parto con feto en cefálica con presentación de cara, en posición mentosacra
- c) Embarazo con herpes genital activo
- d) Primigesta con embarazo complicado con diabetes gestacional y feto de 3.800 Kg.
- e) Mujer con una cesárea anterior de tipo corporal

15) Una mujer de 27 años, cursando embarazo de 32 semanas se realiza ecografía obstétrica que demuestra presencia de polihidramnios moderado, sin otras alteraciones. Ha controlado adecuadamente su embarazo, sin haber presentado patologías previas. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir el parto con misoprostol vaginal
- b) Administrar corticoides endovenosos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- c) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa
- d) Realizar amniocentesis
- e) Controlar con nueva ecografía a las 36 semanas, sin necesidad de estudio adicional

16) Una mujer de 28 años, puérpera hace 2 días, presenta aumento de volumen y dolor intenso en relación a la axila derecha. Al examen se aprecia dicho aumento de volumen, de 4 cm, muy doloroso a la palpación, con escaso eritema. El diagnóstico más probable es:

- a) Mastitis abscedada
- b) Glándula mamaria accesoria
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Adenitis supurada
- e) Mastitis linfagítica

17) Identifique la asociación correcta:

- a) Hipermenorrea – Ciclos menstruales de 20 días
- b) Metrorragia – Menstruaciones muy abundantes en cantidad y duración
- c) Sinusorragia – Hemorragia durante los días de ovulación
- d) Oligomenorrea – Ciclos menstruales de 37 días
- e) Amenorrea – Ausencia de menstruación en los últimos 60 días

18) Las causas más frecuentes de metrorragia, en las pacientes en edad fértil y en las pacientes postmenopáusicas, son respectivamente:

- a) Disfuncional y atrofia endometrial
- b) Anovulación y cáncer de cuello uterino
- c) Miomas y atrofia endometrial
- d) Endometriosis e infecciones
- e) Disfuncional y cáncer de endometrio

19) Una paciente de 30 años presenta dismenorrea desde hace 4 años, la que ha ido en aumento. Además presenta dispareunia profunda que se ha vuelto más intensa en los últimos meses. Refiere que lleva 2 años intentando concebir, sin embargo no lo ha logrado a pesar de no usar métodos anticonceptivos y a mantener relaciones sexuales frecuentes con su marido. Al examen físico presenta dolor a la movilización del cuello uterino, son otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de cuello uterino
- b) Adenomiosis
- c) Endometriosis
- d) Miomatosis
- e) Proceso inflamatorio pélvico

20) El período fértil se extiende desde:

- a) Un día antes hasta un día después de la ovulación
- b) Cinco días antes hasta cinco días después de la ovulación
- c) Cinco días antes hasta el día de la ovulación
- d) Diez días antes hasta tres días después de la ovulación
- e) Siete días antes hasta tres días después de la ovulación

Prueba 5

1) Una paciente de 34 años, con antecedente de SOP presenta metrorragia de 4 días de evolución, asociada lipotimias. Al examen físico se constata PA: 110/60 mmHg, FC: 100x', t°: 36,7°C, palidez y frialdad de extremidades. A la especuloscopia se observa sangre saliendo por el OCE y el test de embarazo en orina resulta negativo. La conducta MÁS adecuada, además de una adecuada reposición de la volemia, es:

- a) Solicitar beta-HCG plasmática
- b) Iniciar anticonceptivos orales en dosis habituales
- c) Solicitar hemograma y perfil de hierro
- d) Enviar a domicilio, indicando control en caso de recurrencia de los síntomas
- e) Realizar legrado uterino

2) La etiología de la endometriosis suele ser:

- a) Anovulación
- b) Hipoestrogenismo
- c) Embarazo
- d) Iatrogénica
- e) Obstrucción al tracto de salida

3) Una paciente de 46 años consulta por oligomenorrea, seguida de amenorrea de 4 meses de evolución. Usted sospecha que la paciente está climatérica. ¿Qué examen de sangre le permite determinar esta situación de mejor manera?

- a) Estrógenos plasmáticos
- b) Estrógenos urinarios
- c) Progesterona plasmática
- d) LH plasmática
- e) FSH plasmática

4) Una paciente es diagnosticada de una neoplasia intraepitelial de alto grado (NIE-3). La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con Papanicolaou mensualmente
- b) Controlar con Papanicolaou cada 6 meses
- c) Realizar legrado biopsico
- d) Indicar conización cervical
- e) Indicar histerectomía total

5) Una niña de 4 años es traída por su madre, ya que presenta metrorragia. Al examen superficial se constata escasa metrorragia, asociada a leucorrea de mal olor. El diagnóstico más probable es:

- a) Vulvovaginitis inespecífica
- b) Metrorragia traumática
- c) Menarquia
- d) Cuerpo extraño vaginal
- e) Abuso sexual

6) Es contraindicación del uso de anticonceptivos orales:

- a) Nuliparidad
- b) Síndrome de ovario poliquístico
- c) Antecedente familiar de cáncer de endometrio
- d) Antecedente familiar de cáncer de ovario
- e) Hepatitis aguda

7) Una mujer de 27 años acude a control de rutina con ginecólogo, quien palpa un tumor anexial izquierdo. Se solicita ecografía transvaginal, que revela un tumor anexial izquierdo de 4,6 cm, de aspecto quístico. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales y controlar en 3 meses
- b) Iniciar tamoxifeno
- c) Realizar biopsia por punción
- d) Realizar tumorectomía, con biopsia intraoperatoria
- e) Realizar anexectomía

8) Respecto al prolapso genital es FALSO que:

- a) Es más frecuente en las mujeres postmenopáusicas
- b) El factor de riesgo más importante es la multiparidad
- c) El prolapso medio suele tratarse con histerectomía más fijación de la cúpula vaginal
- d) El cistocele es un tipo de prolapso anterior, mientras que el rectocele es un tipo de prolapso posterior
- e) Los síntomas más frecuentes suelen ser el dolor y la metrorragia

9) Las dos causas más frecuentes de infertilidad son:

- a) Masculina y endometriosis
- b) Anovulación y endometriosis
- c) Masculina y anovulación
- d) Tuboperitoneal y masculina
- e) Endometriosis y tuboperitoneal

10) La prueba de progesterona es muy útil para identificar las metrorragias causadas por:

- a) Hipoestrogenismo
- b) Alteraciones uterinas
- c) Alteraciones hipotalámicas
- d) Ciclos anovulatorios
- e) Malformaciones genitales

11) Una paciente de 34 años se realiza PAP que es informado como muestra satisfactoria, con presencia de células con displasia moderada. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir PAP en un año
- b) Repetir PAP en 6 meses
- c) Derivar a patología cervical, para colposcopia y biopsia
- d) Realizar cono frío
- e) Realizar histerectomía total

12) Una mujer de 50 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 2. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nueva mamografía en un año
- b) Realizar nueva mamografía en 6 meses
- c) Solicitar ecografía mamaria
- d) Realizar biopsia mamaria con mamótomo
- e) Solicitar estrógenos y progesterona plasmáticas

13) Los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de:

- a) Cáncer de mama
- b) Cáncer de endometrio
- c) Cáncer de ovario
- d) Cáncer de cuello uterino
- e) Neoplasia trofoblástica

14) Una paciente consulta por dismenorrea e hipermenorrea de cerca de un año de evolución. Al examen físico destaca útero aumentado de tamaño, como un embarazo de 10 semanas, sin embargo el test de embarazo es negativo. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Endometriosis
- b) Proceso inflamatorio pélvico
- c) Adenomiosis
- d) Hiperplasia endometrial
- e) Cáncer de endometrio

15) Una paciente de 45 años, consulta por leucorrea. A la especuloscopia se aprecia secreción blanco grisácea, de mal olor, con mínima inflamación de la pared vaginal. El tratamiento más adecuado de la patología descrita es:

- a) Metronidazol oral
- b) Doxiciclina oral
- c) Ceftriaxona intramuscular
- d) Fluconazol oral
- e) Nistatina tópica

16) Una mujer de 46 años, multípara de 4, doble cesarizada anterior, consulta por metrorragia autolimitada, durante el día 14 de su ciclo menstrual. Se solicita ecografía transvaginal que demuestra 3 miomas transmurales, el mayor de ellos de 3 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar miomectomía por vía histeroscópica
- b) Solicitar biopsia de endometrio
- c) Iniciar anticonceptivos orales
- d) Realizar histerectomía total
- e) Realizar histerectomía radical más anexectomía bilateral

17) Una mujer de 60 años, asintomática, presenta un tumor anexial derecho, ecográfico, de 5,8 cm, de aspecto quístico con algunas increscencias. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos solos
- b) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progesterona
- c) Realizar biopsia por punción con aguja gruesa
- d) Realizar tumorectomía con biopsia intraoperatoria
- e) Realizar anexectomía con biopsia intraoperatoria

18) Respecto al cáncer de cuello uterino es verdadero que:

- a) Se asocia a presencia de virus papiloma humano, serotipos 6 y 11
- b) Suele estar precedido por lesiones intraepiteliales
- c) Su factor pronóstico más importante es el tipo histológico
- d) La etapificación se realiza de manera quirúrgica
- e) Suele tener sobrevidas muy cortas

19) Una mujer consulta por disuria y leucorrea amarillenta. A la especuloscopia se aprecia pared vaginal indemne, con cuello uterino muy inflamado y con abundante secreción purulenta. El diagnóstico más probable es:

- a) Vaginitis bacteriana
- b) Candidiasis
- c) Tricomoniasis
- d) Gonorrea
- e) Cáncer de cuello uterino

20) ¿Qué tipo de terapia de reemplazo hormonal indicaría a una mujer perimenopáusica, histerectomizada, con marcados síntomas vasomotores?

- a) Estrógenos orales
- b) Estrógenos más progestágenos orales
- c) Progestágenos orales
- d) Estrógenos tópicos
- e) Progestágenos tópicos

Prueba 6 (GINECOLOGÍA + PSIQUIATRÍA)

1) ¿En cuál de las siguientes circunstancias NO existe riesgo aumentado para utilizar contraceptivos orales?:

- a) Paciente fumadora de más de 35 años.
- b) Antecedentes de hepatitis A.
- c) Antecedentes de trombosis venosa profunda.
- d) Antecedentes de colestasis intrahepática.
- e) Hipertensión arterial.

2) Un mioma uterino de localización fúndica de 5 cm de diámetro, en una mujer de 32 años, con dos abortos anteriores y sin hijos, es indicación de:

- a) Histerectomía total conservando ovarios y trompas, vía vaginal.
- b) Histerectomía intrafascial conservando ovarios y trompas, vía abdominal.
- c) Miomectomía.
- d) Tratamiento médico con análogos de la GnRH (hormona hipotalámica liberadora de gonadotrofinas).
- e) Histerectomía total con salpingoovariectomía.

3) Una mujer de 50 años se somete a mastectomía por cáncer de mama. Entre los estudios de rutina postoperatorios, se encuentra la existencia de receptores estrogénicos. ¿Qué significado clínico tiene esta hallazgo?:

- a) Riesgo de recidiva local.
- b) Riesgo de enfermedad diseminada.
- c) Buena respuesta al tratamiento hormonal.
- d) Riesgo de bilateralidad.
- e) Riesgo de multicentricidad.

4) Una mujer de 26 años, cursando un embarazo de 29 semanas consulta por compromiso del estado general y cefalea. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores y cifras tensionales elevadas hasta 160/100 mmHg en varias oportunidades, sin otras alteraciones. La proteinuria cualitativa resulta ++++ y las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. Se solicitan exámenes que muestran proteinuria cuantitativa de 24 horas: 3,6 g, hematocrito: 40%, plaquetas: 110.000 x mm³, blancos: 10.000 x mm³, creatinina: 1,1 mg/dl, LDH: 380 U/l, GOT: 60 U/l, bilirrubina: 1,3 mg/dl, protrombinemia: 70%. ¿Qué aseveración es FALSA respecto a esta paciente?

- a) Se trata de una preclamsia severa
- b) Deben administrarse corticoides endovenosos a la madre
- c) Debe iniciarse alfametildopa
- d) Durante el trabajo de parto se debe administrar sulfato de magnesio endovenoso
- e) Se debe mantener una conducta expectante, interrumpiendo el embarazo a las 37 semanas

5) Una paciente de 36 años, cursando un embarazo de 35 semanas, sin complicaciones hasta ese momento, inicia contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se aprecian 3 contracciones cada 10 minutos, se palpa feto en cefálica y se auscultan los latidos cardiorfetales a 130 lpm. El tacto vaginal demuestra dilatación de 4 cm con 80% de borramiento, con membranas íntegras. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides
- b) Administrar tocolíticos
- c) Administrar corticoides y tocolíticos
- d) Iniciar profilaxis antibiótica para estreptococo beta hemolítico, grupo B y dejar evolución espontánea
- e) Realizar prueba de trabajo de parto (anestesia regional, rotura artificial de membranas y aceleración occitócica)

6) Una mujer de 34 años con antecedente de promiscuidad sexual, presenta atraso menstrual de 2 semanas, por lo que decide realizarse una prueba de embarazo urinaria, que resulta positiva. Acude al ginecólogo, quien realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza gestación intrauterina y solicita niveles plasmáticos de subunidad beta-HCG, que resulta 850 U/l. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar legrado
- b) Administrar progestágenos en dosis altas
- c) Iniciar metotrexato
- d) Solicitar nuevos niveles de beta-HCG y nueva ecografía transvaginal en 48 horas
- e) Resolver quirúrgicamente

7) Una mujer de 35 años presenta dismenorrea de un año de evolución y en la ecografía transvaginal se visualiza un tumor ovárico izquierdo de 4 cm de diámetro, de aspecto quístico, con contenido en vidrio esmerilado. Se solicitan niveles plasmáticos del marcador Ca-125, los que resultan moderadamente elevados. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer
- b) Cuerpo lúteo
- c) Quiste folicular
- d) Endometriosis
- e) Teratoma

8) Desde 1.960 se observa una preocupante elevación de la tasa de cesáreas. Este incremento se asocia entre otras, pero de forma preferente a una de las indicaciones expuestas a continuación:

- a) Placenta previa.
- b) Prolapso de cordón.
- c) Cesárea anterior (iterativa).
- d) Embarazo gemelar.
- e) Fiebre intraparto.

9) ¿En cuál de los siguientes casos la alfa-fetoproteína en sangre de la madre extraída a la 14ª semana de gestación suele estar elevada?:

- a) Cuando el feto tiene una malformación cardíaca.
- b) Cuando el feto padece un retraso del crecimiento.
- c) Cuando el feto es portador de una trisomía 21.
- d) Cuando el feto tiene una hernia diafragmática.
- e) Cuando el feto tiene un defecto del cierre del tubo neural.

10) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es FALSA entre la patología y el síntoma?

- a) Mioma subseroso – Tumor palpable
- b) Endometriosis – Amenorrea
- c) Adenomiosis – Dismenorrea
- d) Pólipo endometrial – Hipermenorrea
- e) Cáncer de cuello uterino – Sinusorragia

11) Mujer de 26 años que aqueja abruptas crisis de mareos y palpitaciones diarias. Le ocurren sobre todo en el metro y en aglomeraciones, pero también en casa y en la oficina. ¿Cuál de los siguientes cuadros psiopatológicos puede tener?:

- a) Claustrofobia.
- b) Ansiedad generalizada.
- c) Síndrome ansiosodepresivo.
- d) Trastorno evitativo de la personalidad.
- e) Trastorno de angustia.

12) Un paciente de 65 años, sin antecedentes psiquiátricos previos, presenta desde hace un mes aproximadamente, un cuadro clínico de inquietud, desasosiego, insomnio y verbalizaciones de tipo hipocondríaco que la propia familia califica de absurdas, del tipo de: "no puedo comer porque no tengo estómago, llegando en alguna ocasión a expresar su temor a estar muerto. El diagnóstico de presunción, entre los siguientes, es:

- a) Psicosis esquizofrénica.
- b) Depresión psicótica.
- c) Inicio de una demencia.
- d) Neurosis hipocondríaca.
- e) Paranoia involutiva.

13) Cómo llevará a cabo el seguimiento farmacológico de una mujer que viene padeciendo cuadros recurrentes de depresión, una vez remitida la sintomatología aguda del último episodio depresivo con imipramina?:

- a) Mediante carbonato de litio a una dosis aproximada de 1 gramo diario.
- b) Mediante alprazolam a dosis aproximada de 2 gramos diarios.
- c) Continuando con imipramina a la dosis que venía tomando cuando remitió la sintomatología aguda.
- d) Continuando con imipramina a dosis bajas para que no se produzcan efectos secundarios molestos.
- e) Mediante carbamacepina a una dosis aproximada de 1 gramo diario.

14) Un joven de 27 años llega a Urgencias con protrusión de lengua y espasmo de torsión de cuello. Un familiar que le acompaña sólo sabe decir que recientemente tuvo un breve ingreso psiquiátrico y le han puesto un tratamiento inyectable. En esta situación el diagnóstico más probable es:

- a) Tetania.
- b) Disonía aguda inducida por neurolépticos.
- c) Trastorno por ansiedad aguda.
- d) Corea de Huntington.
- e) Trastorno por simulación.

15) Paciente de 45 años, traído a Urgencias por su familia porque escucharon un grito y le encontraron en el suelo, con actividad tónico clónica generalizada. Tiene antecedentes de etilismo crónico, pero en las últimas 24 horas no ha bebido y ha permanecido en casa, por no encontrarse bien. En Urgencias no se observa focalidad neurológica, está orientado y presenta temblor postural en las manos e intranquilidad. ¿Cuál es la actitud más correcta?:

- a) Observación en el hospital e iniciar tratamiento con difenilhidantoína.
- b) Observación en el hospital y tratamiento con benzodiazepinas.
- c) TC craneal y alta si éste es normal.
- d) Traslado inmediato a un centro de desintoxicación.
- e) Alta con tratamiento antiepiléptico.

16) Un paciente de 34 años es traído por sus familiares porque tiene la idea de que el alcalde y sus colaboradores han acordado hacerle la vida imposible. Explica claramente que él voto por el otro candidato y que por eso han puesto reglas municipales que lo afectan directamente, como la prohibición de estacionar en la calle donde vive y la instalación de nuevas señales de tránsito que le obligan a tomar una ruta más larga a su trabajo. Por esto ha puesto reiteradas denuncias en el juzgado de policía local, sin obtener resultados. No ha presentado otros problemas y su examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno depresivo psicótico

17) Una mujer de 55 años observa como su hijo es arrestado por tráfico de drogas. Inicialmente parece muy angustiada, pero minutos después cuenta con total desenvoltura sobre lo orgullosa que está de que su hijo se haya ido a estudiar al extranjero. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno delirante
- c) Trastorno disociativo
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno adaptativo

18) Un paciente de 28 años refiere que cada vez que ve un gato oscuro siente que es una señal de mala suerte y que algo malo le pasará a él o a su familia. Para evitarlo se persigna 3 veces y reza un denario. Refiere que la idea aparece y se instala en su mente, lo que le causa mucha ansiedad. Esto se ha vuelto especialmente sensible en el último tiempo ya que su nueva vecina tiene muchos gatos y éstos pasan a su casa, por lo que ya ve muy afectada su vida diaria y no sabe qué hacer. El tratamiento farmacológico de elección es:

- a) Estabilizadores del ánimo
- b) Antidepresivos
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Antipsicóticos típicos
- e) Benzodiazepinas

19) El trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza por:

- a) Retraimiento, apatía e indiferencia ante las demás personas
- b) Ideas de referencia, pensamiento mágico y comportamiento excéntrico
- c) Impulsividad, agresividad e inestabilidad emocional
- d) Inseguridad, autoestima baja y evitación de situaciones en que debe interactuar con otras personas
- e) Dificultad para expresar desacuerdo, dificultad en la toma de decisiones y dependencia emocional

20) Un paciente de 19 años se angustia mucho en las situaciones en que debe realizar alguna actividad en frente de los demás, como hablar en público, cantar o comer. Por esta razón evita cualquier situación de este tipo. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia social
- b) Fobia específica
- c) Agorafobia
- d) Trastorno de personalidad evitativa
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

NO CONTESTE ESTA PREGUNTA

21) Unos de los medicamentos siguientes NO se considera útil para prevenir ulteriores episodios en los trastornos afectivos de carácter bipolar:

- 1)El clonacepam.
- 2)El carbonato de litio.
- 3)El ácido valproico.
- 4)La levomepromazina.
- 5)La carbamacepina.

Prueba 7

1) ¿Cuál de las siguientes mujeres puede ocupar anticonceptivos orales sin mayor contraindicación?

- a) Mujer con antecedente de promiscuidad sexual
- b) Mujer con antecedente de lupus eritematoso sistémico
- c) Mujer con hepatitis crónica por virus hepatitis B
- d) Mujer con antecedentes familiares marcados de cáncer de mama
- e) Mujer con trombosis venosa profunda

2) Identifique la asociación incorrecta entre la historia clínica y la patología mamaria

- a) Mujer de 65 años, con nódulo mamario irregular, que ha aumentado de tamaño y se asocia a "piel de naranja" de la mama comprometida – Cáncer de mama infiltrante
- b) Mujer de 20 años con nódulo mamario de 3 cm, y consistencia gomosa, fácil de movilizar - Fibroadenoma
- c) Mujer de 45 años con mastalgia premenstrual y mamas con nódulos de pequeño tamaño, bilaterales, sensibles – Carcinoma ductal in situ
- d) Puérpera con aumento de volumen doloroso de 4 cm en la axila derecha – Glándula mamaria accesoria
- e) Puérpera con eritema y dolor mamario bilateral – Mastitis linfagítica

3) Una mujer de 55 años se realiza un Papanicolaou que es informado como "Insatisfactorio por atrofia". La conducta más adecuada es:

- a) Repetir el PAP en un año
- b) Repetir el PAP en 6 meses
- c) Iniciar estrógenos locales y repetir el PAP en 3-6 meses
- d) Realizar cono biopsico
- e) Realizar colposcopia

4) El tratamiento de elección de la vaginosis bacteriana es:

- a) Observación
- b) Fluconazol
- c) Amoxicilina + ácido clavulánico
- d) Albendazol
- e) Metronidazol

5) Una mujer de 30 años se realiza una salpingooforectomía derecha, secundaria a un embarazo tubario. Un año más tarde sufre una torsión ovárica izquierda, que no es diagnosticada a tiempo, por lo que se realiza ooforectomía izquierda. La conducta más adecuada para el reemplazo hormonal en esta paciente es:

- a) Iniciar raloxifeno
- b) Iniciar estrógenos solos, por vía local
- c) Iniciar estrógenos solos, por vía parenteral
- d) Iniciar estrógenos más progestágenos, por vía oral
- e) Iniciar progestágenos solos, por vía oral

6) Una paciente presenta un cuadro caracterizado por algia pélvica crónica cíclica, asociada a dispareunia profunda y dolor al defecar. Refiere además que ha intentado concebir desde hace 2 años, sin lograrlo, a pesar de no usar método anticonceptivo. La etiología más probable del cuadro descrito es:

- a) Chlamydia trachomatis
- b) Mutación de genes supresores de tumores
- c) Virus papiloma humano
- d) Anovulación crónica
- e) Obstrucción al tracto genital

7) ¿Qué hallazgo espera encontrar, de manera más constante en una paciente con incontinencia de orina de urgencia?

- a) Aumento del residuo postmiccional
- b) Hipertrofia del músculo detrusor
- c) Contracciones vesicales no inhibidas
- d) Hipotonía del esfínter uretrovesical
- e) Descenso del piso pélvico

8) Una paciente de 22 años, soltera, presenta reglas abundantes, asociadas a anemia microcítica, con hemoglobina de 9,4 g/dl. El examen físico general y ginecológico no muestra alteraciones. Se solicita una ecografía ginecológica que demuestra un mioma submucoso de 3 cm, en el fondo uterino. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento con hierro oral y controlar en 3 meses
- b) Iniciar hierro oral y estrógenos solos
- c) Si presenta deseos de embarazo, aconsejar embarazo en el corto plazo
- d) Realizar miomectomía histeroscópica e iniciar sulfato ferroso
- e) Realizar histerectomía total e iniciar sulfato ferroso

9) ¿Qué microorganismo es responsable de las infecciones uterinas asociadas a uso de dispositivos intrauterinos plásticos?

- a) Staphylococcus aureus
- b) Enterococo
- c) Actinomyces
- d) Chlamydia
- e) Candida albicans

10) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta?

- a) Hipermenorrea – ciclo menstrual de mayor duración que lo normal
- b) Polimenorrea – reglas más frecuentes de lo normal
- c) Metrorragia – sangrado genital que aparece durante la relación sexual
- d) Oligomenorrea – reglas con menor cantidad de flujo menstrual de lo normal
- e) Hipomenorrea – reglas menos frecuentes de lo normal

11) De las siguientes alternativas escoja la mejor opción para tratar un proceso inflamatorio pélvico.

- a) Ceftriaxona + vancomicina
- b) Ciprofloxacino + metronidazol
- c) Ceftriaxona + doxiciclina
- d) Metronidazol + doxiciclina
- e) Penicilina + clindamicina

12) Una paciente de 35 años presenta amenorrea de 4 meses de duración. El examen físico es normal, por lo que se solicita test de embarazo, que resulta negativo; prolactina y TSH, que resultan normales; prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógenos + progesterona, que resulta positiva; FSH y LH, que resultan elevadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Anovulación
- b) Hipogonadismo hipotalámico
- c) Amenorrea de origen uterino
- d) Insuficiencia ovárica primaria
- e) Hipopituitarismo

13) ¿Cuál de los siguientes cánceres suele presentar síntomas con mayor precocidad, mejorando considerablemente su pronóstico?

- a) Cáncer de cuello uterino
- b) Cáncer de ovario
- c) Cáncer de mama
- d) Cáncer de endometrio
- e) Cáncer de vagina

14) La primera causa de vulvovaginitis en las niñas prepuberales es:

- a) Cuerpo extraño
- b) Anaerobios
- c) Inespecífica
- d) Candida
- e) Alérgica

15) Una paciente usuaria de DIU consulta por dolor hipogástrico y malestar general de 2 días de evolución. Al examen se aprecia en buenas condiciones generales, subfebril, con un abdomen blando depresible, sensible en el hipogastrio. A la especuloscopia se observa escasa leucorrea que proviene desde la cavidad endometrial y al tacto vaginal se produce dolor a la movilización cervical. La conducta más adecuada es:

- a) Retirar el DIU inmediatamente
- b) Iniciar antibióticos de amplio espectro y retirar el DIU en una instancia posterior, bajo cobertura antibiótica
- c) Iniciar antibióticos de amplio espectro y retirar el DIU sólo en caso de falta de respuesta
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis sin contraste y decidir manejo según hallazgos
- e) Resolver quirúrgicamente

16) Una mujer de 28 años, con historia de oligomenorrea de algunos años de evolución, consulta por metrorragia de 5 días de evolución. Al examen físico se observa en buenas condiciones, con abundante flujo rojo que transcurre a través del orificio cervical externo. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de endometrio
- b) Miomatosis uterina
- c) Adenomiosis
- d) Metrorragia disfuncional
- e) Atrofia endometrial

17) Una paciente de 64 años, sin antecedentes conocidos, tuvo 11 hijos con su marido. Tres de ellos nacieron por cesárea, y los demás, por parto vaginal, incluyendo un embarazo gemelar. Ella tiene un mayor riesgo de padecer de:

- a) Cáncer de mama
- b) Infección por virus papiloma
- c) Cáncer de endometrio
- d) Prolapso genital
- e) Cáncer de ovario

18) Una paciente de 33 años, presenta una historia de dismenorrea crónica, que ha ido en aumento. Se realiza una Ecografía transvaginal que demuestra un tumor ovárico derecho de 3,5 cm, quístico, de contenido en vidrio esmerilado. Se solicita Ca-125 que resulta moderadamente aumentado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar anexectomía bilateral y biopsias peritoneales
- b) Iniciar anticonceptivos orales y realizar nueva ecografía en 3 meses
- c) Iniciar análogos de GnRH a permanencia
- d) Realizar punción percutánea
- e) Realizar tumorectomía laparoscópica

19) La presentación más habitual del cáncer de cuello uterino, en una paciente que no se realiza control con Papanicolaou, es:

- a) Tumor palpable
- b) Vulvovaginitis a repetición
- c) Genitorragia
- d) Ascitis
- e) Dolores óseos

20) Una paciente de 28 años presenta reglas irregulares, cada 2 a 3 meses. Al examen físico la paciente presenta obesidad moderada y se aprecia acné y piel grasa, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de hiperestimulación ovárica
- b) Hipotiroidismo
- c) Cuerpo lúteo hiperfuncionante
- d) Síndrome metabólico
- e) Síndrome de ovarios poliquísticos

Prueba 8

1) Un paciente de 35 años, cursando un embarazo de 36 semanas, consulta por salida de abundante líquido genital, transparente, hace una hora. Al examen físico se palpa un feto en presentación podálica, sin contracciones uterinas. Se realiza una especuloscopia que muestra salida de líquido claro por el orificio cervical externo y el tacto vaginal muestra un cuello duro, cerrado. Las pruebas de bienestar fetal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Administrar corticoides endovenosos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- d) Mantener una conducta expectante, administrando corticoides y antibióticos endovenosos
- e) Dejar a evolución espontánea

2) Una paciente de 20 años, multipara de 1, con antecedente de parto prematuro a las 33 semanas, cursa un nuevo embarazo, de 32 semanas. Inicia contracciones uterinas de 3 en 10 minutos, persistentes, y el tacto vaginal muestra dilatación cervical de 1 cm, con borramiento del 50% y membranas íntegras. El feto está en cefálica, con registro cardíaco tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Administrar corticoides y antibióticos
- c) Administrar corticoides y tocolíticos
- d) Administrar corticoides y realizar cerclaje de urgencia
- e) Dejar a evolución espontánea

3) Una mujer de 35 años, cursando un embarazo de 30 semanas consulta por fiebre malestar general y leucorrea. Al examen físico está taquicárdica, febril, con dolor a la palpación uterina. El examen genital no muestra cambios cervicales y se aprecia escasa leucorrea que proviene del OCE. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar amniocentesis y solicitar estudio del líquido amniótico
- b) Administrar corticoides y antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
- c) Administrar antibióticos de amplio espectro e interrumpir el embarazo por cesárea
- d) Administrar penicilina endovenosa, durante el trabajo de parto
- e) Administrar gentamicina, clindamicina y dexametasona e inducir el parto en 48 horas con misoprostol

4) Una mujer de 24 años, con un embarazo de 40 semanas, inicia dinámica uterina. Al examen físico se palpan 4 contracciones cada 10 minutos, con tacto vaginal con dilatación de 8 cm, borramiento completo, membranas rotas y feto en presentación de frente, naso-ilíaca izquierda anterior. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolucionar bajo monitoreo cardiotocográfico
- b) Realizar prueba de parto
- c) Realizar rotación manual a posición naso-sacra
- d) Realizar rotación manual a posición naso-púbica
- e) Realizar cesárea

5) Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 39 semanas, más 3 días, consulta por dinámica uterina persistente, asociada a salida de líquido por genitales. Al examen físico está en buenas condiciones genitales, con 4 contracciones uterinas cada 20 minutos. El cuello uterino está completamente borrado y presenta 10 cm de dilatación, con membranas rotas. El feto se palpa en presentación de vértice, en espaldas -2. Se inicia aceleración oxitócica, logrando 4 contracciones cada 10 minutos y se administra la anestesia epidural, sin embargo la cabeza fetal persiste en espaldas -2 luego de 2 horas de observación. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar forceps
- b) Realizar cesárea
- c) Observar evolución
- d) Aumentar el goteo oxitócico
- e) Suspender el goteo oxitócico

6) Una mujer, cursando un embarazo de 6 semanas, consulta por metrorragia. La ecografía transvaginal muestra un feto intrauterino, con presencia de latidos cardíofetales y el tacto vaginal no muestra cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar legrado
- b) Administrar metotrexato
- c) Hospitalizar, para el manejo médico de la metrorragia
- d) Solicitar niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana
- e) Enviara domicilio, indicando reposo

7) Una mujer de 20 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por cefalea y malestar general. Al examen físico presenta FC: 105x', PA: 150/100 mmHg, edema de extremidades inferiores y reflejos osteotendíneos exaltados. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia de líquido amniótico
- b) Síndrome de HELLP
- c) Preclamsia severa
- d) Insuficiencia cardíaca descompensada
- e) Colestasia intrahepática del embarazo

8) En un registro cardíaco fetal, durante un trabajo de parto se observan desaceleraciones de 30 lpm de amplitud, con presencia de una aceleración inmediatamente antes e inmediatamente después de la desaceleración. La etiología de este fenómeno es:

- a) Compresión de la cabeza fetal
- b) Compresión del cordón umbilical
- c) Isquemia fetal
- d) Descarga vagal fetal
- e) Descarga vagal materna

9) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 7 semanas por amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que no muestra gestación intrauterina. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar una nueva ecografía en 7 días
- b) Indicar metotrexato
- c) Realizar laparoscopia
- d) Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta de HCG
- e) Solicitar nueva ecografía a las 28 semanas de gestación

10) La conducta más adecuada frente a una paciente de 31 semanas de edad gestacional, que presenta una rotura prematura de membranas, es:

- a) Realizar cesárea
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos y mantener una conducta expectante
- d) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos e inducir el parto en 48 horas
- e) Administrar corticoides y tocolíticos e inducir el parto en 48 horas

11) La colestasia intrahepática del embarazo se caracteriza por prurito palmoplantar, que aparece en las últimas semanas del embarazo. Su importancia radica principalmente en que:

- a) Aumenta el riesgo de preclamsia
- b) Se asocia a malformaciones fetales
- c) Se asocia a parto prematuro
- d) Se asocia a muerte fetal intrauterina
- e) Aumenta el riesgo de muerte materna

12) ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta del parto vaginal?

- a) Embarazo gemelar
- b) Edad gestacional menor a 30 semanas
- c) Placenta previa oclusiva
- d) Eclamsia
- e) Miomatosis uterina

13) El síntoma más frecuente del embarazo molar es:

- a) Náuseas y vómitos
- b) Hipertensión arterial
- c) Metrorragia
- d) Dolor
- e) Edema

14) Una mujer de 28 años, cursando un embarazo de 35 semanas de edad gestacional, se realiza un cultivo vaginal, que resulta positivo para estreptococo betahemolítico grupo B. Está asintomática. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar penicilina benzatina semanal por lo que reste de embarazo
- b) Administrar ampicilina endovenosa durante el trabajo de parto
- c) Administrar penicilina y metronidazol durante el trabajo de parto
- d) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos y mantener una conducta expectante
- e) Realizar cesárea

15) Una paciente se realiza un RBNE que resulta no reactivo, por lo que se decide realizar un test de tolerancia a las contracciones, que muestra FCF: 140 x', con variabilidad normal y presencia de desaceleraciones precoces, en espejo con las contracciones uterinas. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar prueba de parto
- c) Solicitar ecografía-Doppler de arterias umbilicales
- d) Solicitar perfil biofísico
- e) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

16) Una mujer embarazada de 35 semanas, presenta altura uterina menor a la esperada, por lo que se decide realizar un ecografía obstétrica, que muestra un feto en presentación cefálica, creciendo en el percentil 5 para la edad gestacional, asociada a oligohidroamnios absoluto. El registro basal no estresante es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Interrumpir el embarazo con misoprostol
- c) Solicitar ecografía-doppler de arterias umbilicales
- d) Indicar reposo y observar evolución
- e) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas

17) Una paciente, con embarazo de 36 semanas de edad gestacional, presenta metrorragia oscura, asociada a contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se constata hipertonia uterina y el registro fetal muestra bradicardia. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de vasa previa
- b) Rotura uterina
- c) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- d) Placenta previa marginal
- e) Placenta previa oclusiva

18) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 28 semanas se realiza un TTOG con 75 g de glucosa, que resulta 180 mg/dl a las 2 horas post-carga. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar hemoglobina glicosilada y decidir manejo según resultados
- c) Iniciar dieta y ejercicios
- d) Iniciar glibenclamida
- e) Iniciar insulina

19) Una mujer de 45 años, usuaria de DIU, presenta un atraso menstrual, por lo que decide realizarse una prueba de embarazo, que resulta positiva. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar especuloscopia para el retiro del DIU
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Realizar legrado uterino
- d) Administrar antibióticos durante el embarazo
- e) Observar evolución

20) Una mujer de 38 años, cursando un embarazo de 12 semanas, presenta presión arterial de 160/100 mmHg. Se solicita proteinuria cualitativa, que resulta ++/++++. El diagnóstico más probable es:

- a) Preclamsia
- b) Hipertensión crónica
- c) Hipertensión transitoria
- d) Insuficiencia renal
- e) Embarazo molar

Prueba 9 (GINECOLOGÍA + OBSTETRICIA)

1) Una paciente con antecedente de reglas irregulares, consulta por amenorrea de 5 meses de evolución. Se solicita test de embarazo en orina, que resulta positiva, por lo que se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza gestación intrauterina, ni otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar beta-HCG plasmática
- b) Solicitar biopsia de endometrio
- c) Solicitar nueva ecografía transvaginal en una semana
- d) Realizar laparoscopia
- e) Observar evolución

2) Una paciente, cursando un embarazo de 30 semanas presenta contracciones uterinas dolorosas, acompañadas de metrorragia oscura. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Rotura uterina
- b) Rotura de vasa previa
- c) Desprendimiento de placenta
- d) Placenta previa
- e) Embarazo molar

3) ¿Qué examen tiene un mayor rendimiento para establecer la corionicidad en un embarazo gemelar?

- a) Ecografía del primer trimestre
- b) Ecografía del segundo trimestre
- c) Ecografía del tercer trimestre
- d) Biopsia y estudio genético
- e) Amnioscopia

4) Una paciente de 31 años, con antecedente de un parto prematuro anterior, cursando un nuevo embarazo de 30 semanas, consulta por percibir contracciones uterinas. Al examen físico se aprecian dos contracciones uterinas en 30 minutos y se palpa un cuello uterino duro, posterior, sin dilatación. La cervicometría muestra un cuello de 35 mm de longitud. El perfil biofísico resulta 10/10. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y tocolíticos
- b) Administrar corticoides y antibióticos
- c) Administrar tocolíticos y antibióticos
- d) Solicitar test de tolerancia a las contracciones
- e) Observar evolución

5) Una paciente de 40 años, cursando un embarazo de 40 semanas, presenta salida de abundante líquido amniótico por genitales hace 2 horas. Al examen físico se ve de buen aspecto, con ausencia de contracciones uterinas, palpándose un feto en presentación cefálica y sin modificaciones cervicales. El test de detección de alfa-microglobulina placentaria (PAMG-1) resulta positivo y el RBNE es reactivo. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Administrar misoprostol intravaginal
- c) Administrar antibióticos endovenosos
- d) Realizar amniocentesis
- e) Solicitar ecografía transvaginal

6) ¿Cuál de las siguientes pacientes NO debe recibir profilaxis para isoinmunización Rh, con gamaglobulina anti-D?

- a) Primigesta A-Rh negativo, con un aborto espontáneo a las 12 semanas de gestación
- b) Mujer O-Rh negativo, con un accidente de tránsito, con golpe en el abdomen y metrorragia, a las 35 semanas de embarazo
- c) Mujer AB-Rh negativo, con un embarazo molar parcial
- d) Mujer B-Rh negativo con una prueba de Coombs indirecto positiva a las 28 semanas de embarazo
- e) Mujer O-Rh negativo, primigesta, que da a luz a un recién nacido A-Rh positivo

7) ¿Cuál de las siguientes es una causa de polihidroamnios?

- a) Preclamsia
- b) Agenesia renal
- c) Consumo materno de AINES
- d) Isoinmunización Rh
- e) Rotura de membranas

8) ¿Qué antibiótico tiene un MAYOR riesgo, al ser administrado durante el embarazo?

- a) Cloxacilina
- b) Eritromicina
- c) Nitrofurantoína
- d) Cefazolina
- e) Doxiciclina

9) Una paciente multipara de 2, cuyo primer hijo nació por parto normal y su segundo hijo nació por cesárea a las 40 semanas, cursa un nuevo embarazo de 39 semanas. Inicia trabajo de parto, constatándose feto en presentación cefálica, variante OIIA, con 4 CU cada 10 minutos y cuello uterino completamente borrado, con 5 cm de dilatación y membranas rotas. El registro estresante es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Dejar a evolución espontánea
- c) Iniciar aceleración occitócica
- d) Administrar sulfato de magnesio
- e) Administrar tocolíticos

10) Una paciente de 33 años, multipara de 5, desea iniciar un método anticonceptivo. Actualmente tienen un niño de 2 meses de edad, al que aún amamanta y no está segura si quiere tener más hijos. ¿Qué método recomendaría?

- a) Anticonceptivos combinados orales de microdosis
- b) Anticonceptivos combinados transdérmicos
- c) Anticonceptivos combinados inyectables
- d) Anticonceptivos orales con estrógeno solo
- e) Anticonceptivos orales con progestágeno solo

11) Una mujer está en trabajo de parto. Se constata adecuada progresión, con 3 CU cada 10 minutos, dilatación de 10 cm y feto en presentación cefálica, en espinas +2, sin embargo se comprueba presentación deflexada de cara, en posición mentopubiana. Las pruebas de bienestar fetal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Realizar fórceps
- c) Realizar cesárea
- d) Realizar una prueba de trabajo de parto
- e) Realizar rotación manual a variante mentosacra

12) Una mujer cursando 28 semanas de embarazo, se realiza un hemograma, que muestra hematocrito de 33%, con hemoglobina de 11 g/dl y VCM: 80 fl. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar perfil de hierro
- c) Solicitar colonoscopia
- d) Solicitar niveles plasmáticos de vitamina B12
- e) Iniciar sulfato ferroso

13) Durante un test de tolerancia a las contracciones se aprecian múltiples desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, que inician 20 segundos después de las contracciones uterinas, alcanzando las 90 pulsaciones por minuto y durando cerca de un minuto. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Observar evolución
- c) Iniciar goteo occitócico
- d) Inducir el trabajo de parto con misoprostol
- e) Realizar rotura de membranas

14) Una paciente, cursando un embarazo de 33 semanas, consulta por prurito palmoplantar, de predominio nocturno, que es muy molesto. La conducta más adecuada:

- a) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- b) Hospitalizar y solicitar test de tolerancia las contracciones
- c) Iniciar progesterona oral
- d) Realizar amniocentesis
- e) Administrar corticoides endovenosos y derivar al policlínico de alto riesgo obstétrico

15) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y la conducta más adecuada:

- a) NIE 1 – Conización cervical
- b) NIE 2 – Conización cervical
- c) Cáncer de cuello uterino localizado menor a 4 cm – Realizar histerectomía radical
- d) PAP con atipías glandulares – Derivar a colposcopia para biopsia y curetaje endocervical
- e) PAP con atipías escamosas – Derivar a colposcopia y biopsia

16) Una paciente se realiza una mamografía, que es informada como BIRADS 4, por presencia de microcalcificaciones lineales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva mamografía en un año
- b) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
- c) Solicitar ecografía de mama
- d) Solicitar RMN de mama
- e) Solicitar biopsia

17) Una mujer de 59 años, diabética, presenta metrorragia autolimitada. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra endometrio de 12 mm, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia de endometrio
- b) Solicitar nueva ecografía transvaginal en 30 días
- c) Iniciar ACO y controlar ecográficamente en 3 meses
- d) Realizar histerectomía total
- e) Derivar a colposcopia

18) Una paciente de 35 años con antecedente de hipermenorrea y anemia ferropénica, acude a control ginecológico, en el cual se palpa un útero nodular, aumentado de tamaño. El diagnóstico más probable es:

- a) Adenomiosis
- b) Endometriosis
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Miomatosis
- e) Cáncer de endometrio

19) El examen más sensible y específico ante la sospecha diagnóstica en una mujer de 30 años con dismenorrea y disquexia progresivas asociadas a infertilidad, es:

- a) Laparoscopia
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Histeroscopia
- d) Ecografía transvaginal
- e) Legrado biopsico

20) Usted recibe a una paciente que consulta porque no ha podido quedar embarazada, a pesar de que no utiliza método anticonceptivo y a que mantiene actividad sexual con cierta regularidad. Sus reglas ocurren cada 50-70 días y al examen físico se aprecia obesa, con acné. EL diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de ovario poliquístico
- b) Hipotiroidismo
- c) Falla ovárica prematura
- d) Endometriosis
- e) Hiperandrogenismo hipofisiario

Prueba 10

1) ¿Qué asociación es INCORRECTA entre la patología y su presentación?

- a) Candidiasis – prurito y leucorrea blanca grumosa
- b) Vaginosis – Leucorrea con test de KOH positivo y sin signos inflamatorios
- c) Vaginosis – Leucorrea grisácea con clue cells en a la microscopía directa y pH mayor a 4,5
- d) Tricomoniasis – Leucorrea verdosa, con “vulva en fresa”
- e) Gonorrea – Leucorrea, asociada a disuria y marcados signos inflamatorios en la mucosa vaginal

2) Una mujer de 68 años presenta metrorragia autolimitada. Se solicita ecografía transvaginal que muestra un endometrio de 3 mm. EL diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de endometrio
- b) Adenomiosis
- c) Atrofia endometrial
- d) Cáncer de cuello uterino
- e) Metrorragia disfuncional

3) Una mujer de 34 años se realiza un PAP que es informado como ininterpretable por marcada atrofia. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevo PAP inmediatamente
- b) Solicitar nuevo PAP en 6 meses, luego de tratar con estrógenos locales
- c) Solicitar nuevo PAP en un año
- d) Derivar a colposcopia
- e) Realizar cono biopsico

4) Una paciente de 35 años presenta deseos de embarazo desde hace un año, sin embargo no lo ha conseguido, a pesar de mantener relaciones sexuales frecuentes con su marido, sin usar método anticonceptivo alguno. ¿Qué exámenes solicitaría para iniciar el estudio?

- a) Espermiograma e histerosalpingografía
- b) Espermiograma y seguimiento folicular ecográfico
- c) Espermiograma e histeroscopia
- d) Espermiograma y cariograma
- e) Espermiograma y laparoscopia

5) Una paciente de 16 años, cuya menarquía fue a los 15 años, consulta porque sus reglas son irregulares, sucediendo cada 2 a 3 meses. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar prueba de progesterona
- b) Solicitar FSH y LH plasmática
- c) Observar evolución
- d) Iniciar anticonceptivos orales
- e) Solicitar TSH y prolactina plasmática

6) ¿Qué método anticonceptivo, entre los mencionados, recomendaría a una paciente dislipidémica?

- a) Anillo vaginal medicado
- b) Anticonceptivos orales en macrodosis
- c) Estrógenos solos orales
- d) Progestágenos solos orales
- e) Progestágenos solos inyectables

7) Una paciente de 43 años presenta marcados signos climatéricos, que iniciaron después de una histerectomía total, mas anexectomía bialteral, producto de un cáncer. ¿Qué terapia recomendaría como remplazo hormonal?

- a) Estrógenos solos
- b) Estrógenos más progestagenos
- c) Progestágenos solos
- d) Raloxifeno
- e) Análogos de la GnRH

8) ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de ovario?

- a) Diabetes
- b) Anticonceptivos orales
- c) Promiscuidad sexual
- d) Nuliparidad
- e) Menarquia tardía

9) Una mujer de 35 años, usuaria de DIU, consulta por fiebre, algia pélvica y leucorrea. Al examen físico presenta leucorrea purulenta, dolor a la palpación hipogástrica y a la movilización cervical. La ecografía transvaginal demuestra el DIU in situ, sin otras alteraciones de importancia. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento antibiótico, sin necesidad de retirar el DIU
- b) Retirar el DIU, sin necesidad de iniciar antibióticos
- c) Iniciar antibióticos y posteriormente retirar el DIU
- d) Retirar el DIU, iniciar antibióticos y realizar legrado uterino
- e) Resolver quirúrgicamente, bajo cobertura antibiótica

10) ¿Qué tratamiento es más adecuado para una metrorragia disfuncional de varios días de evolución?

- a) Anticonceptivos orales en altas dosis
- b) Estrógenos tópicos
- c) Progestágenos tópicos
- d) Ácido mefenámico
- e) Progestágenos orales

11) Son síntomas de endometriosis, EXCEPTO:

- a) Amenorrea
- b) Dolor al defecar
- c) Dispareunia profunda
- d) Infertilidad
- e) Dismenorrea

12) ¿Qué hallazgo determinaría un peor pronóstico en una paciente con cáncer de ovario?

- a) Cáncer de ovario bilateral
- b) Dolor abdominal
- c) Ascitis
- d) Elevación del Ca-125
- e) Histología de cistoadenocarcinoma mucinoso

13) Una mujer de 35 años, asintomática, multipara de 2, sin antecedentes de importancia, se realiza una ecografía transvaginal como parte de un chequeo médico, que muestra 2 miomas intramurales de 2 y 3 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia de los miomas
- b) Observar evolución
- c) Realizar histerectomía total
- d) Iniciar análogos de la GnRH
- e) Iniciar anticonceptivos orales

14) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y su tratamiento:

- a) Incontinencia urinaria de esfuerzos – Resolución quirúrgica
- b) Incontinencia urinaria de urgencia – Bloqueadores alfa-adrenérgicos
- c) Vejiga neurogénica – Autocateterismo limpio
- d) Fístula vésico-vaginal – Resolución quirúrgica
- e) Rectocele – colpoplastia posterior

15) Una mujer se realiza un PAP, que muestra presencia de abundantes células atípicas, por lo que se deriva a colposcopia y biopsia, que demuestran presencia de una NIE 3. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar conización cervical
- b) Realizar crioterapia
- c) Realizar histerectomía radical
- d) Realizar histerectomía total
- e) Iniciar tratamiento con podofilino

16) Una paciente presenta una biopsia de endometrio, informada como hiperplasia endometrial atípica y compleja. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar histerectomía
- b) Realizar legrado uterino
- c) Iniciar anticonceptivos combinados orales
- d) Iniciar progestágenos orales
- e) Observar evolución, con seguimiento ecográfico periódico

17) Una mujer se realiza una mamografía, que visualiza una lesión de 2,5 cm, densa, espiculada, con abundantes microcalcificaciones en el centro, ubicada en el cuadrante inferior externo de la mama izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar quimioterapia
- b) Biopsiar la lesión
- c) Solicitar biopsia de ganglio centinela
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear
- e) Solicitar ecografía mamaria

18) La causa más frecuente de metrorragia prepuberal es:

- a) Disfuncional
- b) Atrofia endometrial
- c) Trauma
- d) Vaginitis inespecífica
- e) Cáncer

19) Una mujer se realiza una ecografía transvaginal, que visualiza un tumor sólido-quístico de 2,5 cm en el ovario derecho. Sus reglas son regulares y su FUR fue hace 20 días. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometrioma
- b) Cuerpo lúteo
- c) Quiste folicular
- d) Cáncer
- e) Teratoma

20) El tratamiento de elección de la vaginosis bacteriana es:

- a) Metronidazol
- b) Ciprofloxacino
- c) Clotrimazol
- d) Cotrimoxazol
- e) Cefadroxilo

Prueba 11

1) Una paciente presenta ciclos menstruales más cortos que lo normal. Por lo tanto presenta:

- a) Oligomenorrea
- b) Menometrorragia
- c) Hipomenorrea
- d) Hipermenorrea
- e) Polimenorrea

2) Una paciente de 45 años se realiza una biopsia endometrial que es informada como hiperplasia endometrial sin atipias, con arquitectura conservada. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar progestágenos orales
- c) Iniciar metotrexato
- d) Realizar legrado uterino
- e) Resolver quirúrgicamente

3) Una mujer de 59 años acude a control ginecológico, en el cual se le palpa un tumor anexial izquierdo, el que se confirma con ecografía, siendo de aspecto quístico, de 6 cm de diámetro, con increscencias. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar estrógenos orales y controlar periódicamente con ecografía
- b) Realizar paracentesis y estudio de líquido peritoneal
- c) Iniciar progestágenos orales y controlar periódicamente con ecografía
- d) Realizar biopsia por punción con aguja fina
- e) Realizar anexectomía y biopsia excisional

4) Una mujer de 39 años se realiza un Papanicolaou que es informado como satisfactorio, con presencia de atipias de grado moderado. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevo PAP en un año
- b) Solicitar nuevo PAP en 3 meses
- c) Solicitar nuevo PAP de inmediato
- d) Realizar cono cervical
- e) Realizar colposcopia

5) Una paciente consulta por dismenorrea severa, que inició hace 6 meses y que ha ido en aumento. Se solicita una ecografía transvaginal que visualiza un tumor ovárico izquierdo, de 5 cm de diámetro, quístico, con contenido en "vidrio esmerilado". El Ca-125 resulta el doble de lo normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Teratoma quístico benigno
- b) Cistoadenoma seroso
- c) Cistadenocarcinoma
- d) Quiste folicular
- e) Endometrioma

6) Una paciente de 48 años, asintomática, acude al ginecólogo para chequeo, quien le palpa un tumor pélvico, por lo que solicita una ecografía transvaginal, que demuestra la presencia de 2 miomas subserosos, de 4 y 5 cm de diámetro respectivamente. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar histerectomía total
- b) Realizar tumorectomía
- c) Observar evolución
- d) Iniciar análogos de GnRH y controlar con nueva ecografía en 3 meses
- e) Realizar esclerosis con inyección de alcohol intratumoral

7) ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma de un proceso inflamatorio pélvico?

- a) Fiebre
- b) Dolor abdominal
- c) Leucorrea
- d) Oligomenorrea
- e) Dispareunia profunda

8) Una paciente se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 4, con presencia de un tumor de 3 cm en la mama izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia de ganglio centinela
- b) Realizar tumorectomía y biopsia
- c) Realizar mastectomía parcial y reconstrucción mamaria
- d) Realizar biopsia por punción con mamótomo
- e) Realizar biopsia por punción con aguja fina

9) Una paciente de 30 años consulta por disuria y leucorrea abundante de mal olor. Al examen físico se aprecia marcada inflamación de las paredes vulvares y genitales, con presencia de abundante leucorrea verde-amarillenta. El diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis
- b) Vaginosis
- c) Gonorrea
- d) Tricomoniasis
- e) Absceso de Bartolino

10) Una mujer sexualmente activa presenta disuria, fiebre y aparición de lesiones dolorosas en la vulva. Al examen físico se aprecian varias úlceras confluentes, en los labios menores y labio mayor derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Condiloma acuminado
- b) Herpes genital
- c) Linfogranuloma venéreo
- d) Sífilis primaria
- e) Donovanosis

11) Las causas más frecuentes de infertilidad son:

- a) Causa masculina y endometriosis
- b) Endometriosis y daño tuboperitoneal
- c) Causa masculina y daño tuboperitoneal
- d) Endometriosis e incompetencia cervical
- e) Causa masculina y anovulación

12) Una mujer de 36 años presenta amenorrea de 4 meses de evolución. Se realiza un test de embarazo en orina que resulta negativo y el examen físico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de HCG
- b) Solicitar niveles plasmáticos de FSH y LH
- c) Solicitar TSH y prolactinemia
- d) Solicitar estradiol y progesterona plasmática
- e) Solicitar seguimiento folicular ecográfico

13) ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación del dispositivo intrauterino?

- a) Diabetes
- b) Trombofilia
- c) Endometriosis
- d) Hepatopatías activas
- e) Cáncer de mama

14) Respecto a los anticonceptivos orales y a la terapia de remplazo hormonal, es VERDADERO que:

- a) El raloxifeno es útil para disminuir los síntomas vasomotores del climaterio
- b) Los anticonceptivos orales combinados aumentan el riesgo de cáncer de endometrio
- c) Los anticonceptivos orales combinados aumentan el riesgo de cáncer de ovario
- d) Los anticonceptivos transdérmicos presentan un mejor perfil que los orales, en cuanto a la alteración de los niveles plasmáticos de lípidos
- e) Las mujeres histerectomizadas deben recibir sólo progestágenos como terapia de remplazo hormonal

15) El factor de riesgo más importante para desarrollar un prolapso genital es:

- a) Actividad sexual
- b) Multiparidad
- c) Conización cervical
- d) Obesidad
- e) Legrados uterinos

16) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante una mujer con incontinencia urinaria de esfuerzo, en la que se ha descartado la presencia de infección y que no ha respondido a las medidas generales y ejercicios de fortalecimiento de la musculatura pélvica?

- a) Iniciar anticolinérgicos
- b) Iniciar antiadrenérgicos alfa
- c) Iniciar antiadrenérgicos beta
- d) Solicitar cistoscopia
- e) Resolver quirúrgicamente

17) Una niña de 4 años presenta metrorragia escasa, con leucorrea de mal olor, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Tricomoniasis
- b) Vulvovaginitis inespecífica
- c) Cuerpo extraño vaginal
- d) Vulvovaginitis estreptocócica
- e) Abusos sexual

18) Una mujer de 25 años se palpa un nódulo mamario, fácil de movilizar de 2 cm de diámetro, de consistencia firme y bordes regulares. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de mama
- b) Quiste simple
- c) Fibroadenoma
- d) Mastopatía fibroquística
- e) Enfermedad de Paget

19) Una paciente de 28 años consulta por metrorragia intensa, de 3 días de evolución, con presencia de abundantes coágulos. El test de embarazo resulta negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar ácido tranexánico
- c) Solicitar niveles plasmáticos de estrógenos
- d) Realizar legrado
- e) Iniciar anticonceptivos orales

20) Una mujer de 24 años, presenta irritabilidad y labilidad emocional durante los 3 días previos a la menstruación, que le traen problemas con su pareja y con sus compañeros de universidad. ¿Qué tratamiento farmacológico es más útil para este cuadro?:

- a) Antidepresivos
- b) Tibolona
- c) Ácido mefenámico
- d) Paracetamol
- e) Ninguno

GINECOLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	19 A	16 B	13 C	9 D	6 A
1 C	20 C	17 D	14 B	10 C	7 A
2 B		18 A	15 B	11 D	8 D
3 A	Prueba 3	19 C	16 B	12 C	9 C
4 E	1 D	20 C	17 C	13 C	10 A
5 D	2 A		18 B	14 B	11 A
6 B	3 D	Prueba 5	19 A	15 A	12 C
7 C	4 A	1 E	20 A	16 B	13 B
8 E	5 D	2 E	21 D	17 C	14 B
9 B	6 D	3 E		18 C	15 A
10 D	7 E	4 D	Prueba 7	19 A	16 A
11 C	8 C	5 D	1 A	20 B	17 B
12 D	9 D	6 E	2 C		18 C
13 A	10 C	7 A	3 C	Prueba 9	19 B
14 C	11 C	8 E	4 E	1 A	20 A
15 B	12 E	9 C	5 D	2 C	
16 C	13 C	10 D	6 E	3 A	Prueba 11
17 C	14 C	11 C	7 C	4 E	1 E
18 C	15 E	12 A	8 D	5 B	2 B
19 D	16 A	13 A	9 C	6 D	3 E
20 D	17 E	14 C	10 B	7 D	4 E
	18 C	15 A	11 C	8 E	5 E
Prueba 2	19 D	16 B	12 D	9 B	6 C
1 A	20 D	17 E	13 D	10 E	7 D
2 C		18 B	14 C	11 A	8 D
3 A	Prueba 4	19 D	15 B	12 A	9 D
4 E	1 C	20 A	16 D	13 A	10 B
5 D	2 D		17 D	14 E	11 E
6 E	3 B	Prueba 6	18 E	15 A	12 C
7 B	4 A	1 B	19 C	16 E	13 C
8 A	5 D	2 C	20 E	17 A	14 D
9 B	6 E	3 C		18 D	15 B
10 B	7 A	4 E	Prueba 8	19 A	16 E
11 D	8 E	5 D	1 A	20 A	17 C
12 B	9 B	6 D	2 C		18 C
13 D	10 C	7 D	3 C	Prueba 10	19 D
14 C	11 B	8 C	4 E	1 E	20 A
15 D	12 C	9 E	5 B	2 C	
16 B	13 E	10 B	6 E	3 B	
17 E	14 D	11 E	7 C	4 B	
18 E	15 C	12 B	8 B	5 C	

II) OBSTETRICIA PRUEBAS

Prueba 1

1) Una mujer de 45 años, presenta hemorragia postparto, que no cede a pesar de realizar masaje uterino y de administrar oxitocina y metilergonovina endovenosas. Paralelamente se administran cristaloides endovenosos. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar coloides endovenosos
- b) Administrar ácido tranexánico
- c) Realizar revisión instrumental del canal del parto
- d) Realizar ligadura de las arterias uterinas
- e) Realizar histerectomía

2) La diabetes gestacional supone un mayor riesgo de presentar las siguientes patologías, EXCEPTO:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Fetos grandes para la edad gestacional
- c) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- d) Poliglobulia neonatal
- e) Fractura de clavícula fetal

3) Una multipara de 38 años, cursando se cuarto embarazo, de 33 semanas consulta por aparición de prurito palmoplantar intenso, mayor en las noches, asociados a ictericia. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de HELLP
- b) Hígado graso agudo del embarazo
- c) Hepatitis viral
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Isoinmunización Rh

4) Una primigesta de 38 semanas de gestación consulta por una clara disminución de la percepción de los movimientos fetales. Se realiza registro basal no estresante que muestra frecuencia cardíaca fetal a 150 lpm, con variabilidad normal y presencia de 3 aceleraciones en 20 minutos, 2 de ellas en relación a movimientos fetales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar perfil biofísico
- b) Realizar ecodoppler umbilical
- c) Realizar cesárea de urgencia
- d) Prolongar el registro por 20 minutos más
- e) Tranquilizar a la madre y enviar a domicilio

5) Una paciente cursando embarazo de 30 semanas inicia metrorragia abundante de color rojo brillante, sin otros síntomas. No presenta contracciones y las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Desprendimiento de placenta normoinsera
- b) Placenta previa
- c) Rotura de vasa previa
- d) Eliminación del tapón mucoso
- e) Inercia uterina

6) Una mujer cursando 9 semanas de embarazo, inicia metrorragia. Se realiza ecografía transvaginal que demuestra gestación única, con latidos cardiorfetales presentes. El factor pronóstico más importante es:

- a) Modificaciones cervicales
- b) Frecuencia cardíaca fetal
- c) Presencia de contracciones uterinas
- d) Severidad de la hemorragia
- e) Tiempo de evolución

7) Una multipara de 4, cursando embarazo de 30 semanas de gestación, inicia dinámica uterina, la que se corrobora, con 3 contracciones en un minuto. Al tacto vaginal se aprecia cuello uterino con 70% de borramiento, 1 cm de dilatación y membranas íntegras. El perfil biofísico resulta 10/10. La conducta más adecuada es:

- a) Tranquilizar a la madre y enviar a domicilio para evolución espontánea
- b) Hospitalizar e iniciar corticoides y tocolíticos
- c) Realizar amniocentesis y decidir manejo según resultados
- d) Realizar cerclaje de emergencia, iniciar corticoides, tocolíticos y antibióticos endovenosos
- e) Realizar test de tolerancia a las contracciones

8) El tratamiento de elección para el manejo de la hipertensión arterial crónica en una paciente embarazada es:

- a) Nifedipino
- b) Hidralazina
- c) Hidroclorotiazida
- d) Alfametildopa
- e) Enalapril

9) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una causa de oligohidroamnios?

- a) Atresia esofágica
- b) Sufrimiento fetal crónico
- c) Rotura prematura de membranas
- d) Uso de AINES
- e) RCIU

10) Una mujer es diagnosticada de VIH en relación a un screening realizado en la primera consulta al obstetra. Se encuentra asintomática. ¿Cuál de las siguientes alternativas supone un MENOR riesgo para el feto, al momento del parto?:

- a) Ausencia de infecciones oportunistas
- b) Recuento de linfocitos helper CD4(+) mayor a 1.000
- c) Carga viral indetectable
- d) Tratamiento antirretroviral
- e) Cesárea

11) Una embarazada de 34 semanas presenta altura uterina menor a la esperada para la edad gestacional. Se realiza ecografía obstétrica con estimación de peso fetal de 1.500 g (percentil 3), con cociente de perímetros craneano/abdominal mayor a uno. El líquido amniótico se encuentra disminuido. La etiología más probable es:

- a) Constitucional
- b) Malformación urinaria
- c) Genopatía
- d) Insuficiencia placentaria
- e) Error en la estimación de la edad gestacional

12) Una mujer con 6 semanas de amenorrea se realiza test de embarazo que resulta positivo. Acude a su primera consulta obstétrica, donde le realizan ecografía transvaginal que no visualiza gestación intrauterina. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nuevo test de embarazo
- b) Solicitar niveles plasmáticos de beta HCG
- c) Realizar nueva ecografía transvaginal en 7 días
- d) Indicar metotrexato
- e) Realizar laparoscopia

13) En Chile la primera causa de cesáreas es:

- a) Sufrimiento fetal
- b) Distocias de presentación
- c) Síndromes hipertensivos del embarazo
- d) Cesáreas anteriores
- e) Desproporción céfalopélvica

14) ¿Cuál de las siguientes presentaciones NO tiene opción de parto vaginal?

- a) Cara
- b) Frente
- c) Bregma
- d) Occipucio
- e) Fontanela posterior

15) Una primigesta de 32 semanas consulta por cuadro de 5 días de evolución de malestar general, cefalea y edema de las extremidades inferiores. Al examen físico se aprecia decaída, con FC: 100x', PA: 146/88 mmHg, t°:36,8°C. Trae algunos exámenes de sangre entre los que destaca Hb: 10,7g/dl, hematocrito: 33%, plaquetas: 90.000, glóbulos blancos: 6.700, GOT: 478, GPT: 335, Bilirrubina: 2,6. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia de líquido amniótico
- b) Hígado graso agudo del embarazo
- c) Corioamnionitis
- d) Preclamsia severa
- e) Hepatitis viral

16) Una paciente de 33 años, cursando embarazo de 35 semanas, presenta salida de abundante líquido claro, por genitales, hace una hora, sin presentar contracciones uterinas. Se realiza especuloscopia que demuestra salida de este líquido por el OCE y el test de cristalización es positivo. El tacto vaginal no presenta modificaciones cervicales. Se solicita registro basal no estresante que demuestra bienestar fetal. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y antibióticos a la madre
- b) Realizar cesárea
- c) Dejar evolución espontánea
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar amniocentesis y decidir conducta según resultados

17) Una paciente con embarazo de 20 semanas, asintomática, se realiza exámenes de orina que muestran desarrollo de Escherichia coli resistente sólo a las cefalosporinas. El tratamiento de elección es:

- a) Ceftriaxona
- b) Ciprofloxacino
- c) Cotrimoxazol
- d) Nitrofurantoína
- e) No requiere tratamiento antibiótico

18) ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada durante el embarazo?

- a) Varicela
- b) Hepatitis A
- c) Hepatitis B
- d) Antitetánica
- e) Antigripal

19) Una embarazada de 30 semanas de gestación consulta por malestar general y fiebre hasta 39°C. Al examen físico se constata taquicardia, sensibilidad a la palpación uterina y escasa leucorrea que proviene del orificio cervical externo. Se auscultan los latidos cardiacos fetales a 175 x'. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia sin necesidad de antibióticos maternos
- b) Realizar amniocentesis
- c) Interrumpir el embarazo bajo cobertura antibiótica
- d) Solicitar test de tolerancia a las contracciones
- e) Iniciar corticoides y antibióticos e interrumpir el embarazo al alcanzar la madurez pulmonar

20) Una paciente multipara de uno, con antecedente de parto vaginal anterior, ingresa en su 34ª semana de gestación por parto en curso. Mediante tacto vaginal se diagnostica dilatación de 6 cm y presentación pelviana (nalgas puras), variedad sacro iliaca izquierda anterior, en II plano de Hodge. Ecográficamente se estima que el peso fetal estará comprendido entre 2.100 y 2.300 g. Señale la conducta obstétrica correcta:

- a) Permitir la evolución espontánea evitando la ayuda manual durante el periodo expulsivo
- b) Iniciar corticoides y tocolíticos
- c) Permitir la evolución hasta periodo expulsivo y finalizar éste mediante aplicación de forceps para evitar la distocia de cabeza última
- d) Terminar el parto mediante cesárea
- e) Determinar la actitud de la cabeza fetal mediante una radiografía simple del abdomen materno

Prueba 2

1) Una gestante de 28 semanas se realiza test de tolerancia a la glucosa, como parte de un control del embarazo, que muestra glicemia de ayunos de 100 mg/dl y de 155 mg/dl, a las 2 horas después de recibir 75 g de glucosa oral. Se encuentra asintomática y el examen físico sólo muestra los cambios normales del embarazo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevo test de tolerancia a la glucosa oral con 100 g de glucosa
- b) Solicitar hemoglobina glicosilada
- c) Iniciar dieta y ejercicios
- d) Iniciar medidas generales y metformina
- e) Iniciar medidas generales e insulino terapia

2) Una mujer de 36 años, primigesta de 30 semanas, presenta presión arterial de 144/92 mmHg en un control ginecológico. Se controla la presión arterial en varias oportunidades durante 6 horas, constatándose varios valores mayores de 140/90. La conducta más adecuada es

- a) Controlar frecuentemente la presión arterial por 48 horas más y decidir manejo según resultados
- b) Solicitar proteinuria de 24 horas
- c) Solicitar hemograma, pruebas hepáticas, LDH, tiempos de coagulación, clearance de creatinina, proteinuria de 24 horas, electrolitos plasmáticos
- d) Indicar dieta hiposódica y ejercicios
- e) Indicar dieta, ejercicios y alfametildopa

3) Una mujer de 25 años, cursando embarazo de 8 semanas de amenorrea, confirmado con test de detección de beta-HCG urinaria, consulta por dolor hipogástrico intenso y metrorragia. Evoluciona con lipotimias y ortostatismo. Al examen físico se aprecia pálida, con frialdad de extremidades, FC: 124x' y PA: 80/50 mmHg. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Desprendimiento de placenta normo inserta
- b) Rotura uterina
- c) Aborto incompleto
- d) Embarazo molar
- e) Embarazo ectópico roto

4) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es una indicación de administrar inmunoglobulina anti-D a una paciente embarazada Rh negativo?

- a) Prueba de Coombs indirecto positiva
- b) Amniocentesis
- c) Postparto
- d) Aborto completo
- e) 28 semanas de gestación

5) Una paciente de 22 años, cursando embarazo de 29 semanas presenta salida de líquido claro, con olor a cloro, por genitales, desde hace algunos días. No presenta otros síntomas. La especuloscopia es normal y el test de cristalización presenta formación de "hojas de helecho". La ecografía obstétrica demuestra un feto en cefálica, con oligoamnios, sin otras alteraciones. El registro basal no estresante es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Administrar corticoides y antibióticos a la madre, manteniendo una conducta expectante respecto al parto
- d) Administrar corticoides y antibióticos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- e) Realizar cerclaje de emergencia e iniciar antibióticos

6) Una mujer de 25 años consulta porque presentó un aborto espontáneo a las 8 semanas de su primer embarazo. Actualmente se encuentra usando anticonceptivos orales, pero desea un nuevo embarazo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía transvaginal y decidir manejo según hallazgos
- b) Solicitar anticuerpos anticardiolipinas, progesterona plasmática de fin de ciclo, ecografía transvaginal, prueba de Hegar y decidir manejo según hallazgos
- c) Suspender anticonceptivos y administrar progesterona en la segunda mitad del ciclo menstrual
- d) Realizar seguimiento folicular y inducción de la ovulación con clomifeno
- e) Tranquilizarla e indicarle que puede intentar un nuevo embarazo sin necesidad de estudio

7) El punto de reparo de la presentación de cara es:

- a) Fontanela anterior
- b) Ojos
- c) Nariz
- d) Boca
- e) Mentón

8) La elevación de la alfafetoproteína es un marcador de:

- a) Síndrome de Down
- b) Defectos del tubo neural
- c) Trisomía 18
- d) Hernia diafragmática congénita
- e) Restricción del crecimiento intrauterino

9) Paciente multipara de dos en trabajo de parto, cuyo monitoreo muestra una FC fetal basal de 130/min, buena variabilidad y presencia de aceleraciones. La rotura artificial de membranas da salida a un líquido con meconio fluido, amarillo verdoso. ¿Cuál es la conducta obstétrica a seguir?

- a) Interrupción inmediata del embarazo mediante cesárea
- b) Reanimación fetal in útero con reevaluación en 20 minutos
- c) Reanimación fetal in útero seguida de interrupción del embarazo
- d) Mantener una conducta expectante y permitir que continúe el trabajo de parto
- e) Interrupción inmediata por la vía más expedita

10) A las 34 semanas de gestación un feto pesa aproximadamente:

- a) 500 a 1.000 g
- b) 1.000 a 1.500 g
- c) 1.500 a 2.000 g
- d) 2.000 g 2.500 g
- e) 2.500 g 3.000 g

11) Una paciente con preclamsia severa presenta cefalea intensa y luego una convulsión tónicoclónica autolimitada. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar sulfato de magnesio, corticoides endovenosos e inducir el parto con misoprostol
- b) Iniciar sulfato de magnesio estabilizar a la madre e interrumpir el embarazo
- c) Administrar lorazepam y realizar cesárea de urgencia
- d) Administrar sulfato de magnesio y solicitar tomografía axial computada de cerebro
- e) Realizar cesárea inmediatamente, sin uso de medicamentos

12) La biopsia endometrial, con reacción de Arias Stella se observa en:

- a) Aborto completo, embarazo ectópico y uso de progestágenos exógenos
- b) Embarazo molar, embarazo ectópico y uso de estrógenos exógenos
- c) Embarazo molar, climaterio y uso de progestágenos exógenos
- d) Aborto completo, climaterio y uso de estrógenos exógenos
- e) Embarazo normal, anovulación crónica y uso de anticonceptivos combinados

13) Una gestante de 32 semanas consulta por metrorragia y contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico destaca útero hipertónico. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento previo de placenta normoinsera
- b) Placenta previa
- c) Rotura uterina
- d) Rotura de vasa previa
- e) Acretismo placentario

14) Una mujer de 25 años, cursando embarazo de 9 semanas inicia metrorragia abundante. La especuloscopia demuestra salida de sangre y restos ovulares por el OCE, la ecografía transvaginal visualiza el saco gestacional de contenido irregular y el tacto vaginal constata dilatación cervical de 2 cm. El resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles de HCG
- b) Administrar misoprostol intravaginal
- c) Realizar cerclaje de emergencia
- d) Indicar reposo y dejar evolución espontánea
- e) Realizar legrado uterino

15) Una multipara de 34 años, cursando su cuarto embarazo, de 40 semanas inicia dinámica uterina. Al examen se constatan 3 contracciones en 10 minutos y el tacto vaginal muestra un cuello completamente borrado, con 4 cm de dilatación y membranas íntegras. Se instala monitoreo fetal que muestra desaceleraciones en relación a la mayoría de las contracciones uterinas, sin decalage, en espejo con éstas. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Administrar oxígeno, poner en decúbito lateral izquierdo e indicar anestesia epidural
- c) Iniciar aceleración occitócica
- d) Realizar rotura artificial de membranas y observar el líquido amniótico
- e) Realizar cesárea de urgencia

16) La complicación más frecuente de la cesárea es:

- a) Hemorragia intraperitoneal
- b) Metrorragia
- c) Dehiscencia de la herida
- d) Atelectasias pulmonares
- e) Infección de la herida operatoria

17) ¿Cuál de los siguientes fármacos es un tocolítico?

- a) Fenoterol
- b) Occitocina
- c) Alfametildopa
- d) Metilergonovina
- e) Prostaglandina

18) ¿Cuál es el mejor parámetro para estimar la edad gestacional en un embarazo avanzado, sin controles previos?

- a) Altura uterina
- b) Inicio de la percepción de movimientos fetales
- c) Fecha de la última regla confiable y segura
- d) Ecografía
- e) Niveles plasmáticos de beta-HCG

19) El una ecografía del primer trimestre de un embarazo gemelar se observa el signo lambda. ¿Qué tipo de embarazo gemelar es?

- a) Dicigótico
- b) Monocigótico
- c) Bicorial
- d) Monocorial
- e) Monoamniótico

20) La primera causa de muerte materna en Chile es:

- a) Síndrome hipertensivo del embarazo
- b) Hemorragia puerperal
- c) Aborto séptico
- d) Enfermedades crónicas descompensadas por el embarazo
- e) Embolía de líquido amniótico

Prueba 3

1) Un paciente presenta atraso menstrual de 2 semanas, por lo que decide realizarse un test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal que no visualiza saco gestacional. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir el test de embarazo
- b) Solicitar nueva ecografía transvaginal en 48 horas
- c) Solicitar beta-HCG plasmática
- d) Resolver quirúrgicamente
- e) Realizar legrado uterino

2) Una paciente de 27 años, cursando su segundo embarazo, en la semana 33, consulta por edema de extremidades inferiores. En el examen físico se constata un leve edema, asociado a cifras tensionales arteriales elevadas hasta 150/100 mmHg, en varias tomas a lo largo de 6 horas. Por esto se decide solicitar proteinuria de 24 horas, que resulta 500 mg. El diagnóstico más probable es:

- a) Preclamsia
- b) Hipertensión crónica
- c) Hipertensión transitoria del embarazo
- d) Eclamsia
- e) Embarazo normal

3) Una paciente en trabajo de parto, en fase activa, con 5cm de dilatación cervical y membranas rotas, presenta un registro estresante con presencia de una bradicardia fetal mantenida a cerca de 70 latidos por minuto, sin desaceleraciones ni aceleraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Iniciar aceleración oxitócica
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Realizar extracción con fórceps
- e) Realizar cesárea de urgencia

4) Son cambios del embarazo normal, EXCEPTO:

- a) Disminución del hematocrito
- b) Aumento de la frecuencia miccional
- c) Aparición de un soplo sistólico
- d) Trombocitopenia
- e) Aumento de la frecuencia cardíaca

5) Una paciente asintomática, cursando un embarazo de 28 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa, con 75 gramos por vía oral, obteniéndose una glicemia basal de 98 mg/dl y una glicemia a las 2 horas post sobrecarga de 190 mg/dl. Se le indica una dieta estricta, la que cumple parcialmente, manteniendo glicemias postprandiales cercanas a 170 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevo test de tolerancia a la glucosa
- b) Hospitalizar para asegurar el cumplimiento de la dieta
- c) Iniciar metformina
- d) Iniciar glibenclamida
- e) Iniciar insulina

6) Una paciente multipara de 2, cursando su tercer embarazo, con 33 semanas de gestación, presenta metrorragia abundante, con sangre roja brillante, sin otros síntomas. El registro cardíaco fetal resulta tranquilizador. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- b) Embarazo molar
- c) Placenta previa
- d) Rotura de vasa previa
- e) Rotura uterina

7) La fase latente del parto es la primera parte de la fase de dilatación y va desde el inicio del trabajo de parto hasta los 3 centímetros de dilatación cervical. Normalmente la fase latente dura:

- a) 10 horas en la primigesta y 5 horas en la múltipara
- b) 12 horas en la primigesta y 7 horas en la múltipara
- c) 16 horas en la primigesta y 12 horas en la múltipara
- d) 20 horas en la primigesta y 14 horas en la múltipara
- e) 48 horas en la primigesta y 24 horas en la múltipara

8) A diferencia de las molas parciales, que son triploides, las molas completas suelen ser diploides, pero todo el material genético es de origen paterno. ¿Qué manifestación NO es más frecuente en los embarazos molares completos?

- a) Hiperemesis gravídica
- b) Síndrome hipertensivo del embarazo
- c) Diabetes gestacional
- d) Quistes tecoluteínicos
- e) Hipertiroidismo

9) Una paciente hospitalizada por una preclamsia severa inicia dolor epigástrico intenso, asociado a ictericia. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Embolía de líquido amniótico
- b) Trombosis portal
- c) Síndrome de HELLP
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Hígado graso agudo del embarazo

10) Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 10 semanas, consulta por metrorragia, asociada a escaso dolor hipogástrico. La especuloscopia confirma que la sangre proviene de la cavidad endometrial. Se realiza una ecografía transvaginal que visualiza un saco gestacional indemne con un embrión de 3,5 mm, con presencia de latidos cardíofetales. La conducta MÁS adecuada es:

- a) Iniciar progestágenos orales
- b) Determinar presencia o ausencia de modificaciones cervicales
- c) Realizar un legrado uterino
- d) Solicitar un registro basal no estresante
- e) Enviar a domicilio con reposo

11) ¿Cuál de las siguientes presentaciones y posiciones tiene opción de parto vaginal?

- a) Presentación de cara en posición mentosacra
- b) Presentación de bregma en posición bregmoiliaca izquierda anterior
- c) Presentación de frente en posición nasopúbica
- d) Presentación de frente en posición nasosacra
- e) Presentación de nalgas en posición sacroilíaca derecha transversa

12) Respecto a la transfusión feto fetal es verdadero que:

- a) Se diagnostica mediante la ecografía doppler, que visualiza los vasos comunicantes entre ambos fetos
- b) Es característica de los embarazos gemelares bicoriales
- c) Es característica de los embarazos gemelares monoamnióticos
- d) Cada feto genera anticuerpos contra la sangre del otro, produciéndose hemólisis
- e) De no ser tratada, tiene una altísima mortalidad

13) Una mujer de 25 años, múltipara de 2, con partos anteriores por vía vaginal, presenta nuevo embarazo, que transcurre sin inconveniente hasta la semana 37 en que presenta salida de abundante líquido por genitales. La especuloscopia demuestra salida de líquido amniótico por el OCE, no presenta dinámica uterina y el cuello uterino está 50% borrado, sin dilatación. El feto se palpa en cefálica, sin alteraciones en la auscultación de LCF. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y antibióticos a la madre
- b) Realizar cesárea
- c) Dejar evolución espontánea
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar amniocentesis y decidir conducta según resultados

14) Una mujer presenta abundante metrorragia, luego del alumbramiento. Se palpa el útero retraído a la altura del ombligo. El diagnóstico más probable es:

- a) Inercia uterina
- b) Hematoma del canal vaginal
- c) Acretismo placentario
- d) Laceración del canal del parto
- e) Rotura uterina

15) Una paciente en trabajo de parto, con feto en presentación de vértice presenta dinámica uterina de 4 contracciones cada 10 minutos, dilatación cervical de 6 cm, con borramiento completo, membranas íntegras y cabeza fetal en espinas 0. Se evalúa a las 2 horas, sin presentar cambios y el monitoreo fetal es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aceleración oxitócica
- b) Realizar rotura de membranas
- c) Administrar misoprostol
- d) Realizar fórceps
- e) Realizar cesárea

16) Son causas de oligohidramnios, EXCEPTO:

- a) Preclamsia
- b) Atresia esofágica
- c) Rotura prematura ovular
- d) Uso de AINEs
- e) Insuficiencia placentaria

17) Una mujer embarazada de 30 semanas inicia dinámica uterina persistente, constatándose 3 contracciones cada 10 minutos. Se realiza tacto vaginal que muestra borramiento cervical del 50% y dilatación de 1 cm. El monitoreo fetal es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Administrar corticoides y antibióticos
- c) Administrar corticoides y tocolíticos
- d) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas
- e) Realizar cesárea

18) Una paciente de 23 años, cursando un embarazo de 32 semanas, con feto en cefálica, consulta por disminución de la percepción de los movimientos fetales, por lo que se realiza un registro basal no estresante que resulta no interpretable. Por esto se solicita un test de tolerancia a las contracciones, que demuestra presencia de desaceleraciones precoces (DIP 1) en la mayoría de las contracciones uterina, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- b) Solicitar un perfil biofísico
- c) Solicitar un eco-doppler de arterias umbilicales
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Tranquilizar a la paciente y enviar a domicilio

19) ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta de parto vaginal?

- a) Parto prematuro menor de 30 semanas
- b) Óbito fetal
- c) Infección intraamniótica
- d) Placenta previa
- e) Una cesárea anterior de tipo segmentaria

20) Una mujer embarazada en su décimo segunda semana acude a control obstétrico, donde se advierte que no se ha realizado Papanicolaou en los últimos 3 años. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar PAP inmediatamente
- b) Solicitar PAP luego del parto
- c) Solicitar PAP 6 semanas luego del parto
- d) Realizar colposcopia
- e) Solicitar biopsia endometrial

Prueba 4

1) Una paciente de 35 años presenta atraso menstrual de un mes, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Se encuentra asintomática y acude al ginecólogo, quien le realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza saco gestacional. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir el test de embarazo
- b) Realizar nueva ecografía en 24 horas
- c) Solicitar beta-HCG plasmática
- d) Administrar metotrexato
- e) Realizar legrado uterino

2) Una mujer de 19 años, primigesta, cursando embarazo de 30 semanas, presenta presión arterial de 156/98 mmHg en su control obstétrico. No presenta síntomas y la proteinuria cualitativa resulta +, sobre un máximo de 4+. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar alfa-metildopa
- b) Solicitar proteinuria cuantitativa, de 24 horas
- c) Solicitar hemograma, tiempos de coagulación, pruebas hepáticas, LDH, pruebas de función renal y proteinuria de 24 horas
- d) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
- e) Indicar semihospitalización y controlar la presión arterial frecuentemente, durante las próximas horas

3) ¿Cuál de las siguientes opciones supone un mayor riesgo de parto prematuro?

- a) Preclamsia
- b) Diabetes gestacional
- c) Parto prematuro previo
- d) Vaginosis bacteriana
- e) Primigesta

4) La primera ecografía obstétrica, que se realiza a mediados del primer trimestre, tiene como objetivo principal:

- a) Determinar el sexo del bebé
- b) Identificar los embarazos molares y ectópicos
- c) Detectar malformaciones fetales
- d) Evaluar el crecimiento fetal
- e) Confirmar la edad gestacional

5) Una paciente de 34 años, cursando embarazo de 8 semanas, consulta por metrorragia de 2 horas de evolución, con escaso dolor hipogástrico. Sus signos vitales son normales y presenta útero mayor al tamaño esperado para su edad gestacional, palpándose a la altura del pubis. La especuloscopia confirma que la sangre proviene de la cavidad endometrial. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar subunidad beta de gonadotrofina coriónica
- b) Realizar legrado uterino
- c) Realizar ecografía transvaginal
- d) Realizar registro basal no estresante
- e) Iniciar metotrexato

6) Una mujer de 40 años, cursando embarazo de 28 semanas, presenta un test de tolerancia a la glucosa, con 75 gramos de glucosa, demostrándose glicemia basal de 107 mg/dl y glicemia post sobrecarga de glucosa de 150 mg/dl. Se decide indicar dieta y ejercicios. Dos semanas después acude a control, constatándose glicemias basales de 90 mg/dl y postprandiales de 110 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener la dieta y ejercicio, controlando periódicamente
- b) Solicitar hemoglobina glicosilada y decidir manejo según resultado
- c) Iniciar metformina
- d) Iniciar insulina
- e) Solicitar nuevo test de tolerancia a la glucosa

7) Una mujer de 32 años, cursando embarazo de 37 semanas, diagnosticada de preclamsia severa, sin complicaciones, inicia contracciones uterinas intensas y frecuentes. Se constata dinámica uterina de 3 en 10 minutos y se palpa un cuello borrado en un 80%, con dilatación de 3 cm. El resto de su examen físico no aporta mayor información. El registro fetal no demuestra alteraciones. La conducta más adecuada, de entre las siguientes es:

- a) Administrar alfa-metildopa oral durante el trabajo de parto
- b) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
- c) Solicitar ecodoppler umbilical y de arterias uterinas
- d) Iniciar corticoides y tocolíticos
- e) Administrar hidralazina o labetalol por vía endovenosa

8) Una mujer de 30 años, cursando embarazo de 10 semanas, consulta por metrorragia, confirmada con especuloscopia. La ecografía transvaginal muestra un feto vivo, con saco gestacional indemne. El tacto vaginal no presenta modificaciones cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar y administrar tocolíticos
- b) Hospitalizar y observar hasta que la metrorragia ceda completamente
- c) Enviar a domicilio indicando reposo
- d) Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta
- e) Realizar legrado uterino

9) Un paciente de 23 años, multipara de uno, cursando un nuevo embarazo de 30 semanas inicia dinámica uterina persistente. Al examen físico se palpa feto en presentación cefálica, se constatan 4 contracciones cada 10 minutos y el tacto cervical demuestra borramiento de 50%, con dilatación cervical de 2 centímetros, con membranas íntegras. El registro fetal resulta tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos a la madre e iniciar tocolíticos
- b) Administrar corticoides y antibióticos a la madre
- c) Administrar tocolíticos y antibióticos a la madre
- d) Dejar a evolución espontánea
- e) Realizar cesárea

10) Una mujer de 38 años, multipara de 2, con ambos niños nacidos por cesárea, cursa su tercer embarazo, con 40 semanas. Consulta por dinámica uterina y luego salida de abundante líquido por genitales. Se constata dinámica uterina de 3 CU en 10 minutos, se palpa cuello completamente borrado, con 5 cm de dilatación y feto en presentación cefálica, en posición occipito ilíaca izquierda transversa en espinas -2. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar tocolíticos endovenosos
- b) Iniciar antibióticos endovenosos
- c) Dejar a evolución espontánea
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea

11) Una mujer de 26 años, primigesta, cursando embarazo de 30 semanas presenta pérdida de líquido claro por genitales, con olor a cloro. En el examen obstétrico no se detectan alteraciones. El test de cristalización muestra formación de "hojas de helecho" y el perfil biofísico resulta 10/10. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir el parto con misoprostol
- b) Realizar cesárea
- c) Administrar corticoides, antibióticos y tocolíticos
- d) Administrar corticoides y antibióticos e inducir el parto en 48 horas
- e) Administrar corticoides y antibióticos, manteniendo una conducta expectante.

12) Una mujer de 40 años, cursando su cuarto embarazo, de 12 semanas, presenta presión arterial cercana a 160/100 mmHg en varios controles. El resto del examen físico no presenta alteraciones y sólo presenta proteinuria cualitativa leve (una +). La ecografía obstétrica no presenta alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo molar
- b) Preclamsia moderada
- c) Hipertensión transitoria del embarazo
- d) Hipertensión arterial crónica
- e) Preclamsia leve

13) La diabetes gestacional se produce por:

- a) Aumento de la insulina fetal
- b) Aumento de la neoglucogénesis (conversión de proteínas en glucosa) en la placenta
- c) Disminución de la secreción de insulina pancreática, por efecto de la progesterona
- d) Aumento de hormonas de contrarregulación
- e) Aumento del consumo de glucosa por parte del feto y de la placenta

14) Una mujer, cursando embarazo de 35 semanas presenta metrorragia moderada, asociado a dolor abdominal. Al examen se aprecia hipertoniá uterina, sin modificaciones cervicales. La especuloscopia demuestra salida de sangre por el orificio cervical externo. El registro fetal constata variabilidad mínima, desaceleraciones variables y taquicardia fetal. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- b) Placenta previa
- c) Rotura de vasa previa
- d) Rotura uterina
- e) Aborto en evolución

15) Deben recibir profilaxis para Estreptococo betahemolítico grupo B, durante el trabajo de parto, todas las siguientes embarazadas, EXCEPTO:

- a) Primigesta de 17 años, sin antecedentes de importancia, en trabajo de parto prematuro de 35 semanas de edad gestacional
- b) Múltipara de 34 años, en trabajo de parto de 40 semanas, con antecedente de sepsis neonatal en de su parto anterior
- c) Múltipara de 28 años, sin antecedentes de importancia, cursando embarazo de 32 semanas, con RPO de 24 horas de evolución
- d) Primigesta con urocultivo positivo para SGB
- e) Múltipara, cesarizada anterior, cursando embarazo de 38 semanas, complicado con diabetes gestacional y preeclampsia moderada

16) El síntoma principal de la colestasia intrahepática del embarazo es:

- a) Prurito
- b) Coluria
- c) Ictericia
- d) Dolor
- e) Náuseas

17) Una mujer de 31 años, múltipara de uno, cursando embarazo de 37 semanas presenta rotura de membranas, sin iniciar el trabajo de parto. Al examen se palpa feto en presentación podálica y se constata ausencia de dinámica uterina y de modificaciones cervicales. En la especuloscopia se aprecia salida de escaso líquido por el OCE. Las pruebas de bienestar fetal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Inducir el parto con misoprostol
- b) Realizar cesárea
- c) Administrar corticoides y antibióticos, realizar amniocentesis y solicitar estudio de líquido amniótico y de exámenes generales a la madre.
- d) Administrar corticoides y antibióticos e inducir el parto en 48 horas
- e) Administrar corticoides y antibióticos, manteniendo una conducta expectante.

18) El principal objetivo del tratamiento del VIH durante el embarazo, a fin de evitar la transmisión al feto, es:

- a) Mantener el máximo nivel de linfocitos CD4+
- b) Evitar infecciones oportunistas
- c) Mantener niveles adecuados de antirretrovirales durante el parto
- d) Lograr cargas virales mínimas
- e) Negativizar el ELISA para VIH

19) Una mujer de 35 años presenta parto vaginal, persistiendo con abundante hemorragia luego del parto y del alumbramiento. Se palpa el fondo uterino entre la apófisis xifoides y el ombligo. El diagnóstico más probable es:

- a) Acretismo placentario
- b) Laceración del canal del parto
- c) Restos ovulares
- d) Rotura uterina
- e) Inercia uterina

20) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA?

- a) Huevo anembrionado – Aborto retenido
- b) Modificaciones cervicales – Aborto inevitable
- c) Quistes tecoluteínicos – Mola completa
- d) Metrorragia con hipotensión – Embarazo ectópico roto
- e) Incompetencia cervical – Abortos tempranos a repetición

Prueba 5

1) Una mujer de 25 años, primigesta, de 39 semanas de edad gestacional, inicia trabajo de parto. Es ingresada a la sala de parto, recibiendo anestesia epidural. En un control intraparto se palpa dinámica uterina 2 CU cada 10 minutos, con el cuello uterino completamente borrado, 7 cm de dilatación, membranas rotas, feto en presentación de vértice y posición OIIA, en el primer plano de Hodge. Dos horas después no presenta cambios. Las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar forceps
- b) Iniciar goteo oxitócico
- c) Realizar cesárea
- d) Iniciar antibióticos endovenosos
- e) Observar evolución

2) Una mujer de 29 años, cursando su segundo embarazo, de 30 semanas de gestación, consulta por metrorragia abundante, de color rojo brillante, sin otros síntomas. Al examen físico está taquicárdica y el registro cardiológico fetal es tranquilizador. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- c) Rotura de vasa previa
- d) Rotura uterina
- e) Embarazo molar

3) Una mujer de 39 años, cursando un embarazo de 8 semanas por amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal que no visualiza gestación intrauterina. Se solicitan niveles plasmáticos de beta-HCG, que resultan 1.000 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparoscopia
- b) Administrar metotrexato
- c) Solicitar nueva ecografía y nuevos niveles plasmáticos de beta-HCG en 2 días
- d) Solicitar nueva ecografía y nuevos niveles plasmáticos de beta-HCG en 7 días
- e) Observar evolución, indicando controles obstétricos habituales

4) Una mujer de 30 años, puérpera de 2 días, presenta dolor torácico y disnea, que iniciaron de una manera relativamente brusca. El examen físico sólo muestra taquicardia y los cambios esperables en una puérpera. La radiografía de tórax es normal, al igual que el electrocardiograma. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos endovenosos
- b) Solicitar troponinas plasmáticas
- c) Iniciar analgésicos y oxígeno en dosis bajas
- d) Solicitar angio-TAC de tórax
- e) Iniciar sulfato de magnesio

5) Una mujer de 36 años, cursando su tercer embarazo, de 34 semanas, presenta presión arterial de 148/96 mmHg en un control. Sus controles previos habían sido normales, por lo que se decide realizar varias tomas de presión arterial durante 6 horas, obteniéndose varias cifras tensionales mayores a 140/90 mmHg. La proteinuria cualitativa resulta + / ++++ y la cuantitativa resulta 150 mg en 24 horas. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión arterial crónica
- b) Hipertensión transitoria del embarazo
- c) Preclamsia
- d) Eclamsia
- e) Insuficiencia renal crónica

6) Una paciente de 35 años cursando un embarazo de 35 semanas presenta fiebre, sin otros síntomas ni hallazgos en el examen físico. Se solicita hemograma que muestra leucocitosis de 18.000 x mm³ y exámenes de orina que descartan infección urinaria. El registro basal no estresante resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- b) Iniciar paracetamol y observar evolución
- c) Iniciar amoxicilina oral
- d) Solicitar amniocentesis
- e) Interrumpir el embarazo bajo cobertura antibiótica con clindamicina y gentamicina

7) Una mujer embarazada, de 38 semanas de gestación se realiza un test de tolerancia a las contracciones que muestra frecuencia cardíaca fetal basal: 105 lpm, variabilidad 3 lpm, presencia de aceleraciones y presencia de desaceleraciones variables. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía doppler de arterias uterinas
- b) Solicitar ecografía doppler de arterias umbilicales
- c) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- d) Observar evolución, bajo monitorización con registro cardíaco fetal
- e) Solicitar perfil biofísico

8) Una mujer de 19 años, cursando su primer embarazo de 20 semanas de gestación, inicia dolor hipogástrico y metrorragia. Al examen físico se constata dilatación cervical de 3 cm y la ecografía muestra feto intrauterino, con latidos cardiorfetales presentes. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cerclaje de emergencia
- b) Administrar corticoides y tocolíticos
- c) Administrar corticoides y antibióticos
- d) Administrar progestágenos
- e) Conducir el trabajo de aborto

9) Una mujer de 26 años, sin antecedentes de importancia, cursando un embarazo de 33 semanas + 0 días, presenta salida de líquido claro abundante, por genitales. A la especuloscopia se observa salida de dicho líquido por el orificio cervical externo. No se observa dinámica uterina, se palpa el feto el presentación de vértice y el registro fetal es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos e interrumpir el embarazo en 7 días
- b) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos e interrumpir el embarazo en 48 horas con misoprostol
- c) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos y mantener una conducta expectante
- d) Interrumpir el embarazo inmediatamente
- e) Administrar corticoides, antibióticos y tocolíticos endovenosos y realizar cesárea e 2 días

10) Una mujer embarazada, de 35 semanas, presenta altura uterina menor a la esperada para la edad gestacional. Se solicita ecografía que muestra feto creciendo en percentil 2 para la edad gestacional, con oligohidramnios severo. La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo
- b) Solicitar ecografía doppler de arterias umbilicales y decidir conducta según hallazgos
- c) Observar evolución, indicando reposo en decúbito lateral izquierdo
- d) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- e) Realizar amniocentesis y estudio de líquido amniótico

11) Una paciente presenta embarazo de 8 semanas, complicado con hiperémesis gravídica. Consulta en este momento por metrorragia y además se palpa el útero por sobre el pubis. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo ectópico
- b) Embarazo gemelar
- c) Embarazo molar
- d) Aborto incompleto
- e) Aborto retenido

12) Una mujer embarazada consulta por disminución de la percepción de los movimientos fetales. Se solicita un registro basal no estresante por 20 minutos, que resulta “no reactivo”. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar perfil biofísico
- b) Alargar el registro por 20 minutos adicionales
- c) Tranquilizar y enviar a domicilio
- d) Solicitar test de tolerancia a las contracciones
- e) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

13) ¿Qué examen es más adecuado para determinar el pronóstico de un embarazo gemelar?

- a) Ecografía obstétrica del primer trimestre
- b) Ecografía obstétrica del segundo trimestre
- c) Ecografía obstétrica del tercer trimestre
- d) Ecografía doppler umbilical
- e) Ecografía doppler uterina

14) Una mujer está en trabajo de parto, en fase de expulsivo y se constata dinámica uterina de 3-4 CU cada 10 minutos y se palpa dilatación completa, con membranas rotas y feto en presentación de cara, con variante de posición mento-púbica, en espinas 0. La evolución del trabajo de parto, hasta entonces, ha sido satisfactoria y las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Iniciar aceleración oxitócica
- c) Permitir evolución del parto vaginal bajo monitorización
- d) Realizar fórceps
- e) Administrar tocolíticos

15) La primera causa de mortalidad materna en Chile, es actualmente:

- a) Aborto
- b) Hemorragia puerperal
- c) Síndromes hipertensivos del embarazo
- d) Sepsis puerperal
- e) Enfermedades intercurrentes

16) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante una mujer embarazada, diagnosticada de VIH?

- a) Indicar triterapia en caso de presentar linfocitos CD4 menores a 500 x mm³
- b) Indicar triterapia en caso de presentar linfocitos CD4 menores a 200 x mm³
- c) Indicar triterapia en caso de presentar enfermedades oportunistas
- d) Indicar triterapia desde el segundo trimestre, para lograr carga viral indetectable al momento del parto
- e) Indicar triterapia durante el trabajo de parto, para lograr niveles plasmáticos óptimos de antirretrovirales en el momento del expulsivo

17) La causa más frecuente de anemia durante el embarazo es:

- a) Metrorragia
- b) Déficit de vitamina B12
- c) Déficit de hierro
- d) Idiopática
- e) Hemolítica

18) Una paciente de 35 años, cursando embarazo de 35 semanas, consulta por contracciones uterinas persistentes. Al examen físico presenta 2 contracciones cada 10 minutos y al tacto vaginal presenta un cm de dilatación y borramiento de 50%, con membranas íntegras. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y tocolíticos
- b) Administrar tocolíticos
- c) Administrar tocolíticos y antibióticos de amplio espectro
- d) Administrar corticoides y antibióticos de amplio espectro
- e) Dejar a evolución espontánea

19) Una mujer embarazada, de 30 semanas consulta por disuria, sin otros síntomas. Se solicita sedimento de orina que muestra abundantes bacterias y leucocitos. El urocultivo está pendiente. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar tratamiento con cefadroxilo
- c) Iniciar tratamiento con ciprofloxacino
- d) Iniciar tratamiento con gentamicina
- e) Iniciar tratamiento con ceftriaxona

20) Un mujer cursando un embarazo de 35 semanas presenta malestar general, dolor abdominal alto y vómitos. Al examen físico se aprecia decaída, con ictericia, pulso: 90x', PA: 160/100 mmHg y auscultación cardiopulmonar normal. Se solicitan exámenes que muestran hematocrito: 30%, hemoglobina: 10 mg/dl, leucocitos: 11.000 x mm³, plaquetas: 50.000 x mm³, frotis: presencia de esquistocitos, bilirrubina: 4,3 mg/dl de predominio conjugado, GOT: 300 UI/l, GPT: 322 UI/l, GGT: 60 UI/l, creatinina: 2,0 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia de líquido amniótico
- b) Colestasia intrahepática del embarazo
- c) Hepatitis viral
- d) Hígado graso agudo del embarazo
- e) Síndrome de HELLP

Prueba 6

1) Una paciente de 19 años, cursando un embarazo de 30 semanas, consulta por compromiso del estado general. Al examen físico destaca edema de extremidades inferiores y presión arterial 160/100 mmHg. Se solicita proteinuria cualitativa que resulta ++ y cuantitativa que resulta 900 mg en 24 horas. El diagnóstico más probable es:

- a) Preclamsia
- b) Eclamsia
- c) Hipertensión arterial crónica esencial
- d) Hipertensión transitoria del embarazo
- e) Hipertensión arterial crónica secundaria

2) Una paciente, cursando un embarazo de 8 semanas por FUR, se realiza una ecografía transvaginal, que constata ausencia de gestación intrauterina, sin otras alteraciones. Se solicita beta-HCG que resulta 10.000 UI / litro. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver mediante laparoscopia
- b) Realizar laparotomía de urgencia
- c) Iniciar metotrexato
- d) Repetir la beta-HCG en 48 horas
- e) Repetir la ecografía en 48 horas

3) Una mujer de 40 años, cursando un embarazo de 35 semanas, se realiza una ecografía que muestra un feto creciendo en el percentil 5 para la edad gestacional, con índice cefálico/abdominal de 0,95. Las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras y el doppler umbilical es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar reposo y mantener una conducta expectante
- b) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- c) Realizar amniocentesis
- d) Administrar corticoides y antibióticos a la madre
- e) Inducir el parto con misoprostol

4) ¿Desde qué edad gestacional es posible ver el saco gestacional por una ecografía transvaginal?

- a) 4 semanas
- b) 5 semanas
- c) 6 semanas
- d) 7 semanas
- e) 8 semanas

5) ¿Cuál de las siguientes NO es una causa de polihidramnios?

- a) Malformaciones congénitas
- b) Diabetes gestacional
- c) Isoinmunización Rh
- d) Tumores placentarios
- e) Uso de AINEs

6) Una mujer de 35 años, cursando un embarazo de 34 semanas, se realiza un registro basal no estresante, que muestra una frecuencia cardíaca fetal en 150 lpm y variabilidad de 10 lpm, con presencia de 3 aceleraciones en relación a los movimientos fetales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar un perfil biofísico
- b) Solicitar un eco-doppler de arterias umbilicales
- c) Solicitar un eco-doppler de arterias uterinas
- d) Interrumpir el embarazo
- e) Enviar a domicilio

7) Una mujer de 24 años, cursando un embarazo de 37 semanas, consulta por salida de escaso líquido genital filante, con pequeñas estrías de sangre. El perfil biofísico es tranquilizador. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura prematura de membranas
- b) Rotura de vasa previa
- c) Placenta previa
- d) Desprendimiento de placenta
- e) Eliminación del tapón mucoso

8) ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo de una inercia uterina, que no responde a masaje?

- a) Labetalol
- b) Nifedipino
- c) Fenoterol
- d) Análogos de la oxitocina
- e) Sulfato de magnesio

9) Una mujer puérpera de 5 días, consulta por dolor mamario izquierdo y fiebre. Al examen se aprecia eritema de la piel de la mama. El tratamiento más adecuado es:

- a) Cloxacilina endovenosa
- b) Ceftriaxona endovenosa
- c) Metronidazol endovenoso
- d) Penicilina endovenosa
- e) Gentamicina endovenosa

10) Una paciente multipara de 3, cursa un nuevo embarazo de 41 + 6 semanas. Su examen físico es normal, al igual que las pruebas de bienestar fetal. No presenta dinámica uterina, ni modificaciones cervicales y se palpa el feto en presentación cefálica. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar ecografía doppler de arterias umbilicales
- c) Realizar cesárea
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Administrar ritodrina

11) El síntoma más frecuente del embarazo molar es:

- a) Hiperemesis
- b) Cefalea
- c) Dolor abdominal
- d) Metrorragia
- e) Hipertensión arterial

12) Una mujer cursando un embarazo de 10 semanas, consulta por metrorragia. A la especuloscopia se demuestra que la sangre proviene del OCE. Se realiza ecografía que muestra un embrión intrauterino vivo. El tacto vaginal no tiene cambios cervicales y la cervicometría muestra un cuello uterino de 3,5 cm de longitud. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, con reposo
- b) Solicitar beta-HCG plasmática
- c) Realizar legrado uterino
- d) Iniciar progestágenos orales
- e) Hospitalizar para observación

13) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 34 semanas consulta por prurito en las palmas de las manos, mayor en la noche. El examen físico es normal. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Dermatitis hormonal
- b) Embarazo molar
- c) Preclamsia
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Embarazo normal

14) Una paciente cursando un embarazo de 9 semanas por amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que determina una edad gestacional de 7 semanas. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener la edad gestacional de 9 semanas
- b) Cambiar la edad gestacional a 7 semanas
- c) Promediar ambas edades gestacionales y utilizar el resultado como la nueva edad gestacional
- d) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
- e) Realizar nueva ecografía a las 14 semanas por FUR

15) ¿Qué mujer requiere de profilaxis antibiótica durante el trabajo de parto?

- a) Mujer con eclampsia
- b) Mujer con bacteriuria asintomática por E. coli
- c) Mujer con antecedente de pielonefritis tratada
- d) Mujer con trabajo de parto a las 36 semanas de edad gestacional
- e) Mujer con RPO de término, de 3 horas de evolución

16) La asociación de metrorragia, contracciones uterinas e hipertensión uterina en una mujer embarazada de 34 semanas, hacen el diagnóstico de:

- a) Miometritis
- b) Embarazo molar
- c) Placenta previa
- d) Desprendimiento de placenta
- e) Rotura uterina

17) Una mujer consulta por disminución de la percepción de los movimientos fetales. Se realiza un perfil biofísico que resulta 6/10, con oligohidramnios marcado. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de tolerancia a las contracciones
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Realizar cesárea de urgencia
- d) Solicitar ecografía-doppler de arterias umbilicales
- e) Observar evolución

18) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y su manejo:

- a) RPO de 36 semanas – Interrupción del embarazo
- b) RPO de 30 semanas – Corticoides y antibióticos y mantener conducta expectante
- c) Parto prematuro de 30 semanas – Corticoides y tocolíticos
- d) Parto prematuro de 36 semanas – Tocolíticos, sin necesidad de corticoides
- e) RPO más parto prematuro de 32 semanas – Antibióticos y corticoides, sin usar tocolíticos

19) El aumento del grosor de la translucencia nuchal fetal se asocia a:

- a) Defectos del tubo neural
- b) Síndrome de Down
- c) Infecciones congénitas
- d) Isoinmunización Rh
- e) Parálisis cerebral

20) Una mujer primigesta, está en trabajo de parto, en fase activa, con 2 contracciones uterinas cada 10 minutos. Se palpa el feto en presentación de frente, en variante nasopúbica, con dilatación de 7 cms, membranas íntegras y registro tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar rotura de membranas
- b) Iniciar goteo oxitócico
- c) Realizar rotación manual
- d) Dejar evolución espontánea bajo monitoreo
- e) Realizar cesárea

Prueba 7

1) Un paciente de 35 años, cursando un embarazo de 36 semanas, consulta por salida de abundante líquido genital, transparente, hace una hora. Al examen físico se palpa un feto en presentación podálica, sin contracciones uterinas. Se realiza una especuloscopia que muestra salida de líquido claro por el orificio cervical externo y el tacto vaginal muestra un cuello duro, cerrado. Las pruebas de bienestar fetal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Administrar corticoides endovenosos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- d) Mantener una conducta expectante, administrando corticoides y antibióticos endovenosos
- e) Dejar a evolución espontánea

2) Una paciente de 20 años, multipara de 1, con antecedente de parto prematuro a las 33 semanas, cursa un nuevo embarazo, de 32 semanas. Inicia contracciones uterinas de 3 en 10 minutos, persistentes, y el tacto vaginal muestra dilatación cervical de 1 cm, con borramiento del 50% y membranas íntegras. El feto está en cefálica, con registro cardíaco tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Administrar corticoides y antibióticos
- c) Administrar corticoides y tocolíticos
- d) Administrar corticoides y realizar cerclaje de urgencia
- e) Dejar a evolución espontánea

3) Una mujer de 35 años, cursando un embarazo de 30 semanas consulta por fiebre malestar general y leucorrea. Al examen físico está taquicárdica, febril, con dolor a la palpación uterina. El examen genital no muestra cambios cervicales y se aprecia escasa leucorrea que proviene del OCE. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar amniocentesis y solicitar estudio del líquido amniótico
- b) Administrar corticoides y antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
- c) Administrar antibióticos de amplio espectro e interrumpir el embarazo por cesárea
- d) Administrar penicilina endovenosa, durante el trabajo de parto
- e) Administrar gentamicina, clindamicina y dexametasona e inducir el parto en 48 horas con misoprostol

4) Una mujer de 24 años, con un embarazo de 40 semanas, inicia dinámica uterina. Al examen físico se palpan 4 contracciones cada 10 minutos, con tacto vaginal con dilatación de 8 cm, borramiento completo, membranas rotas y feto en presentación de frente, naso-ilíaca izquierda anterior. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolucionar bajo monitoreo cardiotocográfico
- b) Realizar prueba de parto
- c) Realizar rotación manual a posición naso-sacra
- d) Realizar rotación manual a posición naso-púbica
- e) Realizar cesárea

5) Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 39 semanas, más 3 días, consulta por dinámica uterina persistente, asociada a salida de líquido por genitales. Al examen físico está en buenas condiciones genitales, con 4 contracciones uterinas cada 20 minutos. El cuello uterino está completamente borrado y presenta 10 cm de dilatación, con membranas rotas. El feto se palpa en presentación de vértice, en espaldas -2. Se inicia aceleración oxitócica, logrando 4 contracciones cada 10 minutos y se administra la anestesia epidural, sin embargo la cabeza fetal persiste en espaldas -2 luego de 2 horas de observación. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar forceps
- b) Realizar cesárea
- c) Observar evolución
- d) Aumentar el goteo oxitócico
- e) Suspender el goteo oxitócico

6) Una mujer, cursando un embarazo de 6 semanas, consulta por metrorragia. La ecografía transvaginal muestra un feto intrauterino, con presencia de latidos cardíofetales y el tacto vaginal no muestra cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar legrado
- b) Administrar metotrexato
- c) Hospitalizar, para el manejo médico de la metrorragia
- d) Solicitar niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana
- e) Enviar a domicilio, indicando reposo

7) Una mujer de 20 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por cefalea y malestar general. Al examen físico presenta FC: 105x', PA: 150/100 mmHg, edema de extremidades inferiores y reflejos osteotendíneos exaltados. El diagnóstico más probable es:

- a) Embolia de líquido amniótico
- b) Síndrome de HELLP
- c) Preclamsia severa
- d) Insuficiencia cardíaca descompensada
- e) Colestasia intrahepática del embarazo

8) En un registro cardíaco fetal, durante un trabajo de parto se observan desaceleraciones de 30 lpm de amplitud, con presencia de una aceleración inmediatamente antes e inmediatamente después de la desaceleración. La etiología de este fenómeno es:

- a) Compresión de la cabeza fetal
- b) Compresión del cordón umbilical
- c) Isquemia fetal
- d) Descarga vagal fetal
- e) Descarga vagal materna

9) Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 7 semanas por amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que no muestra gestación intrauterina. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar una nueva ecografía en 7 días
- b) Indicar metotrexato
- c) Realizar laparoscopia
- d) Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta de HCG
- e) Solicitar nueva ecografía a las 28 semanas de gestación

10) La conducta más adecuada frente a una paciente de 31 semanas de edad gestacional, que presenta una rotura prematura de membranas, es:

- a) Realizar cesárea
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos y mantener una conducta expectante
- d) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos e inducir el parto en 48 horas
- e) Administrar corticoides y tocolíticos e inducir el parto en 48 horas

11) La colestasia intrahepática del embarazo se caracteriza por prurito palmoplantar, que aparece en las últimas semanas del embarazo. Su importancia radica principalmente en que:

- a) Aumenta el riesgo de preclamsia
- b) Se asocia a malformaciones fetales
- c) Se asocia a parto prematuro
- d) Se asocia a muerte fetal intrauterina
- e) Aumenta el riesgo de muerte materna

12) ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta del parto vaginal?

- a) Embarazo gemelar
- b) Edad gestacional menor a 30 semanas
- c) Placenta previa oclusiva
- d) Eclampsia
- e) Miomatosis uterina

13) El síntoma más frecuente del embarazo molar es:

- a) Náuseas y vómitos
- b) Hipertensión arterial
- c) Metrorragia
- d) Dolor
- e) Edema

14) Una mujer de 28 años, cursando un embarazo de 35 semanas de edad gestacional, se realiza un cultivo vaginal, que resulta positivo para estreptococo beta hemolítico grupo B. Está asintomática. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar penicilina benzatina semanal por lo que reste de embarazo
- b) Administrar ampicilina endovenosa durante el trabajo de parto
- c) Administrar penicilina y metronidazol durante el trabajo de parto
- d) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos y mantener una conducta expectante
- e) Realizar cesárea

15) Una paciente se realiza un RBNE que resulta no reactivo, por lo que se decide realizar un test de tolerancia a las contracciones, que muestra FCF: 140 x', con variabilidad normal y presencia de desaceleraciones precoces, en espejo con las contracciones uterinas. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar prueba de parto
- c) Solicitar ecografía-Doppler de arterias umbilicales
- d) Solicitar perfil biofísico
- e) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

16) Una mujer embarazada de 35 semanas, presenta altura uterina menor a la esperada, por lo que se decide realizar un ecografía obstétrica, que muestra un feto en presentación cefálica, creciendo en el percentil 5 para la edad gestacional, asociada a oligohidramnios absoluto. El registro basal no estresante es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Interrumpir el embarazo con misoprostol
- c) Solicitar ecografía-doppler de arterias umbilicales
- d) Indicar reposo y observar evolución
- e) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas

17) Una paciente, con embarazo de 36 semanas de edad gestacional, presenta metrorragia oscura, asociada a contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se constata hipertensión uterina y el registro fetal muestra bradicardia. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de vasa previa
- b) Rotura uterina
- c) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- d) Placenta previa marginal
- e) Placenta previa oclusiva

18) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 28 semanas se realiza un TTOG con 75 g de glucosa, que resulta 180 mg/dl a las 2 horas post-carga. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar hemoglobina glicosilada y decidir manejo según resultados
- c) Iniciar dieta y ejercicios
- d) Iniciar glibenclamida
- e) Iniciar insulina

19) Una mujer de 45 años, usuaria de DIU, presenta un atraso menstrual, por lo que decide realizarse una prueba de embarazo, que resulta positiva. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar especuloscopia para el retiro del DIU
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Realizar legrado uterino
- d) Administrar antibióticos durante el embarazo
- e) Observar evolución

20) Una mujer de 38 años, cursando un embarazo de 12 semanas, presenta presión arterial de 160/100 mmHg. Se solicita proteinuria cualitativa, que resulta ++/++++. El diagnóstico más probable es:

- a) Preclamsia
- b) Hipertensión crónica
- c) Hipertensión transitoria
- d) Insuficiencia renal
- e) Embarazo molar

Prueba 8

Ver GINECOLOGÍA Prueba 3

Prueba 9

Ver GINECOLOGÍA Prueba 4

Prueba 10

Ver GINECOLOGÍA Prueba 9

OBSTETRICIA RESPUESTAS

Prueba 1	5 C	9 C	14 A	17 C	
1 C	6 E	10 B	15 E	18 E	Prueba 7
2 C	7 E	11 B	16 A	19 B	1 A
3 D	8 B	12 E	17 B	20 E	2 C
4 E	9 D	13 D	18 D		3 C
5 B	10 D	14 D	19 E	Prueba 6	4 E
6 A	11 B	15 B	20 E	1 A	5 B
7 B	12 A	16 B		2 A	6 E
8 D	13 A	17 C	Prueba 5	3 A	7 C
9 A	14 E	18 E	1 B	4 B	8 B
10 C	15 A	19 D	2 A	5 E	9 D
11 D	16 E	20 A	3 C	6 E	10 C
12 B	17 A		4 D	7 E	11 D
13 D	18 C	Prueba 4	5 B	8 D	12 C
14 B	19 C	1 C	6 D	9 A	13 C
15 D	20 A	2 E	7 C	10 D	14 B
16 D		3 C	8 E	11 D	15 A
17 D		4 E	9 B	12 A	16 B
18 A	Prueba 3	5 C	10 A	13 D	17 C
19 C	1 C	6 A	11 C	14 B	18 C
20 D	2 A	7 B	12 B	15 D	19 A
	3 E	8 C	13 A	16 D	20 B
	4 D	9 A	14 C	17 C	
Prueba 2	5 E	10 E	15 C	18 D	
1 C	6 C	11 E	16 D	19 B	
2 B	7 D	12 D		20 E	
3 E	8 C	13 D			
4 A					

III) COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRUEBAS GRANDES

Prueba 1 (PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA)

1) Respecto a la hemofilia es FALSO que:

- a) Suele presentar hipermenorrea
- b) Los tiempos de coagulación suelen estar alterados
- c) En una enfermedad hereditaria, ligada al sexo
- d) Las hemartrosis y los hematomas profundos orientan al diagnóstico
- e) Las plaquetas suelen ser normales

2) Una paciente de 33 años, asintomática, cursando un embarazo, con 5 semanas de amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal que no visualiza saco gestacional, por lo que se solicita gonadotropina coriónica humana, que resulta 2.100 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva ecografía en 48 horas
- b) Solicitar nueva gonadotropina coriónica en 48 horas
- c) Realizar legrado uterino
- d) Iniciar metotrexato
- e) Realizar histerectomía y anexectomías

3) Un lactante de 5 meses de edad presenta vómitos y diarrea acuosa explosiva, asociado a compromiso del estado general. Al examen físico se aprecia soporoso y deshidratado, con mucosas secas y ojos hundidos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar sales de rehidratación oral según plan A
- b) Iniciar sales de rehidratación según un esquema preciso y reevaluar en 4 a 6 horas
- c) Administrar un bolo de suero fisiológico por vía endovenosa
- d) Iniciar antibióticos orales y sales de rehidratación oral según plan B
- e) Iniciar antibióticos endovenosos y administrar cristaloides endovenosos

4) Es causa de hipermenorrea:

- a) Cáncer de endometrio
- b) Endometriosis
- c) Proceso inflamatorio pélvico
- d) Útero septado
- e) Hiperplasia endometrial

5) Un niño de 7 años es el más bajo del curso. Su padre mide 1,87 m y su madre 1,70 m. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de carpo
- b) Solicitar testosterona y gonadotropinas plasmáticas
- c) Solicitar cariograma
- d) Revisar la curva de crecimiento
- e) Solicitar test de Sudán

6) Mujer de 35 años, cesarizada anterior, cursando un nuevo embarazo de término, inicia trabajo de parto y 2 horas después evoluciona con intenso dolor abdominal y metrorragia escasa, asociada a hipotensión. El monitoreo fetal muestra bradicardia fetal sostenida. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- b) Rotura de vasa previa
- c) Embolía de líquido amniótico
- d) Placenta previa
- e) Rotura uterina

7) Un niño de 6 años presenta edema facial y de extremidades inferiores, asociado a hematuria. Al examen físico se aprecia pálido, con presión arterial elevada. Se solicitan exámenes donde destacan creatinina plasmática: 1,2 mg/dl, proteinuria ++ (de un máximo de ++++), sedimento de orina con hematuria dismórfica y cilindros eritrocitarios, complemento bajo. El diagnóstico más probable es:

- a) Nefrosis lipoidea
- b) Enfermedad de Berger
- c) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- d) Síndrome hemolítico urémico
- e) Acidosis tubular renal

8) Una mujer de 30 años, sin antecedentes de importancia, presenta amenorrea de 90 días de evolución. El examen físico no presenta alteraciones y el test de embarazo resulta negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía transvaginal
- b) Iniciar anticonceptivos orales
- c) Solicitar TSH, prolactina y prueba de progesterona
- d) Solicitar prueba de progesterona y prueba de estrógenos más progesterona
- e) Solicitar niveles plasmáticos de FSH, LH, estrógenos y progesterona

9) La primera causa de muerte fetal tardía es:

- a) Alteraciones genéticas
- b) Cardiopatías congénitas
- c) Accidentes de placenta y de cordón umbilical
- d) Síndrome hipertensivo del embarazo
- e) Infecciones intraamnióticas

10) Un lactante de 35 días de vida, presenta ictericia desde hace 7 días, sin otros síntomas. ¿Qué examen(es) es (son) más importante(s) para continuar el estudio?

- a) Hemograma y grupo ABO y Rh
- b) Hemograma y prueba de Coombs directo
- c) Bilirrubina total y directa
- d) Ecografía abdominal
- e) Hormona tiroestimulante y prueba de Coombs indirecto

11) Una paciente embarazada, de 36 semanas, consulta por disminución de la percepción de los movimientos fetales. Se solicita un registro basal no estresante de 20 minutos de duración, que muestra frecuencia cardíaca fetal de 130x', con variabilidad de 10 lpm, sin aceleraciones ni desaceleraciones, a pesar de percibir algunos movimientos fetales. La conducta más adecuada:

- a) Tranquilizar a la madre y enviar a domicilio
- b) Prolongar el monitoreo por 20 minutos más
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Solicitar ecodoppler de arterias umbilicales
- e) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

12) ¿Qué tratamiento antibiótico es más adecuado para un recién nacido de 3 días de vida con sospecha de una sepsis neonatal?

- a) Penicilina en dosis altas
- b) Clindamicina + gentamicina
- c) Ceftriaxona + vancomicina
- d) Cefazolina + metronidazol
- e) Cefotaximo + ampicilina

13) El pensamiento del escolar se caracteriza por ser

- a) Mágico
- b) Concreto
- c) Incoherente
- d) Apodíptico
- e) Abstracto

14) Un niño de 8 años con antecedente de asma severo, en tratamiento actual con salbutamol, ipratropio, salmeterol, fluticasona, prednisona y montelukast, acude al servicio de urgencias por cuadro de tos y disnea. Al examen físico se aprecia taquipneico, con uso de musculatura accesoria y habla con palabras entrecortadas. Se auscultan sibilancias inspiratorias y espiratorias bilaterales y satura 90% a FiO2 ambiental. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar set de nebulizaciones con salbutamol y enviar a domicilio aumentando la dosis de prednisona
- b) Iniciar oxígeno, realizar set de nebulizaciones con salbutamol, administrar dexametasona endovenosa y reevaluar en una hora, enviando a domicilio en caso de buena respuesta
- c) Hospitalizar, iniciar oxígeno, nebulizar con salbutamol, iniciar antibióticos endovenosos y reevaluar periódicamente
- d) Hospitalizar, iniciar oxígeno, nebulizar con salbutamol, administrar corticoides endovenosos y reevaluar periódicamente
- e) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilación mecánica

15) Una mujer de 34 años presenta un tumor anexial izquierdo detectado en un examen ginecológico de rutina y confirmado con ecografía transvaginal, que demuestra una lesión ovárica, quística de 5 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución, sin necesidad de mayor estudio
- b) Iniciar anticonceptivos orales y solicitar nueva ecografía en 3 meses
- c) Solicitar biopsia por punción
- d) Realizar tumorectomía laparoscópica y biopsias
- e) Realizar anexectomía laparoscópica y biopsias

16) Una paciente, cursando embarazo de 30 semanas, iniciar contracciones uterinas persistentes. Al examen físico se palpa feto en cefálica, se aprecian contracciones uterinas intensas, de 3 en 10 minutos y se palpa cuello uterino con 50% de borramiento y 1 cm de dilatación, con membranas íntegras. El monitoreo fetal es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Administrar corticoides y antibióticos
- c) Administrar corticoides y tocolíticos
- d) Administrar corticoides, antibióticos y tocolíticos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- e) Realizar cesárea de urgencia

17) Un niño de 6 años presenta fiebre, odinofagia leve y un exantema que compromete las mejillas y luego se extiende al tronco y a las extremidades, apareciendo como un rash macular eritematoso con tendencia a confluir en patrón reticular. EL diagnóstico más probable es:

- a) Sarampión
- b) Eritema infeccioso
- c) Exantema súbito
- d) Rubeola
- e) Escarlatina

18) Un recién nacido, con antecedente de asfixia neonatal recuperada, presenta al tercer día de vida vómitos y deposiciones con sangre. Al examen físico se observa irritable y con el abdomen distendido. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Hirschsprung
- b) Enterocolitis necrotizante
- c) Intususcepción intestinal
- d) Divertículo de Meckel
- e) Deglución de sangre materna

19) Una mujer de 30 años, asintomática, se realiza un Papanicolaou que es informado como satisfactorio, con presencia de células displásicas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar PCR para virus papiloma humano
- b) Solicitar nuevo Papanicolaou en 6 meses
- c) Solicitar colposcopia y biopsias
- d) Realizar curetaje endocervical
- e) Realizar cono cervical

20) Un recién nacido de 37 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria luego del nacimiento. Al examen físico se aprecia aleteo nasal, cianosis y taquipnea, asociados a una marcada excavación abdominal. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Taquipnea transitoria
- c) Cardiopatía congénita
- d) Hernia diafragmática
- e) Lesión del plexo braquial, con parálisis del nervio frénico

21) Son causas de polihidroamnios, EXCEPTO:

- a) Diabetes gestacional
- b) Preclamsia
- c) Atresia esofágica
- d) Isoinmunización Rh
- e) Corioangioma placentario

22) Un niño de 15 meses ha presentado múltiples otitis medias y neumonías desde los 9 meses de edad. Actualmente cursa con una meningitis bacteriana, con buena respuesta al tratamiento antibiótico. ¿Qué tipo de inmunodeficiencia es la más probable?

- a) Déficit de IgG
- b) Inmunodeficiencia combinada severa
- c) Déficit de complemento
- d) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- e) Alteración de la fagocitosis

23) La primera causa de artritis en la edad pediátrica es:

- a) Viral
- b) Enfermedad de Still
- c) Reactiva
- d) Traumática
- e) Séptica

24) Una paciente de 50 años presenta un nódulo mamario derecho de consistencia dura, de lento crecimiento, asociado a inversión del pezón y secreción hemática en algunas oportunidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Papiloma
- b) Cáncer de mama
- c) Fibroadenoma
- d) Quiste simple
- e) Mastopatía fibroquística

25) ¿Qué vacuna(s) recibe un niño en segundo básico?

- a) Trivírica
- b) DPT y polio
- c) BCG y trivírica
- d) DT
- e) Trivírica y polio

26) Son factores de riesgo de rotura prematura ovular, EXCEPTO:

- a) Parto prematuro previo
- b) Polihidramnios
- c) Embarazo gemelar
- d) Primigesta
- e) Infección intraamniótica

27) Un paciente de 5 años presenta tos con expectoración, asociada fiebre hasta 38,9°C de 48 horas de evolución. La expectoración es mucopurulenta, sin sangre. Al examen físico está un buenas condiciones generales, febril, con pulso y presión arterial normales, se auscultan crépitos en la base pulmonar izquierda y satura 96% a FiO2 ambiental. Se solicita radiografía de tórax que demuestra una condensación en el lóbulo inferior izquierdo. El tratamiento de elección es:

- a) Sintomático
- b) Amoxicilina
- c) Ceftriaxona
- d) Eritromicina
- e) Clindamicina

28) Una paciente de 28 años, con dismenorrea crónica de 2 años de evolución, refiere que sus síntomas se han hecho cada vez más intensos y se ha agregado dispareunia profunda en los últimos meses. No presenta otros síntomas. La especuloscopia es normal y al tacto vaginal destaca dolor a la movilización cervical, siendo ésta difícil de realizar. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Cáncer de cuello uterino
- b) Proceso inflamatorio pélvico
- c) Endometriosis
- d) Cáncer de endometrio
- e) Adenomiosis

29) Un niño es capaz de sentarse con apoyo, pasar objetos de una mano a la otra y pronunciar algunos monosílabos. La edad aproximada es:

- a) 2 meses
- b) 4 meses
- c) 6 meses
- d) 8 meses
- e) 10 meses

30) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es considerado como normal en un recién nacido?

- a) Soplo diastólico
- b) Hipertonía en flexión
- c) Signo de Ortolani
- d) Púrpura equimótico
- e) Fontanela anterior cerrada

31) Respecto al retraso del crecimiento intrauterino es VERDADERO que:

- a) En caso de no existir complicaciones debe interrumpirse a las 40 semanas de gestación
- b) El oligohidroamnios es un criterio de interrupción
- c) Debe hospitalizarse toda gestación con peso fetal en percentil 10 o menor para la edad gestacional
- d) Debe seguirse con ecodoppler de arterias umbilicales cada 2 o 3 días
- e) Debe manejarse con reposo, corticoides, antibióticos y tocolíticos

32) Un niño de 4 años se traga una bolita de cristal, evolucionando con dolor torácico, imposibilidad de tragar y sialorrea. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución sin necesidad de mayor estudio
- b) Controlar con radiografías cada 24 horas
- c) Revisar las deposiciones diariamente hasta que aparezca la bolita
- d) Retirar el cuerpo extraño por vía endoscópica
- e) Resolver quirúrgicamente

33) El síntoma más habitual del cáncer de ovario es:

- a) Metrorragia
- b) Dolor abdominal inespecífico
- c) Hipermenorrea
- d) Amenorrea
- e) Dispareunia

34) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la alimentación del recién nacido y del lactante, que no recibe lactancia materna?

- a) Al nacimiento debe alimentarse con una fórmula de inicio o bien con leche purita fortificada al 7,5% más aceite al 1,5% y azúcar al 2,5%
- b) Al nacer es recomendable iniciar con cantidades pequeñas de leche e ir aumentándolas progresivamente, hasta los 7 días de vida
- c) A medida que el lactante crece va disminuyendo la cantidad de leche que requiere por kilogramo de peso
- d) Luego de los 5 a 6 meses de edad se puede iniciar la alimentación con carnes, verduras y frutas
- e) Luego de los 6 meses de edad debe recibir alimentación láctea con una fórmula especial o bien con leche purita fortificada al 10% más aceite al 3% y azúcar al 5%

35) Son indicaciones absolutas de cesárea EXCEPTO:

- a) Placenta previa
- b) Presentación podálica
- c) Dos cesáreas anteriores
- d) Eclampsia
- e) Herpes genital activo

36) Un niño de 5 años presenta IPT: +1,5 DS, IPE: +2,3 DS, ITE: +1,3 DS. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición
- b) Eutrofia
- c) Sobrepeso
- d) Obesidad
- e) Obesidad mórbida

37) Una paciente consulta por disuria intensa y leucorrea abundante. Al examen físico se aprecian marcados signos inflamatorios de la pared vaginal, con algunas Petequias y leucorrea verdosa abundante. El agente causal más probable es:

- a) Gonococo
- b) Chlamydia
- c) Cándida albicans
- d) Trichomona vaginalis
- e) Gardnerella vaginalis

38) Un niño de 7 años es traído por cefalea y fiebre de 1 día de evolución. Al examen físico destacan rigidez de nuca y signo de Brudzinski, por lo que se decide realizar punción lumbar, que da salida a un líquido claro, con 98 células por mm³, con 90% de mononucleares, proteínas de 60 mg/dl y glucosa normal. El agente etiológico más probable es:

- a) Meningococo
- b) Neumococo
- c) Bacilo de Koch
- d) Enterovirus
- e) Virus herpes simplex

39) Una mujer embarazada de 38 semanas, en trabajo de parto, con 3 contracciones uterinas cada 10 minutos, presenta un registro fetal estresante con presencia de desaceleraciones luego de la mayoría de las contracciones uterinas, con un decalaje respecto de ellas, de alrededor de 20 segundos. El tacto vaginal demuestra feto en presentación de vértice, en posición occipito-iliaca anterior, en espinas cero, con dilatación cervical de 10 cm, borramiento del 100% y membranas rotas. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Iniciar aceleración occitócica
- c) Administrar un tocolítico y oxígeno al 100%
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea de urgencia

40) Una paciente puérpera de 2 días presenta aumento de volumen muy doloroso y eritematoso en relación a la axila derecha. Al examen físico se aprecia una tumoración de 4 cm de diámetro, en el borde anterior de la axila, muy dolorosa a la palpación, de bordes fáciles de definir y escaso eritema en la piel circundante. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar analgésico orales y observar evolución
- b) Iniciar antibióticos orales, con cobertura para Staphylococcus aureus
- c) Iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
- d) Realizar biopsia por punción
- e) Suspender la lactancia materna y resolver quirúrgicamente

41) Un recién nacido, cursando una diarrea aguda, evoluciona con anuria. Se solicitan exámenes entre los que destacan creatininemia de 2,6 mg/dl, BUN: 40 mg/dl, pH sanguíneo de 7,25, sodio plasmático de 150 mEq/l, potasio plasmático de 5,8 mEq/l, sodio urinario de 5 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal aguda prerrenal con deshidratación hiperosmolar, hiperkalemia y acidosis metabólica
- b) Insuficiencia renal aguda prerrenal con deshidratación hipoosmolar, hiperkalemia y acidosis metabólica
- c) Insuficiencia renal aguda prerrenal con deshidratación hiperosmolar, hiperkalemia y acidosis respiratoria
- d) Necrosis tubular aguda con deshidratación hiperosmolar, hiperkalemia y acidosis metabólica
- e) Necrosis tubular aguda con deshidratación hipoosmolar, hiperkalemia y acidosis respiratoria

42) Una mujer cursando embarazo de 35 semanas, inicia contracciones uterinas dolorosas y metrorragia oscura. La especuloscopia demuestra salida de sangre por el orificio cervical externo y el monitoreo fetal resulta sospechoso por presencia de desaceleraciones variables. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de vasa previa
- b) Rotura uterina
- c) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- d) Placenta previa
- e) Inercia uterina

43) Un niño de 4 años presenta baja de peso, asociada a diarrea crónica, de aspecto brillante, con gotas de grasa. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta sin gluten
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- c) Solicitar colonoscopia
- d) Solicitar test de D-xilosa
- e) Solicitar test de grasas en deposiciones

44) Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen presentar todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Oligomenorrea
- b) Resistencia a la insulina
- c) Andrógenos altos
- d) Estrógenos bajos
- e) Progesterona baja

45) ¿Qué afirmación es FALSA sobre la diabetes mellitus gestacional?

- a) Se produce por un aumento de las hormonas de contrarregulación
- b) Su tratamiento inicial suele ser con dieta y ejercicios
- c) Se diagnostica mediante dos glicemias de ayuno sobre 105
- d) Se diagnostica mediante un test de tolerancia a la glucosa, con una glicemia mayor a 140, a las dos horas luego de una sobrecarga oral de 75 g de glucosa
- e) Se deben mantener glicemias basales bajo 100 mg/dl y glicemias postprandiales bajo 180 mg/dl

46) Un recién nacido prematuro tendrá más riesgo de presentar:

- a) Coartación aórtica
- b) Poliglobulia
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Displasia de cadera
- e) Sepsis neonatal

47) Es una contraindicación de la terapia de reemplazo hormonal en una mujer de 50 años:

- a) Osteoporosis
- b) Nuliparidad
- c) Hábito tabáquico
- d) Antecedente de cáncer de cuello uterino operado
- e) Histerectomía

48) Una mujer cursando el tercer trimestre de embarazo presenta máculas hiperpigmentadas en las mejillas, indoloras, sin signos inflamatorios. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Insuficiencia suprarrenal primaria
- b) Cloasma
- c) Lupus
- d) Embarazo molar
- e) Herpes gestacional

49) En un examen de rutina no se palpan, en primera instancia, los testículos de un lactante. Sin embargo al examinar bien se constata que están a la salida del conducto inguinal y que es fácil descenderlos hasta el escroto, pero al soltarlos vuelven a su posición inicial. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar ecografía inguinoescrotal
- c) Solicitar cariógrama
- d) Resolver quirúrgicamente durante el segundo año de vida
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

50) ¿Qué método anticonceptivo aconsejaría a una mujer de 27 años, casada, multípara de 2, alérgica al látex y con marcados antecedentes familiares de cáncer de mama?

- a) Preservativo
- b) Anticonceptivos orales
- c) Anticonceptivos por vía transdérmica
- d) Dispositivo intrauterino
- e) Anticonceptivos inyectables

51) Un recién nacido de 14 horas de vida presenta ictericia en la cara y el tronco, sin otras alteraciones. Su madre es de grupo sanguíneo A (II), Rh negativo y él es de grupo O (IV), Rh positivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- b) Hemólisis por incompatibilidad Rh
- c) Atresia biliar primaria
- d) Síndrome de Gilbert
- e) Ictericia fisiológica

52) Una mujer de 37 años queda embarazada, usando un dispositivo intrauterino. La especuloscopia visualiza las guías del DIU y la ecografía transvaginal demuestra la presencia de un pequeño saco gestacional en el fondo uterino y la presencia del DIU más abajo. La conducta más adecuada frente a esta paciente es:

- a) Hacer un legrado
- b) Retirar el dispositivo intrauterino
- c) Iniciar progestágenos
- d) Indicar antibióticos durante el embarazo
- e) Mantener una conducta expectante

53) ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas se acompaña de cianosis?

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular
- c) Ventrículo único
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Coartación aórtica

54) Una mujer de 29 años, cursando un embarazo de 33 semanas y 1 día, presenta salida de líquido abundante por la zona genital. No presenta dinámica uterina ni modificaciones cervicales y se palpa el feto en presentación cefálica. El test de cristalización confirma la presencia de líquido amniótico en el canal vaginal y el monitoreo fetal es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Inducir el parto con misoprostol de inmediato
- c) Administrar corticoides y antibióticos e inducir el parto con misoprostol en 2 días
- d) Administrar corticoides y antibióticos y mantener una conducta expectante
- e) Dejar evolución espontánea

55) Una paciente de 53 años presenta una biopsia endometrial informada como hiperplasia endometrial atípica de alto grado y compleja. El tratamiento de elección es:

- a) Observación
- b) Tamoxifeno
- c) Histerectomía
- d) Hormonoterapia con estrógenos solos
- e) Hormonoterapia con estrógenos y progestágenos

56) Los agentes causales más frecuentes de los procesos inflamatorios pelvianos son:

- a) Bacilos Gram negativos
- b) Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes
- c) Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis
- d) Trichomona vaginalis y Gardnerella vaginales
- e) Virus

57) Un niño de 4 años se golpea la cabeza al caer de una bicicleta. Inicialmente está bien, pero a luego de algunos minutos evoluciona con cefalea progresiva e intensa, asociada a vómitos en varias oportunidades. El examen neurológico no muestra signos focales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con analgésicos e indicaciones de control en caso de aparición de signos de alarma
- b) Administrar antieméticos y AINEs endovenosos y reevaluar en 1 hora
- c) Solicitar radiografía de cráneo
- d) Solicitar TAC de cerebro y cráneo
- e) Realizar punción lumbar

58) Es un efecto frecuente de los anticonceptivos orales:

- a) Disminución del flujo menstrual
- b) Dispareunia
- c) Dismenorrea
- d) Sinosorragia
- e) Endometriosis

59) Un niño de 8 meses de edad presenta marcada irritabilidad, aspecto de dolor y deposiciones rojas, desde hace 2 horas. Por algunos momentos el dolor pareciera ceder, pero luego se reinicia. Al examen físico retrae las piernas y llora al palpar el abdomen. El examen más adecuado, ante la sospecha diagnóstica, es:

- a) Colonoscopia
- b) Ecografía abdominal
- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Radiografía abdominal baritada
- e) Exploración quirúrgica

60) Una mujer embarazada de 16 semanas, asintomática, presenta presiones arteriales elevadas, hasta 150/100 en varias tomas realizadas durante una semihospitalización. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión transitoria del embarazo
- b) Preclamsia
- c) Hipertensión arterial crónica
- d) Hipertensión arterial secundaria a insuficiencia renal
- e) Insuficiencia placentaria

61) Un niño de 8 años presenta disestesias y debilidad progresiva de las cuatro extremidades. Al examen físico se aprecian dichas alteraciones, con abolición de los reflejos osteotendíneos. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor cerebral
- b) Síndrome de Guillain Barre
- c) Miastenia gravis
- d) Distrofia muscular de Duchenne
- e) Cerebelitis autoinmune

62) ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a una paciente con un trabajo de parto en fase de expulsivo, con feto en espinas 0, en presentación de cara y posición mentosacra?

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Realizar flexión de la cabeza fetal
- c) Realizar rotación de la cabeza a posición mentopúbica
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea

63) Son factores de riesgo para muerte súbita del lactante, EXCEPTO:

- a) Prematurez
- b) Sexo femenino
- c) Tabaquismo materno
- d) Sueño en prono
- e) Antecedente de muerte súbita en hijos anteriores

64) Una mujer, cursando embarazo de 39 semanas, consulta en urgencias por contracciones uterinas persistentes. Se constata dinámica uterina de 4 en 10 minutos, con feto en cefálica, cuello uterino completamente borrado, dilatación cervical de 5 cm y membranas íntegras. El monitoreo fetal resulta tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio e indicar reconsulta en algunas horas
- b) Hospitalizar en parto y dejar evolución espontánea
- c) Iniciar aceleración occitócica
- d) Realizar rotura artificial de membranas
- e) Realizar cesárea

65) Un niño de 7 años presenta ortostatismo y deposiciones negras de muy mal olor. Al examen físico se observa pálido y presenta FC: 115x', PA: 80/40 mmHg. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar suero fisiológico endovenoso y solicitar test de Apt Downey de deposiciones
- b) Administrar suero fisiológico endovenoso y solicitar hemograma
- c) Administrar suero fisiológico endovenoso y solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Administrar suero fisiológico endovenoso y solicitar colonoscopia
- e) Administrar suero fisiológico endovenoso y solicitar TAC de abdomen y pelvis

66) Un niño de 5 años de edad es traído por su madre, por epistaxis y petequias que se presentan desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, pálido, con un rash petequial generalizado. Se palpan pequeñas adenopatías generalizadas y esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia aguda
- b) Linfoma
- c) Púrpura trombocitopénica inmune
- d) Hemofilia
- e) Enfermedad de Von Willebrand

67) Una mujer de 60 años presenta metrorragia autolimitada en una oportunidad, sin alteraciones a la especuloscopia. Se solicita ecografía transvaginal que demuestra un útero de tamaño pequeño, con endometrio fino, sin alteraciones anexiales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
- b) Realizar legrado endometrial
- c) Solicitar biopsia de endometrio
- d) Iniciar estrógenos tópicos
- e) Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio

68) Un niño de 11 meses ha presentado 4 crisis bronquiales obstructivas, desde los 6 meses, edad a la que presentó una bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. La última crisis fue hace pocos días y respondió bien al tratamiento, por lo que actualmente se encuentra en buenas condiciones, asintomático. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar test de metacolina
- b) Indicar corticoides inhalados en caso de síntomas y betaagonistas según horario
- c) Indicar corticoides inhalados según horario y betaagonistas en caso de síntomas
- d) Indicar corticoides orales y betaagonistas inhalados, ambos según horario
- e) Observar evolución

69) Una mujer de 24 años, cursando un embarazo de 8 semanas presenta metrorragia. Al la especuloscopia se observa sangre saliendo por el OCE y la ecografía transvaginal demuestra presencia de saco gestacional en la cavidad endometrial, con embrión con latidos cardíofetales presentes y longitud cervical de 40 mm. EL tacto vaginal no muestra cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, con reposo relativo
- b) Solicitar beta-HCG plasmática
- c) Hospitalizar y observar evolución
- d) Administrar metotrexato
- e) Realizar legrado

70) ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para la taquipnea transitoria?

- a) Postmadurez
- b) Preclamsia
- c) Polihidramnios
- d) Parto por cesárea
- e) Rotura prematura de membranas

Prueba 2 (PEDIATRÍA + GINECOLOGÍA + OBSTETRICIA)

1) ¿Cuál de las siguientes patologías suele presentarse como metrorragia?

- a) Hiperplasia endometrial
- b) Miomatosis uterina
- c) Endometriosis
- d) Pólipo endometrial
- e) Adenomiosis

2) Una mujer está en trabajo de parto, desde hace algunas horas. Presenta 2 contracciones cada diez minutos, y el tacto vagina demuestra cuello uterino completamente borrado, con dilatación de 10 cm y se palpa la cabeza fetal en presentación de vértice, en espaldas -2. Se administra la anestesia epidural, se inicia aceleración con oxitocina, logrando 4 contracciones por minuto y se realiza rotura artificial de membranas, dando salida a líquido amniótico claro. Se reevalúa luego de 2 horas sin presentar cambios. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Realizar forceps
- c) Suspender el goteo oxitócico
- d) Aumentar el goteo oxitócico
- e) Realizar cesárea

3) ¿Cuál de los siguientes es un signo de asfixia neonatal?

- a) DIP 1
- b) pH de sangre de cordón de 7,2
- c) Poliglobulia
- d) Signo de Babinsky
- e) Meconio espeso en el líquido amniótico

4) Una paciente de 55 años, con síntomas climatéricos, acude a control ginecológico, detectándose una pequeña lesión soleantada, de 1 cm en la zona posterior del cuello uterino. Su último PAP se lo realizó hace 6 meses y fue informado como normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
- b) Solicitar nuevo PAP inmediatamente
- c) Derivar a colposcopia y biopsia
- d) Realizar conización cervical
- e) realizar histerectomía total

5) Un lactante puede levantar la cabeza y mirar a su alrededor, sin embargo aún no es capaz de sentarse. ¿Qué edad tiene?

- a) 1 a 2 meses
- b) 3 a 4 meses
- c) 5 a 6 meses
- d) 7 a 8 meses
- e) 9 a 10 meses

6) Una paciente de 28 años, obesa, cursando embarazo de 8 semanas, se realiza glicemia de ayuno que resulta en 108 mg/dl. No presenta síntomas y el examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener los controles rutinarios del embarazo, sin necesidad de estudios ni tratamientos adicionales
- b) Solicitar nueva glicemia de ayuno
- c) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
- d) Iniciar dieta y ejercicios y controlar con nueva glicemia de ayunos en 2 semanas
- e) Iniciar insulina

7) Un lactante de 7 meses, previamente sano, presenta rinorrea, tos y luego dificultad para respirar. Al examen físico se aprecia taquipneico, con retracción intercostal y se ausculta múltiples sibilancias inspiratorias y espiratorias. El agente causal más probable es:

- a) Neumococo
- b) Estreptococo betahemolítico grupo B
- c) Virus respiratorio sincicial
- d) Virus parainfluenza
- e) Virus influenza

8) Una mujer acude a control obstétrico, con un embarazo avanzado, que no ha sido controlado previamente por médicos y que no se ha realizado exámenes de sangre ni ecografías. Recuerda el día de su última menstruación, que fue hace 32 semanas y 5 días y refiere que previamente sus reglas eran regulares. También refiere que hace 13 semanas y 3 días inició la percepción de los movimientos fetales. La mejor forma de determinar la edad gestacional en esta paciente es:

- a) Fecha de la última regla
- b) Ecografía obstétrica, con fetometría
- c) Fecha de inicio de la percepción de los movimientos fetales.
- d) Altura uterina
- e) Niveles plasmáticos de gonadotrofina coriónica humana

9) Un niño de 6 años consulta por malestar general de 3 semanas de evolución, asociado a fiebre intermitente y cefalea, que en el último tiempo se ha hecho diaria y que responde sólo parcialmente al uso de paracetamol. Al examen físico se aprecia pálido y se palpa esplenomegalia moderada. No se encuentran otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Mononucleosis infecciosa
- b) Linfoma
- c) Leucemia aguda
- d) Meningitis viral
- e) Tumor del sistema nervioso central

10) Una paciente de 33 años, primigesta, cursando embarazo de 35 semanas, sufre rotura de membranas, la que se confirma con la positividad del test de cristalización. Al examen físico se palpa feto en presentación cefálica, no hay dinámica uterina ni modificaciones cervicales y las pruebas de monitorización fetal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar antibióticos y corticoides y mantener una conducta expectante
- b) Administrar corticoides endovenosos y antibióticos e interrumpir el embarazo en 48 horas con misoprostol
- c) Realizar amniocentesis y decidir manejo según hallazgos
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar cesárea

11) Una mujer de 20 años consulta por leucorrea y prurito vulvar. Al examen se observa leucorrea blanca grumosa, con signos inflamatorios en la pared vaginal. El agente causal más probable es:

- a) Candida albicans
- b) Trichomona Vaginalis
- c) Gardnerella vaginalis
- d) Neisseria gonorrhoeae
- e) Treponema pallidum

12) La causa más frecuente de anemia en los niños es:

- a) Ferropénica
- b) Talasemias
- c) De enfermedades crónicas
- d) Autoinmune
- e) Por déficit de folatos

13) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es considerado como normal en un recién nacido?

- a) Salida continua de líquido por el ombligo
- b) Bolsa serosanguínea
- c) Petequias
- d) Leucocoria
- e) Hipotonía

14) El feto grande para la edad gestacional se define como aquel que:

- a) Pesa más de 4.000 g
- b) Pesa más de 4.500 g
- c) Presenta un peso fetal mayor al percentil 90 para su talla
- d) Presenta un peso fetal mayor al percentil 90 para su edad gestacional
- e) Presenta una relación perímetro abdominal / perímetro cefálico mayor a 1

15) Un lactante menor presenta infecciones respiratorias recurrentes, que han respondido adecuadamente al tratamiento antibiótico. Al examen físico destaca auscultación pulmonar con escasos crépitos bibasales y auscultación cardíaca con un soplo continuo. El diagnóstico más probable es:

- a) Coartación aórtica
- b) Trasposición de grandes vasos
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Comunicación interauricular
- e) Comunicación interventricular

16) Una mujer de 34 años consulta por dismenorrea marcada, que ha aumentado en los últimos meses. Se solicita una ecografía que demuestra un tumor ovárico izquierdo de 4 cm de diámetro, quístico, con contenido en vidrio esmerilado. El diagnóstico más probable es:

- a) Quiste folicular
- b) Cáncer de ovario
- c) Cuerpo lúteo
- d) Endometrioma
- e) Teratoma

17) Un niño de 6 años, presenta desde hace unos meses, diarrea y baja de peso, asociado a piel seca, glositis y caída del cabello. Refiere que presenta diarrea acuosa, con gotas de grasa, sin presencia de sangre en las deposiciones. La etiología más probable es:

- a) Enfermedad inflamatoria intestinal
- b) Giardiasis
- c) Mala absorción intestinal
- d) Invaginación intestinal
- e) Estenosis pilórica hipertrófica

18) Un mujer de 35 años, diagnosticada de hipertensión arterial crónica, en tratamiento con hidroclorotiazida, con adecuados controles, presenta atraso menstrual, por lo que se realiza un test de embarazo que resulta positivo. La conducta más adecuada para el tratamiento de su hipertensión arterial es:

- a) Suspender la hidroclorotiazida e iniciar alfametildopa
- b) Mantener la hidroclorotiazida, sin necesidad de otros medicamentos
- c) Suspender la hidroclorotiazida e iniciar enalapril
- d) Suspender la hidroclorotiazida e iniciar sulfato de magnesio
- e) Solicitar proteinuria de 24 horas para decidir el hipotensor más adecuado

19) ¿Cuál de las siguientes condiciones es más frecuente en el recién nacido pretérmino que en el recién nacido de término?

- a) Síndrome de aspiración de meconio
- b) Cardiopatías congénitas
- c) Hipocalcemia
- d) Poliglobulia
- e) Cefalohematoma

20) Una paciente cursando un embarazo de 34 semanas, presenta un retraso del crecimiento intrauterino, con feto creciendo en percentil 5. ¿Qué afirmación es FALSA?

- a) En caso de no haber complicaciones debe interrumpirse el embarazo a las 37 semanas
- b) Debe solicitarse ecografía-Doppler de arterias uterinas cada 1 o 2 semanas
- c) La presencia de oligohidramnios es un criterio de interrupción del embarazo
- d) Deben realizarse 3 veces a la semana un perfil biofísico o bien un registro basal no estresante
- e) Debe indicarse reposo en decúbito lateral izquierdo

21) Una paciente presenta ciclos menstruales de 24 días de duración y en cada menstruación presenta sangrado muy escaso, menor a 20 cc y de sólo 2 días de duración. Se puede afirmar que presenta:

- a) Oligomenorrea
- b) Polimenorrea
- c) Hipomenorrea
- d) Polimenorrea e hipomenorrea
- e) Oligomenorrea e hipermenorrea

22) Un paciente de 6 años presenta fiebre, cefalea y signos meníngeos, por lo que se solicita una punción lumbar que da salida a líquido purulento, con 100.000 leucocitos por mm³, de marcado predominio polimorfonuclear, glucosa baja y proteínas elevadas. La tinción de Gram muestra cocáceas gram negativas. El agente causal más probable es:

- a) Meningococo
- b) Neumococo
- c) Haemophilus influenza
- d) Staphilococo
- e) Listeria

23) La causa más frecuente de constipación en la edad pediátrica es:

- a) Enfermedad de Hirschsprung
- b) Polipos juveniles
- c) Enfermedades inflamatorias intestinales
- d) Malos hábitos
- e) Giardiasis

24) Un recién nacido de término, de 5 días de vida, presenta ictericia, desde hace 2 días, que actualmente llega hasta los muslos. Al nacer pesó 3.600 g y actualmente pesa 3.650 g, alimentándose exclusivamente con leche materna. No presenta otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- c) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo Rh
- d) Ictericia por leche materna
- e) Hipotiroidismo congénito

25) Una paciente presenta amenorrea secundaria a una falla ovárica prematura de origen autoinmune. La prueba de progesterona y la prueba de estrógenos más progesterona resultarán respectivamente:

- a) Positiva y positiva
- b) Positiva y negativa
- c) Negativa y positiva
- d) Negativa y negativa
- e) No podrán ser realizadas

26) Un recién nacido de 36 semanas de gestación, presenta dificultad respiratoria luego de nacer. Se inicia oxígeno y se realiza radiografía de tórax que muestra hilios pulmonares prominentes, aumento de la trama vascular pulmonar y leve derrame pleural bilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Cardiopatía congénita
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Síndrome de aspiración meconial
- e) Taquipnea transitoria

27) Una paciente de 34 años, cursando embarazo de 11 semanas inicia metrorragia, asociada a dolor hipogástrico. Se realiza ecografía transvaginal que demuestra saco gestacional indemne, con visualización de latidos cardíofetales. El tacto vaginal muestra cuello completamente borrado, con dilatación de 3 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio indicando reposo absoluto
- b) Realizar cerclaje de emergencia
- c) Administrar progestágenos y reevaluar en 48 horas
- d) Hospitalizar, administrar analgésicos y tocolíticos
- e) Realizar legrado

28) ¿Qué examen NO pediría al inicio del estudio de una pareja que consulta por infertilidad de 18 meses de evolución?

- a) Ecografía transvaginal
- b) Espermograma
- c) Seguimiento foliular
- d) Test postcoital
- e) Histerosalpingografía

29) El punto de reparo de la presentación de Bregma es:

- a) La fontanela posterior
- b) La fontanela anterior
- c) La frente
- d) La nariz
- e) El mentón

30) ¿Qué medicamento es de elección para la profilaxis de infecciones del tracto urinario, en un niño con reflujo vesicoureteral leve?

- a) Nitrofurantoína
- b) Eritromicina
- c) Ciprofloxacino
- d) Gentamicina
- e) Amoxicilina + ácido clavulánico

31) Un paciente de 6 años presenta edema facial y de extremidades inferiores. Al examen físico presenta signos vitales normales para su edad. Se solicita estudio de orina completa que demuestra cilindros céreos, sin hematuria ni leucocituria, con proteinuria de 24 horas de 2,5 g. La creatinina plasmática y los electrolitos plasmáticos son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome hemolítico urémico
- b) Enfermedad de Berger
- c) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- d) Riñón poliquístico
- e) Enfermedad por cambios mínimos

32) ¿Desde qué edad deben iniciar la ingesta de alimentos sólidos los niños alimentados con lactancia materna exclusiva?

- a) 3 meses
- b) 6 meses
- c) 9 meses
- d) 10 meses
- e) 12 meses

33) ¿En cuál de las siguientes pacientes aconsejaría el uso de anticonceptivos por vía transdérmica en lugar de vía oral?

- a) Mujer con cáncer de endometrio
- b) Mujer con antecedente familiar de cáncer de mama
- c) Mujer con lupus eritematosos sistémico
- d) Mujer con hipertrigliceridemia
- e) Mujer puérpera, dando lactancia

34) La enfermedad de Kawasaki suele complicarse con:

- a) Meningitis aséptica
- b) Trombosis venosa
- c) Artritis deformante
- d) Uveítis
- e) Aneurismas coronarios

35) La endometriosis es una causa de dismenorrea y de infertilidad. Suele diagnosticarse mediante:

- a) La clínica
- b) Ecografía transvaginal
- c) Biopsia de endometrio
- d) Laparoscopia
- e) Ca-125

36) ¿Qué opción caracteriza mejor a un niño de 10 meses de edad?

- a) Fija la mirada y presenta sonrisa social
- b) Se sienta por sí mismo, vocaliza (agú) y es capaz de tomar objetos y pasarlos de una mano a la otra
- c) Se para por sí mismo, dice cerca de 10 palabras y se muestra indiferente a la presencia de extraños
- d) Se para por sí mismo, sin caminar, entiende el concepto de "no" y llora frente a los extraños
- e) Camina sin apoyo y dice cerca de 10 palabras

37) Una mujer de 18 años, primigesta, cursando 31 semanas de embarazo, consulta por malestar general y cefalea progresiva. Al examen se aprecia taquicárdica e hipertensa, con marcados edemas en ambas extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión transitoria del embarazo
- b) Síndrome de HELLP
- c) Preclamsia
- d) Embarazo molar
- e) Isoinmunización Rh

38) La conducta más adecuada ante un lactante cursando una diarrea aguda por rotavirus, con deshidratación severa (mayor al 10% del peso corporal), es:

- a) Hidratar con suero fisiológico por vía endovenosa
- b) Indicar sales de rehidratación oral y reevaluar en 6 horas
- c) Indicar sales de rehidratación oral luego de cada deposición diarreica, según Plan A
- d) Iniciar antibióticos y sales de rehidratación oral
- e) Iniciar sales de rehidratación oral e indicar vacunación contra el rotavirus

39) Los corticoides prenatales han aumentado considerablemente la sobrevida de los recién nacidos prematuros. Reducen la incidencia de todo lo citado a continuación, EXCEPTO:

- a) Sepsis neonatal
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Hemorragia periventricular
- d) Muerte neonatal precoz
- e) Enterocolitis necrotizante

40) La primera causa de insuficiencia renal aguda, en la edad pediátrica, es:

- a) Malformaciones nefrourológicas
- b) Glomerulonefritis
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Prerenal
- e) Necrosis tubular aguda

41) La etiología de las desaceleraciones tardías, en el registro estresante, es:

- a) Reacción vagal, producto de compresión de la cabeza fetal
- b) Compresión del cordón umbilical
- c) Hipoxia fetal
- d) Flujo reverso en diástole de las arterias umbilicales
- e) Aumento del retorno venoso fetal, producto de la compresión de la placenta

42) Según el programa nacional de vacunaciones, al cumplir un año, los niños deben recibir:

- a) Las vacunas DPT y polio oral
- b) La vacuna trivírica
- c) Las vacunas trivírica, DPT y polio oral
- d) Las vacunas DPT, polio oral, Hib y VHB
- e) La vacuna DT

43) Una mujer de 34 años, cursando embarazo de 35 semanas presenta poliaquiuria, sin disuria, que la hace ir al baño cerca de 15 veces al día. Se solicita sedimento de orina que resulta normal y urocultivo que resulta negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar cefadroxilo en una dosis diaria
- b) Solicitar serología contra mycoplasma
- c) Solicitar urodinamia
- d) Disminuir el consumo de agua
- e) Tranquilizar a la paciente, enviándola explicando la normalidad de su condición

44) ¿Cuál de las siguientes mujeres tiene mayor riesgo de presentar cáncer de endometrio?

- a) Mujer con promiscuidad sexual y antecedente de procesos inflamatorios pélvicos tratados
- b) Mujer obesa, con diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial
- c) Mujer postmenopáusica, con uso de terapia de reemplazo hormonal por 10 años
- d) Mujer con endometriosis
- e) Mujer con miomatosis uterina sintomática

45) Durante la primera semana de vida los recién nacidos pueden presentar una baja de peso de máximo:

- a) 500 gramos
- b) 100 gramos
- c) 5% del peso de nacimiento
- d) 10% del peso de nacimiento
- e) 20% del peso de nacimiento

46) Los niños con enuresis primaria, habitualmente presentan:

- a) Constipación
- b) Alteración en la continencia diurna
- c) Antecedentes familiares de enuresis
- d) Disuria
- e) Osmolaridad urinaria disminuida

47) Son causas de oligohidramnios, EXCEPTO:

- a) Insuficiencia placentaria
- b) Rotura prematura de membranas
- c) Diabetes mellitus gestacional
- d) Preclamsia
- e) Malformaciones renales

48) El primer signo de desarrollo puberal en las niñas es:

- a) Vello púbico
- b) Menarquía
- c) Botón mamario
- d) Adrenarquía
- e) Aceleración del crecimiento

49) Una mujer de 20 años, cursando embarazo de 29 semanas, presenta fiebre persistente, hasta 38,2°C, sin presentar otros síntomas ni otras alteraciones en el examen físico. Se realiza estudio rutinario sin poder identificar un foco infeccioso, por lo que se realiza amniocentesis que demuestra 31 leucocitos por mm³, glucosa de 25 mg/dl. A la tinción de Gram no se visualizan bacterias y el cultivo de líquido amniótico resulta negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Descartar el foco uterino y continuar el estudio de la fiebre
- b) Iniciar antibióticos de amplio espectro y mantener una conducta expectante
- c) Administrar antibióticos y corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas
- d) Interrumpir el embarazo bajo cobertura antibiótica
- e) Realizar cesárea de urgencia

50) Un niño llora y hace berrinches cuando es llevado al jardín infantil, quedando muy ansioso y llorando por largo rato luego que su madre se va, siendo difícil de consolar. La madre suele irse muy ansiosa y preocupada del estado de su hijo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno oposicionista desafiante
- b) Trastorno de conducta
- c) Depresión infantil
- d) Trastorno por ansiedad de separación
- e) Trastorno por déficit atencional

51) Los anticonceptivos orales con microdosis de estrógenos se caracterizan por:

- a) Presentar mayor incidencia de goteo (spotting) que los de macrodosis
- b) Presentar mayor riesgo de cáncer de mama que los de macrodosis
- c) Presentar mayor riesgo de trombosis venosa profunda que los de macrodosis
- d) Tener una mayor efectividad en la prevención de embarazo que los de macrodosis
- e) Ser inyectables

52) El tratamiento de elección de una laringitis obstructiva aguda moderada es:

- a) Salbutamol inhalado
- b) Salbutamol y corticoides inhalados
- c) Adrenalina racémica inhalada y corticoides inhalados
- d) Adrenalina racémica inhalada y corticoides orales
- e) Corticoides inhalados y corticoides orales

53) Un recién nacido de 4 días de vida, nacido prematuro a las 33 semanas, presenta desde algunas hora dificultad para regular la temperatura corporal y debilidad para alimentarse. Al examen presenta tono muscular disminuido y debilidad del reflejo de succión. El diagnóstico más probable es:

- a) Parálisis cerebral
- b) Hipoglicemia
- c) Hipocalcemia
- d) Sepsis
- e) Síndrome de Guillian Barré

54) Una paciente en edad fértil, sexualmente activa, presenta desde hace una semana dolor hipogástrico, asociado a dispareunia profunda. Al tacto vaginal se constata dolor a la movilización cervical y a la palpación anexial. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de cuello uterino
- b) Neoplasia intraepitelial
- c) Cáncer de endometrio
- d) Procesos inflamatorio pélvico
- e) Endometriosis

55) La cardiopatía congénita más frecuente es:

- a) Comunicación interauricular
- b) Foramen oval
- c) Comunicación interventricular
- d) Ducto arterioso persistente
- e) Coartación aórtica

56) Mujer de 35 años, cesarizada anterior, cursando embarazo de 30 semanas, con polihidramnios, de causa no precisada, presenta salida de abundante líquido claro por los genitales. No presenta dinámica uterina y la especuloscopia demuestra salida de líquido transparente por el orificio cervical externo. Se palpa el feto en podálica y no hay modificaciones cervicales. El registro basal no estresante es reactivo y el perfil biofísico es 10/10. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar antibióticos y corticoides y mantener una conducta expectante
- b) Administrar corticoides endovenosos y antibióticos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- c) Administrar corticoides, antibióticos y tocolíticos por vía endovenosa
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar cesárea

57) Respecto a la hepatitis A, es verdadero que:

- a) No existe vacuna para su prevención
- b) Se transmite por vía vertical
- c) El diagnóstico de certeza se realiza con la detección del antígeno de superficie
- d) El tiempo de protrombina es un muy buen indicador de la severidad de la enfermedad
- e) Suele presentarse con ictericia y elevación de las transaminasas cercana al doble de los valores normales

58) Una mujer de 35 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 0. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir la mamografía en un año
- b) Repetir la mamografía en 6 meses
- c) Realizar ecografía mamaria
- d) Solicitar TAC mamario
- e) Derivar para biopsia por punción

59) Un niño de 6 años presenta fiebre hasta 39° y decaimiento, asociado a la aparición de múltiples ulceraciones en la cavidad oral, comprometiendo el paladar blando, paladar duro, lengua, labios y encías. Además se palpan varias adenopatías cervicales sensibles. El diagnóstico más probable es:

- a) Herpangina
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Primoinfección herpética
- d) Escarlatina
- e) Faringoamigdalitis por anaerobios

60) Una mujer se realiza un Papanicolaou, que es informado como muestra NO satisfactoria. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar PAP anualmente
- b) Solicitar estudio de virus papiloma humano
- c) Repetir PAP de inmediato
- d) Derivar a colposcopia
- e) Derivar a conización

61) En promedio, ¿Cuánto mide un niño de 12 meses de edad?

- a) 37 cm
- b) 50 cm
- c) 62 cm
- d) 75 cm
- e) 90 cm

62) Una paciente cursando embarazo de 36 semanas de gestación, consulta por disminución de la percepción de los movimientos fetales. Se solicita registro basal no estresante que es informado como no reactivo, luego de 40 minutos de monitorización. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio
- b) Extender el registro por 60 minutos más
- c) Solicitar ecografía-Doppler de arterias umbilicales
- d) Realizar test de tolerancia a las contracciones
- e) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

63) ¿Qué alternativa es adecuada para alimentar a un lactante de 3 meses de edad, cuya madre ya no puede continuar amamantándolo?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

64) Un niño de 7 años presenta fiebre, decaimiento y un exantema polimorfo, generalizado, con pápulas, vesículas, pústulas y costras en la cabeza, tronco y extremidades. El agente causal más probable es:

- a) Streptococcus
- b) Enterovirus
- c) Virus herpes 6
- d) Parvovirus B19
- e) Virus varicela zoster

65) Una paciente de 34 años, cursando su tercer embarazo, de 30 semanas, inicia metrorragia, asociado a dolor abdominal intenso. Al examen físico se palpa el útero doloroso e hipertónico. El monitoreo fetal demuestra variabilidad disminuida, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides y mantener una conducta expectante
- b) Administrar corticoides e inducir el parto en 48 horas, con misoprostol
- c) Realizar prueba de trabajo de parto
- d) Solicitar un perfil biofísico y decidir conducta según hallazgos
- e) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

66) ¿Cuál de las siguientes es una indicación de hospitalización en un niño que sufre un golpe en la cabeza?

- a) Hematoma del cuero cabelludo de 4 cm
- b) Amnesia del momento del golpe
- c) Pérdida de consciencia de segundos de duración, inmediatamente después del golpe
- d) Náuseas
- e) Sospecha de maltrato infantil

67) Los miomas que con mayor frecuencia presentan síntomas son:

- a) Intramurales
- b) Subserosos
- c) Pediculados
- d) Submucosos
- e) Capsulados

68) Una mujer de 24 años, con antecedentes de promiscuidad sexual, inicial dolor abdominal, asociado a metrorragia. Su última menstruación fue hace 2 meses. Al examen físico se constata FC: 110x', PA: 90/50 mmHg, FR: 16x', con dolor a la palpación hipogástrica, sin signos de irritación peritoneal. Se realiza test de embarazo que resulta positivo y se realiza una ecografía transvaginal que no visualiza saco gestacional. Se administran analgésicos y cristaloides. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar beta HCG plasmática y administrar cristaloides endovenosos
- b) Controlar en 48 horas con nueva ecografía transvaginal
- c) Iniciar metotrexato
- d) Realizar legrado uterino
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

69) Un recién nacido de 5 días de vida presenta varias pústulas pequeñas, con base eritematosa en la cara, el tronco y las extremidades. Se aprecia de buen aspecto y el resto del examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema tóxico
- b) Varicela neonatal
- c) Herpes neonatal
- d) Sífilis congénita
- e) Exantema súbito

70) Los principales beneficios de la terapia de reemplazo hormonal son:

- a) Prevención del envejecimiento prematuro y control de los síntomas vasomotores climatéricos
- b) Control de los síntomas vasomotores climatéricos y prevención de la osteoporosis
- c) Prevención del envejecimiento prematuro y de la osteoporosis
- d) Control de los síntomas vasomotores, prevención de eventos cardiovasculares y prevención de la osteoporosis
- e) Control de los síntomas vasomotores, prevención del envejecimiento prematuro y prevención de eventos cardiovasculares

Prueba 3

1) Paciente de 35 años, cesarizada anterior, cursando embarazo de 36 semanas, presenta RPO de 10 horas de evolución. No se registran contracciones uterinas ni modificaciones cervicales y el registro basal no estresante es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolucionar espontáneamente, sin necesidad de fármacos
- b) Dejar evolucionar, bajo cobertura antibiótica y bajo corticoides para asegurar la maduración fetal
- c) Indicar reposo, antibióticos, corticoides e interrumpir cuando se cumplan 37 semanas de gestación
- d) Inducir el parto inmediatamente con misoprostol
- e) Realizar cesárea

2) En un test de tolerancia a las contracciones, las desaceleraciones precoces son producidas por:

- a) Compresión del cordón umbilical
- b) Compresión de la cabeza fetal
- c) Hipoxia fetal
- d) Hipoxia uterina
- e) Compresión abdominal

3) ¿Cuál de las siguientes opciones, es la causa más frecuente de infertilidad?

- a) Endometriosis
- b) Anovulación crónica
- c) Factor cervical
- d) Factores hormonales
- e) Factor masculino

4) La alteración menstrual que se observa con mayor frecuencia en pacientes hipotiroideas es:

- a) Hipermenorrea
- b) Hipomenorrea
- c) Oligomenorrea
- d) Polimenorrea
- e) Amenorrea

5) ¿Que mostrará la biopsia endometrial de una paciente cursando un embarazo tubario?

- a) Endometrio normal
- b) Reacción de Arias Stella
- c) Vellosidades coriales
- d) Atrofia endometrial
- e) Eritrocitos nucleados y normales

6) La principal ventaja del preservativo, frente a otros métodos anticonceptivos es que:

- a) Es más efectivo en la prevención del embarazo
- b) No tiene efectos adversos
- c) Tiene menor precio
- d) Disminuye el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual
- e) Es de especial utilidad en las relaciones sexuales, practicadas durante el embarazo

7) Una paciente asintomática se realiza Papanicolau, que muestra atipias epiteliales de mediano grado. La especuloscopia es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nuevo Papanicolau en un año más
- b) Realizar nuevo Papanicolau en 3 meses
- c) Repetir el Papanicolau inmediatamente
- d) Derivar a colposcopia y biopsia
- e) Realizar cono cervical

8) Una paciente de 24 años, primípara, presenta importante metrorragia, luego del parto de un embarazo gemelar. Al examen se aprecia paciente taquicárdica, normotensa y se palpa el fondo uterino entre el ombligo y la apófisis xifoides. El diagnóstico más probable es:

- a) Inercia uterina
- b) Laceración del canal del parto
- c) Rotura uterina
- d) Hematoma del canal del parto
- e) Alumbramiento incompleto

9) Paciente de 65 años, presenta escapes de pequeñas cantidades de orina, al toser, reírse o al hacer cierto ejercicios, desde hace un mes. No presenta otros síntomas, sin embargo su problema ha comenzado a afectar sus actividades sociales y laborales. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Iniciar alfa agonistas adrenérgicos
- b) Solicitar urocultivo
- c) Indicar ejercicios de fortalecimiento del piso pelviano
- d) Derivar a resolución quirúrgica
- e) Solicitar ecografía renovesical, perfil uretral y cistoscopia

10) Una mujer puérpera de 7 días inicia dolor y eritema en la mama izquierda, asociados a fiebre hasta 38°C. Al examen físico se aprecia mama izquierda aumentada de volumen, con eritema de la piel, dolorosa a la palpación y de consistencia ligeramente aumentada, de manera difusa. No se palpan nódulos ni zonas fluctuantes. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender lactancia materna e iniciar antibióticos con cobertura para estafilococo áureo
- b) Suspender lactancia materna, realizar drenaje quirúrgico e iniciar antibióticos con cobertura para estafilococo aureo
- c) Mantener lactancia materna, mejorar la técnica de lactancia e iniciar antibióticos con cobertura para estafilococo áureo
- d) Suspender la lactancia materna e iniciar antibióticos con cobertura para bacterias Gram negativas
- e) Mantener lactancia materna, mejorar la técnica de lactancia e iniciar antibióticos con cobertura para bacterias Gram negativas

11) Una mujer de 18 años cursa embarazo de 8 semanas. Consulta por cuadro de metrorragia, fiebre, ictericia, dolor abdominal y gran compromiso del examen general. Al examen se aprecia paciente febril hasta 39°C, ictérica, hipotensa, con salida de líquido purulento por orificio cervical externo. Se sospechan maniobras abortivas. El agente microbiológico, que con mayor probabilidad es el causante de este cuadro es:

- a) Escherichia coli
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Staphylococcus aureus
- d) Bacteroides fragilis
- e) Clostridium perfringens

12) Una mujer de 40 años, sin antecedentes de importancia, multipara de 3, esterilizada mediante ligadura de trompas, consulta por hipermenorrea importante. Al examen físico se constata útero aumentado de tamaño, de contornos irregulares. Se solicitan exámenes donde destaca anemia ferropénica y una ecografía transvaginal con demostración de un mioma submucoso de 5 cm y otro mural de 4 cm. El tratamiento más adecuado para esta paciente es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales combinados
- b) Iniciar tamoxifeno
- c) Iniciar agonistas de GnRH
- d) Realizar tumorectomía endoscópica
- e) Realizar histerectomía transvaginal

13) Primigesta de 39 semanas inicia trabajo de parto. La dinámica uterina es 3 contracciones en 10 minutos y se palpa cuello uterino borrado con dilatación de 2 cm y membranas íntegras. Sin embargo se constatan lesiones vesiculares en labio mayor derecho, consistentes con herpes genital activo. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea, sin necesidad de tratamientos adicionales
- b) Dejar evolucionar el parto vaginal, sin necesidad de tratamientos adicionales
- c) Iniciar aciclovir endovenoso y dejar evolucionar el parto vaginal
- d) Dejar evolucionar el parto vaginal y administrar aciclovir endovenoso al recién nacido
- e) Iniciar aciclovir endovenoso a la madre, realizar cesárea y administrar aciclovir endovenoso al recién nacido

14) Una paciente de 23 años consulta por leucorrea de mal olor, el que se acentúa durante la menstruación. A la especuloscopia se aprecia leucorrea grisácea de olor a pescado podrido, sin signos inflamatorios en la mucosa vaginal. El agente etiológico más probable es:

- a) Gardnerella vaginalis
- b) Trichomona vaginalis
- c) Cándida albicans
- d) Neisseria gonorrhoeae
- e) Chlamydia trachomatis

15) La causa más frecuente de aborto es:

- a) Incompetencia cervical
- b) Alteraciones genéticas embrionarias
- c) Síndrome antifosfolípidos
- d) Alteraciones hormonales
- e) Malformaciones uterinas

16) Una paciente de 55 años se realiza ecografía transvaginal como parte de estudio de un cuadro de dolor abdominal. La ecografía demuestra presencia de un tumor anexial derecho de 6 cm de diámetro, de aspecto quístico, con numerosas increscencias. No se observa líquido libre peritoneal. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Observar y realizar nueva ecografía en 6 meses
- b) Iniciar anticonceptivos orales, mantenidos, durante 3 meses y repetir la ecografía
- c) Realizar punción con aguja fina y decidir manejo según hallazgos
- d) Realizar tumorectomía ovárica, con biopsia intraoperatoria y decidir manejo según hallazgos
- e) Realizar ooforectomía más anexectomía derechas, por vía laparoscópica, con estudio de biopsia rápida

17) El concepto sinusorragia se refiere a:

- a) Menstruaciones irregulares
- b) Menstruaciones abundantes y dolorosas
- c) Sangrado genital fuera del período menstrual
- d) Sangrado genital durante o después de una relación sexual
- e) Sangrado vulvar, que no se origina en la vagina

18) Una paciente multipara de 2, cursando embarazo de 33 semanas fue diagnosticada de diabetes gestacional mediante test de tolerancia a la glucosa, a las 28 semanas de gestación. Se inició dieta, sin embargo persiste con glicemias postprandiales cercanas a 150 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Proseguir con dieta y ejercicios por 4 semanas más y controlar
- b) Iniciar metformina
- c) Iniciar glibenclamida
- d) Iniciar insulina
- e) Iniciar una asociación de glibenclamida e insulina

19) Paciente de 20 años, con menstruaciones previas irregulares, presenta atraso menstrual de 6 semanas por lo que se realiza test de embarazo, que resulta positivo. Presenta dolor abdominal, sin metrorragia. Se solicita ecografía transvaginal que no muestra saco embrionario intrauterino. Sólo se observa endometrio engrosado, sin líquido libre peritoneal. Se controlan niveles de gonadotropina coriónica (HCG,) cuyo resultado es 1.000 UI/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevos niveles de HCG y ecografía transvaginal en 2 días
- b) Indicar metotrexato
- c) Resolver quirúrgicamente, mediante laparoscopia
- d) Resolver quirúrgicamente, mediante laparotomía
- e) Dejar evolución espontánea, sin necesidad de nuevos controles ni tratamientos

20) Una paciente de 25 años, cursando embarazo de 35 semanas, presenta cultivo vaginal positivo para Streptococcus beta hemolítico, grupo B (S. agalactiae). La conducta más adecuada es:

- a) Administrar una dosis de penicilina benzatina intramuscular inmediatamente
- b) Iniciar ampicilina oral desde las 36 semanas hasta el parto
- c) Administrar ampicilina endovenosa durante el trabajo de parto
- d) Administrar penicilina endovenosa al recién nacido
- e) Realizar cesárea

21) Paciente de 35 años, cursando embarazo de 36 semanas, consulta por disminución de los movimientos fetales. Se realiza perfil biofísico que es informado como 8/10, con líquido amniótico 0/2. La conducta más adecuada es:

- a) Tranquilizar a la madre y dejar que evolucione espontáneamente
- b) Realizar nuevo perfil biofísico en 2 días y decidir manejo según hallazgos
- c) Solicitar ecodoppler umbilical y decidir manejo, según hallazgos
- d) Interrumpir el parto por vía vaginal
- e) Realizar cesárea de urgencia inmediatamente

22) La causa más frecuente de retraso del crecimiento intrauterino, de tipo asimétrico es:

- a) Constitucional
- b) Genopatías
- c) Infecciones intrauterinas (TORCH)
- d) Insuficiencia placentaria
- e) Deficiencia de insulina fetal

23) El examen más importante para determinar el pronóstico de un embarazo gemelar es:

- a) La ecografía obstétrica del primer trimestre
- b) La ecografía ginecológica del segundo trimestre
- c) La ecografía ginecológica del tercer trimestre
- d) El ecodoppler de arterias uterinas
- e) El ecodoppler umbilical

24) El período fértil se extiende desde:

- a) Un día antes hasta un día después de la ovulación
- b) Cinco días antes hasta cinco días después de la ovulación
- c) Cinco días antes hasta el día de la ovulación
- d) Diez días antes hasta tres días después de la ovulación
- e) Siete días antes hasta tres días después de la ovulación

25) ¿Cuál de las siguientes opciones orienta mejor a una causa ginecológica de dolor abdominal crónico?

- a) Dolor abdominal hipogástrico
- b) Dolor abdominal que no se acompaña de alteraciones del tránsito intestinal
- c) Dolor abdominal cíclico, relacionado al ciclo menstrual
- d) Dolor abdominal que cede con la eliminación de gases
- e) Dolor abdominal, asociado a cefalea y dispareunia superficial

26) ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada durante el embarazo?

- a) Antigripal
- b) Antineumocócica
- c) Anti hepatitis B
- d) Antitetánica
- e) Antivaricelatoria

27) Paciente de 25 años, consulta por dismenorrea intensa, asociada a dispareunia profunda y disquexia, de 1 año de evolución, que ha ido en aumento en el último tiempo. No refiere leucorrea. Al examen ginecológico se constata dolor a la movilización cervical y a la palpación anexial. También se constata cierto grado de inmovilidad del cuello uterino. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de endometrio
- b) Proceso inflamatorio pélvico
- c) Endometriosis
- d) Miomatosis
- e) Neoplasia intraepitelial cervical

28) Una adolescente de 17 años, sin antecedentes de importancia, es traída por su madre ya que aún no presenta menstruación. No presenta otros síntomas y su desarrollo puberal es normal. Al examen ginecológico se observa himen perforado y el resto del examen físico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonceptivos orales
- b) Solicitar ecografía transvaginal
- c) Solicitar TSH, hemograma, índice de andrógenos libres, prolactina, FSH, LH, cariotipo, androstenediona y 17-hidroxiprogesterona
- d) Solicitar prueba de progesterona
- e) Iniciar pulsos de agonistas de GnRH

29) Una paciente de 35 años, cursando embarazo de 29 semanas, consulta por fiebre y leucorrea purulenta. Al examen se constata FC: 130x', PA: 110/60, t°: 38,3°C. La especuloscopia demuestra salida de exudado purulento por el orificio cervical externo. En sus exámenes de sangre destaca leucocitosis hasta 18.000 y elevación de la PCR. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Administrar corticoides, antibióticos endovenosos de amplio espectro e interrumpir el embarazo al alcanzar la madurez pulmonar
- b) Solicitar amniocentesis, iniciar antibióticos y corticoides y decidir manejo según estudio del líquido amniótico
- c) Realizar cesárea de urgencia, sin necesidad de antibióticos
- d) Solicitar urocultivo, radiografía de tórax, hemocultivos y decidir manejo según resultados
- e) Administrar antibióticos endovenosos e interrumpir el parto por una vía expedita

30) Una paciente puerpera de 7 días inicia metrorragia de moderada cuantía. La causa más probable es:

- a) Inercia uterina
- b) Laceraciones del canal del parto
- c) Endometritis puerperal
- d) Persistencia de restos ovulares
- e) Drenaje espontáneo de hematoma del canal del parto

31) ¿Cuál de las siguientes es una causa clásica de hipermenorrea?

- a) Mioma uterino subseroso
- b) Pólipo endometrial
- c) Uso de anticonceptivos
- d) Cáncer de endometrio
- e) Síndrome de ovario poliquístico

32) Una mujer de 62 años, obesa, con antecedente de ovario poliquístico durante su período fértil, presenta metrorragia escasa. A la especuloscopia se constata que la sangre proviene de la cavidad endometrial. El tacto vaginal es normal, al igual que la ecografía transvaginal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar anticonceptivos orales en altas dosis
- b) Solicitar biopsia endometrial
- c) Iniciar estrógenos locales
- d) Solicitar Papanicolaou, colposcopia y biopsia cervical
- e) Observar y controlar en 7 días, decidiendo manejo según evolución

33) Son contraindicaciones para la terapia hormonal de reemplazo, EXCEPTO:

- a) Metrorragia de causa no precisada
- b) Cáncer de mama
- c) Cáncer de endometrio
- d) Hepatopatías activas
- e) Cáncer de cuello uterino

34) Una paciente de 24 años, consulta por dolor abdominal. Al examen se constata paciente subfebril, con dolor a la palpación hipogástrica, palpación anexial derecha y movilización cervical. No hay signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometriosis
- b) Proceso inflamatorio pélvico
- c) Apendicitis aguda
- d) Absceso tuboovárico roto
- e) Embarazo tubario

35) Paciente multipara de 33 años, cursando embarazo de 28 semanas, asintomática, se realiza urocultivo, como parte de su control prenatal, el cual resulta positivo para Escherichia coli sensible. La conducta más adecuada es:

- a) No realizar nuevos urocultivos ni administrar antibióticos, dada ausencia de síntomas
- b) Administrar ciprofloxacino oral sin necesidad de urocultivos de control
- c) Administrar cefadroxilo oral y realizar urocultivos periódicos
- d) Administrar ceftriaxona endovenosa y realizar urocultivos periódicos
- e) Realizar urocultivos periódicos sin necesidad de tratamiento antibiótico

36) ¿Cuál es la causa más frecuente de tumor anexial en las pacientes en edad fértil?

- a) Hidrosalpinx
- b) Absceso tuboovárico
- c) Quistes de origen funcional
- d) Adenoma
- e) Cáncer de ovario

37) Mujer de 18 años, consulta por reglas irregulares, las que presenta cada 2 a 3 meses. Al examen se aprecia obesa, con hirsutismo leve, acné y piel grasa. La causa más probable de su alteración menstrual es:

- a) Hipotiroidismo
- b) Síndrome de ovario poliquístico
- c) Hipogonadismo hipergonadotrópico
- d) Hiperplasi suprarrenal
- e) Tumor productor de andrógenos

38) Una paciente primigesta, de 30 semanas de gestación, asintomática, presenta presión arterial de 150/90 en una ocasión. El resto del examen físico es normal. Se controla proteinuria cualitativa que resulta levemente positiva. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar diuréticos, asociados a iECA
- b) Indicar dieta y ejercicios
- c) Indicar semihospitalización de 6 horas, controlando la presión arterial en varias ocasiones
- d) Iniciar alfametildopa y solicitar exámenes que determinen la gravedad del cuadro
- e) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo

39) Paciente de 55 años, presenta genitorragia. A la especuloscopia se observa una lesión de 2 cm, con una pequeña ulceración. El Papanicolau resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir Papanicolau en 6 meses
- b) Derivar a colposcopia y biopsia
- c) Realizar cono biopsico
- d) Realizar histerectomía simple
- e) Realizar histerectomía radical

40) Una paciente fumadora, múltipara de 2, cursando embarazo de 32 semanas consulta por metrorragia y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia metrorragia escasa, oscura y se palpa útero hipertónico. El monitoreo fetal demuestra variabilidad disminuida y desaceleraciones variables complejas. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- c) Rotura uterina
- d) Rotura de vasa previa
- e) Acretismo placentario

41) ¿Cuál de las siguientes medidas está contraindicada en una paciente con rotura prematura de membranas, que inicia dinámica uterina a las 30 semanas de gestación?

- a) Administrar corticoides
- b) Administrar antibióticos
- c) Administrar tocolíticos
- d) Realizar amniocentesis
- e) Realizar especuloscopia

42) Una mujer, sin antecedentes mórbidos, cursando embarazo de 28 semanas presenta hemoglobina de 10 mg/dl en hemograma control. La conducta más adecuada es:

- a) Controlar con hemograma en un mes
- b) Tratar con hierro oral
- c) Descartar hemorragia oculta
- d) Administrar ácido fólico
- e) Solicitar cinética de hierro

43) ¿Cuál de las siguientes presentaciones tiene opción de parto vaginal?

- a) Nasoiliaca izquierda anterior
- b) Mentopúbica
- c) Mentosacra
- d) Nasosacra
- e) Acromioiliaca derecha posterior

44) Una paciente de 22 años, cursando embarazo de término inicia trabajo de parto. El registro estresante muestra desaceleraciones tardías en relación al 80% de las contracciones uterinas. La frecuencia cardíaca basal del feto es 130 lpm y la variabilidad es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar un tacto vaginal para determinar la vía de interrupción inmediata
- b) Solicitar ecodoppler umbilical
- c) Realizar perfil biofísico
- d) Esperar evolución espontánea
- e) Administrar corticoides endovenosos, antibióticos y tocolíticos

45) Paciente de 50 años, consulta porque sufre de escapes de orina, desde hace 6 meses, los que se han hecho más frecuentes en el último tiempo. Refiere que siente ganas muy intensas de orinar y que muchas veces le es imposible alcanzar a llegar al baño, mojando su ropa con grandes cantidades de orina. No presenta escapes con la tos ni con el Valsalva. No presenta otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Incontinencia urinaria de urgencia
- b) Infección urinaria
- c) Cistitis intersticial
- d) Incontinencia urinaria por hipoestrogenismo
- e) Incontinencia urinaria de esfuerzo

46) Una paciente de 55 años, asintomática, se realiza mamografía, como parte de su chequeo de salud, la que es informada como Birrads 4. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir la mamografía en 6 meses
- b) Solicitar ecografía mamaria
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Derivar para realizar biopsia estereotáxica
- e) Derivar para resolución quirúrgica inmediata

47) Paciente de 34 años, cursando embarazo de 8 semanas, con hiperémesis gravídica, consulta por metrorragia. Al examen físico se palpa el útero a la altura del pubis y el tacto vaginal no presenta alteraciones cervicales. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Aborto retenido
- b) Aborto incompleto
- c) Mola parcial
- d) Mola completa
- e) Embarazo ectópico

48) Paciente de 25 años, primigesta, cursando embarazo de 30 semanas ingresa por intenso dolor epigástrico y gran compromiso del estado general. Al examen se aprecia paciente en regulares condiciones generales, ictérica con frecuencia cardíaca de 125 lpm, presión arterial de 150/100 mmHg. La palpación abdominal es muy dolorosa, especialmente en el hipocondrio derecho. Se solicita proteinuria cualitativa que resulta +++ . El diagnóstico más probable es:

- a) Eclampsia
- b) Embolia de líquido amniótico
- c) Síndrome de HELLP
- d) Colestasia intrahepática del embarazo
- e) Hígado graso agudo del embarazo

49) El punto de referencia en la presentación de frente es:

- a) La frente
- b) La nariz
- c) El mentón
- d) El Bregma
- e) El Occipucio

50) ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio?

- a) Uso de anticonceptivos orales
- b) Hipertensión arterial
- c) Diabetes
- d) Obesidad
- e) Síndrome de ovario poliquístico

Prueba 4 (PEDIATRÍA + GINECOLOGÍA + OBSTETRICIA)

1) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 7 semanas, consulta por metrorragia y malestar hipogástrico. Al la especuloscopia se observa salida de sangre por el orificio cervical externo. El tacto vaginal no demuestra cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar ecografía transvaginal
- b) Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta de gonadotrofina coriónica
- c) Realizar legrado uterino
- d) Administrar progestágenos orales
- e) Enviar a domicilio con reposo e hidratación

2) Un recién nacido de término, con síntomas de dificultad respiratoria, presenta una radiografía con hili pulmonares prominentes y derrame pleural bibasal e intracisural. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Taquipnea transitoria
- c) Neumonía neonatal
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Síndrome de aspiración meconial

3) Una mujer de 25 años presenta un aborto retenido, que se resuelve con un legrado uterino. No presenta menstruaciones durante los 3 meses siguientes. Se solicita ecografía transvaginal que demuestra un endometrio de 1 mm, sin otros hallazgos de importancia. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinequias cervicales
- b) Embarazo
- c) Amenorrea de origen hipotalámico-hipofisiario
- d) Sinequias uterinas
- e) Anovulación

4) Un niño de 7 años presenta un cuadro de astenia, fiebre intermitente y sudoración de 3 semanas de duración, que ha tratado con paracetamol. Presenta además dolor en el hombro derecho y el tobillo izquierdo que limita los movimientos de dichas articulaciones. Al examen físico destaca palidez y algunas Petequias en abdomen y extremidades inferiores. La auscultación cardiopulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombocitopénico agudo
- b) Artritis séptica
- c) Endocarditis infecciosa subaguda
- d) Leucemia aguda
- e) Mononucleosis infecciosa

5) ¿En qué fase del trabajo de parto se encuentra una paciente con dilatación cervical de 10 centímetros y cabeza fetal en segundo plano de Hodge?

- a) Alumbramiento
- b) Latente
- c) Activa
- d) Quiescente
- e) Expulsivo

6) Una mujer de 22 años, cursando embarazo de 33 semanas presenta pérdida de líquido claro por genitales, que se corrobora que proviene desde la cavidad uterina a la especuloscopia. Se realiza ecografía que demuestra feto en podálica, con perfil biofísico 10/10. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar a evolución espontánea
- b) Iniciar corticoides y antibióticos hasta el inicio espontáneo del trabajo de parto
- c) Administrar corticoides y antibióticos e inducir el parto con misoprostol en 48 horas
- d) Administrar corticoides y antibióticos e interrumpir el parto en 48 horas, mediante cesárea
- e) Interrumpir el parto inmediatamente por la vía más expedita

7) Un niño de 3 años sufre un golpe en la cabeza al caer de una bicicleta. ¿Cuál de las siguientes opciones le otorga una mayor gravedad?

- a) Convulsiones de 30 segundos de duración, inmediatamente luego del golpe
- b) Pérdida de conciencia de 2 minutos
- c) Amnesia del instante de la caída
- d) Salida continua de líquido claro por la nariz
- e) hematoma subcutáneo sobre la zona del golpe

8) Un niño se sienta solo por largo rato, sin ningún apoyo, se pone de pie afirmado de algunos muebles, desconoce a los extraños y dice “mamá” y “papá”. La edad del niño es:

- a) 4 meses
- b) 6 meses
- c) 8 meses
- d) 10 meses
- e) 12 meses

9) Una paciente de 21 años consulta porque mancha la ropa interior con secreción genital. En la especuloscopia se observa leucorrea adherente, blanco-grisácea, sin signos inflamatorios en la pared vaginal. Se realiza test de KOH que produce olor a pescado podrido. El agente causal y el tratamiento de elección del cuadro descrito, son respectivamente:

- a) Cándida albicans y clotrimazol
- b) Bacterias anaerobias y metronidazol
- c) Trichomona vaginalis y fluconazol
- d) Gardnerella vaginalis y cotrimoxazol
- e) Trichomona vaginalis y metronidazol

10) La complicación más temida de la escoliosis es:

- a) Paraplejia
- b) Fracturas vertebrales
- c) Neuropatía
- d) Neumonía
- e) Hipoventilación

11) Una mujer de 33 años presenta amenorrea desde hace 5 meses, sin otros síntomas. La prueba de embarazo es negativa y la TSH y prolactina resultan normales. Se solicita prueba de progesterona que resulta negativa, al igual que la prueba de estrógenos más progesterona. Los niveles plasmáticos de gonadotropinas son normales. ¿Cuál es la etiología más probable de la amenorrea?

- a) Hipotalámica
- b) Hipofisiaria
- c) Anovulatoria
- d) Hipoestrogenismo
- e) Uterina

12) ¿Cuál de los siguientes elementos NO es característico de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica?

- a) Hematuria dismórfica
- b) Proteinuria mayor a 1 g/m2/día
- c) Hipocomplementemia
- d) Hipertensión arterial
- e) Elevación discreta de la creatinemia

13) Una primigesta inicia la percepción de los movimientos fetales. Al examen se palpa el fondo uterino a la altura del ombligo. La edad gestacional es aproximadamente:

- a) 12 semanas
- b) 18 semanas
- c) 20 semanas
- d) 24 semanas
- e) 30 semanas

14) La obesidad infantil se debe fundamentalmente a:

- a) Aumento de la disponibilidad de alimentos a nivel mundial
- b) Disfunción familiar
- c) Malos hábitos de alimentación y actividad física
- d) Predisposición genética-familiar
- e) Resistencia a la insulina

15) La mayor utilidad de la terapia de reemplazo hormonal es:

- a) Prevenir las fracturas osteoporóticas
- b) Prevenir las enfermedades cardiovasculares
- c) Prevenir la enfermedad de Alzheimer
- d) Prevenir la incontinencia urinaria y el prolapso uterino
- e) Prevenir los síntomas vasomotores

16) Una gestante de 41 semanas inicia trabajo de parto. Presenta 4 contracciones cada 10 minutos, con dilatación cervical de 7 cm, membranas rotas y feto en segundo plano de Hodge, con presentación de frente, en posición nasoiliaca izquierda anterior. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución espontánea
- b) Realizar prueba de parto con aceleración occitócica y anestesia epidural
- c) Girar la cabeza hasta posición nasopúbica y dejar evolucionar
- d) Realizar forceps
- e) Realizar cesárea

17) ¿A qué edad fija mirada un niño?

- a) 0-1 mes
- b) 2-3 meses
- c) 4-5 meses
- d) 6-7 meses
- e) 8-9 meses

18) Una mujer presenta ciclos menstruales irregulares, con tendencia a la oligomenorrea. Al examen físico se observa piel grasa, con acné facial y acantosis nigricans. El diagnóstico más probable es:

- a) Intolerancia a la glucosa
- b) Síndrome de ovario poliquístico
- c) Hiperplasia suprarrenal
- d) Hipotiroidismo
- e) Síndrome de hiperestimulación ovárica

19) La presencia de ictericia, acompañada de coluria y acolia, en un lactante de 6 semanas, se debe más probablemente a:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Síndrome de Gilbert
- c) Atresia biliar primaria
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Hepatitis viral

20) Una paciente de 32 años, consulta por dismenorrea e hipermenorrea de 6 meses de evolución. Al examen ginecológico se palpa útero de tamaño equivalente a un embarazo de 9 semanas. Se solicita ecografía transvaginal que demuestra miometrio heterogéneo y engrosado. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

- a) Neoplasia trofoblástica gestacional
- b) Endometriosis
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Cáncer de endometrio
- e) Adenomiosis

21) Un lactante de 6 meses es traído por un cuadro de 2 días de evolución de fiebre hasta 38,1°C, asociado a tos, a lo que hace algunas horas se le agregó dificultad respiratoria. Al examen físico se observa con taquipnea leve, asociada a aleteo nasal, sin uso de musculatura accesoria ni cianosis. La auscultación pulmonar demuestra escasas sibilancias difusas y la saturación de oxígeno por pulsometría es 97%. Se encuentra afebril. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar salbutamol inhalado y si responde bien, enviar a domicilio con inhalaciones de salbutamol e indicaciones de control en caso de aparición de signos de alarma
- b) Administrar oxígeno y broncodilatadores nebulizados y si responde bien, enviar a domicilio con salbutamol en aerosol y prednisona oral por 5 días, con indicaciones de reconsultar en caso de empeoramiento
- c) Administrar adrenalina racémica por nebulización y dexametasona oral y si responde bien enviar a domicilio con indicaciones de control en caso de aparición de signos de alarma
- d) Administrar broncodilatadores nebulizados y una dosis de corticoides orales, y si responde bien, enviar a domicilio con salbutamol en inhalador, asociado a amoxicilina oral
- e) Hospitalizar, administrar oxígeno, broncodilatadores inhalados, corticoides endovenosos y solicitar radiografía de tórax

22) El diagnóstico de un embarazo gemelar, en un embarazo avanzado que no ha sido controlado, se realiza con:

- a) La palpación de 2 fetos
- b) La auscultación de 2 focos de latidos cardiorfetales
- c) Los niveles plasmáticos de beta-HCG
- d) La ecografía obstétrica
- e) La radiografía de abdomen simple

23) Una mujer con promiscuidad sexual presenta una lesión ulcerada, de 1,5 cm, no dolorosa, indurada, en relación al labio mayor derecho, que no sangra ni presenta exudado. El diagnóstico más probable es:

- a) Gonorrea
- b) Linfogranuloma venéreo
- c) Sífilis
- d) Chancroide
- e) Donovanosis

24) Un niño de 6 años presenta cuadro de decaimiento y fiebre hasta 38,6°C, seguido de aparición de un exantema papulovesicular que compromete la cabeza, la cara, el tronco y la cavidad oral. El resto del examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático con paracetamol y antihistamínicos
- b) Iniciar aciclovir oral
- c) Iniciar cefadroxilo oral
- d) Iniciar corticoides orales y paracetamol
- e) Iniciar aspirina y solicitar cultivo de las lesiones

25) El recién nacido prematuro presenta mayor riesgo de presentar las patologías citadas a continuación, EXCEPTO:

- a) Enterocolitis necrotizante
- b) Ictericia fisiológica
- c) Apnea
- d) Anemia hemolítica, por incompatibilidad de grupo
- e) Sepsis neonatal

26) ¿Cuál de las siguientes alteraciones aparece en un estadio más avanzado de la insuficiencia renal crónica?

- a) Elevación de la creatinina plasmática
- b) Elevación de la paratohormona
- c) Anemia
- d) Hiperkalemia
- e) Elevación del nitrógeno ureico sanguíneo

27) ¿Cuál de las siguientes opciones es una opción válida de preparación de la leche para un niño de 7 meses?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

28) Un niño de 6 años presenta mal olor axilar en algunas oportunidades, especialmente al realizar deporte. La causa más probable de esta situación es:

- a) Hiperplasia suprarrenal congénita
- b) Pubertad precoz
- c) Activación de la producción de andrógenos suprarrenales
- d) Micosis axilar
- e) Hidrosadenitis

29) El dispositivo intrauterino se puede indicar en:

- a) Cesariada anterior
- b) Endometriosis
- c) Promiscuidad sexual
- d) Primigesta
- e) Dismenorrea

30) Un recién nacido presenta pequeñas lesiones en el dorso y alas nasales. Se observan como pequeños puntos amarillentos mínimamente solevantados, sin signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Rosácea infantil
- b) Eritema tóxico
- c) Dermatitis seborreica
- d) Vérmix caseoso
- e) Millium sebáceo

31) ¿Cuál es la clínica más probable en una paciente con un mioma intramural de 3 cm?

- a) Tumor pélvico
- b) Dismenorrea
- c) Hipermenorrea
- d) Metrorragia
- e) Asintomática

32) ¿Cuál de los siguientes alimentos no debe ofrecerse a un niño de 10 meses?

- a) Huevo
- b) Pollo
- c) Manzana
- d) Acelga
- e) Cerdo

33) Un recién nacido de 11 días presenta cuadro de rechazo alimentario y letargo. Al examen físico se observa hiporreactivo, en actitud de flexión, con reflejo de succión disminuido. El examen pulmonar demuestra escasos crépitos bibasales y la auscultación cardíaca es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos de amplio espectro y solicitar hemograma, hemocultivos y ecocardiografía
- b) Solicitar radiografía de tórax
- c) Solicitar electroencefalograma
- d) Solicitar cultivos de orina y sangre, hemograma, orina completa, radiografía de tórax y punción lumbar y decidir manejo según resultados
- e) Solicitar cultivos de orina y sangre, hemograma, orina completa, radiografía de tórax y punción lumbar e iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro, a la espera de los resultados

34) Una mujer de 40 años, multípara de 4, cursando un nuevo embarazo de 18 semanas, se pesquiza presión arterial de 154/98 mmHg en un control obstétrico. No presenta otros síntomas y el examen físico no muestra hallazgos patológicos. La proteinuria cualitativa, resulta de 2 cruces, con un máximo de cuatro. Se realiza medición de presión arterial en varias oportunidades durante 6 horas, en régimen de semihospitalización, con varias presiones cercanas a 160/100 mmHg. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión arterial crónica
- b) Hipertensión transitoria del embarazo
- c) Preclamsia moderada
- d) Preclamsia severa
- e) Embarazo normal

35) ¿Cuál de las siguientes patologías puede manifestarse con síntomas de hipertiroidismo?

- a) Preclamsia
- b) Colestasia intrahepática del embarazo
- c) Mola completa
- d) Mola parcial
- e) Hiperprolactinemia

36) Un niño de 7 años, sin antecedentes de importancia, presenta una convulsión tónico clónica de 5 minutos de duración, autolimitada. Se recupera bien y al momento de la consulta se encuentra asintomático. El examen físico, incluyendo un adecuado examen neurológico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Convulsión febril benigna
- b) Encefalitis herpética
- c) Epilepsia
- d) Tumor cerebral
- e) Meningitis

37) Una puérpera presenta importante metrorragia luego del alumbramiento. Se palpa el fondo uterino retraído, a la altura del ombligo. El diagnóstico más probable es:

- a) Inercia uterina
- b) Desgarro del canal vaginal
- c) Rotura uterina
- d) Restos ovulares
- e) Hematoma vaginal

38) El tratamiento de elección de la giardiasis intestinal es:

- a) Clindamicina
- b) Albendazol
- c) Ciprofloxacino
- d) Tinidazol
- e) Fluconazol

39) Una gestante de 33 semanas, con adecuado seguimiento obstétrico y controles previos normales, se realiza una ecografía que demuestra polihidramnios. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- b) Realizar amniocentesis
- c) Administrar corticoides y antibióticos
- d) Solicitar ecografía por especialista para descartar malformaciones fetales
- e) Interrumpir el embarazo

40) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una cardiopatía cianótica?

- a) Troco arterioso
- b) Ventrículo único
- c) Atresia tricuspídea
- d) Foramen oval permeable
- e) Tetralogía de Fallot

41) ¿Cuál de las siguientes opciones es un mejor predictor de eclampsia?

- a) Cefalea intensa
- b) Dolor epigástrico
- c) Presión arterial mayor a 180/110
- d) Reflejos osteotendíneos aumentados
- e) Proteinuria en rango nefrótico

42) Una mujer de 33 años, cursando embarazo de 39 semanas, inicia trabajo de parto, por lo que acude a la urgencia de maternidad. Ahí se constata dilatación de 8 cm, con cabeza fetal en espinas menos 1 y membranas íntegras. Durante el monitoreo fetal intraparto aparece una desaceleración, que llega hasta frecuencia fetal de 60 latidos por minutos y se mantiene en ese valor por 2 minutos. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Administrar oxígeno y poner en decúbito lateral izquierdo reevaluando cada 5 minutos
- c) Administrar oxígeno y poner en decúbito lateral derecho , reevaluando cada 5 minutos
- d) Realizar forceps
- e) Realizar rotura artificial de membranas

43) En segundo básico se administra la vacuna DT, en lugar de la vacuna DPT. Esto se debe fundamentalmente a:

- a) La baja incidencia de tos convulsiva en niños mayores
- b) La alta inmunidad alcanzada con las dosis anteriores de la vacuna DPT, contra la tos convulsiva
- c) La alta tasa de efectos adversos de la vacuna DPT en niños mayores
- d) La poca efectividad de la vacuna DPT en niños mayores
- e) La administración conjunta de la vacuna trivérica, que hace innecesaria la vacuna DPT

44) ¿Qué gases arteriales esperaría usted encontrar en un niño con estenosis hipertrófica del píloro?

- a) pH: 7,26; pCO₂: 27 mmHg: HCO₃: 13 mEq/l
- b) pH: 7,40; pCO₂: 40 mmHg: HCO₃: 24 mEq/l
- c) pH: 7,16; pCO₂: 67 mmHg: HCO₃: 26 mEq/l
- d) pH: 7,49; pCO₂: 12 mmHg: HCO₃: 16 mEq/l
- e) pH: 7,46; pCO₂: 49 mmHg: HCO₃: 32 mEq/l

45) Una paciente obesa, con antecedente de cono cervical por una NIE 3 y de várices en las extremidades inferiores ha presentado 2 abortos espontáneos a las 19 y 17 semanas respectivamente. En ambas oportunidades presentó escaso dolor y pocas contracciones uterinas. El diagnóstico más probable es:

- a) Sana
- b) Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos
- c) Abortos de origen genético
- d) Insuficiencia lútea
- e) Incompetencia cervical

46) Un niño de 9 años presenta tos frecuente, especialmente al exponerse al frío y luego de realizar ejercicio. La madre refiere que además tose en las noches mientras duerme. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Asma
- b) Bronquiolitis
- c) Hipertrofia adenoidea
- d) Cardiopatía congénita no corregida
- e) Sano

47) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de un cáncer de ovario?

- a) Mujer de 65 años con tumor ovárico quístico, con pequeñas increscencias de 6 cm de diámetro, con elevación marcada del marcador Ca-125
- b) Mujer de 36 años con 2 tumores anexiales quísticos de 4 y 7 cm de diámetro, de paredes lisas y Ca-125 normal
- c) Mujer de 25 años, con un tumor sólido quístico de 6 cm de diámetro, en el ovario derecho
- d) Mujer de 43 años, con dismenorrea, dispareunia, un tumor ovárico de 5 cm de diámetro, de contenido quístico, en patrón de vidrio esmerilado y elevación moderada del marcador Ca-125
- e) Mujer de 70 años con ascitis e ictericia

48) Una paciente cursando embarazo de 34 semanas inicia metrorragia abundante, con sangre roja brillante, sin dolor ni contracciones uterinas. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, taquicárdica, con presión arterial normal y buena perfusión periférica. Se solicita ecografía obstétrica que demuestra placenta previa oclusiva total. La especuloscopia demuestra salida de abundante sangre por el orificio cervical externo. El registro basal no estresante resulta tranquilizador. La conducta más adecuada, además de administrar cristaloides endovenosos, es:

- a) Enviar a domicilio e inducir el parto al cumplir las 37 semanas de edad
- b) Administrar corticoides e inducir el parto con misoprostol en 48 horas
- c) Administrar corticoides y realizar cesárea en 48 horas
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar cesárea inmediatamente

49) Una mujer puérpera hace 7 días presenta dolor y enrojecimiento de la mama derecha. Al examen físico se observa mama eritematosa, indurado, muy dolorosa a la palpación, con una zona fluctuante de 3 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar cefadroxilo oral, AINES y mejorar la técnica de lactancia
- b) Realizar punción y drenaje en box y enviar a domicilio con tratamiento antibiótico con flucloxacilina oral
- c) Hospitalizar, iniciar cefazolina endovenosa, puncionar y aspirar el contenido con jeringa
- d) Hospitalizar, iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje en pabellón
- e) Hospitalizar, administrar vancomicina endovenosa y realizar drenaje en pabellón

50) El tratamiento antibiótico de elección de la tos convulsiva es:

- a) Penicilina
- b) Ceftriaxona
- c) Clindamicina
- d) Claritromicina
- e) Cotrimoxazol

51) Un niño de 18 meses, sin antecedentes de importancia, es traído por fiebre hasta 38,5°C e irritabilidad, sin otros síntomas. Al examen físico destaca faringe eritematosa, sin exudado. La otoscopia muestra oído derecho normal y oído izquierdo con tímpano eritematoso y abombado. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar impedanciometría
- b) Iniciar antipiréticos y amoxicilina oral por 10 días
- c) Iniciar paracetamol y una dosis de penicilina benzatina
- d) Realizar punción timpánica e indicar amoxicilina más ácido clavulánico
- e) Iniciar tratamiento sintomático con paracetamol o AINE, sin necesidad de antibióticos

52) La diabetes pregestacional se diferencia de la diabetes gestacional, ya que la primera presenta mayor riesgo de:

- a) Polihidramnios
- b) Malformaciones congénitas
- c) Macrosomía fetal
- d) Poliglobulia neonatal
- e) Hipoglicemia neonatal

53) Un recién nacido presenta aumento de volumen de 5 cm en la cabeza, en relación al hueso parietal derecho, sin sobrepasarlo. El resto del examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Craneosinostosis
- b) Hidrocefalia
- c) Bolsa serosanguínea
- d) Deformación plástica del cráneo
- e) Cefalohematoma

54) Una mujer cursando embarazo de 24 semanas, consulta por disuria y poliaquiuria, de 2 días de evolución, sin otros síntomas. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita sedimento de orina con 20 leucocitos por campo y urocultivo, que está pendiente. La conducta más adecuada es:

- a) Esperar resultado de urocultivo y decidir tratamiento antibiótico con el antibiograma
- b) Iniciar cefradina oral y controlar con el resultado del urocultivo
- c) Iniciar ceftriaxona endovenosa y controlar con el urocultivo
- d) Iniciar nitrofurantoína oral y controlar en 7 días
- e) Iniciar ciprofloxacino oral y controlar en 7 días

55) Una niña de 7 años, extranjera, consulta por un cuadro de 4 días de evolución, que comenzó con malestar general, artralgias, ligera odinofagia y fiebre hasta 38,2°C, a lo que se agregó un exantema eritematoso generalizado, macular, de color rosado. En el examen físico destacan además varias adenopatías cervicales posteriores. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarampión
- b) Rubeola
- c) Eritema infeccioso
- d) Exantema súbito
- e) Escarlatina

56) Paciente de 38 años con nódulo mamario indoloro, de bordes imprecisos. La mamografía revela imagen nodular, con espículas en todos sus márgenes, y 10 microcalcificaciones finas, agrupadas en el interior. El diagnóstico más probable, entre los que se citan, es:

- A) Fibroadenoma
- B) Quiste
- C) Displasia mamaria
- D) Carcinoma
- E) Mamografía normal para la edad de la paciente

57) ¿Cuál de los siguientes parámetros disminuye normalmente durante el embarazo?

- a) Frecuencia cardíaca
- b) Volemia
- c) Hematocrito
- d) Filtración glomerular
- e) Fosfatasas alcalinas

58) Un lactante de 5 meses presenta mal incremento ponderal e infecciones respiratorias recurrentes. Al examen físico destaca un soplo continuo, con componentes sistólico y diastólico, mayor en el foco aórtico. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Coartación aórtica
- c) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- d) Tronco arterioso
- e) Persistencia del ductus arterioso

59) Un niño de 6 años, consulta por cuadro de rinorrea, decaimiento y eritema periocular derecho. Al examen físico se constata dicho eritema alrededor del ojo derecho, con oculomotilidad normal, reflejos corneales y fotomotores conservados, agudeza visual 20/20 bilateral, sin proptosis. El diagnóstico más probable es:

- a) Etmoiditis
- b) Conjuntivitis bacteriana aguda
- c) Dacrocistitis aguda
- d) Celulitis preseptal
- e) Celulitis orbitaria

60) Un niño presenta fiebre y aparición de lesiones purpúricas de pequeño tamaño en las extremidades inferiores, la que crecen luego de algunas horas, apareciendo otras lesiones similares en el tronco y asociándose a importante deterioro del estado general. Al examen se observa en regulares condiciones generales, con perfusión límite y sopor. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombocitopénico inmune
- b) Leucemia linfática aguda
- c) Púrpura de Shoenlein-Henoch
- d) Síndrome hemolítico urémico
- e) Meningococemia

61) Los síntomas más frecuentemente referidos en las pacientes con prolapso genital son:

- a) Incontinencia urinaria y leucorrea
- b) Prurito y metrorragia
- c) Dispareunia y sinusorragia
- d) Sensación de peso y humedad genital
- e) Disuria y dolor genital

62) Las siguientes opciones son causantes de hipermenorrea, EXCEPTO:

- a) Anticonceptivos orales
- b) Enfermedad de Von Willebrand
- c) Útero doble
- d) Dispositivo intrauterino
- e) Pólipo endometrial

63) Un niño de 7 años es diagnosticado de hemofilia tipo A, en relación a historia de hemorragias fáciles y hemartrosis. Su madre cursa un nuevo embarazo de 35 semanas, con feto masculino. ¿Cuál es la probabilidad de este nuevo niño de padecer la enfermedad?

- a) 0%
- b) 25%
- c) 33%
- d) 50%
- e) 100%

64) El screening de cáncer de cuello uterino, durante el embarazo debe realizarse con:

- a) Papanicolaou luego del parto
- b) Papanicolaou en el primer control, a las 28 semanas y luego del parto
- c) Papanicolaou en una oportunidad, sin realizar cepillado endocervical
- d) Papanicolaou en una oportunidad, que incluya el cepillado endocervical
- e) Coloposcopia en una oportunidad

65) ¿Cuál de las siguientes patologías es más frecuente en usuarias de anticonceptivos orales?

- a) Cáncer de ovario
- b) Cáncer de endometrio
- c) Cáncer de cuello uterino
- d) Cáncer de mama
- e) Cáncer de estómago

66) Un recién nacido, por cesárea de urgencia debida a sufrimiento fetal, presenta hipotonía y apnea al nacer. Se realiza estimulación táctil y se constata cianosis marcada y frecuencia cardíaca de 90 lpm, luego de 60 segundos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar masaje cardíaco
- b) Realizar ventilación a presión positiva con oxígeno
- c) Secar y asegurar un ambiente con temperatura adecuada
- d) Administrar adrenalina endovenosa
- e) Administrar oxígeno, estimular por 60 segundos más y reevaluar

67) Una mujer de 44 años, nulípara, con antecedente de hipertensión arterial, presenta metrorragia moderada de 3 días de evolución, que cede espontáneamente. El examen físico, así como la ecografía transvaginal son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con indicación de control en caso de recurrencia de los síntomas
- b) Solicitar Papanicolaou
- c) Solicitar colposcopia y biopsia
- d) Solicitar biopsia endometrial
- e) Iniciar anticonceptivos orales para ciclar las menstruaciones

68) La primera causa de muerte en adolescentes es:

- a) Accidentes de tránsito
- b) Cáncer
- c) Suicidio
- d) Infecciones respiratorias
- e) Anomalías genéticas

69) La conducta más adecuada ante un Papanicolaou, que demuestra atipías de grado moderado, es:

- a) Solicitar nuevo Papanicolaou en 30 días
- b) Solicitar nuevo Papanicolaou en 3 meses
- c) Solicitar colposcopia y biopsia
- d) Realizar curetaje endocervical
- e) Realizar biopsias cervicales de los 4 cuadrantes

70) Una niña de 10 años es la más baja de su curso. Su madre mide 1,68 metros y su padre 1,82 metros. El examen físico resulta normal. Al revisar su curva de crecimiento, se encuentra en el percentil 6 para su edad y presenta una velocidad de crecimiento normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cariograma
- b) Solicitar LH, FSH y estradiol
- c) Iniciar análogos de GNRH
- d) Solicitar radiografía de carpo
- e) Explicarle a los padres que la altura de la niña es la esperada para su carga genética

Prueba 5

1) Una paciente de 36 años, multípara de 3, con dos cesáreas anteriores, cursando actualmente un embarazo de 30 semanas, sufre salida de líquido con “olor a cloro” por los genitales. Al examen físico se aprecia sin dinámica uterina ni modificaciones cervicales y el perfil biofísico resulta 10/10. Se realiza test de cristalización que visualiza “hojas de helecho”. La conducta más adecuada es:

- a) Permitir evolución espontánea
- b) Interrumpir el parto con misoprostol
- c) Interrumpir el parto mediante cesárea
- d) Administrar corticoides y antibióticos endovenosos e interrumpir el embarazo en 48 horas
- e) Administrar corticoides y antibióticos y mantener una conducta expectante

2) Una paciente con amenorrea de 4 meses de evolución se realiza test de embarazo que resulta negativo, prolactina y TSH normales y prueba de progesterona positiva. La etiología más probable es:

- a) Anovulación
- b) Falla ovárica primaria
- c) Hipofisiaria
- d) Hipotalámica
- e) Uterina

3) Un recién nacido presenta dificultad respiratoria y la radiografía de tórax muestra pulmones en patrón de “vidrio esmerilado”, con broncograma aéreo. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Neumonía neonatal
- e) Hipertensión pulmonar persistente

4) Una mujer de 34 años, cursando un embarazo de 6 semanas, por FUR, se realiza una ecografía transvaginal que visualiza un endometrio de 14 mm de grosor, sin presencia de gestación intrauterina, ni otras alteraciones. Se solicita beta-HCG, que resulta 2.200 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Repetir la ecografía y la HCG en 48 horas
- b) Repetir la ecografía y la HCG en 7 días
- c) Realizar legrado uterino
- d) Administrar metotrexato
- e) Tratar quirúrgicamente de inmediato, mediante laparotomía

5) Una mujer de 68 años, multípara de 5 consulta por sensación de peso y humedad genital frecuente. Al examen físico se aprecia cistocele que se asoma 2 cm por fuera del introito, aumentando con la maniobra de Valsalva. El tratamiento más adecuado es:

- a) Histerectomía
- b) Ejercicios de Koegel
- c) Observación
- d) Colporrafia anterior
- e) Colporrexis

6) Un niño de 6 años presenta episodio de inicio súbito de compromiso de conciencia, asociado a contracción en flexión de las extremidades superiores y en extensión de las extremidades inferiores, seguido de movimientos repetitivos de todas las extremidades, de cerca de 3 minutos de duración. Al examen físico está en buenas condiciones, sin signos focales y no recuerda lo sucedido. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor cerebral
- b) Epilepsia primaria
- c) Epilepsia focal
- d) Esclerosis múltiple
- e) Convulsión inocente

7) Un recién nacido de 33 semanas de edad gestacional presenta taquipnea y dificultad respiratoria que iniciaron 2 horas después de nacer y que fueron progresando rápidamente. Al examen físico está taquipneico, con aleteo nasal y cianosis generalizada. Presenta crepitaciones pulmonares escasas, bilaterales y requiere FiO₂:40% para saturar normalmente. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Neumonía neonatal
- e) Hipertensión pulmonar persistente

8) Una mujer de 29 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dinámica uterina. Al examen físico se aprecian 2 contracciones cada 20 minutos y se palpa el cuello uterino cerrado, sin borramiento. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar amniocentesis
- b) Administrar corticoides y tocolíticos
- c) Administrar corticoides y antibióticos
- d) Administrar corticoides, tocolíticos y antibióticos
- e) Monitorizar evolución de la dinámica uterina y solicitar cervicometría ecográfica

9) El tratamiento de elección de la tricomoniasis vaginal es:

- a) Clindamicina
- b) Cotrimoxazol
- c) Metronidazol
- d) Fluconazol
- e) Doxiciclina

10) Un paciente de 5 años presenta cefalea y rigidez de nuca, por lo que se realiza punción lumbar que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 120 células por mm³, de predominio mononuclear, con glucosa: 60 mg/dl y proteínas: 50 mg/dl. El agente etiológico más probable es:

- a) Meningococo
- b) Neumococo
- c) Bacilo de Koch
- d) Enterovirus
- e) Virus herpes simple

11) Un niño de 10 años es muy desobediente, pelea frecuentemente con sus compañero y golpea a los animales. Además fue sorprendido robando en una oportunidad, reaccionando de manera muy agresiva. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Depresión infantil
- d) Trastorno por déficit atencional del adulto
- e) Trastorno adaptativo

12) Una mujer de 28 años, puérpera hace 7 días, consulta por dolor en la mama izquierda. Al examen físico se aprecia mama aumentada de volumen, eritematosa, con presencia de una zona fluctuante de 4 cm de diámetro en el cuadrante inferomedial. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar analgésicos orales y mejorar la técnica de lactancia
- b) Iniciar penicilina G endovenosa
- c) Iniciar cloxacilina endovenosa
- d) Iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje por punción con aguja
- e) Iniciar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico en pabellón

13) Una mujer de 32 años acude a control ginecológico y en el tacto vaginal se palpa un tumor anexial a derecha. Se solicita ecografía que visualiza un tumor de 5 cm de diámetro, de aspecto quístico en el ovario derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar anexectomía laparoscópica
- b) Realizar tumorectomía laparoscópica con biopsia rápida intraoperatoria
- c) Solicitar biopsia por punción
- d) Iniciar progestágenos en dosis altas y controlar en un mes
- e) Iniciar anticonceptivos orales y controlar en 3 meses

14) Un recién nacido de término de 7 días de vida, alimentado con leche materna exclusiva, pesó 3.500 gramos al nacer. Actualmente pesa lo mismo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar relleno, manteniendo la lactancia materna
- b) Iniciar relleno y suspender la lactancia materna
- c) Indicar mejoría en la técnica de lactancia materna y solicitar control en 24 horas
- d) Indicar extracción de leche materna y alimentación con leche extraída y cuantificada
- e) Mantener controles habituales, sin necesidad de medidas adicionales

15) ¿Cuál de las siguientes cardiopatías es cianótica?

- a) Tronco arterioso
- b) Comunicación interauricular
- c) Comunicación interventricular
- d) Coartación aórtica
- e) Canal aurículoventricular

16) Una mujer de 30 años, multipara de 2, con una cesárea anterior, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto. El último tacto vaginal mostró dilatación cervical de 8 cm, con feto en presentación occipito-sacra, en el primer plano de Hodge. Inicia contracciones uterinas muy dolorosas, asociadas a metrorragia escasa. El dolor aumenta considerablemente, desapareciendo las contracciones uterinas y apareciendo signos de sufrimiento fetal en el registro cardiotocográfico. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Acretismo placentario
- c) Desprendimiento de placenta
- d) Rotura uterina
- e) Rotura de vasa previa

17) ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación del uso de anticonceptivos orales?

- a) Antecedentes familiares de cáncer de ovario
- b) Obesidad
- c) Oligomenorrea
- d) Metrorragia de causa no precisada
- e) Endometriosis

18) Un niño de 8 meses ha presentado 3 crisis obstructivas en los últimos 3 meses, que iniciaron luego de una bronquiolitis por VRS. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar corticoides inhalados según horario y salbutamol inhalado según síntomas
- b) Indicar salbutamol inhalado según horario y según síntomas
- c) Indicar salmeterol inhalado según horario y salbutamol inhalado según síntomas
- d) Indicar corticoides orales según horario y salbutamol inhalado según síntomas
- e) Indicar salbutamol inhalado según síntomas

19) Un niño de 7 años presenta edema generalizado, asociado a orinas espumosas. Al examen físico presenta signos vitales normales sin alteraciones adicionales. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 0,6 mg/dl, sedimento de orina con gotas de grasa, albuminemia: 2,4 g/dl, colesterol: 300 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 1,6 g/m3, complemento normal, ANA negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar biopsia renal
- c) Iniciar corticoides
- d) Iniciar alfametildopa y furosemida
- e) Iniciar diuréticos

20) Una mujer de 26 años, cursando embarazo de 38 semanas, inicia trabajo de parto. Al examen físico se aprecia dinámica uterina de 3 CU cada 10 minutos, con dilatación cervical de 2 cm y borramiento completo. El feto está en presentación cefálica y se observa presencia de varias vesículas en relación al labio mayor izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar aciclovir endovenoso durante el trabajo de parto
- b) Realizar cesárea de inmediato
- c) Administrar aciclovir y antibióticos durante el trabajo de parto
- d) Dejar evolución espontánea
- e) Administrar aciclovir endovenoso durante el trabajo de parto y luego al recién nacido

21) ¿Qué terapia de reemplazo hormonal debe recibir a una mujer climática, sin otros antecedentes de importancia y con marcados síntomas vasomotores?

- a) Estrógenos orales
- b) Progestágenos orales
- c) Estrógenos + progestágenos orales
- d) Raloxifeno
- e) Estrógenos tópicos

22) Un recién nacido presenta 3 pequeñas pápulas blanquecinas en la línea media del paladar duro. El diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis
- b) Millium
- c) Dientes supernumerarios
- d) Perlas de Ebstein
- e) Hiperplasia linfonodular

23) Un niño de 6 años presenta aparición de múltiples petequias y equimosis generalizadas. Además ha presentado varias epistaxis en los últimos 2 días. La madre refiere que estuvo resfriado recientemente. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfática aguda
- b) Leucemia mieloide crónica
- c) Púrpura trombocitopénica inmune
- d) Enfermedad de Von Willebrand
- e) Linfoma

24) Una mujer multipara de 1, cursando un nuevo embarazo de 41 semanas, se realiza inducción del parto con misoprostol, iniciando el trabajo de parto. Presenta 4 contracciones cada 10 minutos y al tacto vaginal se aprecia dilatación cervical de 6 cm, con cuello completamente borrado, feto en presentación de vértice, con membranas íntegras. Se reevalúa 2 horas después, sin constatar cambios. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea
- b) Realizar fórceps
- c) Realizar rotura de membranas
- d) Iniciar goteo oxitócico
- e) Observar evolución

25) Una mujer de 65 años presenta metrorragia autolimitada en una oportunidad. Se solicita ecografía transvaginal que visualiza endometrio de 12 mm de grosor, sin hallazgos patológicos. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar nueva ecografía transvaginal en 1 mes
- c) Realizar legrado uterino
- d) Solicitar biopsia con Pipelle
- e) Realizar histerectomía total

26) Un niño de 2 años presenta claudicación de la marcha. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales, pero cojea levemente. Presenta dolor a la movilización de la cadera izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteomielitis
- b) Sinovitis transitoria
- c) Artritis séptica
- d) Enfermedad de Perthes
- e) Síndrome de Osgood-Schlatter

27) Una niña de 1 año presenta una pielonfritis aguda, la que es tratada con cefadroxilo con buena respuesta. Se realiza una ecografía renal y vesical que resulta normal y una uretrocistografía miccional, que demuestra presencia de reflujo vesicoureteral leve (grado 1). La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cateterismo limpio
- b) Solicitar pielografía de eliminación
- c) Indicar profilaxis antibiótica y controlar con urocultivos seriados
- d) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- e) Observar evolución

28) Una puérpera de 48 horas presenta metrorragia moderada, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Neoplasia trofoblástica gestacional
- b) Hematoma del canal vaginal
- c) Laceración del canal del parto
- d) Inercia uterina
- e) Restos ovulares

29) Una mujer se realiza un PAP, que visualiza células con atipias de alto grado. Se solicita colposcopia que visualiza una lesión de 1 cm, que es biopsiada, demostrándose la presencia de un carcinoma escamoso infiltrante de grado moderado de diferenciación. La palpación de los parametrios no sugiere invasión. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cono cervical
- b) Realizar histerectomía total
- c) Realizar histerectomía radical
- d) Realizar tumorectomía
- e) Iniciar tratamiento paliativo

30) Los embarazos suelen interrumpirse antes de las 42 semanas de gestaciones, especialmente porque el recién nacido post-término tiene MAYOR riesgo de presentar:

- a) Asfixia
- b) Anemia
- c) Enfermedad de membrana hialina
- d) Malformaciones congénitas
- e) Hipoglicemia

31) Un niño de 18 meses presenta una hernia umbilical de 1 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar uso de faja
- b) Observar evolución
- c) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- d) Resolver quirúrgicamente a los 24 meses
- e) Indicar kinesioterapia para fortalecimiento de la musculatura abdominal

32) Respecto al embarazo gemelar es verdadero que:

- a) La corionicidad se diagnostica habitualmente en el segundo trimestre del embarazo
- b) El síndrome de transfusión feto-fetal es característico de los embarazos bicoriales, biamnióticos
- c) Tiene mayor riesgo de parto prematuro y de restricción del crecimiento intrauterino
- d) Los monocigóticos son en su mayoría bicoriales
- e) Los monocoriales son en su mayoría monoamnióticos

33) Los miomas intramurales habitualmente se diagnostican en relación a:

- a) Hipermenorrea
- b) Metrorragia
- c) Palpación de masa abdominal
- d) Dismenorrea
- e) Hallazgo en ecografías ginecológicas

34) Un niño de 3 años presenta fiebre y vómitos de un día de evolución, seguidos de diarrea acuosa explosiva y dolor abdominal tipo cólico. Al examen físico está en buenas condiciones, sin signos de deshidratación. ¿Qué conducta es MENOS adecuada?

- a) Administrar sales de rehidratación oral
- b) Suspender la alimentación sólida, indicando régimen hídrico
- c) Indicar antiespasmódicos en caso de dolor abdominal
- d) Indicar paracetamol en caso de fiebre o malestar
- e) Indicar medidas de higiene

35) ¿Qué examen es más adecuado para diagnosticar una malaabsorción intestinal?

- a) Endoscopia digestiva alta y biopsia
- b) Anticuerpos anti-endomisio
- c) Test de Sudan
- d) Test de D-xilosa
- e) Colonoscopia y biopsia

36) Una mujer de 19 años, cursando su primer embarazo, de 33 semanas presenta un cuadro de cefalea, malestar general y náuseas de cerca de una semana de evolución. Hace 20 minutos presenta una convulsión tónico-clónica. Al examen físico está soporosa, con FC: 108x', PA: 160/100, edema de EEI y ROT aumentados. Se instala sonda Foley que da salida a orina con proteinuria cualitativa ++++. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar sulfato de magnesio intravenoso e interrumpir el embarazo mediante cesárea
- b) Solicitar TAC de cerebro y administrar fenitoína por SNG
- c) Administrar lorazepam endovenoso e interrumpir el embarazo mediante cesárea
- d) Administrar labetalol endovenoso y solicitar proteinuria de 24 horas
- e) Administrar sulfato de magnesio intravenoso y mantener conducta expectante

37) Respecto al ciclo menstrual, es verdadero que:

- a) En la fase folicular la progesterona suele estar elevada
- b) El periodo fértil se extiende desde la ovulación hasta 5 días después de ésta
- c) La ovulación suele estar precedida por un peak en los niveles plasmáticos de hormona luteinizante
- d) La menstruación se debe a una descamación del endometrio, precipitada por una caída en los niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona
- e) La duración normal del ciclo es entre 21 y 35 días

38) Un recién nacido, con antecedente de una bradicardia sostenida durante el trabajo de parto, nacido por cesárea de urgencia, presenta apgar 2 al minuto. Se inicia estimulación y se aporta oxígeno, reevaluándose a los 30 segundos, sin lograr mejoría y constatándose FC: 50 lpm. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Iniciar masaje cardíaco
- b) Iniciar ventilación a presión positiva
- c) Realizar intubación orotraqueal
- d) Administrar atropina endovenosa
- e) Administrar adrenalina endovenosa

39) Un niño de 4 años cursando una disentería, de 2 días de evolución, presenta malestar general y oliguria. Al examen físico está algo pálido, con FC: 88x', PA: 130/80 mmHg y edema de extremidades inferiores. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar sales de rehidratación oral
- b) Indicar sales de rehidratación oral y antibióticos orales
- c) Indicar sales de rehidratación oral y antibióticos endovenosos
- d) Indicar bolo con suero fisiológico y antibióticos endovenosos
- e) Hospitalizar para estudio

40) Durante un trabajo de parto se constata un registro cardíaco fetal con presencia de desaceleraciones tardías en el 80% de las contracciones uterinas. La conducta más adecuada es:

- a) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- b) Solicitar perfil biofísico
- c) Solicitar ecografía doppler umbilical
- d) Dejar evolución espontánea bajo monitorización
- e) Acelerar el parto mediante oxitocina endovenosa

41) Una paciente de 34 años consulta por leucorrea y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia leucorrea amarillenta escasa, dolor a la palpación hipogástrica, a la palpación anexial izquierda y a la movilización cervical. Las paredes vaginales se aprecian sin signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Vaginitis bacteriana
- b) Tricomoniasis vaginal
- c) Candidiasis vaginal
- d) Proceso inflamatorio pélvico
- e) Vulvovaginitis inespecífica

42) Las malformaciones congénitas más frecuentes son:

- a) Nefrourológicas
- b) Cardíacas
- c) Nerviosas
- d) Digestivas
- e) Óseas

43) Un niño de 5 años consulta por fiebre y malestar general de 7 días de evolución. Al examen físico destaca esplenomegalia y palidez. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,2 g/dl, plaquetas: 56.000 x mm³, blancos: 35.000 x mm³, linfocitos: 89%, la mayoría de ellos atípicos, neutrófilos: 7% y monocitos: 3%. El diagnóstico más probable es:

- a) Fiebre
- b) Reacción leucemoide
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Leucemia linfática aguda
- e) Púrpura trombocitopénico trombótico

44) Una mujer de 30 años, cursando embarazo de 8 semanas por FUR, presenta metrorragia y dolor abdominal bajo, asociada a taquicardia y ortostatismo. Se solicita ecografía transvaginal que muestra ausencia de gestación intrauterina, con presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar culdocentesis
- b) Iniciar metotrexato
- c) Solicitar beta-HCG plasmática
- d) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- e) Realizar legrado uterino

45) La asociación de hipermenorrea, dismenorrea y aumento del tamaño uterino, debe hacer sospechar:

- a) Embarazo molar
- b) Adenomiosis
- c) Hiperplasia endometrial
- d) Cáncer de endometrio
- e) Endometriosis

46) Un niño de 5 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de un exantema macular, eritematoso, generalizado, con compromiso de las mejillas, el tronco y la zona proximal de las extremidades, en disposición reticular. El agente etiológico más probable es;

- a) Enterovirus
- b) Virus herpes 6
- c) Streptococcus pyogenes
- d) Parvovirus B19
- e) Virus de la rubeola

47) ¿Qué vacuna puede administrarse en un paciente con inmunodepresión severa?

- a) BCG
- b) Trivírica
- c) Varicela
- d) Polio oral
- e) DPT

48) La causa más frecuente de abortos es:

- a) Provocados
- b) Alteraciones genética
- c) Insuficiencia lútea
- d) Incompetencia cervical
- e) Síndrome anifosfolípidos

49) La causa más frecuente de metrorragia en la edad fértil es:

- a) Disfuncional
- b) Uso de DIU
- c) Cáncer de endometrio
- d) Cáncer de cuello uterino
- e) Atrofia endometrial

50) Un recién nacido de 3 días de vida, con antecedente de asfixia neonatal, con buena respuesta a la reanimación, presenta decaimiento, vómitos frecuentes y marcada distensión abdominal. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis hipertrófica del píloro
- b) Atresia duodenal
- c) Duplicidad intestinal
- d) Enterocolitis necrotizante
- e) Enfermedad de Hirschsprung

51) Un niño es capaz de caminar, puede subirse a una silla, ayuda a desvestirse y ha comenzado a comer solo. Además conoce algunas partes de su cuerpo y pide las cosas por su nombre, pudiendo decir varias palabras de manera incorrecta, sin formar frases. La edad aproximada es:

- a) 12 meses
- b) 18 meses
- c) 24 meses
- d) 36 meses
- e) 48 meses

52) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 30 semanas consulta por metrorragia oscura y contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se aprecia útero hipertónico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía doppler de arterias umbilicales
- b) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- c) Administrar tocolíticos y corticoides y mantener una conducta expectante
- d) Administrar tocolíticos y corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas
- e) Administrar tocolíticos y corticoides e interrumpir el embarazo al cumplir las 32 semanas de edad gestacional

53) Una mujer presenta escapes de pequeñas cantidades de orina, cuando de ríe o cuando realiza esfuerzos físico. Esto le trae problemas de autoestima y ha afectado sus actividades habituales. Se descarta la presencia de infección urinaria y se inician ejercicios y medidas conductuales, sin lograr resultados. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticolinérgicos
- b) Iniciar antiadrenérgicos alfa
- c) Resolver mediante cirugía
- d) Iniciar antiadrenérgicos beta
- e) Iniciar procolinérgicos

54) Un lactante de 9 meses presenta, desde hace unos meses, lesiones recidivantes papulares y microvesiculares eritematosas en las mejillas y en los codos. Al examen físico se aprecia ojeroso, con las lesiones descritas, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit de vitamina A
- b) Déficit de vitamina C
- c) Dermatitis atópica
- d) Sarna
- e) Pénfigo del lactante

55) Un niño se traga una bolita de vidrio, evolucionando con dolor cervical, sialorrea e imposibilidad de tragar. La conducta más adecuada es:

- a) Retirar el cuerpo extraño mediante endoscopia
- b) Retirar el cuerpo extraño de manera quirúrgica
- c) Solicitar radiografías seriadas cada 12 horas
- d) Solicitar radiografías seriadas cada 24 horas
- e) Tranquilizar al niño y a la madre y observar evolución

56) ¿Cuál de las siguientes pacientes tiene diagnóstico de diabetes mellitus gestacional?

- a) Mujer embarazada con glicemia de ayuno de 190 mg/dl
- b) Mujer embarazada con glicemia postprandial de 206 mg/dl
- c) Mujer embarazada con 2 glicemias de ayuno de 120 y 110 mg/dl respectivamente
- d) Mujer embarazada con TTOG con 75 g de glucosa, con glicemia a las 2 horas de 138 mg/dl
- e) Mujer embarazada con poliuria, polifagia, podipsia y una glicemia de 169 mg/dl

57) ¿Cuál de las siguientes pacientes tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio?

- a) Mujer usuaria de anticonceptivos orales
- b) Mujer con promiscuidad sexual
- c) Mujer obesa e hipertensa, con síndrome de ovario poliquístico
- d) Mujer múltipara de 8
- e) Mujer con antecedente de cáncer de mama

58) Un recién nacido de 4 semanas de vida presenta ictericia de piel y mucosas, asociado a coluria y acolia. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipotiroidismo
- b) Ictericia fisiológica
- c) Ictericia por lactancia materna
- d) Atresia biliar primaria
- e) Ictericia hemolítica

59) La primera causa de hipertensión arterial crónica en los pacientes de edad pediátrica es:

- a) Esencial
- b) Renovascular
- c) Insuficiencia renal
- d) Hiperaldosteronismo primario
- e) Cáncer

60) Una mujer de 25 años, cursando su primer embarazo, de 36 semanas, consulta por poliaquiuria y astenia. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico II/VI en el segundo espacio intercostal derecho. Se solicitan exámenes generales que muestran RBNE reactivo, glicemia: 89 mg/dl, hemograma con hemoglobina: 11,5 g/dl, blancos: 10.000 x mm³, plaquetas: 450.000 x mm³, sedimento de orina normal, glucosuria +/- y urocultivo negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento con nitrofurantoína oral
- b) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
- c) Solicitar ecocardiografía y hemocultivos
- d) Iniciar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
- e) Observar evolución

61) ¿Qué método anticonceptivo indicaría a una mujer de 23 años, con promiscuidad sexual?

- a) Anticonceptivos orales combinados
- b) Anillo vaginal medicado
- c) Dispositivo intrauterino
- d) Preservativo
- e) Ligadura de trompas

62) Una niña de 7 años es la más baja de su curso. Sus padres son altos y ella está en percentil 1 para su edad. Su cuello es corto y ancho y su tórax es ancho y plano. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Retraso constitucional del crecimiento
- b) Enfermedad celíaca
- c) Síndrome de Turner
- d) Acondroplasia
- e) Déficit de GH

63) Un recién nacido de 7 días de vida presenta decaimiento y fiebre hasta 38,8°C. No presenta otros síntomas y el examen físico no muestra otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar antipiréticos y solicitar hemograma, sedimento de orina y urocultivo
- c) Solicitar hemograma, hemocultivos, exámenes de orina, urocultivos y estudio de líquido cefalorraquídeo y administrar antibióticos endovenosos de amplio espectro, hasta completar el estudio
- d) Solicitar hemograma, sedimento de orina y urocultivos e iniciar cefadroxilo y antipiréticos orales
- e) Solicitar hemograma, hemocultivos, exámenes de orina, urocultivos y estudio de líquido cefalorraquídeo y decidir tratamiento según hallazgos

64) Una mujer embarazada de 33 semanas consulta por disminución de la percepción de movimientos fetales. Se solicita registro basal no estresante, que muestra frecuencia cardíaca fetal de 115 lpm, con variabilidad de 20 lpm y presencia de varias aceleraciones de hasta 35 lpm, en relación a algunos movimientos. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio
- b) Alargar el registro, por 20 minutos adicionales
- c) Solicitar perfil biofísico
- d) Solicitar eco-doppler de arterias umbilicales
- e) Interrumpir el embarazo

65) Una mujer de 56 años se realiza una mamografía que es informada como Birrads 2. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva mamografía en un mes
- b) Solicitar nueva mamografía en un año
- c) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
- d) Solicitar ecografía mamaria
- e) Solicitar biopsia estereotáxica

66) Un niño cumplió un año de edad. ¿Qué tipo de leche debe recibir?

- a) LPF 5 %, azúcar 2.5 %, cereal 3 %
- b) LPF 7.5 %, azúcar 5 %, aceite 5 %
- c) LPF 7.5 %, azúcar 2.5 %, cereal 3 %
- d) LPF 10 %, azúcar 2.5 %, cereal 3 %
- e) LPF 10 %, azúcar 5 %, cereal 2.5 %

67) El tratamiento de primera línea del coqueluche suele ser:

- a) Penicilina
- b) Ceftriaxona
- c) Macrólidos
- d) Quinolonas
- e) Tetraciclina

68) La elevación de la alfafetoproteína es característica de:

- a) Diabetes gestacional
- b) Síndrome de Down
- c) Síndrome de Potter
- d) Defectos del cierre del tubo neural
- e) Infección por CMV

69) Un bebé es capaz de fijar la mirada y presenta sonrisa social. Presenta tono muscular en flexión, con las manos empuñadas la mayor parte del tiempo y con presencia de los reflejos de moro, prensión plantar y prensión palmar. ¿Qué edad tiene?

- a) 2 meses
- b) 4 meses
- c) 6 meses
- d) 8 meses
- e) 10 meses

70) Un recién nacido de 24 días de vida es traído por su madre, ya que presenta regurgitaciones frecuentes de leche. Refiere que todos los días vomita 1 o 2 veces. Ha mantenido un buen incremento ponderal y no presenta alteraciones en el examen físico. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis hipertrófica del píloro
- b) Enterocolitis necrotizante
- c) Enfermedad de Hirschsprung
- d) Atresia duodenal
- e) Reflujo gastroesofágico del lactante

Prueba 6

1) Una paciente de 34 años acude a control ginecológico, en el cual se palpa una masa anexial izquierda. Se solicita ecografía transvaginal que muestra un tumor ovárico de 6 cm de diámetro, de aspecto sólido-quístico. Se inician anticonceptivos orales, sin embargo un mes después presenta intenso dolor pélvico izquierdo, de inicio súbito y asociado a náuseas y vómitos alimentarios. El diagnóstico más probable es:

- a) Cuerpo lúteo hemorrágico
- b) Torsión ovárica
- c) Endometrioma roto
- d) Embarazo ectópico roto
- e) Ovulación dolorosa

2) La conducta más adecuada frente a una paciente que sufre una rotura prematura ovular a las 31 semanas de embarazo es:

- a) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- b) Interrumpir el embarazo bajo cobertura antibiótica
- c) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas
- d) Administrar corticoides e iniciar tratamiento antibiótico, manteniendo una conducta expectante
- e) Dejar evolución espontánea

3) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta un síndrome de dificultad respiratoria, caracterizado por aleteo nasal y taquipnea. Al examen físico se auscultan escasos crépitos pulmonares difusos y la radiografía de tórax muestra hilios pulmonares prominentes con redistribución del flujo sanguíneo hacia los ápices. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de aspiración meconial
- b) Cardiopatía congénita
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Taquipnea transitoria
- e) Enfermedad de membrana hialina

4) ¿En qué momento se debe administrar la vacuna BCG a un recién nacido prematuro?

- a) A los 2 meses de edad
- b) A los 6 meses de edad
- c) Al alcanzar los 2 kilogramos de peso
- d) Al doblar el peso de nacimiento
- e) Al momento de nacer

5) Una mujer de 30 años, nulípara, consulta por hipermenorrea y astenia. Se solicita un hemograma que muestra una anemia microcítica, un perfil de hierro sugerente de ferropenia y una ecografía transvaginal que muestra un mioma submucoso de 3,5 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar sulfato ferroso oral y realizar histerectomía total
- b) Iniciar sulfato ferroso oral y realizar miomectomía por histeroscopia
- c) Iniciar sulfato ferroso oral y progestágenos orales
- d) Iniciar sulfato ferroso oral y estrógenos orales
- e) Iniciar sulfato ferroso oral y administrar análogos de la GnRH por 6 meses, controlando con nueva ecografía y nuevo hemograma

6) Una paciente de 20 años, cursando un embarazo de 30 semanas, inicia dinámica uterina. Al examen se constata 3 contracciones cada 10 minutos. Se realiza tacto vaginal que corrobora borramiento cervical de un 60%, sin dilatación. Se solicita una cervicometría ecográfica, que muestra un cuello uterino de 10 mm de longitud. Además se constata persistencia de la dinámica uterina, luego de 30 minutos de observación. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos e iniciar protocolo de tocolisis
- b) Iniciar corticoides y antibióticos po vía endovenosa
- c) Realizar amniocentesis
- d) Iniciar progestágenos y controlar en 48 horas
- e) Observa evolución, dejando a evolución espontánea

7) A los 2 meses de edad un niño que no recibe lactancia materna se debe alimentar con:

- a) LPF 7,5% + azúcar 2,5% + aceite 1,5%, tomar 150 cc/kg/día
- b) LPF 7,5% + azúcar 2,5% + aceite 1,5%, tomar 180 cc/kg/día
- c) LPF 10% + azúcar 2,5% + cereal 3%, tomar 180 cc/kg/día
- d) LPF 10% + azúcar 2,5% + aceite 1,5%, tomar 120 cc/kg/día
- e) LPF 7,5% + azúcar 2,5% + cereal 3%, tomar 150 cc/kg/día

8) Un niño de 6 años, sin antecedentes de importancia vive con su madre, quien fue recientemente diagnosticada de tuberculosis pulmonar bacilífera. El niño está en buenas condiciones, sin síntomas. Tiene sus vacunas al día y se solicita una radiografía de tórax, que resulta normal y un PPD que resulta negativo. La conducta más adecuada con el niño es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar radiografías de tórax seriadas
- c) Solicitar PPD seriados
- d) Solicitar baciloscopías
- e) Iniciar isoniazida

9) Una paciente de 34 años de IMC: 23, consulta porque desde hace un año sus reglas son irregulares y suceden cada 40 a 60 días. Refiere que además presenta astenia y piel seca. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de ovario poliquístico
- b) Hipotiroidismo
- c) Anemia ferropénica
- d) Falla ovárica prematura
- e) Climaterio

10) Una paciente de 38 años, embarazada de 10 semanas, presenta hiperémesis gravídica, síntomas de hipertiroidismo y desde hace 24 horas también metrorragia. El diagnóstico más probable es:

- a) Struma ovari
- b) Teratoma maligno
- c) Teratoma quístico benigno
- d) Embarazo molar
- e) Embarazo gemelar

11) La leche materna se caracteriza por:

- a) Ser rica en hierro
- b) Ser rica en glóbulos blancos maternos, que brindan protección al recién nacido
- c) Contener una alta carga proteica, comparada con la leche de vaca
- d) Contener una alta carga osmolar, comparada con la leche de vaca
- e) Ser rica en ácidos grasos esenciales

12) Un niño de 9 años consulta por hematuria, asociada a edema de extremidades inferiores. Al examen físico presenta hipertensión arterial y edema de EEII, sin otras alteraciones. Se solicita sedimento de orina que muestra cilindros hemáticos, creatinina plasmática que resulta 0,5 mg/dl y complemento que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrótico
- b) Síndrome nefrítico
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Necrosis tubular aguda
- e) Glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva

13) Los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de:

- a) Trombosis venosa profunda
- b) Cáncer de ovario
- c) Cáncer de cuello uterino
- d) Mastopatía fibroquística
- e) Osteoporosis

14) Una mujer de 37 años, cursando embarazo de 30 semanas, consulta por metrorragia abundante, roja brillante, sin otros síntomas. No presenta dinámica uterina, la especuloscopia demuestra que la sangre proviene del OCE y el tacto vaginal no muestra modificaciones cervicales. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Acretismo placentario
- c) Desprendimiento de placenta
- d) Embarazo molar
- e) Síntomas de aborto

15) Un recién nacido de término de 5 días de evolución, presenta ictericia desde hace 2 días, que actualmente compromete la cara y el tronco. Actualmente se alimenta con lactancia materna y ha bajado 250 gramos de peso, pesando actualmente 3.200 gramos. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia hemolítica
- b) Ictericia por leche materna
- c) Ictericia fisiológica
- d) Ictericia por hipotiroidismo
- e) Atresia biliar primaria

16) El síndrome nefrótico secundario a una nefrosis lipoidea suele presentarse como:

- a) Edema, orinas espumosas, proteinuria y lipiduria
- b) Edema, hipertensión y proteinuria
- c) Edema, hematuria, proteinuria y dislipidemia
- d) Hipertensión arterial, proteinuria, trombocitopenia y palidez
- e) Edema, proteinuria y disminución del complemento y hematuria

17) ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para el desarrollo de un proceso inflamatorio pélvico?

- a) Uso de anticonceptivos orales
- b) Multiparidad
- c) Edad mayor a 40 años
- d) Múltiples parejas sexuales
- e) Endometriosis

18) Una paciente de 19 años, cursando un embarazo de 32 semanas, presenta PA: 150/100 mmHg en una toma de presión arterial. El perfil biofísico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar clearance de creatinina y proteinuria de 24 horas
- b) Realizar semihospitalización para tomas seriadas de presión arterial por 6 horas
- c) Iniciar alfametildopa
- d) Solicitar pruebas hepáticas, LDH, proteinuria de 24 horas, hemograma y tiempos de coagulación
- e) Solicitar Holter de presión arterial

19) Un niño de 4 años continúa orinándose en la cama mientras duerme. Su continencia diurna es normal y no presenta otros síntomas ni alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía renal y vesical
- b) Solicitar osmolaridad urinaria y plasmática
- c) Solicitar glicemia de ayuno
- d) Solicitar sedimento de orina y urocultivo por sondeo
- e) Observar evolución

20) Un niño con un cuadro meníngeo se realiza un punción lumbar que da salida a un líquido con 890 células por mm³, 85% de mononucleares y 15% de polimorfonucleares, con glucosa: 30 mg/dl, proteínas: 196 mg/dl. La tinción de Gram no visualiza bacterias. El agente más probable es:

- a) Neumococo
- b) Meningococo
- c) Enterovirus
- d) Virus herpes simplex
- e) Mycobacterium tuberculosis

21) Una mujer de 33 años consulta por leucorrea y prurito vaginal. Refiere que un mes atrás tomó amoxicilina como parte del tratamiento de una sinusitis aguda. A la especuloscopia se aprecia leucorrea grumosa, blanquecina. El diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis vaginal
- b) Vaginosis bacteriana
- c) Tricomoniasis vaginal
- d) Vulvovaginitis inespecífica
- e) Infección por Chlamydia trachomatis

22) Una mujer de 30 años, cursando embarazo de 7 semanas por amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza saco gestacional. Se solicita beta-HCG, que resulta 600 UI/l. Se repite la ecografía dos días después, sin visualizarse cambios y también se pide una nueva beta-HCG, que resulta 800 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Mola parcial
- b) Mola completa
- c) Embarazo ectópico
- d) Aborto completo
- e) Embarazo de menor edad gestacional

23) Un recién nacido de 2 días de vida presenta vómitos explosivos después de tomar leche, que iniciaron desde que inició la lactancia. Se aprecia deshidratado y la radiografía de abdomen muestra una imagen de doble burbuja. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis hipertrófica del píloro
- b) Invaginación intestinal
- c) Enterocolitis necrotizante
- d) Enfermedad de Hirschsprung
- e) Atresia duodenal

24) La conducta más adecuada frente a un recién nacido hijo de madre con VIH es:

- a) Suspender la lactancia materna y solicitar Elisa para VIH
- b) Suspender la lactancia materna y solicitar western blot para VIH
- c) Mantener la lactancia materna y solicitar carga viral
- d) Suspender la lactancia materna e iniciar triterapia
- e) Mantener la lactancia materna y solicitar western blot

25) Identifique la asociación CORRECTA:

- a) Incontinencia urinaria de esfuerzo – Escape de grandes cantidades de orina
- b) Incontinencia urinaria de urgencia – Debilidad del piso pélvico
- c) Incontinencia urinaria de urgencia – Buena respuesta a bloqueadores alfa adrenérgicos
- d) Incontinencia urinaria de esfuerzo – Buena respuesta al tratamiento farmacológico con anticolinérgicos
- e) Fístula vesicovaginal – Goteo continuo de orina

26) Una paciente de 20 años de embarazo, cursando un embarazo de 35 semanas, presenta una altura uterina de 28 cm. Se solicita ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en el percentil 6 para la edad gestacional, con líquido amniótico normal y sin alteraciones anatómicas. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cesárea de urgencia
- b) Inducir el parto con misoprostol
- c) Indicar reposo y controlar frecuentemente a la paciente, con perfil biofísico y doppler umbilical
- d) Solicitar amniocentesis y realizar estudio de líquido amniótico
- e) Administrar corticoides intravenosos a la madre e interrumpir el embarazo en 48 horas

27) ¿Qué antecedente representa la MENOR gravedad en contexto de un niño que se golpeó la cabeza contra el suelo?

- a) Equimosis retroauricular
- b) Otorraquia
- c) Cefalea intensa y progresiva
- d) Desorientación y amnesia transitorias
- e) Vómitos explosivos y frecuentes

28) ¿Qué es lo más constante en el examen físico de un paciente con una síndrome de Guillain-Barré?

- a) Arreflexia
- b) Hipoventilación
- c) Compromiso de conciencia
- d) Hipoestesia
- e) Oftalmoplejia

29) Una paciente de 45 años se realiza un PAP que muestra células escamosas con atipias de alto grado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cono biopsico
- b) Solicitar nuevo PAP en 3 meses
- c) Derivar a colposcopia
- d) Solicitar PCR para virus papiloma humano
- e) Realizar histerectomía radical

30) Una paciente de 29 años, cursando embarazo de 9 semanas, presenta metrorragia escasa, asociada a dolor abdominal. Al examen físico está taquicárdica, con PA: 110/70, sin otros signos de importancia. Se solicita ecografía transvaginal que muestra ausencia de gestación intrauterina, con presencia de líquido libre abundante en la cavidad peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
- b) Solicitar nueva ecografía en 3 semanas
- c) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- d) Iniciar metotrexato
- e) Solicitar nueva ecografía en 2 días

31) Un paciente de 8 años presenta tos y disnea luego de trotar o jugar fútbol. La madre refiere que tose mucho en las noches y además en ocasiones ha presentado respiración ruidos. Al examen presenta espiración prolongada y escasas sibilancias bilaterales. La radiografía de tórax es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar TAC de tórax
- b) Solicitar prick test
- c) Solicitar niveles plasmáticos de IgE
- d) Solicitar espirometría
- e) Iniciar salbutamol SOS

32) El tratamiento de una ITU baja en la edad pediátrica, puede hacerse con:

- a) Doxiciclina
- b) Metronidazol
- c) Nitrofurantoína
- d) Clindamicina
- e) Amoxicilina

33) Una mujer de 55 años, obesa y diabética, consulta por metrorragia. Al examen físico se palpa el útero aumentado de tamaño, como de un embarazo de 8 semanas. Se solicita ecografía transvaginal que muestra endometrio heterogéneo de 15 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Adenomiosis
- b) Endometriosis
- c) Cáncer de endometrio
- d) Atrofia endometrial
- e) Miomatosis uterina

34) ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a una paciente con un test de tolerancia a las contracciones que muestra una frecuencia cardíaca fetal que se mantiene en 80lpm por 2 minutos?

- a) Solicitar un eco-doppler de arterias umbilicales
- b) Interrumpir el embarazo por la vía más expedita
- c) Tranquilizar a la madre y enviar a domicilio
- d) Solicitar un perfil biofísico
- e) Iniciar oxitocina endovenosa

35) El recién nacido prematuro tiene mayor riesgo de:

- a) Síndrome de aspiración meconial
- b) Displasia de cadera
- c) Cardiopatías congénitas
- d) Hipocalcemia neonatal
- e) Síndrome de Sown

36) Un niño de 4 años consulta por fiebre alta de 5 días de evolución, asociado a ojo rojo bilateral y aparición de un exantema maculopapular generalizado. Al examen físico se palpan algunas adenopatías cervicales y se observa además edema de los pies y las manos. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarampión
- b) Quinta enfermedad
- c) Exantema súbito
- d) Púrpura de Schonlein Henoch
- e) Enfermedad de Kawasaki

37) Una mujer de 60 años consulta porque se palpó un nódulo mamario izquierdo, indoloro. Al examen físico se aprecia un nódulo de 2 cm de diámetro, de consistencia dura, difícil de movilizar y asociado a una reacción cutánea localizada en “piel de naranja”. El diagnóstico más probable es:

- a) Fibroadenoma
- b) Papiloma invertido
- c) Enfermedad de Paget
- d) Mastopatía fibroquística
- e) Cáncer de mama

38) Una mujer presenta un trabajo de parto en fase de expulsivo, constatándose presentación de cara, palpándose el mentón en relación con el sacro. La dinámica uterina es 4 CU cada 10 minutos y el registro fetal es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Girar manualmente hasta posición mentosacra
- b) Realizar fórceps
- c) Realizar cesárea
- d) Iniciar goteo oxitócico
- e) Dejar evolucionar el parto bajo monitorización

39) Un niño de 7 años, sin sus vacunas al día, consulta por malestar general, fiebre hasta 38,7°C, artralgias y aparición de un exantema macular rosado, generalizado. Al examen físico se palpan adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores. El cuadro clínico corresponde a:

- a) Rubéola
- b) Sarampión
- c) Quinta enfermedad
- d) Escarlatina
- e) Exantema súbito

40) El síndrome de Klinefelter presenta todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Cariograma 47 XXY
- b) Talla baja
- c) Testículos pequeños
- d) Aumento de los niveles plasmáticos de gonadotropinas
- e) Retraso puberal

41) Una mujer de 59 años, usuaria de terapia de remplazo hormonal, desde hace 5 años, decide discontinuar la TRH, por consejo de su médico. Al tercer día de haberla suspendido presenta metrorragia escasa. El examen físico no aporta mayor información. La consulta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía transvaginal
- b) Solicitar biopsia endometrial
- c) Iniciar estrógenos locales
- d) Reiniciar la terapia de remplazo hormonal
- e) Tranquilizar a la paciente y explicarle la normalidad del síntoma

42) Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 40 semanas, inicia dinámica uterina, por lo que es ingresada a la sala de parto. Al examen físico presenta 3 contracciones cada 10 minutos y se palpa el feto en presentación cefálica. El tacto vaginal muestra cuello completamente borrado, con dilatación de 5 cm, membranas rotas y feto en presentación de vértice, variante OIIA en espinas -2. El registro fetal muestra FCF: 130 lpm, con variabilidad 15 lpm, sin desaceleraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aceleración oxitócica
- b) Realizar cesárea
- c) Dejar evolucionar el parto
- d) Realizar fórceps
- e) Realizar rotación manual hasta posición occipito-púbica

43) Un recién nacido de término, sin antecedentes de importancia, presenta cianosis marcada desde el nacimiento, que no responde a oxígeno a altas concentraciones, saturando cerca de 70% a FiO2: 50%. Al examen físico presenta examen pulmonar normal y auscultación cardíaca sin presencia de soplos. El diagnóstico más probable es:

- a) Comunicación interauricular
- b) Comunicación interventricular
- c) Transposición de grandes vasos
- d) Coartación aórtica
- e) Ductus arterioso persistente

44) Un niño de 1 año consulta por dolor abdominal muy intenso, asociado a eliminación de deposiciones rojas en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Divertículo de Meckel complicado
- b) Invaginación intestinal
- c) Hiperplasia linfonodular
- d) Adenitis mesentérica
- e) Embolia mesentérica

45) ¿Qué situación orienta MÁS al origen orgánico de una dispareunia?

- a) Dolor a la especuloscopia
- b) Edad menor a 30 años
- c) Dolor a la penetración profunda
- d) Aparición desde la primera relación sexual
- e) Dolor intenso al tacto vaginal

46) Una mujer de 25 años, presenta su primer parto hace 4 días. Consulta por dolor mamario bilateral. Al examen físico se aprecian mamas de consistencia aumentada, dolorosas a la palpación, sin presencia de eritema ni de zonas fluctuantes. El diagnóstico más probable es:

- a) Mastitis linfangítica
- b) Congestión mamaria
- c) Absceso mamario
- d) Glándula mamaria accesoria
- e) Hiperprolactinemia

47) Un lactante de 30 días de vida presenta fiebre hasta 39°C, asociado a decaimiento. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos y controlar en 48 horas
- b) Solicitar urocultivo y sedimento de orina
- c) Solicitar urocultivo, sedimento de orina y hemograma
- d) Solicitar urocultivo, sedimento de orina, hemograma, hemocultivos y radiografía de tórax
- e) Solicitar urocultivo, sedimento de orina, hemograma, hemocultivos, radiografía de tórax, estudio de líquido cefalorraquídeo e iniciar antibióticos endovenosos

48) Un niño de 1 años presenta fiebre hasta 40 grados, convulsionando en una oportunidad con una crisis tónico-clónica, la que duró ceca de 2 minutos. Al examen físico está en buenas condiciones, reactivo, con t°: 38,7°C, sin signos focales ni otras alteraciones en el examen físico, excepto por faringe eritematosa y pequeñas adenopatías cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con antipiréticos
- b) Enviar a domicilio con antipiréticos y anticonvulsivantes
- c) Solicitar RMN de cerebro
- d) Solicitar electroencefalograma
- e) Solicitar hemograma, hemocultivos, punción lumbar y TAC de cerebro

49) Una paciente de 35 años, consulta por ausencia de menstruación desde hace 5 meses. El test de embarazo resulta negativo. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Indicar anticonceptivos orales y controlar en 3 meses
- b) Solicitar ecografía transvaginal
- c) Solicitar una prueba de estrógenos más progesterona
- d) Solicitar niveles plasmáticos de estrógenos, progesterona y gonadotropinas
- e) Solicitar TSH, prolactinemia y prueba de progesterona

50) Una mujer múltipara de 3, con una cesárea anterior, presenta trabajo de parto a las 41 semanas de embarazo. Al momento de romper las membranas presenta metrorragia moderada, seguida de aparición de signos de sufrimiento fetal. El estado de la mujer es bueno y la dinámica uterina es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de placenta
- b) Acretismo placentario
- c) Rotura uterina
- d) Rotura de vasa previa
- e) Placenta previa

51) Un niño de 4 años presenta diarrea crónica, asociada a piel seca, caída del pelo, queilitis, detención del crecimiento y anemia microcítica. El diagnóstico más probable es:

- a) Acidosis tubular renal
- b) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- c) Inmunodeficiencia por déficit de IgA
- d) Enfermedad celíaca
- e) Fibrosis quística

52) Un niño de 3 años presenta cefalea de varios días de evolución, asociada a ataxia progresiva y caídas frecuentes. En una oportunidad presenta además una crisis convulsiva. El diagnóstico más probable es:

- a) Cerebelitis postinfecciosa
- b) Tumor del sistema nervioso central
- c) Hematoma intracraneano
- d) Meningitis tuberculosa
- e) Meningitis neumocócica

53) Una mujer, trabajadora sexual, consulta por una lesión indolora en la zona genital. Al examen físico se aprecia una úlcera de fondo limpio, indurada, de 1 cm de diámetro. El agente causal más probable es:

- a) Gonococo
- b) Clamidia
- c) Treponema pallidum
- d) Tricomona
- e) Haemophilus ducreyi

54) Una mujer de 30 años presenta abundante metrorragia postparto, cercana a 1.000 cc. Al examen físico se palpa el útero a nivel del apófisis xifoides. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar masaje uterino e iniciar metilergonovina endovenosa
- b) Realizar masaje uterino e iniciar sulfato de magnesio endovenoso
- c) Realizar revisión instrumental del canal de parto
- d) Observar evolución
- e) Realizar ligadura de arterias uterinas

55) Un recién nacido presenta aumento de volumen y edema de la cabeza y la cara, que compromete la zona frontal y parietal izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Deformación plástica de la cabeza
- b) Cefalohematoma
- c) Bolsa serosanguínea
- d) Meningitis bacteriana aguda
- e) Hidrocefalia

56) Un niño de 7 años consulta por un cuadro de tos y expectoración de 14 días de evolución, que en los últimos días ha empeorado. Al examen físico presenta sibilancias y crepitaciones en ambas bases pulmonares. Se solicita radiografía de tórax que muestra un patrón alveolointersticial bilateral, mayor en la base derecha. El agente causal más probable es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Virus influenza
- c) Mycoplasma
- d) Neumococo
- e) Haemophilus influenza

57) Una mujer se realiza un PAP que es informado como satisfactorio con presencia de células glandulares atípicas, sin alteraciones en las células escamosas. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar coposcopia con curetaje endocervical
- b) Realizar cono biopsico
- c) Solicitar biopsia de endometrio
- d) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
- e) Solicitar nuevo PAP en un año

58) Una mujer de 36 años, hipertensa crónica, en tratamiento con enalapril, presenta embarazo, por lo que se suspende el enalapril y se inicia alfametildopa. A las 30 semanas inicia malestar general y se aprecia edema marcado de extremidades inferiores, manteniendo cifras tensionales cercanas a 160/100 mmHg, a pesar del medicamento y de seguir una dieta hiposódica. Se solicita proteinuria cualitativa que resulta +++. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertensión renovascular
- b) Síndrome antifosfolípido
- c) Preclamsia sobreagregada
- d) Insuficiencia renal
- e) Hipertensión transitoria del embarazo

59) Un niño de 5 años inicia un cuadro de fiebre baja, rinorrea y tos, que ceden completamente luego de 3 días con tratamiento sintomático. Una semana después presenta aparición de múltiples petequias generalizadas y de algunas equimosis, ante pequeños traumatismos. Se solicita un hemograma, que muestra Hb: 14 mg/dl, Hematocrito: 41%, plaquetas: 60.000 x mm³, blancos: 6.500 x mm³, con 31% de linfocitos, 63% de neutrófilos, 5% de monocitos y 2% de eosinófilos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar corticoides orales
- b) Indicar reposo relativo y observar evolución
- c) Derivar para esplenectomía
- d) Solicitar biopsia de médula ósea
- e) Administrar inmunoglobulina endovenosa

60) ¿Qué tipo de manifestaciones esperaría encontrar en un niño con déficit de inmunoglobulina G?

- a) Otitis, sinusitis, neumonías y meningitis a repetición, que inician después de los 6 meses de vida
- b) Neumonías y diarreas a repetición, alergia e infecciones por protozoos, que inician después de los 6 meses de vida
- c) Otitis, sinusitis, neumonías y meningitis a repetición, que inician antes de los 6 meses de vida
- d) Neumonías y diarreas a repetición, alergia e infecciones por protozoos, que inician antes de los 6 meses de vida
- e) Meningococcemias a repetición desde el nacimiento

61) Una paciente, puérpera hace 4 semanas, dando lactancia materna, presenta metrorragia en varias oportunidades. Se realiza un test de embarazo que resulta positivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Embarazo ectópico
- b) Síntomas de aborto
- c) Neoplasia trofoblástica gestacional
- d) Restos ovulares
- e) Endometritis aguda

62) Una mujer se realiza un test de tolerancia a la glucosa como parte de los estudios rutinarios de un embarazo de 38 semanas. Como resultado se obtiene glicemia basal: 100 mg/dl y glicemia 2 horas post 75 gramos de glucosa: 130 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta y ejercicio
- b) Iniciar metformina
- c) Iniciar insulina
- d) Solicitar glicemia de ayuno
- e) Observar evolución

63) ¿A qué edad se cierra normalmente la fontanela POSTERIOR?

- a) 3 a 6 meses
- b) 6 a 9 meses
- c) 9 a 18 meses
- d) 12 a 24 meses
- e) 24 a 36 meses

64) La primera causa de muerte en la edad escolar es:

- a) Infecciones respiratorias
- b) Accidentes de tránsito
- c) Malformaciones congénitas
- d) Cáncer
- e) Meningitis bacteriana

65) ¿Qué método anticonceptivo indicaría a una mujer puérpera reciente, que está dando lactancia materna y que no desea tener más hijos por el momento?

- a) Dispositivo intrauterino
- b) Anticonceptivos combinados orales
- c) Anticonceptivos orales con estrógenos solos
- d) Esterilización quirúrgica
- e) Anillo vaginal medicado

66) El mejor parámetro para evaluar la edad gestacional entre las 7 y las 10 semanas de embarazo es:

- a) Diámetro biparietal
- b) Circunferencia abdominal
- c) Longitud cefalotal
- d) Niveles plasmáticos de HCG
- e) Diámetro del saco gestacional

67) La tasa de mortalidad neonatal precoz corresponde a:

- a) Muertes producidas entre las 28 semanas de gestación y las 24 horas postnacimiento/ nacidos vivos
- b) Muertes producidas entre las 28 semanas de gestación y los 7 días postnacimiento/ nacidos vivos
- c) Muertes producidas entre el nacimiento y las 24 horas postnacimiento/ nacidos vivos
- d) Muertes producidas entre el nacimiento y los siete días de vida/ nacidos vivos
- e) Muertes producidas entre el nacimiento y los 28 días de vida/ nacidos vivos

68) Un paciente de 6 años presenta un cuadro caracterizado por fiebre, malestar general y odinofagia. Al examen físico se aprecian varias vesículas en el paladar blando y algunas vesículas en ambas palmas de las manos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aciclovir oral
- b) Iniciar oseltamivir
- c) Iniciar penicilina
- d) Iniciar paracetamol
- e) Solicitar IgM para virus varicela zóster

69) Un lactante se ríe a carcajadas cuando interactúa con un adulto. Además es capaz de mantener el control de la cabeza sin problemas, mientras se lo mantiene sentado, sin embargo no puede mantenerse sentado por sí mismo. En oportunidades es capaz de tomar objetos con la mano y llevárselos a la boca. ¿Qué edad tiene aproximadamente?

- a) 2 meses
- b) 4 meses
- c) 6 meses
- d) 8 meses
- e) 10 meses

70) ¿Cuán pesa un feto de 36 semanas de edad gestacional en promedio?

- a) 1.000 gr aproximadamente
- b) 1.500 gr aproximadamente
- c) 2.000 gr aproximadamente
- d) 2.500 gr aproximadamente
- e) 3.000 gr aproximadamente

Prueba 7

1) ¿Cuál de las siguientes es una indicación de cesárea?

- a) Peso fetal de 4.700 gramos
- b) Condiloma acuminado
- c) Antecedente de conización cervical
- d) Antecedente de una cesárea previa
- e) Multípara de 5 hijos

2) Un recién nacido de 34 semanas de edad gestacional presenta taquipnea, asociada a quejido. Al examen físico se aprecia aleteo nasal y cianosis perioral, asociados a crépitos pulmonares escasos, bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax que muestra ambos pulmones con un patrón de vidrio esmerilado, con presencia de broncograma aéreo. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Taquipnea transitoria
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Cardiopatía congénita
- e) Neumonía neonatal

3) Una paciente consulta porque en varias ocasiones presenta intensos deseos de orinar, que no es capaz de controlar, por lo que presenta graves escapes de orina, lo que ha afectado significativamente su calidad de vida y sus actividades fuera de la casa. El diagnóstico más probable es:

- a) Incontinencia urinaria de urgencia
- b) Incontinencia urinaria de esfuerzo
- c) Fístula vesicovaginal
- d) Vejiga neurogénica
- e) Incontinencia de orina por rebalse

4) La visualización de cocáceas gram negativas, en diplos, en el líquido cefalorraquídeo de un niño con un cuadro meníngeo es altamente sospechoso de:

- a) Meningitis por neumococo
- b) Meningitis por meningococo
- c) Meningitis por Haemophilus influenzae
- d) Meningitis por Listeria
- e) Meningitis por estafilococo áureo

5) Una paciente 31 años, cursando un embarazo de 10 semanas, consulta por metrorragia. La ecografía muestra feto intrauterino, con presencia de latidos cardíofetales. Al examen físico se aprecia metrorragia escasa y el tacto vaginal muestra borramiento del 80%, con 2 cm de dilatación. La conducta más adecuada es:

- a) Conducir el trabajo de aborto
- b) Solicitar subunidad beta-HCG plasmática
- c) Administrar progestágenos
- d) Enviar a domicilio, indicando reposo
- e) Realizar cerclaje de emergencia

6) Un niño de 6 años, consulta por edema facial y de extremidades inferiores, asociado a orinas espumosas. Al examen físico está en buenas condiciones, sin otros síntomas. Se solicitan exámenes generales, que muestran creatinina: 0,6 mg/dl, albuminemia: 2,9 g/dl, colesterol: 300 mg/dl, sedimento de orina normal y proteinuria de 24 horas de 2,9 gramos. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome nefrítico
- b) Síndrome nefrótico
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Pielonefritis aguda
- e) Necrosis tubular aguda

7) Una paciente de 34 años acude a control ginecológico, en el que le palpan un tumor anexial izquierdo. Se solicita ecografía transvaginal, que muestra un tumor anexial quístico de 4,2 cm de diámetro y de contenido anecogénico. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia por punción con aguja fina
- b) Iniciar ACO y realizar seguimiento ecográfico
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Realizar ooforectomía bilateral
- e) Realizar tumorectomía laparoscópica

8) Un niño de 7 años presenta un cuadro caracterizado por epistaxis en varias oportunidades, asociada a la aparición de múltiples petequias generalizadas. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar biopsia de médula ósea
- b) Solicitar hemograma
- c) Solicitar TTPA y tiempo de protrombina
- d) Observar evolución, indicando reposo
- e) Iniciar corticoides orales

9) Una paciente embarazada se realiza una glicemia de ayuno a las 8 semanas de gestación, que resulta 115 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar una nueva glicemia de ayuno a las 28 semanas de edad gestacional
- b) Solicitar un TTOG a las 28 semanas de edad gestacional
- c) Solicitar una nueva glicemia de ayuno de inmediato
- d) Solicitar un TTOG de inmediato
- e) Iniciar dieta y ejercicios y controlar con glicemias de ayuno y postprandiales

10) Un recién nacido de término, que pesó 3.000 Kg, presenta una zona de hipetricosos lumbar, de 3 cm de diámetro. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Síndrome de Down
- b) Neurofibromatosis
- c) Espina bífida
- d) Hiperplasia suprarrenal congénita
- e) Recién nacido normal

11) El factor pronóstico más importante en el cáncer de cuello uterino es:

- a) Presencia de virus papiloma humano
- b) Presencia de ganglios linfáticos comprometidos
- c) Invasión de los parametrios
- d) Tamaño del tumor
- e) Grado de diferenciación histológica

12) Un niño de 7 años es traído por sus padre, ya que es muy bajo. Se revisa la curva de crecimiento y se aprecia que se ha mantenido creciendo en el percentil 5 para su edad, en los últimos años. La edad ósea resulta equivalente a la de un niño de 5 años y medio. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit de GH
- b) Talla baja familiar
- c) Enfermedad celíaca
- d) Retraso constitucional del crecimiento
- e) Acondroplasia

13) La principal hormona del crecimiento fetal es:

- a) Somatomedina
- b) Somatotrofina
- c) Insulina
- d) Lactógeno placentario
- e) Tiroxina

14) Un niño de 5 años sufre una convulsión tónicoclónica, mientras jugaba con su madre. No ha presentado otros síntomas y su examen físico es normal, al igual que sus exámenes generales (hemograma, pruebas hepáticas, electrolitos y pruebas de función renal). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Convulsión febril benigna
- b) Epilepsia
- c) Tumor cerebral
- d) Meningitis viral
- e) Síndrome hemolítico urémico

15) Una niña de 6 años presenta disuria y leucorrea. Al examen físico se aprecia leucorrea blanquecina escasa, asociada a signos inflamatorios de la mucosa vulvar y vaginal. El diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis
- b) Vulvovaginitis inespecífica
- c) Tricomoniasis
- d) Vaginosis bacteriana
- e) Cuerpo extraño vaginal

16) Un niño de 6 años consulta por leve odinofagia, asociada a fiebre hasta 38,5°C y un exantema macular eritematoso, que inició en ambas mejillas, similar a una cachetada y que luego se extendió al tronco y a las extremidades, con disposición reticular. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aciclovir oral más tratamiento sintomático
- b) Iniciar paracetamol
- c) Solicitar IgM para sarampión e iniciar tratamiento sintomático
- d) Solicitar IgM para rubeola e iniciar tratamiento sintomático
- e) Iniciar amoxicilina oral más tratamiento sintomático

17) Una paciente, cursando un embarazo de 32 semanas, con todos sus controles normales, se realiza una ecografía obstétrica, que demuestra presencia de una placenta previa oclusiva total. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo por cesárea, a las 37 semanas o en caso de complicación
- b) Administrar corticoides y antibióticos e interrumpir el embarazo por cesárea, a las 34 semanas o en caso de complicación
- c) Administrar corticoides y realizar cesárea en 48 horas
- d) Administrar corticoides y antibióticos y realizar cesárea en 48 horas
- e) Mantener conducta expectante, realizando controles ecográficos semanales hasta que inicie espontáneamente el trabajo de parto, momento en que debe realizarse una cesárea

18) ¿Qué leche puede darse a un recién nacido que no recibe lactancia materna?

- a) LPF al 7,5%, con azúcar al 2,5% y cereal al 3%
- b) LPF al 10%, con azúcar al 5% y cereal al 3%
- c) LPF al 7,5%, con azúcar al 2,5% y aceite al 3%
- d) LPF al 7,5%, con azúcar al 2,5% y aceite al 1,5%
- e) LPF al 10%, con azúcar al 5% y aceite al 3%

19) ¿Qué método anticonceptivo es más eficaz, siendo adecuadamente utilizado?

- a) Preservativo
- b) Método de Billings
- c) Anticonceptivos orales
- d) "T" de cobre
- e) Diafragma con espermicida

20) El ductus arterioso persistente se aprecia clínicamente como:

- a) Cianosis + soplo sistólico eyectivo + desdoblamiento fijo del segundo ruido
- b) Cianosis + soplo holosistólico
- c) Cianosis + soplo continuo
- d) Soplo continuo, sin cianosis
- e) Soplo sistólico eyectivo + desdoblamiento fijo del segundo ruido, sin cianosis

21) Una mujer de 19 años, cursando embarazo de término, inicia el trabajo de parto. Presenta 4 contracciones 10 minutos, con dilatación cervical de 6 cm y feto en presentación OIIA, con membranas íntegras. El registro fetal muestra FCF de 130 lpm, con desaceleraciones tardías, en relación a la mayoría de las contracciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar oxitocina
- b) Realizar rotura artificial de membranas
- c) Realizar fórceps
- d) Administrar nifedipino
- e) Realizar cesárea de urgencia

22) Un lactante de 8 meses de edad presenta un cuadro caracterizado por tos, rinorrea, fiebre hasta 38,8°C y dificultad respiratoria. Al examen físico se aprecia taquipnea, retracción intercostal y se ausculta sibilancias inspiratorias. Se solicita radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial bilateral en ambas bases. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus parainfluenza
- b) Streptococcus pneumoniae
- c) Mycoplasma pneumoniae
- d) Adenovirus
- e) Virus respiratorio sincicial

23) Son causas de hipermenorrea, EXCEPTO:

- a) Hiperplasia endometrial
- b) Mioma submucoso
- c) Pólipo endometrial
- d) Enfermedad de Von Willebrand
- e) Uso de DIU

24) Son causa habitual de disentería, EXCEPTO:

- a) Giardia lamblia
- b) Entamoeba histolytica
- c) Shigella
- d) Escherichia coli
- e) Enfermedades inflamatorias intestinales

25) Una mujer de 20 años, puerpera hace 5 días, consulta por fiebre hasta 38,6°C y dolor mamario. Al examen físico se aprecia eritema de ambas mamas, mayor a izquierda, doloroso a la palpación, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Indicar cabergolina
- c) Iniciar cloxacilina endovenosa
- d) Iniciar penicilina endovenosa y realizar drenaje quirúrgico
- e) Iniciar eritromicina oral

26) Un recién nacido de 21 días presenta ictericia hasta los muslos. Se solicita bilirrubina diferenciada que resulta, bilirrubina total: 10 mg/dl y bilirrubina directa: 1,3 mg/dl. El diagnóstico más probable, entre los mencionados, es:

- a) Hemólisis por incompatibilidad Rh
- b) Hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- c) Ictericia fisiológica
- d) Atresia biliar primaria
- e) Hipotiroidismo congénito

27) ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de endometrio?

- a) Anovulación crónica
- b) Multiparidad
- c) Uso de anticonceptivos orales
- d) Uso del dispositivo intrauterino
- e) Promiscuidad sexual

28) ¿Qué vacuna puede recibir un paciente con una inmunodepresión severa?

- a) Anti-varicela
- b) Anti-pneumocócica
- c) Anti-sarampión
- d) Anti-polio oral (Sabin)
- e) BCG

29) Una mujer de 37 años, cursando su tercer embarazo de 39 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas, asociadas a metrorragia. Al examen físico se observa que la metrorragia proviene del OCE, se palpa útero hipertónico, con feto en presentación de vértice, auscultándose los LCF a 100 lpm. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de vasa previa
- b) Rotura uterina
- c) Desprendimiento de placenta normoinsera
- d) Placenta previa
- e) Placenta acreta

30) Un niño sufre una caída mientras andaba en bicicleta, presentando una fractura de antebrazo en tallo verde, la que es manejada ortopédicamente con un yeso braquiopalmar. Sin embargo 2 horas después evoluciona con aumento del dolor, especialmente a la movilización pasiva de los dedos. EL diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis venosa profunda
- b) Necrosis avascular
- c) Síndrome de túnel carpiano
- d) Rotura de la arteria braquial
- e) Síndrome compartimental

31) La sinusorragia es:

- a) El sangrado genital fuera del ciclo menstrual en pacientes usuarias de ACO
- b) El sangrado genital fuera del ciclo menstrual en pacientes usuarias de DIU
- c) El sangrado genital durante el día de ovulación
- d) El sangrado genital durante o después de las relaciones sexuales
- e) El sangrado genital después de la toma del Papanicolaou

32) Un niño de 5 años sufre una caída de la escalera, golpeándose la cabeza y permaneciendo inconsciente por cerca de 1 minuto. Luego de eso se recupera bien y al examen físico está en Glasgow 15, sin focalidad neurológica ni dolor. Refiere que no es capaz de recordar cuando lo levantaron de la escalera. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con indicación de reconsulta en caso de aparición de signos de alarma
- b) Hospitalizar para observación por 24 horas
- c) Solicitar radiografía de cráneo
- d) Solicitar TAC de cerebro con ventana ósea
- e) Solicitar electroencefalograma

33) Los embarazos gemelares bicoriales y biamnióticos tienen un MAYOR riesgo de (escoja aquella complicación en la que el riesgo sea mayor que en las demás):

- a) Parto prematuro
- b) Tranfusión feto-fetal
- c) Secuelas neurológicas
- d) Infección intraamniótica
- e) Diabetes mellitus gestacional

34) Un recién nacido, con antecedente de asfixia recuperada, presenta, al cuarto día de vida, vómitos alimentarios y deposiciones con sangre. El diagnóstico más probable es:

- a) Atresia duodenal primaria
- b) Enterocolitis necrotizante
- c) Estenosis hipertrófica del píloro
- d) Enfermedad de Hirschsprung
- e) Invaginación intestinal

35) Una paciente, de 30 años, con antecedente de promiscuidad sexual, consulta por dolor hipogástrico. Al examen físico se aprecia dolor a la palpación hipogástrica y en la fosa iliaca izquierda. Además se constata dolor a la movilización cervical y a la palpación anexial izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Endometriosis
- b) Adenomiosis
- c) Embarazo ectópico
- d) Proceso inflamatorio pelviano
- e) Herpes genital

36) Un paciente de 7 años, asmático en tratamiento con fluticasona y salbutamol, consulta por mayor disnea de la habitual, asociada a tos y respiración ruidosa. Al examen físico se aprecia taquipneico, con uso de musculatura accesoria y sibilancias inspiratorias y espiratorias intensas, bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar oxígeno, salbutamol por nebulización y corticoides orales
- b) Administrar oxígeno, salbutamol por nebulización, corticoides sistémicos y antibióticos endovenosos
- c) Administrar salbutamol por nebulización, corticoides sistémicos, antihistamínicos endovenosos y adrenalina intramuscular
- d) Realizar intubación orotraqueal, administrar salbutamol y corticoides nebulizados e iniciar ventilación a presión positiva
- e) Administrar broncodilatadores inhalados e iniciar corticoides orales

37) Una mujer de 28 años, cursando un embarazo de 7 semanas por FUR, se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza gestación intrauterina. Se solicita gonadotropina coriónica humana, que resulta 1.000 UI/litro. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva ecografía en 7 días
- b) Solicitar nueva ecografía y nueva HCG en 2 días
- c) Iniciar metotrexato
- d) Realizar legrado uterino
- e) Resolver quirúrgicamente

38) Un niño de 8 años presenta un cuadro de malestar general y fiebre hasta 38,6°C, de 7 días de evolución, que en el último tiempo se ha acompañado de orinas oscuras e ictericia. Se solicitan exámenes generales, en los que destaca bilirrubina total: 6,2 mg/dl, bilirrubina directa: 5,3 mg/dl, GGT: 130 UI/l, GOT: 1.206 UI/l, GPT: 988 UI/l, FA: 213 UI/l, TP: 80%. El diagnóstico más probable es:

- a) Atresia biliar primaria
- b) Colédocolitiasis
- c) Hepatitis A
- d) Síndrome hemolítico urémico
- e) Microesferocitosis familiar

39) Una paciente consulta por leucorrea verdosa, abundante, asociada a disuria intensa. Se solicita microscopía óptica de la secreción, que visualiza presencia de algunos protozoos flagelados. El tratamiento más adecuado es:

- a) Aseo local diario
- b) Metronidazol oral
- c) Clotrimazol oral
- d) Ciprofloxacino oral
- e) Clindamicina tópica

40) ¿Cuánto mide y pesa un niño al año de vida?

- a) 50 cm y 6 Kg
- b) 60 cm y 9 Kg
- c) 60cm y 15 Kg
- d) 75cm y 10 Kg
- e) 100 cm y 10 Kg

41) Una mujer de 20 años, primigesta, sin antecedentes de importancia, cursando un embarazo de 36 semanas, presenta salida de líquido claro abundante por los genitales hace 12 horas, sin presentar dinámica uterina. Al examen físico se palpa feto en presentación cefálica, con cuello uterino sin dilatación ni borramiento. Se solicita test de cristalización, que muestra cristalización en hojas de helecho y el perfil biofísico resulta tranquilizador. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Administrar antibióticos y tocolíticos
- c) Administrar antibióticos y corticoides a la madre y mantener conducta expectante
- d) Inducir el parto con misoprostol
- e) Realizar cesárea de urgencia

42) El recién nacido postérmino tiene un mayor riesgo de presentar:

- a) Síndrome de aspiración meconial
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Taquipnea transitoria
- d) Neumonía neonatal
- e) Cardiopatías congénitas

43) Una mujer de 42 años, consulta por mastalgia premenstrual intensa. Al examen físico se palpan ambas mamas con múltiples nódulos pequeños bilaterales, sensibles. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de mama
- b) Enfermedad de Paget
- c) Papilomas invertidos
- d) Fibroadenomas mamarios
- e) Mastopatía fibroquística

44) ¿Qué antibiótico utilizará como primera opción para el tratamiento de una ITU baja en un niño de 3 años?

- a) Amoxicilina
- b) Ceftriaxona
- c) Cefadroxilo
- d) Ciprofloxacino
- e) Gentamicina

45) Una mujer, cursando un embarazo de 31 semanas de edad gestacional, inicia dinámica uterina persistente. Al examen físico se palpa feto en presentación cefálica y presenta 3 contracciones uterinas cada 10 minutos, con un tacto vaginal que demuestra borramiento del 50% y 1 cm de dilatación cervical, con membranas íntegras. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar evolución espontánea
- b) Iniciar antibióticos y tocolíticos endovenosos
- c) Iniciar corticoides y tocolíticos endovenosos
- d) Iniciar corticoides endovenosos
- e) Iniciar corticoides y antibióticos endovenosos

46) ¿Qué vacunas deben administrarse al año de edad, según el programa nacional de inmunizaciones?

- a) DPT
- b) DPT y trivírica
- c) BCG
- d) Trivírica
- e) Polio y DPT

47) Una mujer de 30 años, sin antecedentes de importancia, se realiza una ecografía transvaginal, como parte de un chequeo médico, que muestra un mioma subseroso de 1,5 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar análogos de la GnRH
- b) Realizar resección del mioma por histeroscopia
- c) Realizar histerectomía transvaginal
- d) Iniciar anticonceptivos orales
- e) Observar evolución

48) Un niño de 10 años consulta por astenia y fiebre. Al examen físico se aprecia pálido y se palpan múltiples adenopatías inguinales bilaterales, la mayor de ellas de 3,5cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteomielitis crónica
- b) Leucemia aguda
- c) Leucemia crónica
- d) Primoinfección herpética
- e) Linfoma

49) ¿Cuál de las siguientes presentaciones TIENE opción de parto vaginal?

- a) Presentación de frente variante naso-púbica
- b) Presentación de frente variante naso-sacra
- c) Presentación de cara variante mento-sacra
- d) Presentación de nalgas variante sacro-sacra
- e) Presentación de bregma variante bregmo-púbica

50) Un recién nacido de 3 horas de vida, hijo de madre diabética, de 4.200 de peso presenta convulsiones en una oportunidad. Presenta hemoglucotest de 48 mg/dl, hematocrito: 68%, calcio plasmático: 7,5 mg/dl, sin focalidad neurológica al examen físico. EL diagnóstico más probable es:

- a) Hipoglicemia neonatal
- b) Encefalopatía hipóxico-isquémica
- c) Hipocalcemia neonatal
- d) Meningitis neonatal
- e) Policitemia neonatal

51) Una paciente de 50 años consulta por reglas irregulares y por bochornos frecuentes y muy molestos. No presenta antecedentes de importancia y su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar raloxifeno
- b) Iniciar estrógenos solos
- c) Iniciar progestágenos solos
- d) Iniciar una asociación entre estrógenos y progestágenos
- e) Iniciar antidepresivos

52) ¿Cuál es el primer signo de desarrollo puberal en una niña?

- a) Menarquia
- b) Adrenarquia
- c) Pubarquia
- d) Telarquia
- e) Aumento de la velocidad de crecimiento

53) Una paciente de 18 años, primigesta, cursando un embarazo de 35 semanas de edad gestacional, consulta por cefalea. Al examen físico presenta PA: 180/110 mmHg, FC: 92x', se aprecia edema blando en ambas extremidades inferiores, sin otras alteraciones. Se solicita proteinuria cualitativa, que resulta ++++. El diagnóstico más probable es:

- a) Preclamsia
- b) Eclamsia
- c) Hipertensión arterial esencial crónica
- d) Hipertensión transitoria del embarazo
- e) Hipertensión arterial secundaria a enfermedad renal crónica

54) Un niño de 7 años presenta un cuadro de tos de 11 días de evolución, asociado a malestar general y disnea de esfuerzos. Al examen físico se auscultan crépitos pulmonares y sibilancias bilaterales, mayores en las bases. Se solicita radiografía de tórax que muestra un patrón alveolo-intersticial bilateral, localizado en ambas bases. El tratamiento más adecuado es:

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina
- c) Clindamicina
- d) Ceftriaxona
- e) Sintomático

55) Una mujer de 25 años consulta porque presenta sus reglas cada 2 a 3 meses, sin otros síntomas. Al examen físico destaca acné e hirsutismo leve, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperplasia suprarrenal
- b) Síndrome de ovario poliquístico
- c) Falla ovárica prematura
- d) Hipogonadismo hipogonadotrópico
- e) Hiperprolactinemia

56) Un niño de 4 meses presencia ausencia del testículo izquierdo, el que no es posible de ser palpado con un adecuado examen físico. Se revisan sus controles previos, en los que no se describe el examen testicular. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía inguinoescrotal
- b) Observar evolución
- c) Solicitar cariograma
- d) Iniciar andrógenos
- e) Solicitar testosterona plasmática y gonadotropinas

57) La primera causa de hemorragia puerperal es:

- a) Acretismo placentario
- b) Restos ovulares
- c) Endometritis
- d) Inercia uterina
- e) Laceraciones del canal del parto

58) Un recién nacido pesó 3.500 gramos al nacer. Es pesado a los 7 días de vida, pesando 3.080 gramos. Actualmente se alimenta sólo de leche materna y se ve de buen aspecto, sin presentar ninguna alteración en el examen físico. La conducta más adecuada es:

- a) Tranquilizar a la madre, explicando la normalidad de la situación y mantener la lactancia materna exclusiva
- b) Mejorar la técnica de lactancia y controlar en 48 horas
- c) Suspender la lactancia materna e iniciar un relleno
- d) Mantener la lactancia materna y adicionar un relleno
- e) Hospitalizar e iniciar nutrición parenteral

59) Una mujer se realiza un PAP que resulta satisfactorio, sin presencia de atipías escamosas ni glandulares, pero con un patrón inflamatorio inespecífico. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar colposcopia
- b) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
- c) Solicitar nuevo PAP en 1 año
- d) Iniciar antibióticos orales y solicitar nuevo PAP en 1 mes
- e) Iniciar antibióticos locales y solicitar nuevo PAP en 14 días

60) Un niño de 4 años, no habla y presentó retraso en alcanzar los hitos del desarrollo motor. La madre refiere que presenta poco interés en interactuar con ella o con otros niños y que aprendió a caminar a los 20 meses de edad. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión infantil
- b) Trastorno del desarrollo
- c) Trastorno oposicionista desafiante
- d) Síndrome de déficit atencional
- e) Parálisis cerebral

61) Una mujer, cursando un embarazo de 28 semanas, presenta un VDRL (+), solicitado, como parte del control habitual de su embarazo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar penicilina endovenosa
- b) Solicitar RPR
- c) Solicitar MHA-TP
- d) Iniciar ceftriaxona endovenosa
- e) Observar evolución y solicitar nuevo VDRL al final de embarazo

62) ¿Cómo debe tratar una escarlatina en un paciente alérgico a los betalactámicos?

- a) Macrólidos
- b) Quinolonas
- c) Aminoglicósidos
- d) Vancomicina
- e) Cefazolina

63) Una mujer de 68 años presenta metrorragia escasa en una oportunidad. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía transvaginal
- b) Realizar histerectomía
- c) Iniciar progestágenos orales en dosis altas
- d) Observar evolución
- e) Solicitar histeroscopia

64) Un niño sufre una picadura de avispa en el brazo izquierdo hace 4 horas. Inicialmente presenta mucho dolor, sin embargo luego éste disminuye, dando lugar a prurito, eritema y aumento de volumen de 5 cm de diámetro, asociado a aumento del calor local en la zona de la picadura. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar antihistamínicos y analgésicos como tratamiento sintomático
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Administrar adrenalina intramuscular
- d) Indicar corticoides tópicos
- e) Iniciar cloxacilina más un AINE por vía oral

65) ¿Qué alteración ES parte de un embarazo normal?

- a) Aumento de la creatinina plasmática
- b) Trombocitopenia
- c) Rash petequeial
- d) Elevación de las transaminasas
- e) Poliaquiuria

66) Un niño de 3 años consume una sustancia desconocida, evolucionando con sialorrea, vómitos, temblor de extremidades y desorientación. Al examen físico se aprecia aumento de los ruidos hidroaéreos, miosis y temblor de extremidades superiores. ¿Qué sustancia es la responsable?

- a) Anticolinérgicos
- b) Organofosforados
- c) Agonistas adrenérgicos
- d) Opiáceos
- e) Benzodiacepinas

67) ¿Qué información orienta MÁS al origen ginecológico en un dolor abdominal crónico?

- a) Palpación de un tumor anexial
- b) Ciclicidad, sincronizada con el ciclo menstrual
- c) Localización en el hipogastrio
- d) Ausencia de cambios en el hábito intestinal
- e) Asociación a amenorrea

68) Un lactante es capaz de ponerse de pie, sin lograr caminar por su cuenta, sin embargo gatea de manera activa. Además se ríe a carcajadas cuando interactúa con sus familiares, por ahora sólo dice la palabra “mamá”, desconoce a los extraños y no presenta reflejos arcaicos. ¿Qué edad tiene?

- a) 6 meses
- b) 8 meses
- c) 10 meses
- d) 12 meses
- e) 14 meses

69) Una mujer cursando un embarazo de 15 semanas por FUR segura y confiable, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto de sólo 10 semanas de edad, tanto por longitud cefalonalgas, como por diámetro biparietal. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a la edad gestacional?

- a) Mantener la edad gestacional determinada por la FUR
- b) Tomar la nueva edad gestacional, dada por la ecografía
- c) Calcular un promedio entre ambas edades gestacionales y ocupar dicha información para el cálculo de la edad gestacional
- d) Solicitar niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana y determinar la edad gestacional según el resultado
- e) Solicitar nueva ecografía en 14 días y determinar la edad gestacional según el resultado

70) Un niño de 3 años presenta claudicación de la marcha, asociada a fiebre hasta 39,4°C. Al examen físico se aprecia decaído e irritable, con dolor a la movilización de la cadera izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Sinovitis transitoria
- c) Enfermedad de Perthes
- d) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- e) Enfermedad de Osgood-Schlatter

RESPUESTAS COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Prueba 1	47 C	22 A	68 E	43 B	38 D
1 A	48 B	23 D	69 A	44 A	39 A
2 D	49 A	24 A	70 B	45 A	40 D
3 C	50 D	25 C		46 D	41 D
4 D	51 B	26 E	Prueba 3	47 D	42 A
5 D	52 B	27 E	1 E	48 C	43 C
6 B	53 C	28 E	2 B	49 B	44 E
7 C	54 C	29 B	3 E	50 A	45 E
8 C	55 C	30 A	4 C		46 A
9 C	56 C	31 E	5 B	Prueba 4	47 A
10 C	57 D	32 B	6 D	1 A	48 E
11 B	58 A	33 D	7 D	2 B	49 D
12 E	59 B	34 E	8 A	3 D	50 D
13 B	60 C	35 D	9 B	4 D	51 B
14 D	61 B	36 D	10 C	5 E	52 B
15 B	62 E	37 C	11 E	6 D*	53 E
16 C	63 B	38 A	12 E	7 D	54 B
17 B	64 B	39 A	13 A	8 D	55 B
18 B	65 C	40 D	14 A	9 B	56 D
19 C	66 A	41 C	15 B	10 E	57 C
20 D	67 C	42 B	16 E	11 E	58 E
21 B	68 C	43 E	17 D	12 B	59 D
22 A	69 A	44 B	18 D	13 C	60 E
23 D	70 D	45 D	19 A	14 C	61 D
24 B		46 C	20 C	15 E	62 A
25 D	Prueba 2	47 C	21 D	16 E	63 D
26 D	1 A	48 C	22 D	17 A	64 C
27 B	2 E	49 A	23 A	18 B	65 D
28 C	3 E	50 D	24 C	19 C	66 B
29 C	4 C	51 A	25 C	20 E	67 D
30 B	5 B	52 D	26 E	21 A	68 A
31 B	6 B	53 D	27 C	22 D	69 C
32 D	7 C	54 D	28 D	23 C	70 D
33 B	8 A	55 C	29 E	24 A	
34 E	9 C	56 A	30 D	25 D	Prueba 5
35 D	10 D	57 D	31 B	26 D	1 E
36 C	11 A	58 C	32 B	27 B	2 A
37 D	12 A	59 C	33 E	28 C	3 B
38 D	13 B	60 C	34 B	29 A	4 D
39 E	14 D	61 D	35 C	30 E	5 D
40 A	15 C	62 D	36 C	31 E	6 B
41 A	16 D	63 A	37 B	32 A	7 B
42 C	17 C	64 E	38 C	33 E	8 E
43 E	18 A	65 E	39 B	34 A	9 C
44 D	19 C	66 E	40 B	35 C	10 D
45 E	20 B	67 D	41 C	36 C	11 A
46 E	21 C		42 B	37 B	12 E

13 E	61 D	37 E	13 C	61 C
14 E	62 C	38 C	14 B	62 A
15 A	63 C	39 A	15 B	63 A
16 D	64 A	40 B	16 B	64 A
17 D	65 B	41 E	17 A	65 E
18 A	66 D	42 C	18 D	66 B
19 C	67 C	43 C	19 C	67 B
20 B	68 D	44 B	20 D	68 C
21 C	69 A	45 C	21 E	69 B
22 D	70 E	46 B	22 E	70 A
23 C		47 E	23 A	
24 C	Prueba 6	48 A	24 A	
25 D	1 B	49 E	25 C	
26 B	2 D	50 D	26 E	
27 C	3 D	51 D	27 A	
28 E	4 C	52 B	28 B	
29 C	5 B	53 C	29 C	
30 A	6 A	54 A	30 E	
31 B	7 B	55 C	31 D	
32 C	8 E	56 C	32 A	
33 E	9 B	57 A	33 A	
34 B	10 D	58 C	34 B	
35 C	11 E	59 B	35 D	
36 A	12 B	60 A	36 A	
37 C	13 A	61 C	37 B	
38 B	14 A	62 E	38 C	
39 E	15 C	63 A	39 B	
40 A	16 A	64 B	40 D	
41 D	17 D	65 A	41 D	
42 A	18 B	66 C	42 A	
43 D	19 E	67 D	43 E	
44 D	20 E	68 D	44 C	
45 B	21 A	69 B	45 C	
46 D	22 C	70 D	46 D	
47 E	23 E		47 E	
48 B	24 D	Prueba 7	48 E	
49 A	25 E	1 A	49 E	
50 D	26 C	2 A	50 E	
51 B	27 D	3 A	51 D	
52 B	28 A	4 B	52 D	
53 C	29 C	5 A	53 A	
54 C	30 C	6 B	54 A	
55 A	31 D	7 B	55 B	
56 C	32 C	8 B	56 A	
57 C	33 C	9 C	57 D	
58 D	34 B	10 C	58 B	
59 C	35 D	11 C	59 C	
60 E	36 E	12 D	60 B	

PEDIATRÍA

I) NEONATOLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) ¿Cuál de las siguientes patologías NO es más frecuente en los recién nacidos prematuros?

- a) Sépsis neonatal
- b) Ictericia
- c) Poliglobulia
- d) Enfermedad de membrana hialina
- e) Hipocalcemia

2) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una alternativa válida para la alimentación de un recién nacido, que no recibe pecho materno?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

3) Un recién nacido PEG se define como aquél que presenta:

- a) Peso al menos una desviación estándar menor que el promedio para su edad gestacional
- b) Talla un 10% menor al promedio para su edad gestacional
- c) Peso de nacimiento menor a 2.500 gramos
- d) Peso de nacimiento bajo el percentil 10 para su talla de nacimiento
- e) Peso de nacimiento bajo el percentil 10 para su edad gestacional

4) La primera causa de muerte neonatal es:

- a) Asfixia neonatal
- b) Problemas relacionados con la prematurez
- c) Malformaciones congénitas
- d) Sepsis neonatal
- e) TORCH

5) Un recién nacido de 35 semanas de gestación, presenta ictericia hasta los muslos a las 10 horas de vida. No presenta otros síntomas y se observa en buen estado. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar bilirrubina total y directa y decidir manejo según hallazgos
- b) Realizar exanguineotransfusión y fototerapia de inmediato
- c) Iniciar fototerapia sola y asegurar una adecuada hidratación y alimentación
- d) Solicitar bilirrubina plasmática, hemograma, prueba de Coombs directo, grupo-Rh y hemocultivos y decidir manejo según resultados
- e) Observar evolución por 24 horas, asegurando una adecuada alimentación e hidratación, sin necesidad de mayor estudio

6) ¿Cuál de los siguientes hallazgos se considera como patológico en un recién nacido?

- a) Hernia umbilical
- b) Hígado palpable
- c) Exantema petequial
- d) Eritema tóxico
- e) Mancha salmón

7) ¿Cuándo se debe administrar la vacuna BCG al recién nacido prematuro?

- a) Al nacer
- b) Al cumplir 2 meses de edad
- c) Al alcanzar la edad gestacional de 38 semanas
- d) Al alcanzar los 2 kilogramos de peso
- e) Al doblar el peso de nacimiento

8): ¿Cuál de las siguientes situaciones supone un mayor riesgo para un neonato?

- a) Recién nacido de 35 semanas de gestación con antecedente de RPO de 12 horas de evolución
- b) Recién nacido de 33 semanas de gestación con antecedente de embarazo gemelar y uso de corticoides previo al parto
- c) Recién nacido de 37 semanas de gestación pequeño para la edad gestacional
- d) Recién nacido de 43 semanas de gestación con antecedente de meconio espeso en el líquido amniótico
- e) Recién nacido de 37 semanas de gestación, hijo de madre diabética y grande para la edad gestacional

9) Un recién nacido de 3 días de vida presenta letargo, debilidad en la succión e hipotermia. En el examen físico se aprecia además un cierto grado de hipotonía. La conducta más adecuada es:

- a) Asegurar un ambiente temperado y administrar líquidos tibios, hasta recuperar la temperatura normal, sin necesidad de mayor estudio
- b) Iniciar cefadroxilo oral y enviar a domicilio explicando los signos de alarma
- c) Regular la temperatura y solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos y pruebas de función renal, decidiendo el manejo según hallazgos
- d) Iniciar soporte, solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos, pruebas de función renal, gases venosos, radiografía de tórax, punción lumbar y exámenes de orina e iniciar una asociación de ceftriaxona y vancomicina endovenosa, inmediatamente
- e) Iniciar soporte, solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos, pruebas de función renal, gases venosos, radiografía de tórax, punción lumbar y exámenes de orina e iniciar una asociación de cefotaximo y ampicilina endovenosa, inmediatamente

10) Un recién nacido pretérmino, de 33 semanas de gestación presenta taquipnea, quejido y aleteo nasal, que inició algunos minutos luego del nacimiento y que ha ido en detrimento en las horas siguientes, de modo que requiere altas concentraciones de oxígeno para mantener saturación arterial de oxígeno normal. El examen físico resulta inespecífico. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Persistencia de la circulación fetal
- e) Sepsis neonatal

11) El examen más adecuado para iniciar el estudio de un neonato de 20 días de vida, con ictericia es:

- a) Prueba de Coombs
- b) TSH
- c) Bilirrubina total y directa
- d) Ecografía abdominal
- e) Pruebas hepáticas

12) La mayor utilidad del test de Apgar es:

- a) Diferenciar los pacientes con asfixia neonatal de aquéllos con depresión neonatal
- b) Definir la conducta a seguir durante la reanimación neonatal
- c) Identificar los pacientes con secuelas neurológicas
- d) Determinar la causa de la dificultad respiratoria del recién nacido
- e) Identificar la presencia de malformaciones congénitas

13) Un recién nacido prematuro de 3 días de vida, presenta decaimiento, actitud de dolor, distensión abdominal, vómitos y deposiciones sanguinolentas en una oportunidad. El examen más adecuado para confirmar la sospecha clínica es:

- a) Radiografía abdominal
- b) Ecografía abdominal
- c) Radiografía de tórax en posición de pie
- d) Enema baritado
- e) Laparotomía exploradora

14) Una mujer embarazada de 28 semanas, Rh negativo, se realiza test de Coombs indirecto como parte del control prenatal, el que resulta positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nuevo test de Coombs antes del parto y decidir conducta según resultados
- b) Realizar nuevos test de Coombs mensualmente y decidir conducta según resultados
- c) Realizar ecografías doppler seriadas, de arteria cerebral media fetal y decidir conducta según hallazgos
- d) Administrar inmunoglobulina anti-D (Rhogam) a la madre, ahora y luego del parto
- e) Solicitar pruebas de inmunización contra grupos atípicos, ya que las mujeres Rh negativo no tienen riesgo de hemólisis fetal

15) Un recién nacido de término, de 4 horas de vida, hijo de madre diabética y grande para la edad gestacional, presenta hiporreactividad y convulsiones en una oportunidad. Al examen físico se observa hiporreactivo e hipotónico, sin otros hallazgos. La primera medida a tomar es:

- a) Iniciar oxígeno al 35%
- b) Solicitar hemograma, hemocultivos y punción lumbar
- c) Solicitar ecografía de cerebro por fontanela anterior
- d) Administrar suero fisiológico y antibióticos endovenosos
- e) Realizar hemoglucotest

16): Un recién nacido de término, sin antecedentes obstétricos de importancia, presenta cianosis intensa y desaturación arterial, desde el nacimiento, que no responde a oxígeno al 100%. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Intubar y ventilar con presión positiva
- b) Derivar para resolución quirúrgica inmediata
- c) Administrar prostaglandina E y realizar ecocardiografía a la brevedad
- d) Administrar indometacina y realizar ecocardiografía a la brevedad
- e) Administrar antibióticos endovenosos, surfactante endotraqueal y oxígeno al 100%

17) Un recién nacido de término, de 3 días de vida, presenta ictericia desde hace 24 horas, que actualmente llega a los muslos. Al nacer pesó 3.420 gramos, se alimenta adecuadamente y actualmente pesa 3.230 gramos. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- c) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo Rh
- d) Ictericia por leche materna
- e) Sepsis neonatal

18) Los microorganismos que más frecuentemente son responsables de la neumonía neonatal son:

- a) Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus
- b) Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus
- c) Streptococcus agalactiae y Escherichia coli
- d) Streptococcus pneumoniae y Streptococcus agalactiae
- e) Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae

19) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria, taquipnea y quejido. Al examen físico se auscultan crépitos escasos, difusos. La radiografía de tórax muestra aumento de la trama vascular, líquido en las cisuras y un mínimo derrame pleural bilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Cardiopatía congénita
- d) Neumonía neonatal
- e) Hipoplasia pulmonar

20) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una contraindicación para la lactancia materna exclusiva?

- a) Galactosemia
- b) Infección materna por VIH
- c) Consumo materno de cocaína
- d) Infección materna por hepatitis B
- e) Uso materno de antineoplásicos

Prueba 2

1) ¿Qué hallazgo se considera normal en un recién nacido?

- a) Nevo congénito gigante
- b) Exantema petequial
- c) Hipotonía
- d) Fiebre
- e) Signo de Babinsky

2) Un recién nacido de 3 días de vida presenta rechazo alimentario e irritabilidad. La madre refiere que no se ha alimentado hace 7 horas. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, explicando la normalidad de la situación
- b) Iniciar fórmula láctea por sonda nasogástrica
- c) Solicitar radiografía de abdomen simple
- d) Iniciar vancomicina más un aminoglicósido por vía endovenosa y solicitar hemograma, hemocultivos y urocultivo
- e) Hospitalizar, solicitar hemograma, hemocultivos, exámenes de orina, analítica sanguínea general y estudio de líquido cefalorraquídeo e iniciar cefotaximo más ampicilina por vía endovenosa

3) Un paciente pretérmino, presenta un síndrome de distrés respiratorio, severo. Se realiza radiografía de tórax, que demuestra pulmones con relleno en patrón de vidrio esmerilado y broncograma aéreo. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Oxigenoterapia en bajas concentraciones hasta que
- b) Ventilación mecánica y oxígeno al 100%
- c) Corticoides endovenosos y soporte ventilatorio, con oxígeno
- d) Surfactante endotraqueal y soporte ventilatorio, con oxígeno
- e) Oxígeno y antibióticos de amplio espectro endovenosos

4) La poliglobulia neonatal es más frecuente en todas las situaciones mencionadas a continuación, EXCEPTO:

- a) Recién nacido pequeño para la edad gestacional
- b) Recién nacido prematuro
- c) Hijo de madre diabética
- d) Retraso en la sección del cordón umbilical
- e) Tabaquismo materno

5) Un recién nacido presenta cianosis que no responde a oxígeno al 100%, asociado a un soplo sistólico eyectivo. ¿Qué patología es compatible con esta información?

- a) Comunicación interauricular
- b) Ductus arterioso persistente
- c) Transposición de grandes vasos
- d) Tetralogía de Fallot
- e) Coartación aórtica

6) ¿Cuál de los siguientes es una contraindicación absoluta de la lactancia materna?

- a) Hepatitis B materna
- b) Grietas del pezón
- c) Galactosemia
- d) Mastitis linfangítica
- e) Hepatitis C materna

7) Un recién nacido de 5 horas de vida, presenta ictericia que afecta la cara y el tronco. El resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar bilirrubinemia total
- b) Solicitar pruebas hepáticas, con bilirrubinemia diferenciada
- c) Solicitar bilirrubinemia, hemograma, grupo sanguíneo y Rh, prueba de Coombs directo y hemocultivos
- d) Iniciar fototerapia
- e) Iniciar fototerapia y realizar exangüineotransfusión

8) El principal riesgo del recién nacido postérmino, es decir aquel que nace de las 42 semanas de gestación, es:

- a) Sufrimiento fetal
- b) Trauma del canal del parto
- c) Hipotermia
- d) Poliglobulia
- e) Taquipnea transitoria

9) Una mujer de 35 años, con historia de preclamsia severa, inicia trabajo de parto, que durante el monitoreo fetal muestra desaceleraciones variables frecuentes, seguido de una bradicardia fetal amntenida, por lo que se realiza cesárea de urgencia. El recién nacido está cianótico, con FC: 90x', no realiza esfuerzos respiratorios ni movimientos de las extremidades. Se inicia estimulación, sin lograr cambios luego de 30 segundos. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ventilación a presión positiva, con oxígeno
- b) Administrar oxígeno al 100% por mascarilla
- c) Iniciar masaje cardíaco
- d) Solicitar gases de sangre de cordón umbilical y decidir manejo según los resultados
- e) Administrar adrenalina endovenosa

10) Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional presentan mayor riesgo de todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Síndrome de aspiración meconial
- b) Poliglobulia neonatal
- c) Asfixia
- d) Hipoglicemia neonatal
- e) Hipotermia

11) Un recién nacido de término, con sufrimiento fetal agudo, durante el trabajo de parto, presenta dificultad respiratoria marcada, con cianosis. Al examen físico se aprecia taquipnea, cianosis marcada y desaturación arterial severa, que sólo mejora parcialmente con oxígeno en altas concentraciones. La auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que la radiografía de tórax. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Síndrome de aspiración meconial
- c) Cardiopatía congénita cianótica
- d) Canal aurículoventricular
- e) Hipertensión pulmonar primaria

12) Las infecciones connatales (TORCH) son producidas principalmente por:

- a) Escherichia coli
- b) VIH
- c) Citomegalovirus
- d) Clamidia
- e) Mycoplasma

13) ¿Cuál de las siguientes patologías se previene con la administración de corticoides antenatales a la madre?

- a) Sepsis neonatal por Streptococcus agalactiae
- b) Hemorragia intracraneana periventricular
- c) Hipocalcemia neonatal
- d) Síndrome de aspiración de meconio
- e) Ictericia neonatal

14) Una mujer de 37 años, Rh negativa, cursando su segundo embarazo de 28 semanas, se realiza prueba de Coombs indirecta, para determinar inmunización anti-D, la que resulta positiva. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nuevo test de Coombs indirecto a las 36 semanas de gestación
- b) Solicitar test de Coombs directo
- c) Realizar seguimientos periódicos con ecografía de arteria cerebral media fetal
- d) Administrar gamaglobulina anti-D (Rhogam) endovenosa
- e) Realizar transfusión fetal intraamniótica

15) Un recién nacido de término, hijo de madre diabética, nacido por cesárea, sin incidentes, indicada por macrosomía fetal, presenta convulsiones autolimitadas a las 3 horas de vida. Al examen físico está hiporreactivo, sudoroso y taquicárdico. El diagnóstico más probable es:

- a) Sepsis
- b) Hipocalcemia
- c) Hipoglicemia
- d) Encefalopatía hipóxico-isquémica
- e) Hemorragia periventricular

16) Un recién nacido de 32 semanas de gestación, presenta quejido, aleteo nasal, taquipnea y cianosis desde algunos minutos luego de nacer. Al examen físico está taquipneico, con saturación arterial de oxígeno de 80%, que sube a 91% con oxígeno a 50%. En el examen físicodestacan escasos crépitos bilaterales en la auscultación pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Síndrome de aspiración meconial
- e) Cardiopatía congénita

17) ¿Qué alternativa es FALSA respecto a la ictericia fisiológica neonatal?

- a) Es más frecuente en el recién nacido prematuro que en el de término
- b) La hiperbilirrubinemia es de predominio indirecto
- c) La ictericia suele manifestarse durante la segunda semana de vida
- d) Se beneficia del uso de fototerapia cuando los niveles de bilirrubina plasmática son muy elevados
- e) Actualmente es muy infrecuente la evolución a Kernicterus

18) Un recién nacido, de 4 días de vida, presenta algunas pústulas de base eritematosa, que comprometen el tronco, la cara y las extremidades. Sus signos vitales son normales, se ve de buen aspecto y el resto del examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar aciclovir endovenoso
- c) Solicitar hemocultivos, hemograma, exámenes generales e iniciar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
- d) Solicitar VDRL a la madre y al niño
- e) Solicitar IgM para virus herpes simplex

19) Un recién nacido presenta retraso en la eliminación de meconio. Durante los días siguientes presenta rara vez deposiciones y además vomita en múltiples oportunidades. Al examen físico se aprecia distensión abdominal, con bazuque intestinal y claro aumento de los ruidos hidroaéreos. La patología descrita se debe a:

- a) Isquemia intestinal y traslocación bacteriana
- b) Hipertrofia de las fibras musculares lisas del píloro
- c) Atresia de la tercera o cuarta porción duodenal
- d) Ausencia de somas neuronales en los plexos mientéricos intestinales
- e) Mutación de genes responsables de la síntesis de un canal epitelial de cloro

20) ¿Qué antecedente es MÁS importante para un lactante de 4 semanas de edad que presenta ictericia?

- a) Nacido prematuro
- b) Madre de grupo sanguíneo O, Rh negativo
- c) Bilirrubinemia mayor a 15 mg/dl
- d) Presencia de coluria
- e) Presencia de regurgitación frecuente de leche

Prueba 3

1) ¿Cuál de las siguientes patologías NO es más frecuente en los recién nacidos prematuros?

- a) Sépsis neonatal
- b) Ictericia
- c) Hemorragia periventricular
- d) Enterocolitis necrotizante
- e) Cardiopatías congénitas

2) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una alternativa válida para la alimentación láctea de un lactante de 8 meses, que no recibe pecho materno?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%

3) El recién nacido pequeño para la edad gestacional NO tiene mayor riesgo de:

- a) Poliglobulia
- b) Hipoglicemia
- c) Muerte
- d) Enfermedad de membrana hialina
- e) Asfixia neonatal

4) Las dos primeras causas de muerte neonatal son:

- a) Malformaciones congénitas y asfixia neonatal
- b) Asfixia y sepsis neonatal
- c) Problemas relacionados con la prematurez y asfixia neonatal
- d) Problemas relacionados con la prematurez y malformaciones congénitas
- e) Sepsis neonatal y muerte súbita

5) Un recién nacido de término, de 27 días de vida, alimentado exclusivamente con pecho materno, presenta ictericia hasta las rodillas, asociada a coluria y acolia. El resto del examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Hemólisis
- c) Hipotiroidismo
- d) Ictericia por lactancia materna
- e) Atresia biliar primaria

6) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre hallazgo en un recién nacido y características clínicas es INCORRECTA?

- a) Bolsa serosanguínea – Sobrepasa las suturas
- b) Millium sebáceo – Compromiso de la nariz
- c) Eritema tóxico – Respeta las palmas y plantas
- d) Granuloma umbilical – Salida continua de líquido por el ombligo
- e) Mancha salmón – Ubicación en la línea media de la cabeza

7) Un recién nacido de término, hijo de madre diabética, de 4 horas de vida presenta una convulsión. Al examen físico se aprecia hiporreactivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Encefalopatía hipóxico-isquémica
- b) Hipoglicemia
- c) Hipocalcemia
- d) Hiponatremia
- e) Epilepsia

8) Un recién nacido, de 29 semanas de gestación, presenta rápido deterioro, asociado a compromiso de consciencia. Al examen físico presenta abombamiento de la fontanela anterior y anisocoria. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis neonatal
- b) Parálisis cerebral
- c) Encefalopatía hipóxico-isquémica
- d) Hemorragia periventricular
- e) Hipocalcemia neonatal

9) Un recién nacido de 4 días de vida presenta rechazo alimentario y dificultades para regular la temperatura. En el examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, pero con cierta disminución del tono muscular. La conducta más adecuada es:

- a) Asegurar un ambiente temperado y administrar líquidos tibios, hasta recuperar la temperatura normal, sin necesidad de mayor estudio
- b) Iniciar cefadroxilo oral y enviar a domicilio explicando los signos de alarma
- c) Regular la temperatura y solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos y pruebas de función renal, decidiendo el manejo según hallazgos
- d) Iniciar soporte, solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos, pruebas de función renal, gases venosos, radiografía de tórax, punción lumbar y exámenes de orina e iniciar una asociación de ceftriaxona y vancomicina endovenosa, inmediatamente
- e) Iniciar soporte, solicitar hemograma, hemocultivos, glicemia, calcemia, electrolitos, pruebas de función renal, gases venosos, radiografía de tórax, punción lumbar y exámenes de orina e iniciar una asociación de cefotaximo y ampicilina endovenosa, inmediatamente

10) Respecto a la taquipnea transitoria del recién nacido es verdadero que:

- a) La radiografía de tórax característica, muestra un patrón de relleno en vidrio esmerilado
- b) Es la causa más frecuente de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido pretérmino
- c) Su manejo inicial requiere de antibióticos de amplio espectro
- d) Se asocia a neumotórax
- e) Es más frecuente en los recién nacidos por cesárea

11) ¿Qué situación NO es fisiológica en un recién nacido?

- a) Signo de Babinsky
- b) Metrorragia
- c) Cefalohematoma
- d) Hernia umbilical
- e) Fiebre

12) Los huesos que con mayor frecuencia se lesionan durante el parto son:

- a) Parietales
- b) Frontales
- c) Fémures
- d) Clavículas
- e) Costillas

13) Un recién nacido de 3 días de vida, nacido por cesárea y alimentado con pecho materno exclusivo, con antecedente de sufrimiento fetal agudo, presenta decaimiento, actitud de dolor, distensión abdominal, vómitos y deposiciones sanguinolentas en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Hirschsprung
- b) Enterocolitis necrotizante
- c) Estenosis hipertrófica del píloro
- d) Invaginación intestinal
- e) Íleo meconial

14) Una mujer embarazada de 28 semanas, Rh negativo, se realiza test de Coombs indirecto como parte del control prenatal, el que resulta negativo. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar test de Coombs directo antes del parto y decidir conducta según resultados
- b) Realizar nuevos test de Coombs indirecto mensualmente y decidir conducta según resultados
- c) Realizar ecografías doppler seriadas, de arteria cerebral media fetal y decidir conducta según hallazgos
- d) Administrar inmunoglobulina anti-D (Rhogam) a la madre, y continuar controles con test de Coombs indirecto
- e) Solicitar pruebas de inmunización contra grupos atípicos, ya que las mujeres Rh negativo no tienen riesgo de hemólisis fetal por incompatibilidad de grupo Rh

15) La imagen de doble burbuja es característica de:

- a) Enterocolitis necrotizante
- b) Enfermedad de Hirschsprung
- c) Fibrosis quística
- d) Atresia duodenal
- e) Estenosis hipertrófica del píloro

16) Un recién nacido, con antecedente de líquido amniótico con meconio espeso, nace cianótico, sin movimientos respiratorios y con marcada hipotonía. Se inicia estimulación y aporte de oxígeno, permaneciendo en apnea, con FC cercana a 70x'. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar desfibrilación eléctrica
- b) Iniciar masaje cardíaco
- c) Iniciar ventilación a presión positiva
- d) Iniciar masaje cardíaco y ventilación a presión positiva
- e) Administrar adrenalina

17) Un recién nacido de término, de 3 días de vida, presenta ictericia desde hace 24 horas, que actualmente llega a los muslos. Al nacer pesó 3.420 gramos, se alimenta adecuadamente y actualmente pesa 3.230 gramos. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender la lactancia materna e iniciar fórmula
- b) Solicitar bilirrubinemia
- c) Iniciar fototerapia
- d) Realizar exanguineotransfusión
- e) Solicitar pruebas hepáticas, prueba de Coombs directa, hemograma, y hemocultivos

18) Las infecciones connatales (TORCH) son producidas principalmente por:

- a) Escherichia coli
- b) VIH
- c) Citomegalovirus
- d) Clamidia
- e) Mycoplasma

19) Un recién nacido de 43 semanas de edad gestacional, con antecedente de sufrimiento fetal, durante el parto, presenta taquipnea y quejido a los pocos minutos de nacer. Al examen físico se aprecia dificultad respiratoria y se auscultan crépitos y sibilancias bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Síndrome aspirativo meconial
- d) Neumonía neonatal
- e) Hipertensión pulmonar persistente

20) ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una contraindicación absoluta de la lactancia materna?

- a) Infección materna por hepatitis B
- b) Mastitis linfangítica
- c) Consumo materno de cocaína
- d) Prótesis mamaria de silicona
- e) Grietas del pezón

Prueba 4

1) Un recién nacido de término, con antecedente de sufrimiento fetal agudo, presenta una convulsión tónico-clónica, a las 3 horas de haber nacido. Al examen físico se aprecia hipotónico, sin focalidad neurológica. Se solicitan exámenes que muestran hemoglucotest: 53 mg/dl, Na: 136 mEq/l, Ca: 7,3 mg/dl, K: 5,1 mg/dl, hematocrito: 62%. La causa más probable de su convulsión es:

- a) Poliglobulia
- b) Hipoglicemia
- c) Hipocalcemia
- d) Hiponatremia
- e) Encefalopatía hipóxico-isquémica

2) Un recién nacido de 28 días de vida, alimentado con lactancia materna, presenta ictericia y coluria. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con ictericia hasta los muslos. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia por lactancia materna
- c) Atresia biliar primaria
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Ictericia por hemólisis

3) Un recién nacido de 21 días de edad gestacional ha presentado mal incremento ponderal y la madre refiere que se fatiga al mamar. Al examen físico se constatan crépitos bilaterales, difusos, mayores en las bases, con un soplo sistólico intenso y saturación de oxígeno de 79% a FiO2 ambiental, que mejora a 89% con FiO2: 0,35. EL diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía congénita con mezcla total
- b) Cardiopatía congénita sin mezcla
- c) Cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha
- d) Cardiopatía congénita con cortocircuito de derecha a izquierda
- e) Cardiopatía congénita obstructiva izquierda

4) Un recién nacido de 5 días de vida pesa 3.500 gr. Al nacer pesó 3.800 gr y se ha alimentado con lactancia materna exclusiva. La conducta más adecuada es

- a) Observar evolución, manteniendo la lactancia materna exclusiva
- b) Agregar fórmula láctea y mantener la lactancia materna
- c) Iniciar fórmula láctea y suspender la lactancia materna
- d) Solicitar test del sudor
- e) Iniciar nutrición parenteral

5) Son factores de riesgo para la muerte súbita neonatal, EXCEPTO:

- a) Sexo femenino
- b) Prematurez
- c) Antecedente de hermanos con muerte súbita
- d) Posición prona al dormir
- e) Tabaquismo materno

6) Las etiologías más frecuentes de la mortalidad fetal tardía y la mortalidad neonatal precoz son respectivamente:

- a) Infecciones congénitas y Malformaciones congénitas
- b) Accidentes de placenta y cordón y Prematurez
- c) Síndrome hipertensivo del embarazo y Malformaciones congénitas
- d) Anomalías genéticas y Sepsis neonatal
- e) Síndrome hipertensivo del embarazo y Prematurez

7) Respecto a la enfermedad de membrana hialina es FALSO que:

- a) Es menos frecuente en los recién nacidos pequeños para la edad gestacional
- b) Puede prevenirse con el uso de corticoides antenatales
- c) Es la causa más frecuente de distrés respiratorio en el recién nacido pretérmino
- d) Radiológicamente puede ser indistinguible de una neumonía
- e) El neumotórax es una complicación característica

8) Un recién nacido de 3 días de vida presenta decaimiento, hipotonía y dificultad para regular la temperatura. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemograma, glicemia, calcemia e iniciar medidas físicas para regular la temperatura
- b) Iniciar amoxicilina por vía oral y controlar en 24 horas
- c) Solicitar hemograma, sedimento de orina, urocultivo, glicemia, electrolitos y creatinina, decidiendo la conducta según los hallazgos
- d) Iniciar soporte, solicitar hemograma, hemocultivos, sedimento de orina, urocultivo, radiografía de tórax, glicemia, electrolitos, creatinina, estudio de líquido cefalorraquídeo e iniciar ampicilina más cefotaximo por vía endovenosa
- e) Iniciar soporte, pedir exámenes en busca de un foco infeccioso, incluyendo el estudio de líquido cefalorraquídeo e iniciar ceftriaxona + vancomicina por vía endovenosa

9) Es un factor de riesgo para el síndrome de aspiración meconial:

- a) Prematurez
- b) Fibrosis quística
- c) Postmadurez
- d) Hijo de madre diabética
- e) Parto por cesárea

10) El tratamiento de la poliglobulia neonatal sintomática suele ser:

- a) Exangineotransfusión
- b) Hidroxiurea
- c) Extracción de sangre y administración de suero fisiológico
- d) Aspirina
- e) Anticoagulación

11) Un recién nacido de término presenta ictericia hasta las rodillas, que inició a las pocas horas de haber nacido. Su madre no había presentado embarazos previos y tiene grupo sanguíneo O-Rh(-). Se solicita bilirrubina total y directa, que resultan 5,4 mg/dl y 0,9 mg/dl respectivamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia por incompatibilidad de grupo clásico
- c) Ictericia por incompatibilidad Rh
- d) Atresia biliar primaria
- e) Hipotiroidismo

12) ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO es normal en un recién nacido?

- a) Bazo palpable
- b) Bolsa serosanguínea
- c) Fiebre
- d) Granuloma umbilical
- e) Millium sebáceo

13) La estenosis hipertrófica del píloro suele diagnosticarse mediante:

- a) Endoscopia digestiva
- b) Radiografía abdominal
- c) Ecografía abdominal
- d) TAC de abdomen
- e) Contigraña con tecnecio

14) Una mujer Rh negativa, de 28 semanas de gestación, se realiza una prueba de Coombs indirecto que resulta positiva para el antígeno D. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva prueba de Coombs indirecto previo al parto
- b) Solicitar prueba de Coombs directo
- c) Administrar Gamaglobulina anti-D
- d) Realizar cordocentesis y realizar hemograma y pruebas de inmunización en la sangre fetal
- e) Solicitar ecografías doppler periódicas de arteria cerebral media fetal

15) Respecto a la parálisis cerebral es verdadero que:

- a) La mayoría de las veces se debe a causas anteriores al parto
- b) La mayoría de las veces se asocia a retraso mental
- c) La mayoría de las veces el compromiso es mayormente sensitivo
- d) La mayoría de las veces se aprecia hipotonía generalizada
- e) La mayoría de las veces es diagnóstico se realiza mediante una ecografía cerebral

16) Un recién nacido prematuro presentará un mayor riesgo de:

- a) Sepsis
- b) Displasia de cadera
- c) Cardiopatías congénitas
- d) Síndrome de Down
- e) Poliglobulia

17) ¿Cuál de las siguientes alternativas es una contraindicación de la lactancia materna?

- a) Adicción materna a la pasta base
- b) Hepatitis B materna
- c) Estenosis hipertrófica del píloro
- d) Mastitis linfagítica
- e) Influenza materna

18) Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional presenta aleteo nasal y taquipnea algunos minutos después de haber nacido. Al examen físico se auscultan algunos crépitos bibasales y satura 89% a FIO₂ ambiental. Se solicita una radiografía de tórax que muestra hilios prominentes, con derrame pleural pequeño bilateral. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar oxígeno y observar evolución
- b) Indicar apoyo ventilatorio, administrar antibióticos endovenosos y surfactante endotraqueal
- c) Administrar indometacina y oxígeno
- d) Administrar prostaglandina y solicitar ecografía cardíaca
- e) Administrar oxígeno y diuréticos

19) La fórmula de relleno que se suele dejar en el sistema público suele ser: Leche purita fortificada al 7,5% + azúcar al 2,5% + aceite al 1,5%. ¿Cuál es la razón del aporte del aceite?

- a) Aporte de vitaminas liposolubles
- b) Aporte de ácidos grasos esenciales
- c) Aumento de la carga osmolar
- d) Disminución de la carga osmolar
- e) Aporte de calorías

20) Un recién nacido pequeño para la edad gestacional, con antecedente de sufrimiento fetal agudo, presenta vómitos reiterados, asociados a deposiciones hemorrágicas en 2 oportunidades. Al examen físico se aprecia distensión abdominal. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar régimen cero, iniciar hidratación y antibióticos endovenosos y solicitar radiografía de abdomen
- b) Indicar régimen cero, iniciar hidratación y antibióticos endovenosos y colonoscopia
- c) Mantener la lactancia materna y solicitar radiografía de abdomen
- d) Mantener la lactancia materna y solicitar test de Apt-Downey de las deposiciones
- e) Suspender la lactancia materna e iniciar fórmula de inicio

Prueba 5

1) Un recién nacido de 32 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria, que inicia 2 horas después de nacido y que va empeorando al pasar de las horas. Se solicita radiografía de tórax que muestra pulmones radiopacos en patrón de vidrio esmerilado, con broncograma aéreo. El tratamiento de la patología descrita es:

- a) Oxigenoterapia
- b) Soporte respiratorio más surfactante endotraqueal
- c) Corticoides endovenosos
- d) Antibióticos endovenosos y soporte ventilatorio
- e) Broncodilatadores inhalados y corticoides sistémicos

2) Un recién nacido de 10 horas de vida, presenta ictericia hasta los muslos, constatándose elevación importante de la bilirrubina indirecta. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia por leche materna
- c) Hipotiroidismo congénito
- d) Hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- e) Atresia biliar primaria

3) En la reanimación neonatal es especialmente importante:

- a) La administración de bicarbonato endovenoso
- b) El masaje cardíaco
- c) Las drogas vasoactivas endovenosas
- d) La desfibrilación eléctrica
- e) La ventilación a presión positiva

4) Un recién nacido de pocas horas de vida presenta aumento de volumen de la cabeza, caracterizado por edema y equimosis en la frente y ambas zonas parietales. El diagnóstico más probable es:

- a) Cefalohematoma
- b) Caput succedaneum
- c) Deformación plástica de los huesos parietales
- d) Meningitis neonatal
- e) Mielomeningocele

5) El niño pequeño para la edad gestacional tiene mayor riesgo de presentar todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Hipoglicemia
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Poliglobulia
- d) Asfixia neonatal
- e) Hipotermia

6) Un recién nacido de término, de 25 días de edad consulta por vómitos recurrentes, que acontecen pocos minutos después de alimentarse. Muchas veces se muestra hambriento y ha dejado de subir de peso. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía abdominal
- b) Observar evolución
- c) Solicitar radiografía simple de abdomen
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Iniciar domperidona oral

7) Un recién nacido presenta cianosis marcada que no responde a oxígeno al 100%. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico eyectivo. El diagnóstico más probable, de entre las siguientes alternativas, es:

- a) Tronco arterioso
- b) Ductus arteriosos persistente
- c) Comunicación interventricular
- d) Comunicación interauricular
- e) Coartación aórtica

8) Un niño recién nacido presenta salida persistente de líquido transparente, amarillento por el ombligo, con pH ácido, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Onfalitis
- b) Persistencia del conducto onfalomesentérico
- c) Persistencia del uraco
- d) Impétigo buloso
- e) Normal

9) La etiología más frecuente del hipotiroidismo congénito es:

- a) Disgenesia tiroidea
- b) Autoinmune
- c) Infeccioso
- d) Déficit de yodo
- e) Cromosomopatía

10) Un recién nacido de 42+2 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria y aleteo nasal. Al examen físico se constata taquipnea, retracción intercostal, murmullo pulmonar disminuido, sibilancias bilaterales y escasos crépitos. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Hipertensión pulmonar persistente
- c) Enfermedad de membrana hialina
- d) Síndrome de aspiración meconial
- e) Neumonía neonatal

11) Un recién nacido pretérmino de 4 días de vida, consulta por decaimiento y temperatura de 38,8°C. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar paracetamol oral y observar evolución
- c) Solicitar hemograma, urocultivo y sedimento de orina y administrar tratamiento sintomático
- d) Solicitar hemograma, urocultivo, sedimento de orina, radiografía de tórax, hemocultivos y punción lumbar y realizar tratamiento sintomático
- e) Solicitar hemograma, urocultivo, sedimento de orina, radiografía de tórax, hemocultivos, punción lumbar e iniciar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa.

12) Un recién nacido que no recibe lactancia materna, puede alimentarse con:

- a) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más cereal al 3%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%

13) La enfermedad de Hirschsprung se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Su tratamiento suelen ser quirúrgico
- b) Se diagnostica habitualmente mediante ecografía abdominal
- c) Sus síntomas suelen ser similares a una obstrucción intestinal
- d) El retraso en la eliminación de meconio es característica
- e) Su etiología es la ausencia de neuronas en el plexo mientérico

14) Un recién nacido, con antecedente de asfixia neonatal, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta vómitos, asociados a distensión abdominal y hematoquezia en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Atresia duodenal
- b) Enterocolitis necrotizante
- c) Estenosis hipertrófica del píloro
- d) Intususcepción intestinal
- e) Intolerancia a la lactosa

15) La poliglobulia neonatal se diagnostica mediante:

- a) Hematocrito
- b) Hemoglobina plasmática
- c) Cantidad de glóbulos rojos por mm³ de sangre
- d) Eritropoyetina plasmática
- e) Examen físico

16) Un recién nacido presenta un exantema pustular, con base eritematosa, que compromete la cara tronco y la zona proximal de las extremidades, con cerca de 20 lesiones en total. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con las lesiones descritas, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar IgM para varicela
- c) Iniciar cloxacilina endovenosa
- d) Iniciar aciclovir
- e) iniciar cefotaximo +ampicilina y solicitar exámenes en busca de un foco infeccioso

17) Un recién nacido pretérmino presenta ictericia hasta el abdomen, que aparece 5 días después de nacer. Se solicita bilirrubina total, que resulta 8 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Sepsis neonatal
- b) Hemólisis
- c) Ictericia fisiológica
- d) Ictericia por nutrición parenteral
- e) Ictericia por lactancia materna

18) Identifique la asociación INCORRECTA:

- a) Mortalidad neonatal precoz – Muertes entre el nacimiento y los 7 días de vida / nacidos vivos
- b) Mortalidad neonatal tardía – Muertes entre los 7 días y los 28 días de vida / nacidos vivos
- c) Mortalidad fetal tardía – Muertes intrauterinas después de las 28 semanas de EG / nacidos vivos
- d) Mortalidad perinatal – Muertes entre los 5 días antes y los 5 días después del parto / nacidos vivos
- e) Tasa de abortos – Muertes antes de las 22 semanas de EG / nacidos vivos

19) Un recién nacido, hijo de madre diabética, presenta hiporreactividad e hipotonía, a las 3 horas de nacido, seguidas de una convulsión. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipocalcemia
- b) Meningitis neonatal
- c) Epilepsia
- d) Encefalopatía hipóxica isquémica
- e) Hipoglicemia

20) El recién nacido prematuro tiene mayor riesgo de:

- a) Displasia de cadera
- b) Hemorragias cerebrales
- c) Cardiopatías congénitas
- d) Poliglobulia neonatal
- e) Síndrome de Down

Prueba 6

1) Un recién nacido de término, de 5 días de vida, presenta ictericia hasta los muslos, que inició al tercer día de vida. Se alimenta con leche materna exclusiva y al examen físico no presenta otras alteraciones. Su madre es de grupo sanguíneo O-Rh(+). El diagnóstico más probable es:

- a) Hemólisis por grupo Rh
- b) Ictericia fisiológica
- c) Hemólisis por grupo clásico
- d) Sepsis
- e) Ictericia por leche materna

2) Un recién nacido de 3 días de vida presenta múltiples equimosis generalizadas, sin otros hallazgos. La madre refiere que no ha sufrido traumatismos. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar biopsia de médula ósea
- c) Solicitar hemograma, con recuento de plaquetas y pruebas de coagulación
- d) Realizar transfusión de plasma fresco congelado
- e) Iniciar corticoides sistémicos

3) La etiología más frecuente de la sepsis neonatal es:

- a) Estreptococo grupo A y bacilos gram negativos
- b) Estreptococo grupo B y bacilos gram positivos
- c) Estafilococo áureo y bacilos gram negativos
- d) Estafilococo áureo y bacilos gram positivos
- e) Streptococcus agalactiae y Escherichia coli

4) Ante una ictericia prolongada, de predominio indirecto se debe seospechar:

- a) Hemólisis
- b) Atresia biliar primaria
- c) Hipotiroidismo congénito
- d) Hepatitis neonatal
- e) Ictericia fisiológica

5) El principal factor de riesgo para desarrollar una sepsis neonatal es:

- a) Prematurez
- b) Diabetes materna
- c) Parto prolongado
- d) Infección urinaria materna
- e) Retraso del crecimiento intrauterino

6) ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo para presentar poliglobulia neonatal?

- a) Diabetes materna
- b) Recién nacido pequeño para la edad gestacional
- c) Preclamsia materna
- d) Retraso en la sección del cordón umbilical
- e) Prematurez

7) Un recién nacido de término presenta marcada dificultad para respirar con cianosis pocos minutos después de nacer. Al examen físico se aprecia excavación abdominal profunda. El diagnóstico más probable es:

- a) Enterocolitis necrotizante
- b) Síndrome de aspiración meconial
- c) Enfermedad de membrana hialina
- d) Agenesia pulmonar
- e) Hernia diafragmática congénita

8) La mortalidad perinatal engloba a aquellas muertes que suceden:

- a) Entre el parto y los 7 días de vida
- b) El día del parto
- c) Entre las 28 semanas de gestación y los 7 días de vida extrauterina
- d) Entre el nacimiento y los 28 días de vida
- e) Entre las 36 semanas de edad gestacional y los 28 días de vida

9) Un recién nacido pretérmino, de 30 semanas de edad gestacional, presenta compromiso de conciencia algunas horas después de nacer. Al examen físico se aprecia abombamiento de la fontanela anterior y anisocoria. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis neonatal
- b) Hidrocefalia congénita
- c) Infección congénita por citomegalovirus
- d) Edema cerebral
- e) Hemorragia periventricular

10) El recién nacido postérmino tiene mayor riesgo de presentar:

- a) Anemia
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Taquipnea transitoria
- d) Ictericia
- e) Asfixia

11) Un recién nacido de 35 semanas de edad gestacional presenta dificultad respiratoria, que responde a oxígeno al 28%. Al examen físico se auscultan escasos crépitos en las bases. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Cardiopatía congénita cianótica
- b) Cardiopatía congénita acianótica
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Neumonía neonatal
- e) Taquipnea transitoria

12) ¿Qué alteración es normal en un recién nacido?

- a) Temperatura de 38,5°C
- b) Convulsiones
- c) Hipotonía
- d) Hematocrito de 60%
- e) Presencia de reflejos arcaicos

13) Un recién nacido, pequeño para la edad gestacional, de 3 horas de vida, presenta deterioro del estado general y una convulsión tónico-clónica. El primer examen que debe solicitarse es:

- a) Hemoglucotest
- b) Ecografía cerebral
- c) Electroencefalograma
- d) Hemograma
- e) Calcemia

14) La enfermedad de membrana hialina se produce por:

- a) Falta de desarrollo de los sacos alveolares
- b) Falta de surfactante pulmonar
- c) Retraso en la reabsorción del líquido pulmonar
- d) Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar
- e) Vasoconstricción pulmonar

15) Un recién nacido es diagnosticado de galactosemia. Esto significa que:

- a) Tiene contraindicación absoluta de lactancia materna y de alimentación con relleno a base de leche de vaca u otro mamífero
- b) Sólo puede consumir lactancia materna y tiene contraindicada la alimentación con relleno a base de leche de vaca
- c) Sólo puede ser alimentado con relleno a base de leche de vaca y tiene contraindicación absoluta de la lactancia materna
- d) Debe alimentarse con leche materna extraída y tratada con lactasa
- e) Debe alimentarse con leche de vaca tratada con lactasa

16) ¿Qué leche indicaría a un lactante de 8 meses, de entre las alternativas enumeradas?

- a) 100 ml/kg/d de leche purita fortificada al 10% más azúcar al 2,5% y cereal al 3%
- b) 120 ml/kg/d de leche purita fortificada al 10% más azúcar al 2,5% y aceite al 1,5-2%
- c) 120 ml/kg/d de leche purita fortificada al 7,5% más azúcar al 2,5% y cereal al 3%
- d) 150 ml/kg/d de leche purita fortificada al 7,5% más azúcar al 2,5% y aceite al 1,5-2%
- e) 150 ml/kg/d de leche purita fortificada al 7,5% más azúcar al 2,5% y cereal al 3%

17) Un recién nacido presenta una hernia umbilical que se palpa con un anillo herniario de 1,5 cm de diámetro mayor. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar ecografía de pared abdominal
- c) Realizar cirugía electiva
- d) Realizar cirugía de urgencia
- e) Realizar cirugía al cumplir un año de edad

18) Un recién nacido pequeño para la edad gestacional, con antecedente de asfixia neonatal, presenta distensión abdominal, asociada a vómitos y deposiciones explosivas, con estrías de sangre. El diagnóstico más probable es:

- a) Invaginación intestinal
- b) Estenosis hipertrófica del píloro
- c) Enfermedad de Hirschsprung
- d) Enterocolitis por citomegalovirus
- e) Enterocolitis necrotizante

19) ¿Qué fármaco debe ser administrado ante la sospecha clínica de una cardiopatía congénita cianótica, ductus-dependiente?

- a) Ninguno
- b) Noradrenalina
- c) Indometacina
- d) Prostaglandina
- e) Bicarbonato de sodio

20) Una mujer embarazada Rh negativa se realiza una prueba de Coombs indirecto a las 28 semanas, que resulta negativa. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Coombs directo materno
- b) Solicitar Coombs directo fetal
- c) Solicitar ecografía transvaginal
- d) Administrar una dosis de inmunoglobulina anti-D (Rhogam)
- e) Observar evolución, sin necesidad de administrar fármacos

RESPUESTAS NEONATOLOGÍA

Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
1 C	1 E	1 E	1 E	1 B	1 B
2 A	2 E	2 B	2 C	2 D	2 C
3 E	3 D	3 D	3 C	3 E	3 D
4 B	4 B	4 D	4 A	4 B	4 C
5 D	5 D	5 E	5 A	5 B	5 A
6 C	6 C	6 D	6 B	6 A	6 E
7 D	7 C	7 B	7 E	7 A	7 E
8 D	8 A	8 D	8 D	8 C	8 D
9 E	9 A	9 E	9 C	9 A	9 E
10 B	10 A	10 E	10 C	10 D	10 E
11 C	11 E	11 E	11 B	11 E	11 E
12 B	12 C	12 D	12 C	12 E	12 D
13 A	13 B	13 B	13 C	13 B	13 A
14 C	14 C	14 D	14 E	14 B	14 B
15 E	15 C	15 D	15 A	15 A	15 A
16 C	16 B	16 C	16 A	16 A	16 C
17 A	17 C	17 B	17 A	17 C	17 A
18 C	18 A	18 C	18 A	18 D	18 E
19 A	19 D	19 C	19 B	19 E	19 D
20 D	20 D	20 C	20 A	20 B	20 D

II) PEDIATRÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Un lactante de 10 meses ha presentado 3 episodios de tos y dificultad respiratoria. Al examen físico se aprecia taquipnea, retracción intercostal y se auscultan sibilancias bilaterales. El primer episodio fue a los 5 meses de edad y no ha presentado síntomas entre ellos. La etiología más probable de este problema es:

- a) Infecciones reiteradas por VRS
- b) Cardiopatía congénita
- c) Displasia broncopulmonar
- d) Hiperreactividad bronquial alérgica contra antígenos ambientales
- e) Hiperreactividad bronquial secundaria a infección por VRS, exacerbada por infecciones posteriores por otros virus respiratorios

2) Un paciente de 14 meses es traído por su madre, ya que presenta diarrea acuosa abundante, asociada a fiebre hasta 38,4°C de un día de evolución. Al examen físico se observa en buenas condiciones, animado, afebril y con signos vitales normales. Las mucosas están húmedas, la piel turgente y llora con lágrimas. La conducta más adecuada es

- a) Enviar a domicilio con régimen liviano, sin residuos e hidratación oral con sales de rehidratación luego de cada deposición diarreica
- b) Indicar antibióticos y sales de rehidratación oral, según plan A
- c) Indicar reposición hídrica con sales de rehidratación oral con 50-100cc/Kg y reevaluar en 4 a 6 horas
- d) Indicar antidiarreicos y sales de rehidratación oral, según plan B
- e) Enviar a domicilio con régimen liviano sin residuos, hidratación oral, según plan A, antibióticos y antidiarreicos

3) Un lactante de 4 meses de edad se cansa fácilmente durante la succión. Ha presentado varios episodios de infecciones respiratorias y presenta mal incremento ponderal. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico III/VI en el precordio izquierdo, la auscultación pulmonar demuestra escasos crépitos. No se observa cianosis, sin embargo satura 90% a FiO2 ambiental, lo que se normaliza con oxígeno. El diagnóstico más probable es:

- a) Coartación aórtica
- b) Comunicación interauricular
- c) Comunicación interventricular
- d) Tetralogía de Fallot
- e) Ductus arterioso persistente

4) Un niño de 7 años presenta fiebre, y compromiso del estado general de 7 días de evolución. La madre refiere que en algunas oportunidades cojea por dolor en la rodilla derecha. No presenta síntomas urinarios, respiratorios ni digestivos. Al examen se observa moderadamente pálido, con petequias en tronco y extremidades inferiores, sin otros hallazgos de importancia. El diagnóstico más probable es:

- a) Fiebre tifoidea
- b) Endocarditis bacteriana subaguda
- c) Púrpura trombocitopénico inmune
- d) Osteomielitis aguda
- e) Leucemia aguda

5) Las primeras causas de muerte en los lactantes, prescolares y escolares son respectivamente:

- a) Asfixia neonatal, infecciones respiratorias y traumatismos
- b) Prematurez, traumatismos y traumatismos
- c) Prematurez, malformaciones congénitas e infecciones respiratorias
- d) Malformaciones congénitas, traumatismos y traumatismo
- e) Asfixia neonatal, malformaciones congénitas e infecciones respiratorias

6) ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor el cuadro clínico de la glomerulonefritis postestreptocócica?

- a) Hematuria dismórfica, proteinuria leve, edema e hipertensión arterial, asociadas a elevación transitoria del complemento, que inicia 7 a 14 días después de una amigdalitis pultácea
- b) Hematuria aislada, con complemento normal, durante una infección estreptocócica
- c) Proteinuria, lipiduria, orinas espumosas y edema, sin hipertensión y con complemento normal, que inicia 10 días después de una amigdalitis pultácea
- d) Hematuria, edema e hipertensión arterial, asociada a hipocomplementemia, que inicia 10 días después de una infección estreptocócica
- e) Proteinuria, edema e hipertensión arterial, asociada a hipocomplementemia, durante una infección estreptocócica

7) Un niño de 4 años ingiere accidentalmente una sustancia desconocida, evolucionando con náuseas, vómitos, malestar y compromiso de conciencia. Al examen físico se aprecia taquicárdico, hipertenso, en sopor superficial y desorientado. Se observa midriasis bilateral y no se auscultan ruidos intestinales. ¿Qué sustancia es responsable de este cuadro clínico, con mayor probabilidad?

- a) Organofosforados
- b) Opiodes
- c) Anticolinérgicos
- d) Betabloqueadores adrenérgicos
- e) Hidrocarburos

8) Un niño consulta por fiebre de 7 días de evolución, asociado a un rash papuloeritematoso generalizado. En el examen se observa eritema e inyección conjuntival, los labios y la lengua están enrojecidas y aumentadas de volumen. Se palpan 2 adenopatías cervicales anteriores, la mayor de ellas de 2,5 cm. Además se constata edema, eritema y fina descamación en ambos pies. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia linfoblástica aguda
- b) Sarampión
- c) Escarlatina
- d) Artritis reumatoídea juvenil
- e) Enfermedad de Kawasaki

9) Un lactante de 11 meses presenta, presenta palidez, por lo que se solicita hemograma, objetivándose anemia, con hematocrito: 30%, Hb: 9,2; VCM: 70; HCM: 25. El índice de dispersión del tamaño de los glóbulos rojos está aumentado. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Talasemia
- c) Déficit de vitamina B12
- d) Anemia fisiológica
- e) Anemia de enfermedades crónicas

10) Respecto al manejo de la hepatitis A, ¿Cuál de las siguientes alternativas es FALSA?

- a) Debe solicitarse tiempo de protrombina para determinar la gravedad de la hepatitis
- b) El diagnóstico es clínico, ya que no se cuenta con exámenes diagnósticos específicos
- c) Debe administrarse inmunoglobulina no específica a los contactos cercanos
- d) La vacunación se aconseja en mayores de un año, que no han sufrido la enfermedad
- e) El compromiso de conciencia determina un peor pronóstico

11) Un niño de 7 años presenta tos con el ejercicio y durante algunas infecciones respiratorias, que se ha acompañado de respiración sibilante y 3 oportunidades. Presenta cerca de un episodio al mes y no refiere síntomas nocturnos ni en reposo. Actualmente se encuentra asintomático y el examen físico es normal. Usted solicita una radiografía de tórax que es informada como normal y un test de metacolina, que demuestra hiperreactividad bronquial. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar beta-agonistas de acción corta previo al ejercicio y durante los síntomas
- b) Iniciar corticoides inhalados, según horario, asociados a beta-agonistas de acción corta, durante los síntomas
- c) Iniciar corticoides y beta-agonistas de acción larga inhalados, según horario, asociados a beta-agonistas de acción corta, durante los síntomas
- d) Solicitar prick test y decidir manejo según hallazgos
- e) Solicitar espirometría y decidir conducta según hallazgos

12) ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en el paciente severamente inmunodeprimido?

- a) Hepatitis B
- b) Varicela
- c) DPT
- d) Polio parenteral
- e) Hepatitis A

13) Un niño de 2 meses, presenta decaimiento y fiebre hasta 38,7°C, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, reactivo, hidratado, bien perfundido, con temperatura de 38,3°C. El examen segmentario resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con antipiréticos y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento
- b) Enviar a domicilio con antipiréticos y antibióticos orales
- c) Solicitar sedimento de orina y urocultivo y decidir manejo según resultados
- d) Solicitar sedimento de orina, urocultivo, hemograma, VHS y PCR y decidir manejo según resultados
- e) Solicitar sedimento de orina, urocultivo, hemograma, VHS, PCR y punción lumbar, e iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro

14) Un niño de 10 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de malestar general y náuseas, evolucionando con dolor abdominal y vómitos en 4 oportunidades. Algunas horas, previo a la consulta, se agrega desorientación y luego sopor. Al examen físico se aprecia deshidratado, en Glasgow 13, con respiraciones profundas, su pulso es regular a 139 lpm y su presión arterial es 90/60. El resto del examen físico no aporta mayor información. La saturación de oxígeno por pulsometría es 98%. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Iniciar hidratación con sales de rehidratación, por vía oral
- b) Administrar 20 cc/Kg de suero fisiológico por vía periférica y reevaluar en 1 hora
- c) Solicitar hemoglucotest e instalar vía venosa periférica
- d) Administrar suero fisiológico e hidrocortisona por vía endovenosa y solicitar hemograma, electrolitos plasmáticos, glicemia y calcemia
- e) Solicitar hemograma, electrolitos plasmáticos, glicemia, calcemia y TAC de cerebro y decidir conducta según hallazgos

15) Un niño de 6 años consulta por cuadro de malestar, fiebre hasta 38,7°C y eritema facial, al que luego se agrega un exantema macular eritematoso, que compromete tronco y extremidades, con confluencia de las lesiones, en disposición reticular. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema toxico
- b) Quinta enfermedad
- c) Rubéola
- d) Exantema súbito
- e) Síndrome pie mano boca

16) La primera causa de insuficiencia renal crónica y la primera causa de hipertensión arterial, en los niños, son respectivamente:

- a) Diabetes mellitus 1 e hipertensión esencial
- b) Hipertensión arterial y renovascular
- c) Malformaciones renales e insuficiencia renal crónica
- d) Diabetes mellitus 1 y malformaciones vasculares
- e) Malformaciones urológicas y malformaciones vasculares

17) Un niño de 7 años de edad presenta índice peso/edad: +0,6 DS; índice peso/talla: +1,2 DS e índice talla/edad: -0,8 DS. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición
- b) Eutrofia
- c) Sobrepeso
- d) Obesidad
- e) Obesidad mórbida

18) Usted atiende a un lactante de 10 meses febril hasta 39,2°C, sin otros síntomas. Su examen físico es normal por lo que usted solicita un urocultivo por sondeo, que muestra desarrollo de Escherichia coli multisensible, con 1000 unidades formadoras de colonias por ml. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar nitrofurantoína oral
- b) Iniciar cefadroxilo oral
- c) Iniciar ciprofloxacino oral
- d) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- e) Enviar a domicilio con tratamiento sintomático y controlar en 24 horas

19) Un adolescente de 14 años consulta por malestar abdominal, febrícula ocasional y diarrea de 5 semanas de evolución, que en el último tiempo se ha hecho sanguinolenta. Al examen físico se palpa un abdomen blando, depresible, sensible difuso, sin masas ni visceromegalia, con ruidos hidroaéreos aumentados. No se aprecian otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperplasia nodular linfática
- b) Polipomatosis adenomatosa intestinal
- c) Divertículo de Meckel
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Amebiasis

20) Un niño de 10 años es traído por su madre, ya que es el más bajo del curso. No presenta otros síntomas y el examen físico es normal. Su estatura se encuentra entre el percentil 5 y el percentil 10 para su edad. El padre mide 1,80 m y ella mide 1,73 m. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar testosterona libre y total
- b) Solicitar TSH, FSH y testosterona plasmática
- c) Solicitar radiografía de carpo
- d) Solicitar hemograma, pruebas de función renal y pruebas hepáticas
- e) Revisar su curva de crecimiento

Prueba 2

1) Lactante de 3 meses, peso de nacimiento 3.200 grs. En los últimos 2 meses se alimenta con lentitud y se pone sudoroso. Ha presentado bronquitis obstructivas a repetición.

Al examen: peso 4200 g, polipneico, saturación de hemoglobina 80% que se corrige al aportar oxígeno. Presenta crepitaciones basales bilaterales, hígado a 4 cm bajo reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Bronconeumonía en lactante hiperreactivo bronquial
- b) Displasia broncopulmonar
- c) Cardiopatía congénita cianótica
- d) Fibrosis quística
- e) Cardiopatía congénita no cianótica

2) Un lactante de 3 meses de edad, previamente sano, es traído a consultorio por haber presentado hace 2 horas un episodio descrito como de cese de la respiración por unos 20 segundos y palidez intensa, que se recuperó al estimularlo. Al examen, se ve de buen aspecto, afebril, rosado. Llama la atención la presencia de restos de sangre en la boca y nariz del niño.

La principal sospecha diagnóstica que usted debe plantear es:

- a) Maltrato infantil
- b) Apnea primaria.
- c) Apnea secundaria a reflujo gastroesofágico
- d) ALTE (Apparent Life Threatening Event) de causa neurológica
- e) ALTE y sangramiento por reanimación vigorosa

3) Escolar de 10 años, con antecedentes de asma bronquial, que presenta ahogo progresivo. Se observa pálido y angustiado. Presenta una frecuencia respiratoria de 40 por minuto, frecuencia cardíaca de 140 por minuto, T_{ax} 36,8°C, retracción subcostal e intercostal. El murmullo pulmonar se encuentra globalmente disminuido. No se auscultan sibilancias.

El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax espontáneo
- b) Neumonía bilateral
- c) Crisis asmática
- d) Cuerpo extraño
- e) Laringitis obstructiva

4) ¿Cuál es la frecuencia de recurrencia de la convulsión febril?

- a) 1 a 2%
- b) 5 a 10%
- c) 10 a 20%
- d) 30 a 40%
- e) 70 a 80%

5) Un niño de 7 años presenta un cuadro de anorexia, fiebre, fatiga, mialgias y cefalea. Al examen físico se aprecia pálido, con petequias en tórax y extremidades. Se observa una cicatriz quirúrgica en el tórax y en la auscultación cardíaca se escuchan un soplo cardíaco con un componente sistólico y otro diastólico. Destaca además un bazo palpable 2 cm bajo el reborde costal y temperatura axilar de 38.5°C. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura trombocitopénico idiopático
- b) Leucemia linfoblástica aguda
- c) Mononucleosis infecciosa
- d) Endocarditis bacteriana subaguda
- e) Púrpura anafiláctico

6) Un niño de 6 años con historia de dolor abdominal de 4 días. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, afebril, con hemodinamia estable. La palpación abdominal demuestra una masa de 15 cm en el flanco y fosa iliaca izquierda. La conducta inicial debe ser:

- a) Realizar tacto rectal y descartar fecaloma
- b) Solicitar ecografía abdominal para descartar Tumor de Wilms
- c) Solicitar radiografía de abdomen simple para descartar obstrucción intestinal
- d) Realizar hemograma para descartar un plastrón apendicular
- e) Eco abd para descartar riñón ectópico

7) La principal complicación y más temida de la enfermedad de Kawasaki es:

- a) Miocardiopatía dilatada
- b) Arritmias
- c) Insuficiencia cardíaca congestiva
- d) Aneurismas de las arterias coronarias
- e) Hemorragias cerebrales

8) Un niño de 7 años se cae en el colegio, golpeándose la cabeza. No recuerda como se cayó, pero posteriormente recuerda bien. No perdió la conciencia en ningún momento. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica ni otros hallazgos patológicos. La conducta más adecuada es:

- a) Remitir a su domicilio con observación cuidadosa y con indicación de control en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar radiografía de cráneo y decidir manejo según hallazgos
- c) Solicitar TAC de cerebro sin contraste, inmediatamente y decidir manejo según hallazgos
- d) Administrar analgésicos y anticonvulsivantes y solicitar TAC de cerebro con contraste
- e) Derivar para manejo ambulatorio por un neurólogo

9) Niño de 4 años con fiebre de 4 días y síndrome purpúrico (petequias y equimosis aisladas en el tronco). En la anamnesis surge el dato de dolor óseo en el extremo distal del fémur derecho, que lo hace claudicar. Al examen físico se pesquiza esplenomegalia de 2 cm. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura trombocitopénico inmune
- b) Lupus eritematoso
- c) Artritis reumatoidea juvenil
- d) Leucemia aguda
- e) Enfermedad de Kawasaki

10) La etiología más frecuente de la bronquiolitis aguda en lactantes es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Mycoplasma pneumoniae
- c) Influenza
- d) Parainfluenza
- e) Adenovirus

11) Un joven de 14 años llega a su consultorio con la madre, porque están preocupados por sus mamas. El niño está bien desarrollado y con sobrepeso; tiene vello axilar y pubiano, y el desarrollo peneano y el crecimiento testicular están apropiados para la edad (etapa Tanner III). Sus mamas están aumentadas simétricamente de tamaño; el tejido mamario mide 4 cm. de diámetro a derecha y 6 cm a izquierda, con grosor de 0.5 cm. No hay inflamación ni flujo. El diagnóstico más probable es:

- a) Ginecomastia puberal benigna
- b) Ginecomastia secundaria a fumar marihuana
- c) Síndrome de Klinefelter
- d) Tumor adenocortical
- e) Síndrome adrenogenital

12) Una niña de 6 años es hospitalizada para la evaluación de un cuadro de anasarca. Los resultados de los exámenes de laboratorio son: creatinina sérica, 0,5 mg/dl; albúmina, 1,8 g/dl; colesterol, 300 mg/dl; triglicéridos, 350 mg/dl; complemento C3, 100 mg/dl, anticuerpos antinucleares, negativo; y análisis de orina 5-10 eritrocitos por campo y proteína en orina: 300 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico MAS probable de acuerdo a estos datos?

- a) Nefropatía membranosa
- b) Glomerulonefritis membranoproliferativa
- c) Síndrome nefrótico a cambios mínimos
- d) Glomerulonefritis aguda posinfecciosa
- e) Lupus eritematoso sistémico

13) Niño de 10 años consulta en el servicio de urgencia pediátrico por presentar vómitos, cólicos abdominales y enterorragia. Ha tenido 3 episodios previos de hemorragia rectal indolora entre los 2 y 5 años. Usted sospecha invaginación intestinal y pide una ecografía abdominal. Se reduce la invaginación y no se comprueba otra alteración. ¿Cuál es la causa más probable de la invaginación intestinal en él?

- a) Divertículo de Meckel
- b) Adenitis mesentérica
- c) Hiperplasia nodular de intestino delgado
- d) Shigellosis
- e) Linfoma de intestino delgado

14) ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde a un soplo funcional?

- a) Sistólico
- b) Intensidad III/VI
- c) Tonalidad musical
- d) Presencia de frémito
- e) Eyectivo

15) Un niño de 10 años presenta una historia de 10 días de sensación de hormigueo y disestesias en las 4 extremidades, asociado a debilidad simétrica, progresiva. Al examen físico destaca arreflexia e hipotonía de las 4 extremidades. ¿Cuál es la complicación más temida de la patología descrita?

- a) Arritmias cardíacas malignas
- b) Insuficiencia respiratoria global
- c) Encefalitis necrotizante
- d) Síndrome de distrés respiratorio
- e) Tetraplejia definitiva

16) Usted atiende a un niño de 1 año que no viene a control de salud desde los 5 meses. ¿Qué vacunas le pondría y cuándo?

- a) Trivírica, DPT, Haemophilus influenza B, polio y hepatitis B, todas al mismo tiempo
- b) Trivírica solamente
- c) Trivírica, y luego de 1 mes: DPT, Haemophilus influenza B, polio y hepatitis B
- d) DPT, Haemophilus influenza B, polio y hepatitis B, y luego de un mes: trivírica
- e) BCG, trivírica, hepatitis B y polio, todas al mismo tiempo

17) Un lactante de 6 meses de edad, 7.200 grs. de peso y que recibió durante 3 meses lactancia materna, es enviado desde su Sala-Cuna al servicio de urgencia por un cuadro diarreico de 24 horas de evolución, con fiebre baja y presencia de 4 vómitos en las últimas 12 horas. Al examen físico usted lo encuentra con mucosas algo secas, consciente, irritable, sediento. La madre se ve preocupada, receptiva y cooperadora. ¿Cuál es la conducta que se debe iniciar?

- a) Hospitalizar al niño, para rehidratación intravenosa
- b) Indicar dieta hídrica con variados líquidos (aguas de hierba, Coca-Cola, etc) por 8 horas, seguida de realimentación a concentraciones graduales de leche (que dure 4 a 5 días) y control cada 2 a 3 días
- c) Administración de sales de rehidratación oral según esquema preciso, durante 4 a 6 horas, seguida de realimentación relativamente rápida y control periódico del paciente
- d) Administración de un antibiótico de amplio espectro y sales de rehidratación oral, con seguimiento frecuente del paciente
- e) Dieta hídrica con variados líquidos (aguas de hierba, Coca-Cola, etc) por 8 horas, seguida de realimentación a concentraciones graduales de leche (que dure 4 a 5 días) y control cada 2 a 3 días, además de administración de fármacos opioides que reduzcan la motilidad intestinal (loperamida, por ejemplo)

18) Un adolescente de 14 años con tos de 3 semanas de evolución y sensación febril. La radiografía de tórax muestra imágenes peribronquiales bibasales e hiperinsuflación pulmonar difusa.

El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía neumocócica
- b) Tuberculosis pulmonar
- c) Coqueluche
- d) Neumopatía por mycoplasma
- e) Bronquiolitis por virus respiratorio sincicial

19) Con respecto a la diabetes juvenil, mencione la respuesta correcta:

- a) Raras veces requiere insulina
- b) Casi nunca se acompaña de cambios degenerativos vasculares
- c) Frecuentemente se acompaña de cetoacidosis
- d) No muestra frecuencia familiar
- e) Se puede tratar con hipoglicemiantes orales

20) Se ha confirmado el diagnóstico de coqueluche en un lactante de 6 semanas que fue hospitalizado por presentar apneas y crisis severas de tos. Su hermano de 3 años ha recibido la vacuna triple según programa nacional. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más apropiada para el niño de 3 años?

- a) Dar profilaxis cefadroxilo
- b) Dar profilaxis con eritromicina
- c) Dar profilaxis amoxicilina.
- d) Observación sin tratamiento antibiótico, a menos que presente síntomas
- e) Administrar un refuerzo de la vacuna triple

Prueba 3

1) Un lactante de 10 meses cae de la cama, golpeándose la cabeza. No pierde la conciencia ni convulsiona. Al examen se observa irritable, con signos vitales normales, sin signos neurológicos focales. Se observa un pequeño hematoma en la zona parietal derecha del cuero cabelludo. La conducta más importante es:

- a) Enviar a domicilio para observación y reconsultar en caso de aparición de signos de alarma
- b) Hospitalizar en sala y administrar analgesia endovenosa, con AINES
- c) Solicitar radiografía de cráneo
- d) Solicitar TAC de cráneo y cerebro sin contraste
- e) Hospitalizar en UCI

2) Un niño de 3 años presenta anemia con Hb:10, Hcto:29%, VCM:78, HCM:30. Los blancos y plaquetas son normales. Se inicia tratamiento con sulfato ferroso, sin lograr respuesta luego de 1 mes, por lo que se solicita perfil de hierro que muestra ferremia disminuida, transferrina baja y ferritina aumentada. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia ferropénica
- b) Anemia por enfermedades crónicas
- c) Leucemia
- d) Anemia sideroblástica
- e) Anemia por déficit de vitamina B12

3) ¿Qué hallazgos espera usted encontrar en las pruebas hepáticas de un niño con hepatitis A?

- a) Elevación discreta de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- b) Elevación marcada de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- c) Elevación discreta de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio directo
- d) Elevación marcada de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio directo
- e) Elevación marcada de las transaminasas sin hiperbilirrubinemia

4) Un lactante de 7 meses ha presentado 4 episodios de dificultad respiratoria sibilante. El primero de ellos fue a los 4 meses, en relación a una infección por VRS. El último episodio fue hace 4 días y fue tratado con broncodilatadores inhalados y corticoides orales. Actualmente se encuentra asintomático. El tratamiento farmacológico de elección para el manejo de este paciente, de ahora en adelante, es:

- a) Beta-agonistas de acción corta por vía inhalatoria, en caso de síntomas
- b) Beta-agonistas de acción corta por vía inhalatoria según horario
- c) No es necesario iniciar tratamiento farmacológico alguno
- d) Corticoides inhalados según horario y beta-agonistas de acción corta según síntomas
- e) Corticoides orales y beta-agonistas de acción larga por vía inhalatoria, ambos según horario

5) Un niño de 5 años, con detención de su crecimiento presenta además deposiciones frecuentes, amarillentas y brillantes, desde hace algunas semanas. El primer examen que debe solicitarse para confirmar la sospecha diagnóstica es:

- a) Test de Sudan
- b) Anticuerpos anti-transglutaminasa
- c) Endoscopia digestiva alta
- d) Hemograma
- e) Parasitológico de deposiciones

6) ¿A qué edad se detecta con mayor frecuencia el déficit atencional del niño?

- a) En el lactante menor
- b) En el lactante mayor
- c) En el preescolar
- d) En el escolar
- e) En el adolescente

7) ¿A qué edad se debe administrar la vacuna trivírica?

- a) A los 12 meses y en primero básico
- b) A los 12 meses y en segundo básico
- c) A los 12 meses y a los 4 años
- d) A los 6 meses y a los 12 meses
- e) Sólo a los 12 meses

8) Al cumplir un año de edad, el lactante normalmente:

- a) Pesa 7 Kg y mide 50 cm
- b) Pesa 7 Kg y mide 75 cm
- c) Pesa 10 Kg y mide 75 cm
- d) Pesa 10 Kg y mide 100 cm
- e) Pesa 15 Kg y mide 100 cm

9) Un niño de 8 meses presenta fiebre alta, decaimiento marcado y convulsiona en una oportunidad. Al examen físico se observa hiporreactivo, febril hasta 39,6°C, destacando rigidez de nuca y fontanela anterior abombada. No presenta signos focales. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis bacteriana aguda
- b) Meningitis tuberculosa
- c) Encefalitis herpética
- d) Meningitis por enterovirus
- e) Convulsión febril benigna

10) El daño renal producido por el reflujo vesicoureteral, se produce fundamentalmente como consecuencia de:

- a) Hipertensión urinaria
- b) Asociación a otras malformaciones renales
- c) Nefrocalcinosis
- d) Pielonefritis
- e) Disfunción tubulointersticial

11) El agente etiológico más frecuente de la neumonía en el preescolar es:

- a) Mycoplasma pneumoniae
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Streptococcus pneumoniae
- d) Haemophilus influenzae
- e) Virus respiratorios

12) Un paciente de 3 años presenta presión arterial en percentil 98 para su edad. Al examen físico destaca un soplo sistólico eyectivo y una clara asimetría en los pulsos de las extremidades superiores, respecto a las inferiores, siendo más débil en estas últimas. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Estenosis aórtica
- b) Coartación aórtica
- c) Síndrome de Marfan
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Foramen oval permeable

13) Un niño de 6 años presenta insuficiencia renal crónica por riñones poliquísticos. La madre se encuentra cursando un nuevo embarazo, con un feto de sexo masculino. ¿Cuál es el riesgo de este nuevo hijo, de padecer la misma enfermedad?

- a) 25%
- b) 33%
- c) 50%
- d) 75%
- e) 100%

14) La fontanela posterior habitualmente se cierra:

- a) Antes de los 6 meses de edad
- b) Entre los 6 y los 9 meses de edad
- c) Entre los 9 y los 12 meses de edad
- d) Entre los 12 y los 24 meses de edad
- e) Entre los 24 y los 36 meses de edad

15) Un niño de 8 años presenta equimosis frecuentemente, ante pequeños golpes. En 2 oportunidades ha presentado hemartrosis de rodilla en relación a la actividad física. También ha presentado hematomas musculares en 3 oportunidades. ¿Cuál de los siguientes exámenes espera encontrar alterado, con mayor probabilidad en este paciente?

- a) Recuento de plaquetas
- b) Pruebas de agregación plaquetaria
- c) Tiempo de tromboplastina parcial activada
- d) Tiempo de sangría
- e) Fibrinogenemia

16) Un niño de 7 años consulta por odinofagia intensa, asociada a rinorrea, tos y disfonía. Al examen físico se observa faringe y amígdalas edematosas y eritematosas, sin exudado. Se palpan algunas pequeñas adenopatías cervicales bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático
- b) Solicitar cultivo faríngeo y decidir manejo según resultados
- c) Solicitar test pack para estreptococo betahemolítico grupo A
- d) Iniciar amoxicilina oral
- e) Iniciar ciprofloxacino oral

17) Un niño sufre picadura de abeja, evolucionando a los pocos minutos con un exantema pseudopapular generalizado, asociado a angioedema de párpados y labios. Luego se agrega tos y estridor inspiratorio. Al examen físico se encuentra taquipneico, taquicárdico, con uso de musculatura accesoria. Saturación 95% por pulsometría y su presión arterial es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar en UCI, conectado a ventilador automático y administrar adrenalina, corticoides y antihistamínicos endovenosos
- b) Hospitalizar aportar oxígeno y administrar adrenalina por vía intramuscular
- c) Instalar tubo orotraqueal para proteger la vía aérea, aportar oxígeno y administrar adrenalina e hidrocortisona por vía endovenosa
- d) Administrar suero fisiológico, corticoides y antihistamínicos endovenosos,
- e) Iniciar corticoides orales

18) Un niño de 3 meses presenta una circunferencia craneana en percentil 95 para su edad. La talla y peso están en percentil 80 para su edad. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y fontanelas a nivel. El examen neurológico es normal, al igual que el desarrollo psicomotor. El diagnóstico más probable es:

- a) Hidrocefalia
- b) Craneosinostosis
- c) Meningitis viral
- d) TORCH
- e) Macrocefalia constitucional

19) Un niño de 8 meses cursando diarrea acuosa de 3 días de evolución, asociada a fiebre durante los primeros 2 días, presenta compromiso del estado general y rechazo alimentario. Al examen físico se observa somnoliento, con mucosas secas y turgencia de la piel muy disminuida. El hemoglucotest resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con hidratación oral con sales de rehidratación, luego de cada deposición
- b) Enviar a domicilio con hidratación oral con leche materna o fórmula, luego de cada deposición
- c) Realizar hidratación oral con sales de rehidratación, en 4 a 6 horas, según plan B y reevaluar
- d) Administrar bolo de suero fisiológico endovenoso y reevaluar
- e) Hospitalizar en UCI, con monitorización invasiva e hidratación endovenosa

20) Un niño de 8 años consulta porque en 5 oportunidades ha presentado cuadros autolimitados de palpitaciones y disnea de algunos minutos de duración. El más prolongado duró cerca de 20 minutos. Trae un electrocardiograma, que realizó mientras estaba asintomático que demuestra un ritmo sinusal, con ensanchamiento del QRS, acortamiento del PR y presencia de onda delta. El diagnóstico más probable es:

- a) Flutter auricular
- b) Síndrome de QT largo
- c) Taquicardia paroxística supraventricular
- d) Miocardiopatía hipertrófica
- e) Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

Prueba 4

1) Recién nacido de 3 semanas de vida, que presenta bronconeumonía y conjuntivitis.

La radiografía de tórax muestra infiltrado intersticial.

La etiología más probable es:

- a) *Treponema pallidum*
- b) *Chlamydia trachomatis*
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) *Candida albicans*
- e) *Streptococcus pneumoniae*

2) ¿Qué medicamento se debe utilizar inicialmente en la reanimación de un recién nacido con asfixia severa?

- a) Naloxona
- b) Bicarbonato de sodio
- c) Adrenalina
- d) Dopamina
- e) Atropina

3) El trastorno metabólico que determina mayor riesgo de mortalidad en un niño con insuficiencia renal aguda es la:

- a) hiperkalemia.
- b) hipokalemia.
- c) hipernatremia.
- d) acidosis metabólica.
- e) hipocalcemia.

4) Una opción de alimentación para lactantes menores de 6 meses, cuando no son amamantados, es utilizar Leche Purita Fortificada diluida al 7,5 % con agregado de sacarosa al 5% y aceite al 1,5%.

La razón para diluir la leche al 7,5% es:

- a) Disminuir su densidad energética.
- b) Permitir agregar aceite con ácidos grasos esenciales.
- c) Disminuir la concentración de solutos.
- d) Mejorar la absorción intestinal de nutrientes
- e) Mejorar la estabilidad de la fórmula

5) Un recién nacido de pretérmino (34 semanas) que pesó 1750 g al nacer, a los 10 días presenta ictericia con bilirrubinemia total 10 mg/dl y una fracción directa de 0,8 mg/dl. Está recibiendo alimentación orogástrica intermitente de leche materna extraída y nutrición parenteral suplementaria.

El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Crigler-Najjar.
- b) Ictericia por nutrición parenteral.
- c) Hepatitis neonatal.
- d) Ictericia fisiológica.
- e) Atresia de vía biliar

6) Niña de 13 años presenta fiebre de baja intensidad, adenopatías occipitales, exantema maculopapular tenue en tronco y artralgias. No tiene inmunizaciones completas.

El diagnóstico más probable es:

- a) eritema infeccioso
- b) rubéola
- c) sarampión
- d) mononucleosis infecciosa
- e) escarlatina

7) Un escolar de 11 años consulta por talla baja. El padre mide 173 cm., la madre 156 cm., ambos son sanos. Al examen físico se constata una talla de 120 cm., peso de 19 kg, sin estigmas de genopatía.

¿Cuál es la información más útil para orientar el diagnóstico?

- a) Los antecedentes de crecimiento de la familia.
- b) Su curva de crecimiento.
- c) Sus niveles de T4 y TSH.
- d) Su edad ósea.
- e) Sus niveles de hormona de crecimiento.

8) ¿Cuál de los siguientes hallazgos indica una mayor gravedad de la infección meningocócica?

- a) Leucocitosis mayor a 15.000/mm³
- b) Presencia de leucocitosis en el líquido céfalo raquídeo.
- c) Púrpura de menos de 12 hrs. de evolución.
- d) Velocidad de sedimentación globular aumentada.
- e) Presencia de artralgias o artritis.

9) Lactante de 1 año, con fiebre de 40°C y convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Cuál es la conducta más apropiada durante la crisis, después de estabilizar al paciente (ABC)?

- a) Colocar enema frío
- b) Administrar antipiréticos
- c) Administrar anticonvulsivante
- d) Realizar punción lumbar
- e) Instalar vía venosa central

10) Escolar de 12 años, deportista, consulta por dolor en ambas rodillas desde hace dos semanas. Hay sensibilidad a la palpación de la tuberosidad anterior en ambas tibias.

El diagnóstico más probable es:

- a) enfermedad de Osgood-Schlatter.
- b) dolor de crecimiento.
- c) enfermedad de Legg-Calvé-Perthes.
- d) artritis reumatoidea juvenil.
- e) artritis reactiva.

11) ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en el mayor de seis años?

- a) Sabin
- b) DTP
- c) Trivírica
- d) BCG
- e) DT

12) La edad óptima para la corrección quirúrgica de la criptorquidia es:

- a) 1 año y 6 meses
- b) en la pubertad
- c) a los 5 años
- d) a los 3 años
- e) al nacimiento

13) La estimación precisa del área de superficie de una quemadura requiere conocer las proporciones de cada una de las diversas áreas del cuerpo con el área de superficie corporal total. La diferencia principal entre lactantes y adultos en cuanto al área de superficie consiste en que los lactantes tienen un área proporcionalmente:

- a) mayor para cabeza y cuello
- b) menor para los genitales
- c) mayor para regiones glúteas
- d) menor para manos y pies
- e) menor de tronco

14) Señale la opción CORRECTA en relación con la etiología MAS frecuente de SBOR en el lactante.

- a) Fibrosis quística
- b) Reflujo gastroesofágico
- c) Displasia pulmonar
- d) Hiperreactividad bronquial primaria.
- e) Cardiopatía congénita

15) Los factores de riesgo para la displasia de cadera incluyen todos los siguientes, EXCEPTO:

- a) Género femenino
- b) Primer(a) hijo(a)
- c) Presentación de nalgas
- d) Torticollis congénita
- e) Prematuridad

16) Andrea de 12 años con asma estable le trae un formulario médico del colegio para completar. La única medicación que recibe es salbutamol mediante un inhalador. Ud. describe los efectos colaterales conocidos de este fármaco, incluidas las consecuencias de una sobredosis. ¿Cuál de los siguientes es el efecto colateral que se asocia con MAYOR frecuencia a este fármaco?

- a) Hipercalemia
- b) Debilidad muscular
- c) Aftas orales
- d) Somnolencia
- e) Taquicardia

17) Un niño de dos años, presenta en el mes de Abril, un cuadro respiratorio consistente en fiebre hasta 38,5 °C, disfonía, tos disfónica, y un episodio de obstrucción de la vía aérea, con signos de tiraje, durante la segunda noche de enfermedad. ¿Cuál es la etiología MAS PROBABLE de este cuadro?

- a) Epiglotitis
- b) Absceso retrofaríngeo
- c) Laringotraqueítis bacteriana
- d) Laringotraqueítis por virus parainfluenza
- e) Croup espasmódico

18) Señale cuál de los siguientes conceptos en relación a criptorquidea es ERRONEO:

- a) En el caso de testículo no palpable, el examen de ultrasonido inguinal permite descartar la presencia de tejido testicular bajo el anillo inguinal interno, lo que corresponde al 50% de los testículos no palpables
- b) La laparoscopia ha pasado a ser el examen de elección para la ubicación de los testículos intraabdominales
- c) La localización testicular intraabdominal es la que se asocia con más alta incidencia a cáncer testicular
- d) En el caso de testículos no palpables bilaterales, es estudio requiere un examen cromosómico
- e) La criptorquidea aumenta en 3 a 4 veces la incidencia de cáncer testicular

19) ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA en relación al Síndrome de dificultad respiratoria (SDR) por aspiración de meconio?

- a) El SDR por aspiración de meconio se presenta en recién nacidos cerca del término de la gestación, especialmente en el RN posttérmino
- b) La hipoxemia induce a que el feto haga esfuerzos respiratorios profundos, produciéndose la aspiración de líquido amniótico con meconio hacia las vías aéreas superiores
- c) En el momento de nacer, como consecuencia de las primeras respiraciones, es cuando se produce el mayor riesgo de aspirar líquido amniótico meconial
- d) El SDR por aspiración de meconio es un cuadro respiratorio principalmente de tipo restrictivo
- e) El atrapamiento de aire es una de las causas de la alta incidencia de neumotórax que presenta el SDR por aspiración de meconio

20) Se consideran tareas del desarrollo del adolescente las siguientes opciones, EXCEPTO:

- a) Identificarse con los modelos de los padres
- b) Explorar el mundo fuera de la familia
- c) Revisar su identidad como persona
- d) Establecer relaciones heterosexuales
- e) Definir un conjunto de normas y valores

Prueba 5

1) El ductus arterioso persistente se manifiesta semiológicamente como:

- a) Chasquido de apertura, asociado a aumento del segundo ruido
- b) Click de apertura, asociado a disminución del segundo ruido
- c) Chasquido de apertura, asociado a soplo sistólico
- d) Soplo con componente sistólico y diastólico
- e) Soplo sistólico, asociado a desdoblamiento paradójico del segundo ruido

2) Se considera pubertad precoz el inicio del desarrollo puberal antes de:

- a) Los 6 años en los niños y los 7 años en las niñas
- b) Los 9 años en los niños y las niñas
- c) Los 9 años en los niños y los 8 años en las niñas
- d) Los 8 años en los niños y los 7 años en las niñas
- e) Los 8 años en los niños y los 9 años en las niñas

3) La hormona que más incide en el crecimiento fetal intrauterino es:

- a) GH
- b) Insulina
- c) Tiroxina
- d) Lactógeno placentario
- e) Somatomedina

4) La clínica más característica de la hemofilia es:

- a) Niños con equimosis, hemartrosis y hematomas profundos ante traumas pequeños
- b) Adolescentes con equimosis recurrentes y menstruaciones abundantes
- c) Niños con epistaxis, gingivorragia y petequias a repetición
- d) Niños con petequias, equimosis y tendencia a formar cicatrices hipertróficas, ante traumas menores
- e) Niños con equimosis, hematuria y hemorragias digestivas recurrentes

5) Un niño de 7 años presenta un cuadro de rinorrea y tos con escasa expectoración mucosa desde hace 7 días. En las últimas 48 horas aumenta la tos, la que se hace productiva y se agrega fiebre hasta 38,5°C y disnea de grandes esfuerzos. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, sin cianosis ni uso de musculatura accesoria y satura 97% con FiO₂ ambiental. Al examen pulmonar se auscultan crepitaciones y sibilancias escasas, mayores en las bases. Se solicita radiografía de tórax que muestra un patrón de relleno alveolo-intersticial, mayor en la base izquierda. El tratamiento antibiótico de elección es:

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina
- c) Ceftriaxona
- d) Vancomicina
- e) Amoxicilina más ácido clavulánico

6) El principal problema de la agenesia renal bilateral congénita es:

- a) Su asociación con cardiopatías congénitas
- b) La necesidad de hemodiálisis a permanencia
- c) Su asociación a defectos del tubo neural
- d) La necesidad de trasplante renal, dentro del primer mes de vida
- e) La incompatibilidad con la vida, dada por hipoplasia pulmonar

7) Un niño de 3 años presenta cuadro de odinofagia, fiebre alta y tos irritativa escasa. Presenta convulsión tónico clónica en una oportunidad, de 2 minutos de duración. Habría presentado otra convulsión febril hace 1 año. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica ni signos meníngeos. La faringe se observa eritematosa, sin exudado. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, iniciar antibióticos y realizar punción lumbar
- b) Enviar a domicilio, indicando paracetamol durante los cuadros febriles, sin necesidad de anticonvulsivantes
- c) Iniciar ácido valproico y solicitar resonancia magnética nuclear
- d) Enviar a domicilio, indicando antipiréticos y diazepam durante las alzas térmicas
- e) Solicitar electroencefalograma y decidir manejo según hallazgos

8) Durante el primer año de vida, habitualmente se suplementa la alimentación con todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Vitamina A
- b) Vitamina B1
- c) Vitamina C
- d) Vitamina D
- e) Hierro

9) Un paciente 4 años, con sus vacunas al día, estuvo en contacto con un paciente diagnosticado recientemente de tuberculosis bacilífera. Se solicita radiografía de tórax que resulta normal y PPD que resulta negativo

- a) Observar evolución, sin necesidad de nuevos exámenes ni tratamientos
- b) Iniciar quimioprofilaxis primaria con isoniazida
- c) Indicar nueva vacunación con BCG y observar evolución
- d) Solicitar baciloscopías de expectoración mensuales, por 6 meses y decidir conducta según resultados
- e) Solicitar nuevas radiografías de tórax y PPD mesualmente, por 6 meses y decidir conducta según resultados

10) Un lactante de 4 meses, con mal incremento ponderal ha presentado varios cuadros de neumonía y diarreas, de difícil tratamiento. Actualmente cursando síndrome diarreico. Al examen físico destaca presencia de alborza y candidiasis anogenital. Un hermano falleció tempranamente por neumonía. El diagnóstico más probable es:

- a) Agamaglobulinemia ligada al sexo
- b) Déficit de complemento
- c) Inmunodeficiencia común variable
- d) Inmunodeficiencia combinada severa
- e) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

11) Un niño de 8 años presenta artralgias y artritis de manos y pies, asociada a compromiso del estado general. El examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes de laboratorio destaca elevación importante de la ferritina plasmática y elevación moderada de la PCR y VHS. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis por cristales
- b) Hemocromatosis
- c) Artritis viral
- d) Artritis reactiva
- e) Artritis juvenil idiopática

12) Un niño de 7 años se cae en el colegio, golpeándose la cabeza. No recuerda como se cayó, pero posteriormente recuerda bien. No perdió la conciencia en ningún momento. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, en Glasgow 15, sin focalidad neurológica ni otros hallazgos patológicos. La conducta más adecuada es:

- a) Remitir a su domicilio con observación cuidadosa y con indicación de control en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar radiografía de cráneo y decidir manejo según hallazgos
- c) Solicitar TAC de cerebro sin contraste, inmediatamente y decidir manejo según hallazgos
- d) Administrar analgésicos y anticonvulsivantes y solicitar TAC de cerebro con contraste
- e) Derivar para manejo ambulatorio por un neurólogo

13) Usted atiende a un niño de 1 año que no viene a control de salud desde los 5 meses. ¿Qué vacunas le pondría y cuándo?

- a) Trivírica, DPT, Haemophilus influenza B, polio y hepatitis B, todas al mismo tiempo
- b) Trivírica solamente
- c) Trivírica, y luego de 1 mes: DPT, Haemophilus influenza B, polio y hepatitis B
- d) DPT, Haemophilus influenza B, polio y hepatitis B, y luego de un mes: trivírica
- e) BCG, trivírica, hepatitis B y polio, todas al mismo tiempo

14) Un niño de 6 años consulta por cuadro de malestar, fiebre hasta 38,7°C y eritema facial, al que luego se agrega un exantema macular eritematoso, que compromete tronco y extremidades, con confluencia de las lesiones, en disposición reticular. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema toxico
- b) Quinta enfermedad
- c) Rubeola
- d) Exantema súbito
- e) Síndrome pie mano boca

15) Un adolescente de 14 años consulta por malestar abdominal, febrícula ocasional y diarrea de 5 semanas de evolución, que en el último tiempo se ha hecho sanguinolenta. Al examen físico se palpa un abdomen blando, depresible, sensible difuso, sin masas ni visceromegalia, con ruidos hidroaéreos aumentados. No se aprecian otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Hiperplasia nodular linfática
- b) Polipomatosis adenomatosa intestinal
- c) Divertículo de Meckel
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Amebiasis

16) ¿Qué hallazgos espera usted encontrar en las pruebas hepáticas de un niño con hepatitis A?

- a) Elevación discreta de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- b) Elevación marcada de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- c) Elevación discreta de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio directo
- d) Elevación marcada de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio directo
- e) Elevación marcada de las transaminasas sin hiperbilirrubinemia

17) ¿A qué edad se detecta con mayor frecuencia el déficit atencional del niño?

- a) En el lactante menor
- b) En el lactante mayor
- c) En el preescolar
- d) En el escolar
- e) En el adolescente

18) Un recién nacido de término, de 3 días de vida, presenta ictericia desde hace 24 horas, que actualmente llega a los muslos. Al nacer pesó 3.420 gramos, se alimenta adecuadamente y actualmente pesa 3.230 gramos. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- c) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo Rh
- d) Ictericia por leche materna
- e) Sepsis neonatal

19) Un niño de 5 años es traído por su madre por cuadro de fiebre y compromiso del estado general de algunas semanas de evolución. El hemograma muestra hematocrito: 27%, hemoglobina: 9,1 mg/dl, plaquetas: 48.000 por mm³, glóbulos blancos: 2.900 por mm³, con 84% de linfocitos, 9% de neutrófilos segmentados, 2% de monocitos, 0% de eosinófilos, 0% de basófilos y 5% de blastos. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfoma
- b) Leucemia linfática aguda
- c) Leucemia linfática crónica
- d) Púrpura trombocitopénico trombótico
- e) Sepsis por bacterias Gram negativas

20) Las cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, que son corregidas tardíamente, desarrollan característicamente:

- a) Endocarditis bacteriana
- b) Embolías cardíacas
- c) Hipertensión pulmonar persistente
- d) Hipertensión arterial
- e) Fibrilación auricular

Prueba 6

1) Un niño de 6 meses de edad presenta fiebre y llanto fácil, asociado a reticencia a alimentarse. Al examen físico tiene temperatura 39,3°C y sopor, despertando con los estímulos más intensos. El examen físico segmentario no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos, solicitar urocultivo y controlar con resultado
- b) Indicar amoxicilina y paracetamol por vía oral
- c) Solicitar hemograma, hemocultivos, PCR, sedimento de orina y urocultivo y controlar con los resultados
- d) Solicitar exámenes generales, hemograma, hemocultivos, exámenes de orina, realizar punción lumbar, solicitar estudio de líquido cefalorraquídeo e iniciar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
- e) Enviar a domicilio con antipiréticos y controlar en 24 horas

2) Un niño de 3 años con mal incremento ponderal y diarreas frecuentes, con heces esteatorreicas, ha presentado varias neumonías desde su nacimiento. La última de ellas fue causada por Staphylococcus aureus y respondió bien al tratamiento con cloxacilina. Se solicita una radiografía de tórax de control, que muestra algunas imágenes sugerentes de bronquiectasias. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit de IgA
- b) Neurofibromatosis
- c) Inmunodeficiencia combinada severa
- d) Enfermedad celíaca
- e) Fibrosis quística

3) ¿Qué alimento puede comer un niño de 8 meses?

- a) Sandía
- b) Miel
- c) Mayonesa
- d) Atún
- e) Maní

4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) La glomerulonefritis aguda postestreptocócica presenta disminución transitoria del complemento
- b) La nefrosis lipoídea se presenta como un síndrome nefrótico puro
- c) El síndrome hemolítico urémico se caracteriza por ser una insuficiencia renal aguda, con anemia y trombocitopenia
- d) La enfermedad de Berger es la glomerulonefritis más frecuente
- e) La glomerulopatía por cambios mínimos no responde a corticoides

5) Un paciente de 6 años presenta fiebre y aparición de un exantema pruriginoso, generalizado, que inició en la cabeza, con algunas vesículas y que luego se extendió al tronco y finalmente a las extremidades. Al examen físico se observan vesículas y pústulas generalizadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de pie mano boca
- b) Varicela
- c) Prúrigo
- d) Síndrome de piel escaldada
- e) Escarlatina

6) Una niña de 8 años presenta IPT en p50, ITE en p5 e IPE: en p5. La curva de crecimiento muestra una velocidad de crecimiento normal. Se realiza radiografía de carpo que es compatible con una edad ósea de 6 años. El diagnóstico más probable es:

- a) Desnutrición
- b) Retraso puberal
- c) Síndrome de Turner
- d) Retraso constitucional del crecimiento
- e) Talla baja familiar

7) Un paciente de 3 años presenta cojera y dolor al caminar desde hace 24 horas, asociado a fiebre hasta 38,1°C. La madre refiere que habría cursado una infección respiratoria alta hace 7 días. Al examen físico, los signos vitales son normales y sólo se aprecia cierto dolor a los movimientos de la cadera derecha. Se decide realizar ecografía de cadera, que muestra escaso derrame articular, por lo que se decide realizar punción y estudio de líquido sinovial, que es informado como transparente, filante y con menos de 500 células. La tinción de Gram no identifica bacterias y los cultivos están pendientes. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Enfermedad de Perthes
- c) Sinovitis transitoria
- d) Artritis viral
- e) Enfermedad de Still

8) Un lactante de 7 meses cae de los brazos de su hermana, golpeándose la cabeza contra un mueble. Al examen físico está en buenas condiciones, con un pequeño hematoma en el cuero cabelludo de la región occipital, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar en su domicilio con indicaciones de control en caso de aparición de signos de alarma
- b) Hospitalizar y solicitar radiografías de todo el cuerpo, por sospecha de maltrato infantil
- c) Iniciar paracetamol e indicar control ambulatorio en neurología
- d) Solicitar radiografía de calota
- e) Solicitar TAC de cerebro y cráneo

9) ¿Cómo se transmite habitualmente el virus de la hepatitis A?

- a) Por gotitas respiratorias
- b) Por contacto directo
- c) Por vía fecal oral
- d) Por vía sexual
- e) Por vía vertical

10) ¿Entre qué edades se presenta el reflejo de prensión plantar?

- a) Desde el nacimiento hasta los 3 meses de vida
- b) Desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida
- c) Desde el nacimiento hasta los 10 meses de vida
- d) Desde los 3 meses hasta el año de vida
- e) Desde los 6 meses hasta el año de vida

11) ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más compatible con el diagnóstico de púrpura trombocitopénico inmune agudo?

- a) Poliadenopatías
- b) Esplenomegalia
- c) Hemartrosis
- d) Leucocitosis
- e) Hematoquezia

12) Un niño de 5 años presenta un soplo sistólico eyectivo, asociado a disminución de la intensidad de los pulsos pedios y tibiales posteriores. El resto del examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Ductus arterioso persistente
- b) Coartación aórtica
- c) Comunicación interauricular
- d) Comunicación interventricular
- e) Ventrículo único

13) Un niño de 4 años es traído por un cuadro de 5 días de fiebre alta, decaimiento, eritema de labios y artralgias de extremidades superiores. Al examen físico se aprecia inyección conjuntival bilateral, labios rojos y partidos, se palpan algunas adenopatías cervicales anteriores y se aprecia enrojecimiento y edema de las extremidades inferiores. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ferritina plasmática e iniciar AINEs orales
- b) Hospitalizar y administrar aspirina oral e inmunoglobulina endovenosa
- c) Solicitar serología para sarampión
- d) Iniciar amoxicilina oral
- e) Iniciar penicilina + clindamicina por vía endovenosa

14) Identifique la asociación INCORRECTA entre el agente y el tipo de vacuna:

- a) Varicela – Virus vivo atenuado
- b) Hepatitis A – Virus vivo atenuado
- c) Hepatitis B – Antígeno de superficie recombinante
- d) Bordetella Pertusis – Bacterias inactivadas
- e) Rubeola – Virus vivo atenuado

15) Un niño de 5 años, obeso, presenta poliuria y baja de peso. Se solicita glicemia de ayuno que resulta 250 mg/dl. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar dieta y ejercicios y controlar en 3 meses
- b) Iniciar dieta, ejercicios, solicitar hemoglobina glicosilada y controlar con resultado
- c) Iniciar metformina y controlar en 3 meses
- d) Iniciar insulina lenta en 2 dosis, una matinal y otra nocturna
- e) Hospitalizar para inicio de insulino terapia en esquema intensificado

16) Un paciente de 8 años consulta por hemorragia digestiva baja de escasa cuantía. Ha presentado cuadros similares en 2 ocasiones previas, a los 3 años y a los 6 años. Usted sospecha un divertículo de Meckel. ¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio?

- a) Endoscopia digestiva alta
- b) Ecografía abdominal
- c) Cintigrafía con tecnecio
- d) TAC de abdomen y pelvis
- e) Colonoscopia

17) Un niño de 4 años, asintomático, es traído por su madre ya que fue diagnosticado de pie plano en su consultorio. Ella decide consultar una segunda opinión, por lo que acude a su consulta particular. Al examen se aprecia ausencia del arco plantar durante el apoyo de ambos pies, pero éste se forma al levantarlos. No se identifican otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar plantillas
- b) Solicitar radiografías de pies
- c) Derivar a traumatología para resolución quirúrgica
- d) Derivar a traumatología para corrección con órtesis
- e) Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio

18) Una paciente de 4 años presenta orinas turbias y de mal olor, asociado a disuria. No presenta fiebre y la puño percusión es negativa. Se solicita urocultivo de orina de segundo chorro, que resulta positivo para E. coli sensible, con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿Qué afirmación es verdadera respecto a esta paciente?

- a) Está confirmado el diagnóstico de infección urinaria aguda
- b) Una buena alternativa terapéutica es la nitrofurantoína
- c) No es necesario controlar con nuevos urocultivos
- d) No está indicado la realización de una ecografía
- e) La uretrocistografía miccional seriada no será de utilidad

19) Ante la sospecha de enfermedad celíaca se debe solicitar:

- a) Anticuerpos antiendomisio y endoscopia digestiva alta
- b) Colonoscopia y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
- c) Test de D-xilosa
- d) Gluten fecal
- e) Anticuerpos antinucleares y radiografías baritadas

20) Un niño de 5 años es muy desobediente y suele hacer pataletas y berrinches cuando no se le da en el gusto. Los padres están muy preocupados, ya que no saben cómo controlarlo. Cuando se le contradice escupe, pateo y rompe sus juguetes y algunos adornos de la casa. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de conducta disocial
- b) Síndrome de ansiedad por separación
- c) Trastorno oposicionista desafiante
- d) Trastorno global del desarrollo
- e) Depresión infantil

Prueba 7

1) Un niño de 6 años no habla y demoró más de lo normal en empezar a caminar. La madre refiere que no contesta al hablarle ni tampoco responde al indicarle cosas. Juega con sus juguetes, sin interactuar con otros niños. Al examen físico no presenta signos neurológicos focales. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de déficit atencional
- b) Síndrome de Asperger
- c) Autismo
- d) Trastorno del lenguaje
- e) Hipoacusia

2) Un niño de 6 años presenta edema facial y de extremidades inferiores, asociado a orinas espumosas. Se ve de buen aspecto y sus signos vitales son normales. Se solicita hemograma que resulta normal, sedimento de orina con cilindros hialinos y gotas de grasa, sin hematuria; índice proteinuria/creatininuria de 3,1 y albuminuria de 2,7 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis postinfecciosa
- b) Enfermedad de Berger
- c) Síndrome hemolítico urémico
- d) Glomerulopatía membranosa
- e) Glomerulopatía por cambios mínimos

3) Un niño de 30 días de edad es llevado a control de niño sano. En el examen físico no es posible palpar el testículo derecho. No tiene registros de exámenes testiculares previos y el resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar testosterona y gonadotropinas plasmáticas
- b) Solicitar cariograma
- c) Solicitar ecografía inguinal y testicular
- d) Solicitar tomografía axial computada de abdomen, pelvis y zona inguinal
- e) Realizar exploración quirúrgica

4) La obesidad infantil es una patología cuya frecuencia va en aumento, debido principalmente a un mal desarrollo de hábitos alimenticios y de actividad física. ¿Cuál de los siguientes niños presenta obesidad?

- a) Niño de 5 meses, alimentado con lactancia materna exclusiva, con índice peso/edad +2,5 DS, índice peso/talla +2,4DS e índice talla/edad +0,1DS
- b) Niño de 6 años con índice peso/edad +1,0 DS, índice peso/talla +2,1DS e índice talla/edad -1,1DS
- c) Niña de 7 años con IMC 23
- d) Niño de 1 año con índice peso/edad +1,5 DS, índice peso/talla 1,5 DS e índice talla/edad +1,0 DS
- e) Niña de 4 años con índice peso/edad +2,6 DS, índice peso/talla 0,8DS e índice talla/edad +2,3DS

5) Un niño de 6 meses de edad cae de la cama, golpeándose la cabeza. La madre acude muy preocupada y refiere que inicialmente el lactante lloró por varios minutos, pero luego se tranquilizó. Al examen físico se observa en buenas condiciones, con tono muscular normal, reflejos conservados y ausencia de signos focales. Sólo se observa un pequeño hematoma en la zona occipital. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, explicando los signos de alarma para reconsultar
- b) Solicitar radiografía de cráneo
- c) Solicitar TAC de cerebro
- d) Iniciar AINEs y derivar para atención ambulatoria con neurólogo
- e) Iniciar paracetamol y fenobarbital, controlando en 24 horas

6) Un niño de 13 meses ha presentado 4 otitis medias agudas y 3 neumonías, desde los 9 meses de edad. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Fibrosis quística
- b) Déficit de inmunoglobulinas
- c) Déficit de complemento
- d) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- e) Inmunodeficiencia celular

7) Un urocultivo por sondeo será diagnóstico de infección urinaria, si presenta unidades formadoras de colonias, en una cantidad mayor de:

- a) 1
- b) 100
- c) 1.000
- d) 10.000
- e) 100.000

8) ¿Cuál de las siguientes lesiones es más característica de maltrato infantil?

- a) Fractura de antebrazo
- b) Hematoma de la zona frontal
- c) Fractura supracondílea de húmero
- d) Fractura de metatarsiano
- e) Fractura de escápula

9) El tratamiento de elección de la laringitis aguda obstructiva es:

- a) Salbutamol inhalado
- b) Adrenalina racémica inhalada
- c) Salbutamol y corticoides inhalados
- d) Adrenalina racémica y corticoides inhalados
- e) Adrenalina racémica inhalada y corticoides orales

10) La coartación aórtica NO presenta:

- a) Soplo sistólico
- b) Mayor riesgo de endocarditis
- c) Hipertensión arterial
- d) Cianosis
- e) Disminución de los pulsos pedios

11) Un niño de 6 años presenta una convulsión tónico-clónica mientras estaba en su colegio, autolimitada, de 5 minutos de duración. Al examen físico no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticonvulsivantes
- b) Solicitar electroencefalograma con privación de sueño
- c) Solicitar TAC de cerebro
- d) Solicitar creatininfosfoquinasas
- e) Realizar punción lumbar y solicitar estudio de líquido cefalorraquídeo

12) La lactancia materna tiene todos los siguientes beneficios, EXCEPTO:

- a) Osmolaridad óptima, para una adecuada absorción
- b) Trasmisión de protección materna, mediante inmunoglobulina A
- c) Ácidos grasos esenciales adecuados a los requerimientos del lactante
- d) Aportes óptimos de hierro, para los requerimientos del niño
- e) Fortalecimiento del lazo madre-hijo

13) Un niño de 3 años presenta cojera de 2 días de evolución. Al examen se observa en buenas condiciones, con sólo leve dolor a los movimientos extremosa de la cadera izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- b) Sinovitis transitoria
- c) Artritis séptica
- d) Enfermedad de Perthes
- e) Síndrome de Osgood Schlatter

14) En los lactantes menores, la mayoría de las neumonías son causadas por:

- a) Virus
- b) Neumococo
- c) Mycoplasma
- d) Estreptococo beta-hemolítico grupo B
- e) Estreptococo beta-hemolítico grupo A

15) Un niño de 6 meses de edad presenta una pielonefritis aguda, la que es tratada de manera exitosa con ceftriaxona endovenosa. Luego es estudiado con ecografía abdominal que resulta normal y con uretrocistografía miccional seriada, que demuestra leve grado de reflujo vesicoureteral. Se decide indicar profilaxis antibiótica, en espera de la resolución espontánea de su patología. ¿Qué antibióticos son más adecuados para dicha profilaxis?

- a) Ciprofloxacino o nitrofurantoína
- b) Nitrofurantoína o cefadroxilo
- c) Cefadroxilo o cotrimoxazol
- d) Cotrimoxazol o ciprofloxacino
- e) Ciprofloxacino o cefadroxilo

16) La gravedad de la enfermedad de Kawasaki se evalúa MÁS adecuadamente con:

- a) La clínica
- b) Ecocardiograma
- c) Angiografía coronaria
- d) Hemograma
- e) Biopsia

17) El tratamiento antibiótico de elección para la meningitis bacteriana aguda, a germen desconocido, en un niño de 6 años, es:

- a) Penicilina + metronidazol
- b) Ceftriaxona + metronidazol + dexametasona
- c) Vancomicina + cefotaximo + dexametasona
- d) Ceftriaxona
- e) Penicilina + rifampicina + dexametasona

18) Un niño de 2 años presenta desde ayer en la noche mucha tos, con expectoración, sin fiebre ni rinorrea. Al examen físico se auscultan algunos crépitos y sibilancias en la base pulmonar derecha, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Bronquiolitis
- b) Neumonía
- c) Laringitis obstructiva
- d) Cuerpo extraño bronquial
- e) Síndrome bronquial obstructivo

19) Un niño de 4 años es diagnosticado de tos convulsiva con IFD para Bordetella pertusis, iniciándose tratamiento con eritromicina. Tiene un hermano de 8 años, que está asintomático y tiene todas sus vacunas al día. La conducta más adecuada para con el hermano es:

- a) Indicar control en caso de síntomas
- b) Solicitar IFD para Bordetella pertusis
- c) Solicitar hemograma y radiografía de tórax
- d) Indicar una dosis de vacuna DPT acelular
- e) Iniciar eritromicina

20) Un niño de 5 años, sin antecedentes de importancia, presenta púrpura petequial y algunas equimosis en las extremidades inferiores, de 48 horas de evolución, sin otros síntomas. La madre refiere que habría estado resfriado hace 10 días. Al examen físico está en buenas condiciones, constatándose sólo las alteraciones ya descritas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar hemograma, con recuento de plaquetas
- b) Solicitar TP, TTPA y tiempo de sangría
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Derivar para esplenectomía
- e) Solicitar biopsia de médula ósea

Prueba 8

1) Un niño de 7 años presenta un cuadro de astenia, fiebre intermitente y sudoración de 3 semanas de duración, que ha tratado con paracetamol. Presenta además dolor en el hombro derecho y el tobillo izquierdo que limita los movimientos de dichas articulaciones. Al examen físico destaca palidez y algunas petequias en abdomen y extremidades inferiores. La auscultación cardiopulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Púrpura trombocitopénico agudo
- b) Artritis séptica
- c) Endocarditis infecciosa subaguda
- d) Leucemia aguda
- e) Mononucleosis infecciosa

2) Un lactante de 6 meses es traído por un cuadro de 2 días de evolución de fiebre hasta 38,1°C, asociado a tos, a lo que hace algunas horas se le agregó dificultad respiratoria. Al examen físico se observa con taquipnea leve, asociada a aleteo nasal, sin uso de musculatura accesoria ni cianosis. La auscultación pulmonar demuestra escasas sibilancias difusas y la saturación de oxígeno por pulsometría es 97%. Se encuentra afebril. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar salbutamol inhalado y si responde bien, enviar a domicilio con inhalaciones de salbutamol e indicaciones de control en caso de aparición de signos de alarma
- b) Administrar oxígeno y broncodilatadores nebulizados y si responde bien, enviar a domicilio con salbutamol en aerosol y prednisona oral por 5 días, con indicaciones de reconsultar en caso de empeoramiento
- c) Administrar adrenalina racémica por nebulización y dexametasona oral y si responde bien enviar a domicilio con indicaciones de control en caso de aparición de signos de alarma
- d) Administrar broncodilatadores nebulizados y una dosis de corticoides orales, y si responde bien, enviar a domicilio con salbutamol en inhalador, asociado a amoxicilina oral
- e) Hospitalizar, administrar oxígeno, broncodilatadores inhalados, corticoides endovenosos y solicitar radiografía de tórax

3) En segundo básico se administra la vacuna DT, en lugar de la vacuna DPT. Esto se debe fundamentalmente a:

- a) La baja incidencia de tos convulsiva en niños mayores
- b) La alta inmunidad alcanzada con las dosis anteriores de la vacuna DPT, contra la tos convulsiva
- c) La alta tasa de efectos adversos de la vacuna DPT en niños mayores
- d) La poca efectividad de la vacuna DPT en niños mayores
- e) La administración conjunta de la vacuna trivérica, que hace innecesaria la vacuna DPT

4) Una niña de 7 años, extranjera, consulta por un cuadro de 4 días de evolución, que comenzó con malestar general, artralgias, ligera odinofagia y fiebre hasta 38,2°C, a lo que se agregó un exantema eritematoso generalizado, macular, de color rosado. En el examen físico destacan además varias adenopatías cervicales posteriores. El diagnóstico más probable es:

- a) Sarampión
- b) Rubeola
- c) Eritema infeccioso
- d) Exantema súbito
- e) Escarlatina

5) Un niño de 3 meses presenta un soplo sistólico eyectivo III/VI, asociado a un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Usted debe sospechar:

- a) Comunicación interventricular
- b) Comunicación interauricular
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Coartación aórtica
- e) Transposición de grandes vasos

6) ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas se acompaña de cianosis?

- a) Drenaje anómalo de las venas pulmonares
- b) Comunicación interventricular
- c) Ventriculo único
- d) Ductus arterioso persistente
- e) Coartación aórtica

7) ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor el cuadro clínico de la glomerulonefritis postestreptocócica?

- a) Hematuria dismórfica, proteinuria leve, edema e hipertensión arterial, asociadas a elevación transitoria del complemento, que inicia 7 a 14 días después de una amigdalitis pultácea
- b) Hematuria aislada, con complemento normal, durante una infección estreptocócica
- c) Proteinuria, lipiduria, orinas espumosas y edema, sin hipertensión y con complemento normal, que inicia 10 días después de una amigdalitis pultácea
- d) Hematuria, edema e hipertensión arterial, asociada a hipocomplementemia, que inicia 10 días después de una infección estreptocócica
- e) Proteinuria, edema e hipertensión arterial, asociada a hipocomplementemia, durante una infección estreptocócica

8) Un lactante de 6 meses presenta fiebre hasta 38,7°C, sin otros síntomas y con examen físico normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos, solicitar hemograma y sedimento de orina y decidir conducta según resultados
- b) Iniciar cefadroxilo oral y antipiréticos, sin necesidad de exámenes
- c) Iniciar antipiréticos y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento, sin necesidad de mayor estudio
- d) Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos y solicitar hemograma, VHS, sedimento de orina, urocultivo, radiografía de tórax y punción lumbar, decidiendo manejo según resultados
- e) Iniciar antipiréticos y claritromicina, controlando en 48 horas o en caso de empeoramiento

9) Un niño de 3 meses presenta una circunferencia craneana en percentil 95 para su edad. La talla y peso están en percentil 80 para su edad. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y fontanelas a nivel. El examen neurológico es normal, al igual que el desarrollo psicomotor. El diagnóstico más probable es:

- a) Hidrocefalia
- b) Craneosinostosis
- c) Meningitis viral
- d) TORCH
- e) Macrocefalia constitucional

10) La adrenarquia se caracteriza por:

- a) Aparición de vello púbico
- b) Aumento de la velocidad de crecimiento
- c) Inicio de la fertilidad
- d) Olor axilar adulto
- e) Pigmentación cutánea

11) ¿Qué hallazgos espera usted encontrar en las pruebas hepáticas de un niño con hepatitis A?

- a) Elevación discreta de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- b) Elevación marcada de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
- c) Elevación discreta de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio directo
- d) Elevación marcada de las transaminasas e hiperbilirrubinemia de predominio directo
- e) Elevación marcada de las transaminasas sin hiperbilirrubinemia

12) Un lactante de 6 meses de edad, 7.200 grs. de peso y que recibió durante 3 meses lactancia materna, es enviado desde su Sala-Cuna al servicio de urgencia por un cuadro diarreico de 24 horas de evolución, con fiebre baja y presencia de 4 vómitos en las últimas 12 horas. Al examen físico usted lo encuentra con mucosas algo secas, consciente, irritable, sediento. La madre se ve preocupada, receptiva y cooperadora. ¿Cuál es la conducta que se debe iniciar?

- a) Hospitalizar al niño, para rehidratación intravenosa
- b) Indicar dieta hídrica con variados líquidos (aguas de hierba, Coca-Cola, etc) por 8 horas, seguida de realimentación a concentraciones graduales de leche (que dure 4 a 5 días) y control cada 2 a 3 días
- c) Administración de sales de rehidratación oral según esquema preciso, durante 4 a 6 horas, seguida de realimentación relativamente rápida y control periódico del paciente
- d) Administración de un antibiótico de amplio espectro y sales de rehidratación oral, con seguimiento frecuente del paciente
- e) Dieta hídrica con variados líquidos (aguas de hierba, Coca-Cola, etc) por 8 horas, seguida de realimentación a concentraciones graduales de leche (que dure 4 a 5 días) y control cada 2 a 3 días, además de administración de fármacos opioides que reduzcan la motilidad intestinal (loperamida, por ejemplo)

13) En los niños, la complicación más frecuente de la varicela es:

- a) Cerebelitis postvaricela
- b) Neumonía varicelatos
- c) Hepatitis viral
- d) Sobreinfección de las lesiones por bacterias Gram positivas
- e) Síndrome de Reye

14) Un recién nacido prematuro, de 3 días de evolución presenta irritabilidad, vómitos, distensión abdominal y hematoquezia en una oportunidad. Al examen físico se observa irritable, en buenas condiciones con el abdomen distendido, blando. Se solicita radiografía de abdomen simple que demuestra neumatos intestinal, sin aire en la cavidad peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar colonoscopia
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis e iniciar antibióticos endovenosos
- c) Hidratar por vía oral, iniciar antibióticos orales, suspender la lactancia materna y alimentar con fórmula
- d) Administrar hidratación por vía endovenosa, instalar sonda nasogástrica, suspender la alimentación oral e iniciar antibióticos de amplio espectro
- e) Resolver quirúrgicamente a la brevedad

15) Los 3 hitos del desarrollo psicomotor, que el lactante logra normalmente al cumplir el año de edad, son:

- a) Gatea, usa las primeras palabras y pasa objetos de una mano a otra
- b) Camina sin apoyo, pasa objetos de una mano a otra y dice sus primeras palabras
- c) Caminar sin apoyo, uso de la pinza madura entre pulgar e índice, y uso de las primeras palabras
- d) Uso de las primeras palabras, continencia urinaria diurna y caminar con apoyo
- e) Caminar sin apoyo, formación de las primeras frases y continencia urinaria diurna

16) Un niño de 10 años, diabético tipo 1, en tratamiento con insulina en esquema intensivo, presenta cuadro de sudoración, temblor y actitud agresiva, seguida luego de inconciencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Accidente vascular encefálico
- b) Cetoacidosis diabética
- c) Coma hiperglicémico hiperosmolar
- d) Hipoglicemia
- e) Encefalitis herpética

17) Un recién nacido de 20 días de vida presenta hematemesis en una oportunidad, sin otros síntomas. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, bien perfundido, con pulso y presión arterial normales para la edad. El examen segmentario es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Iniciar reposición de volumen con cristaloides por vía venosa periférica gruesa
- c) Solicitar test de Apt-Downey de la sangre emitida
- d) Solicitar hemograma
- e) Administrar omeprazol endovenoso

18) Niño de 2 años consulta por cuadro de 2 días de evolución de otalgia y otorrea escasa a derecha. A la otoscopia se observa el tímpano derecho eritematoso y abombado, con salida de pus escasa. El tratamiento antibiótico de elección es:

- a) Amoxicilina
- b) Cefadroxilo
- c) Amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Azitromicina
- e) Ciprofloxacino

19) ¿Cuál de los siguientes microorganismos producirá infecciones con mayor frecuencia en un niño con inmunodeficiencia por alteración de la producción de inmunoglobulinas?

- a) Candida albicans
- b) Pseudomona aureginosa
- c) Citomegalovirus
- d) Escherichia coli
- e) Streptococcus pneumoniae

20) La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es:

- a) Hipopituitarismo
- b) Alteraciones de la conversión periférica de T4 en T3
- c) Disgenesia tiroidea
- d) Déficit de yodo
- e) Tiroiditis crónica

Prueba 9

1) Un niño de 6 años presenta un cuadro caracterizado por edema de extremidades inferiores y cara, asociado a hematuria. La madre refiere que presentó una amigdalitis hace 10 días. Al examen físico está hipertenso, con el edema descrito. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 1,2 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 100 mg/m², sedimento de orina con visualización de abundantes eritrocitos con 10% de dismorfia y complemento disminuido. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia renal
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Hospitalizar e iniciar hemodiálisis
- d) Indicar alfametildopa y furosemida según evolución y controlar
- e) Iniciar corticoides endovenosos y ciclofosfamida

2) Un niño de 4 años se traga una moneda. Al examen físico no presenta alteraciones y las radiografías demuestran que la moneda está en el antro gástrico. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución e indicar reconsulta sólo en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar control radiológico cada 12 horas
- c) Solicitar TAC de abdomen
- d) Solicitar endoscopia digestiva
- e) Resolver quirúrgicamente

3) Un niño de 2 años de edad presenta diarrea de 1 mes de evolución, con deposiciones explosivas, acuosas, sin sangre, que tiende a mejorar por algunos días y luego recurre. El examen físico es normal y mantiene su ritmo de crecimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Giardiasis
- c) Diarrea crónica inespecífica
- d) Divertículo de Meckel
- e) Enfermedad inflamatoria intestinal

4) Un niño de 3 años presenta cuadro de fiebre, cefalea, irritabilidad y luego compromiso de consciencia. Al examen físico se destaca rigidez de nuca. Se solicita TAC de cerebro que muestra signos de hipertensión endocraneana. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar punción lumbar
- b) Iniciar ceftriaxona + ampicilina + corticoides
- c) Iniciar ceftriaxona + vancomicina + corticoides
- d) Iniciar drogas antituberculosas + corticoides
- e) Resolver quirúrgicamente

5) Un niño de 7 años consulta por odinofagia muy intensa de un día de evolución, asociada a fiebre hasta 39,8°C, sin otros síntomas. Al examen físico se palpan adenopatías cervicales anteriores y se observa la faringe muy eritematosa, con algunas petequias y presencia de exudado amigdalino bilateral. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus influenza
- b) Virus Epstein Barr
- c) Streptococcus pyogenes
- d) Anaerobios
- e) Adenovirus

6) Un lactante de 8 meses de edad, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de fiebre, rinorrea y tos, seguidas de dificultad respiratoria. Al examen físico se observa taquipneico, con retracción intercostal y se auscultan escasas sibilancias espiratorias bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar oxígeno y broncodilatadores y una vez recuperado, enviar a domicilio con broncodilatadores SOS
- b) Administrar oxígeno y broncodilatadores y una vez recuperado, enviar a domicilio con corticoides según horario y broncodilatadores SOS
- c) Administrar oxígeno, broncodilatadores y corticoides sistémicos y una vez recuperado, enviar a domicilio con broncodilatadores SOS
- d) Administrar oxígeno, broncodilatadores y corticoides sistémicos y una vez recuperado, enviar a domicilio con corticoides según horario y broncodilatadores SOS
- e) Administrar oxígeno, broncodilatadores, corticoides sistémicos y antibióticos endovenosos, y una vez recuperado, enviar a domicilio con corticoides según horario y broncodilatadores SOS

7) Un lactante de 8 meses de edad presenta un cuadro de malestar e irritabilidad, con crisis de llanto, que luego se acompaña de eliminación de deposiciones sanguinolentas abundantes. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colonoscopia
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar radiografía abdominal
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

8) Un niño de 10 años presenta un cuadro de artralgias, asociado a hematuria y dolor abdominal, con presencia de lesiones purpúricas en las extremidades inferiores y en los glúteos, sin otras alteraciones en el examen físico. Se solicitan exámenes generales, que muestran presencia de hematuria y cilindros hemáticos, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada ante la patología descrita es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar metotrexato
- c) Solicitar biopsia renal
- d) Indicar tratamiento prolongado con corticoides orales
- e) Solicitar biopsia de médula ósea

9) Un niño consume, accidentalmente, una sustancia desconocida, evolucionando con compromiso de consciencia y depresión respiratoria. Al examen físico presenta presión arterial y pulso normales, con frecuencia respiratoria de 6 rpm, sopor profundo y presencia de miosis bilateral, marcada, sin signos focales en el examen neurológico. ¿Qué sustancia fue consumida con mayor probabilidad?

- a) Anticolinérgicos
- b) Organofosforados
- c) Benzodiacepinas
- d) Opiáceos
- e) Agonistas adrenérgicos

10) Un niño presenta tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre alta. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales, saturación arterial de oxígeno de 97% y al examen pulmonar se auscultan crepitaciones localizadas en la base derecha. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen de relleno alveolar del lóbulo inferior derecho, sin signos de derrame. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar amoxicilina oral
- b) Indicar levofloxacino oral
- c) Indicar claritromicina + metronidazol oral
- d) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- e) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona + clindamicina endovenosa

11) Un niño de 5 años, asintomático, presenta un soplo sistólico eyectivo de intensidad III/VI en el examen de control de niño sano. Se ve de buen aspecto, no presenta cianosis ni alteraciones en el examen pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Coartación aórtica
- b) Ductus arterioso persistente
- c) Comunicación interauricular
- d) Comunicación interventricular
- e) Soplo inocente

12) Un niño de 8 años presenta hematoquezia en 3 oportunidades, sin otros síntomas. Su examen físico es completamente normal, incluyendo un tacto rectal. El diagnóstico más probable es:

- a) Pólipo juvenil
- b) Hiperplasia linfática nodular
- c) Divertículo de meckel
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Angiodisplasia

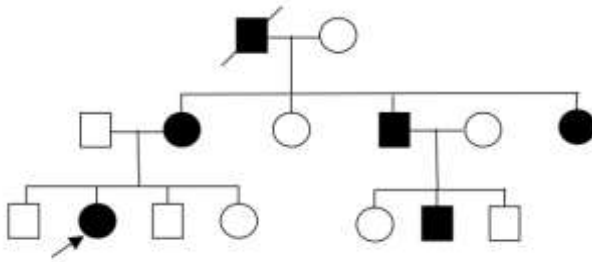
13) Un niño de 11 años presenta aumento de volumen y leve dolor en la zona retroareolar izquierda. Al examen físico presenta ginecomastia unilateral izquierda de 1,5 cm de diámetro, sin secreción. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver quirúrgicamente
- b) Solicitar niveles plasmáticos de estrógenos y FSH
- c) Administrar testosterona en dosis bajas
- d) Solicitar prolactina plasmática
- e) Observar evolución

14) Una niña de 3 años presenta disuria y poliaquiuria, sin otros síntomas. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita urocultivo por sondeo que muestra presencia de E. coli sensible con más de 100.000 UFC por cm³. Se indica tratamiento con cefadroxilo, con buena respuesta clínica. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cintigrafía renal e indicar profilaxis antibiótica hasta terminar el estudio, solicitando urocultivos de control
- b) Solicitar ecografía renal y uretrocistografía miccional e indicar profilaxis antibiótica hasta terminar el estudio, solicitando urocultivos de control
- c) Indicar profilaxis antibiótica hasta terminar el estudio, solicitando urocultivos de control, sin necesidad de mayor estudio
- d) Solicitar urocultivos seriados, sin necesidad de estudio adicional ni de profilaxis antibiótica
- e) Indicar control en caso de recurrencia de síntomas, sin necesidad de mayor estudio ni de profilaxis antibiótica

15) ¿A qué tipo de herencia corresponde el siguiente pedigrí?



- a) Autosómica dominante
- b) Autosómica recesiva
- c) Ligada al cromosoma X
- d) Ligada al cromosoma Y
- e) Mitocondrial

16) Un niño de 5 años presenta IPE: +0,8 DS, IPT: + 1,3 DS, ITE: -0,6DS. EL diagnóstico más probable es:

- a) Eutrófico
- b) Desnutrición
- c) Obesidad
- d) Sobrepeso
- e) Obesidad mórbida

17) Un niño de 10 años presenta un cuadro de debilidad generalizada. ¿Qué alteración es MENOS compatible con un síndrome de Guillain Barré?

- a) Hipoestesia
- b) Hipercarbica
- c) Signo de Babinsky
- d) Hipotonía
- e) Arreflexia

18) Un lactante de 2 meses de edad presenta hemoglobina de 9,5 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Talasemia
- b) Anemia ferropénica
- c) Anemia fisiológica
- d) Anemia hemolítica
- e) Anemia por déficit de vitamina B12

19) Un lactante de 10 meses presenta diarrea aguda, de 1 día de evolución, con deposiciones explosivas, 6 a 10 veces al día, asociadas a fiebre hasta 38,4°C. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, con las mucosas hidratadas y signos vitales normales. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar sales de rehidratación oral, luego de cada deposición diarreica
- b) Indicar sales de rehidratación oral 50-100 cc/kg a tomar en 4-6 horas y reevaluar
- c) Administrar bolo 20 cc/Kg de suero fisiológico y reevaluar
- d) Indicar antibióticos y sales de rehidratación oral, luego de cada deposición diarreica
- e) Indicar antibióticos y sales de rehidratación oral 50-100 cc/kg a tomar en 4-6 horas y reevaluar

20) Un niño presenta fiebre alta y un exantema generalizado, que inicia como pequeñas máculas rosadas, que evolucionan a lesiones purpúricas que crecen rápidamente, acompañándose de compromiso hemodinámico. El agente más probable es:

- a) Sarampión
- b) Yersinia Pestis
- c) Virus varicela zóster
- d) Parvovirus B19
- e) Neisseria meningitidis

Prueba 10

1) Un niño de 6 años presenta un cuadro caracterizado por edema de extremidades inferiores y cara, asociado a hematuria. La madre refiere que presentó una amigdalitis hace 10 días. Al examen físico está hipertenso, con el edema descrito. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 1,2 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 100 mg/m², sedimento de orina con visualización de abundantes eritrocitos con 10% de dismorfia y complemento disminuido. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia renal
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Hospitalizar e iniciar hemodiálisis
- d) Indicar alfametildopa y furosemida según evolución y controlar
- e) Iniciar corticoides endovenosos y ciclofosfamida

2) Un niño de 4 años se traga una moneda. Al examen físico no presenta alteraciones y las radiografías demuestran que la moneda está en el antro gástrico. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución e indicar reconsulta sólo en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar control radiológico cada 12 horas
- c) Solicitar TAC de abdomen
- d) Solicitar endoscopia digestiva
- e) Resolver quirúrgicamente

3) Un niño de 2 años de edad presenta diarrea de 1 mes de evolución, con deposiciones explosivas, acuosas, sin sangre, que tiende a mejorar por algunos días y luego recurre. El examen físico es normal y mantiene su ritmo de crecimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad celíaca
- b) Giardiasis
- c) Diarrea crónica inespecífica
- d) Divertículo de Meckel
- e) Enfermedad inflamatoria intestinal

4) Un niño de 3 años presenta cuadro de fiebre, cefalea, irritabilidad y luego compromiso de consciencia. Al examen físico se destaca rigidez de nuca. Se solicita TAC de cerebro que muestra signos de hipertensión endocraneana. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar punción lumbar
- b) Iniciar ceftriaxona + ampicilina + corticoides
- c) Iniciar ceftriaxona + vancomicina + corticoides
- d) Iniciar drogas antituberculosas + corticoides
- e) Resolver quirúrgicamente

5) Un niño de 7 años consulta por odinofagia muy intensa de un día de evolución, asociada a fiebre hasta 39,8°C, sin otros síntomas. Al examen físico se palpan adenopatías cervicales anteriores y se observa la faringe muy eritematosa, con algunas petequias y presencia de exudado amigdalino bilateral. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus influenza
- b) Virus Epstein Barr
- c) Streptococcus pyogenes
- d) Anaerobios
- e) Adenovirus

6) Un lactante de 8 meses de edad, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de fiebre, rinorrea y tos, seguidas de dificultad respiratoria. Al examen físico se observa taquipneico, con retracción intercostal y se auscultan escasas sibilancias espiratorias bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar oxígeno y broncodilatadores y una vez recuperado, enviar a domicilio con broncodilatadores SOS
- b) Administrar oxígeno y broncodilatadores y una vez recuperado, enviar a domicilio con corticoides según horario y broncodilatadores SOS
- c) Administrar oxígeno, broncodilatadores y corticoides sistémicos y una vez recuperado, enviar a domicilio con broncodilatadores SOS
- d) Administrar oxígeno, broncodilatadores y corticoides sistémicos y una vez recuperado, enviar a domicilio con corticoides según horario y broncodilatadores SOS
- e) Administrar oxígeno, broncodilatadores, corticoides sistémicos y antibióticos endovenosos, y una vez recuperado, enviar a domicilio con corticoides según horario y broncodilatadores SOS

7) Un lactante de 8 meses de edad presenta un cuadro de malestar e irritabilidad, con crisis de llanto, que luego se acompaña de eliminación de deposiciones sanguinolentas abundantes. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colonoscopia
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Solicitar radiografía abdominal
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

8) Un niño de 10 años presenta un cuadro de artralgias, asociado a hematuria y dolor abdominal, con presencia de lesiones purpúricas en las extremidades inferiores y en los glúteos, sin otras alteraciones en el examen físico. Se solicitan exámenes generales, que muestran presencia de hematuria y cilindros hemáticos, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada ante la patología descrita es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar metotrexato
- c) Solicitar biopsia renal
- d) Indicar tratamiento prolongado con corticoides orales
- e) Solicitar biopsia de médula ósea

9) Un niño consume, accidentalmente, una sustancia desconocida, evolucionando con compromiso de consciencia y depresión respiratoria. Al examen físico presenta presión arterial y pulso normales, con frecuencia respiratoria de 6 rpm, sopor profundo y presencia de miosis bilateral, marcada, sin signos focales en el examen neurológico. ¿Qué sustancia fue consumida con mayor probabilidad?

- a) Anticolinérgicos
- b) Organofosforados
- c) Benzodiacepinas
- d) Opiáceos
- e) Agonistas adrenérgicos

10) Un niño presenta tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre alta. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales, saturación arterial de oxígeno de 97% y al exmaen pulmonar se auscultan crepitaciones localizadas en la base derecha. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen de relleno alveolar del lóbulo inferior derecho, sin signos de derrame. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar amoxicilina oral
- b) Indicar levofloxacino oral
- c) Indicar claritromicina + metronidazol oral
- d) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- e) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona + clindamicina endovenosa

11) Un niño de 5 años, asintomático, presenta un soplo sistólico eyectivo de intensidad III/VI en el examen de control de niño sano. Se ve de buen aspecto, no presenta cianosis ni alteraciones en el examen pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Coartación aórtica
- b) Ductus arterioso persistente
- c) Comunicación interauricular
- d) Comunicación interventricular
- e) Soplo inocente

12) Un niño de 8 años presenta hematoquezia en 3 oportunidades, sin otros síntomas. Su examen físico es completamente normal, incluyendo un tacto rectal. El diagnóstico más probable es:

- a) Pólipo juvenil
- b) Hiperplasia linfática nodular
- c) Divertículo de meckel
- d) Enfermedad inflamatoria intestinal
- e) Angiodiplotasia

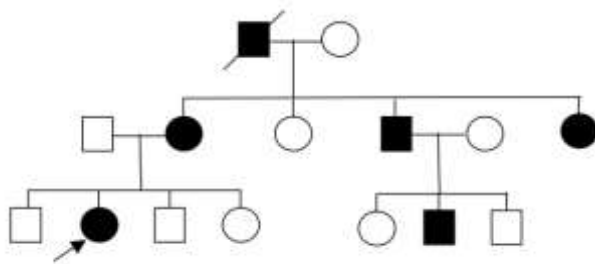
13) Un niño de 11 años presenta aumento de volumen y leve dolor en la zona retroareolar izquierda. Al examen físico presenta ginecomastia unilateral izquierda de 1,5 cm de diámetro, sin secreción. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver quirúrgicamente
- b) Solicitar niveles plasmáticos de estrógenos y FSH
- c) Administrar testosterona en dosis bajas
- d) Solicitar prolactina plasmática
- e) Observar evolución

14) Una niña de 3 años presenta disuria y poliaquiuria, sin otros síntomas. El examen físico no aporta mayor información. Se solicita urocultivo por sondeo que muestra presencia de E. coli sensible con más de 100.000 UFC por cm³. Se indica tratamiento con cefadroxilo, con buena respuesta clínica. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cintigrafía renal e indicar profilaxis antibiótica hasta terminar el estudio, solicitando urocultivos de control
- b) Solicitar ecografía renal y uretrocistografía miccional e indicar profilaxis antibiótica hasta terminar el estudio, solicitando urocultivos de control
- c) Indicar profilaxis antibiótica hasta terminar el estudio, solicitando urocultivos de control, sin necesidad de mayor estudio
- d) Solicitar urocultivos seriados, sin necesidad de estudio adicional ni de profilaxis antibiótica
- e) Indicar control en caso de recurrencia de síntomas, sin necesidad de mayor estudio ni de profilaxis antibiótica

15) ¿A qué tipo de herencia corresponde el siguiente pedigrí?



- a) Autosómica dominante
- b) Autosómica recesiva
- c) Ligada al cromosoma X
- d) Ligada al cromosoma Y
- e) Mitocondrial

16) Un niño de 5 años presenta IPE: +0,8 DS, IPT: + 1,3 DS, ITE: -0,6DS. EL diagnóstico más probable es:

- a) Eutrófico
- b) Desnutrición
- c) Obesidad
- d) Sobrepeso
- e) Obesidad mórbida

17) Un niño de 10 años presenta un cuadro de debilidad generalizada. ¿Qué alteración es MENOS compatible con un síndrome de Guillain Barré?

- a) Hipoestesia
- b) Hipercarbica
- c) Signo de Babinsky
- d) Hipotonía
- e) Arreflexia

18) Un lactante de 2 meses de edad presenta hemoglobina de 9,5 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Talasemia
- b) Anemia ferropénica
- c) Anemia fisiológica
- d) Anemia hemolítica
- e) Anemia por déficit de vitamina B12

19) Un lactante de 10 meses presenta diarrea aguda, de 1 día de evolución, con deposiciones explosivas, 6 a 10 veces al día, asociadas a fiebre hasta 38,4°C. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, con las mucosas hidratadas y signos vitales normales. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar sales de rehidratación oral, luego de cada deposición diarreica
- b) Indicar sales de rehidratación oral 50-100 cc/kg a tomar en 4-6 horas y reevaluar
- c) Administrar bolo 20 cc/Kg de suero fisiológico y reevaluar
- d) Indicar antibióticos y sales de rehidratación oral, luego de cada deposición diarreica
- e) Indicar antibióticos y sales de rehidratación oral 50-100 cc/kg a tomar en 4-6 horas y reevaluar

20) Un niño presenta fiebre alta y un exantema generalizado, que inicia como pequeñas máculas rosadas, que evolucionan a lesiones purpúricas que crecen rápidamente, acompañándose de compromiso hemodinámico. El agente más probable es:

- a) Sarampión
- b) Yersinia Pestis
- c) Virus varicela zóster
- d) Parvovirus B19
- e) Neisseria meningitidis

Prueba 11

1) Un niño de 6 años consulta por aumento de volumen facial. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y con edema facial y de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran: creatinina: 0,5 mg/dl, sedimento de orina: normal, proteinuria de 24 horas: 1,5 g/m² de superficie corporal, albuminemia: 2,2 g/dl. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis postestreptocócica
- b) Enfermedad de Berger
- c) Nefrosis lipoídea
- d) Glomerulopatía membranosa
- e) Glomerulonefritis mesangiocapilar

2) Un niño de 8 meses de edad, sin antecedentes de importancia, consulta presenta fiebre hasta 38,5°C, asociado a tos y dificultad para respirar. Al examen físico se aprecia retracción intercostal, taquipnea y se auscultan sibilancias bilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Asma
- b) Bronquiolitis aguda
- c) Laringitis obstructiva
- d) Neumonía
- e) Bronquitis aguda

3) Un niño de 6 años presenta un cuadro meníngeo, que se estudia mediante punción lumbar, que da salida a un líquido con 1.200 células por mm³, con 95% de polimorfonucleares, glucosa: 30 mg/dl y proteínas: 160 mg/dl. El agente etiológico más probable es:

- a) Bacilo de Koch
- b) Enterovirus
- c) Neumococo
- d) Virus herpes simplex
- e) Estafilococo áureo

4) ¿Qué esperarías encontrar en la curva de crecimiento y en la edad ósea de un niño con talla baja debida a un retraso constitucional del crecimiento?

- a) Velocidad de crecimiento normal y edad ósea acorde con la edad cronológica
- b) Velocidad de crecimiento normal y edad ósea mayor que la edad cronológica
- c) Velocidad de crecimiento normal y edad ósea menor que la edad cronológica
- d) Velocidad de crecimiento disminuida y edad ósea acorde con la edad cronológica
- e) Velocidad de crecimiento disminuida y edad ósea menor que la edad cronológica

5) Un recién nacido presenta alteración de la prueba neonatal de detección de hipotiroidismo congénito, con sangre capilar. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar levotiroxina
- b) Solicitar T4 libre de sangre venosa
- c) Solicitar TSH de sangre venosa
- d) Solicitar ecografía cervical
- e) Repetir la prueba

6) Un niño de 2 años presenta tos y disnea de inicio súbito, que ceden parcialmente mientras la madre lo llevaba a la urgencia. Al examen físico se aprecia asimetría del murmullo pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Laringitis obstructiva
- b) Neumotórax espontáneo
- c) Cuerpo extraño bronquial
- d) Bronquitis obstructiva
- e) Asma

7) Un lactante presenta mal incremento ponderal, asociado a infecciones respiratorias a repetición. Al examen físico presenta un soplo sistólico eyectivo III/VI, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Satura 80% a FiO2 ambiental, mejorando a 91% con oxígeno al 30%. EL diagnóstico más probable es:

- a) Tetralogía de Fallot
- b) Coartación aórtica
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Comunicación interventricular
- e) Comunicación interauricular

8) Un niño de 2 años presenta diarrea acuosa de 2 meses de evolución, que en algunos días es más intensa que en otros. La madre refiere que le da abundante jugo, para evitar que se deshidrate. El diagnóstico más probable es:

- a) Amebiasis
- b) Giardiasis
- c) Colitis bacteriana
- d) Enfermedad celíaca
- e) Diarrea inespecífica

9) Un niño de 4 años presenta diarrea disintérica de 2 días de evolución, asociada a fiebre alta, marcado compromiso del estado general y sopor superficial. Al examen físico se aprecia deshidratado, irritable y con temperatura axilar de 40°C. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución, indicando sales de rehidratación oral
- b) Hospitalizar e iniciar suero fisiológico y ceftriaxona por vía intravenosa
- c) Iniciar sales de rehidratación y ciprofloxacino oral
- d) Solicitar coprocultivo y parasitológico seriado y decidir conducta según hallazgos
- e)

10) Un lactante de 3 meses de edad ha sufrido varias neumonías y gastroenteritis desde el nacimiento, asociadas a mal incremento ponderal. Al examen físico presenta algorra. ¿A qué nivel se encuentra su inmunodeficiencia?

- a) Inmunoglobulina G
- b) Complemento
- c) Linfocitos T
- d) Linfocitos B
- e) Inmunoglobulina A

11) Un niño de 10 meses presenta fiebre hasta 38,5°C. No presenta otros síntomas y su examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos y controlar en 48 horas
- b) Solicitar sedimento de orina, urocultivo y hemograma
- c) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral y controlar en 24 horas
- d) Solicitar hemograma, hemocultivos, sedimento de orina, urocultivo, estudio de líquido cefalorraquídeo, radiografía de tórax y decidir conducta según hallazgos
- e) Solicitar hemograma, hemocultivos, sedimento de orina, urocultivo, estudio de líquido cefalorraquídeo, radiografía de tórax e iniciar antibióticos de amplio espectro, por vía endovenosa

12) Un niño de 6 años presenta malestar general, fiebre y cefalea desde hace una semana. Al examen físico se aprecian algunas petequias en el tórax y se palpa esplenomegalia. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia
- b) Púrpura trombocitopenico trombótico
- c) Púrpura trombocitopenico inmune
- d) Mononucleosis infecciosa
- e) Púrpura de Shonlein-Henoch

13) Un niño de 3 años presenta claudicación de la marcha y fiebre hasta 40°C. Al examen físico está decaído y muestra dolor a la movilización de la cadera izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Sinovitis transitoria
- b) Enfermedad de Perthes
- c) Artritis séptica
- d) Artritis juvenil idiopática
- e) Enfermedad de Kawasaki

14) Un niño consulta por tos nocturna y en relación al ejercicio, que en ocasiones se asocia a algún grado de disnea. El examen físico es normal, al igual que la radiografía de tórax y el PEF. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de tórax
- b) Solicitar prueba de provocación con metacolina
- c) Solicitar prick test
- d) Iniciar antihistamínicos y corticoides orales
- e) Observar evolución

15) Un niño de 8 años ha bajado considerablemente su rendimiento escolar y además se ha vuelto retraído y agresivo con sus padres, que acaban de separarse. ¿Qué diagnóstico debería plantear en primer lugar?

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno de conducta
- c) Trastorno oposicionista desafiante
- d) Depresión
- e) Normal

16) Un recién nacido de 10 días de vida presenta hematemesis en una oportunidad. Al examen físico está en buenas condiciones, con signos vitales normales. La conducta diagnóstica más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopía digestiva alta
- b) Solicitar ecografía de abdomen y pelvis
- c) Solicitar angiografía mesentérica
- d) Solicitar hemograma con recuento de plaquetas y tiempos de coagulación
- e) Solicitar test de Apt

17) Un lactante de 10 meses de edad presenta fiebre alta, hasta 40,5°C de 2 días de evolución, que luego cede, dando paso a aparición de un exantema papular eritematoso, que compromete la cara, tronco y zona proximal de las extremidades, con cerca de 30 lesiones en total. El diagnóstico más probable es:

- a) Exantema inespecífico
- b) Exantema súbito
- c) Eritema infeccioso
- d) Rubeola
- e) Síndrome de pie-mano-boca

18) ¿Qué hallazgos son más orientadores a un síndrome hemolítico urémico?

- a) Anemia, trombocitopenia y elevación de la creatinina
- b) Anemia, trombocitosis y hematuria dismórfica
- c) Hemoconcentración trombocitopenia y hematuria dismórfica
- d) Hemoconcentración, trombocitosis y elevación de la creatinina
- e) Trombocitopenia, leucocitosis y hematuria dismórfica

19) Un niño de 3 años presenta un IPE: +1DS, IPT: +0DS, ITE: +1DS. El diagnóstico es:

- a) Desnutrición
- b) Riesgo de desnutrición
- c) Eutrofia
- d) Sobrepeso
- e) Obesidad

20) Un niño de 8 años consulta por odinofagia, fiebre y aparición de un exantema papular generalizado, con compromiso de las axilas y los pliegues cubitales. Al examen físico se aprecia faringe eritematosa, con exudado grisáceo en las amígdalas, lengua saburral, con puntos rojos y adenopatías cervicales bilaterales sensibles. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar paracetamol y solicitar IgM-VCA
- b) Iniciar AINEs y observar evolución
- c) Iniciar amoxicilina oral y antipiréticos
- d) Solicitar IgM para Sarampión e iniciar tratamiento sintomático
- e) Iniciar ceftriaxona endovenosa

RESPUESTAS PEDIATRÍA

Prueba 1	19 C	15 E	12 B	9 E	6 A
1 E	20 B	16 E	13 B	10 D	7 B
2 A		17 D	14 B	11 D	8 A
3 C	Prueba 3	18 E	15 E	12 C	9 D
4 E	1 D	19 D	16 C	13 D	10 A
5 B	2 B	20 A	17 E	14 D	11 E
6 D	3 D		18 B	15 C	12 A
7 C	4 D	Prueba 5	19 A	16 D	13 E
8 E	5 A	1 D	20 C	17 C	14 D
9 A	6 D	2 C		18 A	15 A
10 B	7 A	3 B	Prueba 7	19 E	16 D
11 A	8 C	4 A	1 C	20 C	17 C
12 B	9 A	5 A	2 E		18 C
13 D	10 D	6 E	3 C	Prueba 9	19 A
14 C	11 C	7 D	4 B	1 D	20 E
15 B	12 B	8 B	5 C	2 A	
16 C	13 A	9 B	6 B	3 C	Prueba 11
17 C	14 A	10 D	7 D	4 C	1 C
18 E	15 C	11 E	8 E	5 C	2 B
19 D	16 A	12 A	9 E	6 A	3 C
20 E	17 B	13 A	10 D	7 B	4 C
	18 E	14 B	11 B	8 A	5 B
Prueba 2	19 D	15 D	12 D	9 D	6 C
1 E	20 C	16 D	13 B	10 A	7 E
2 A		17 D	14 A	11 E	8 E
3 C		18 A	15 B	12 A	9 B
4 D	Prueba 4	19 B	16 B	13 E	10 C
5 D	1 B	20 C	17 C	14 B	11 A
6 A	2 C		18 D	15 A	12 A
7 D	3 A	Prueba 6	19 E	16 D	13 C
8 A	4 C	1 D	20 A	17 C	14 B
9 D	5 D	2 E		18 C	15 D
10 A	6 B	3 A	Prueba 8	19 A	16 E
11 A	7 B	4 E	1 D	20 E	17 B
12 C	8 C	5 B	2 A		18 A
13 A	9 C	6 D	3 C	Prueba 10	19 C
14 D	10 A	7 C	4 B	1 D	20 C
15 B	11 B	8 E	5 B	2 A	
16 A	12 A	9 C	6 C	3 C	
17 C	13 A	10 C	7 D	4 C	
18 D	14 D	11 E	8 C	5 C	

III) PEDIATRÍA POR TEMA PRUEBAS

Prueba 1

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
CARDIOLOGÍA, prueba 6

Prueba 2

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
RESPIRATORIO, prueba 5

Prueba 3

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
NEFROLOGÍA, prueba 5

Prueba 4

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
NEUROLOGÍA, prueba 6

Prueba 5

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN, prueba 9

Prueba 6

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN, prueba 10

Prueba 7

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
REUMATOLOGÍA, prueba 4

Prueba 8

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
INFECTOLOGÍA, prueba 7

Prueba 9

Ver libro de banco de preguntas de MEDICINA INTERNA
HEMATO-ONCOLOGÍA, prueba 4

IX) PEDIATRÍA PRUEBAS GRANDES

Prueba 1

1) ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en el mayor de seis años?

- a) Sabin
- b) DTP
- c) Trivírica
- d) BCG
- e) DT

2) ¿Cuál de los siguientes microorganismos es responsable, con mayor frecuencia de un cuadro de laringitis obstructiva?

- a) Virus Respiratorio Sincial (VRS)
- b) Mixovirus
- c) Parainfluenza
- d) Rinovirus
- e) Adenovirus

3) ¿Cuál de las siguientes conductas en crisis o episódicas se acompaña de retraso mental en el lactante?

- a) Episodios de apnea con temblor y rubicundez
- b) Crisis atónicas
- c) Episodios de pestañeo (3 por segundo) con transitoria pérdida de conciencia
- d) Episodios de temblores leves con palidez y/o cianosis
- e) Espasmos masivos

4) En relación a la talla de nacimiento de un varón, ¿Cuál de los siguientes factores es MAS determinante?

- a) Carga genética promedio de los padres
- b) Función tiroidea materna
- c) Raza
- d) Talla del padre
- e) Condiciones ambientales intrauterinas

5) Germán, de 6 meses de edad, 7.200 grs. de peso y que recibió durante 3 meses lactancia materna, es enviado desde su Sala-Cuna a policlínico por un cuadro diarreico de 24 horas de evolución, con fiebre baja y presencia de 4 vómitos en las últimas 12 horas. Al examen físico usted lo encuentra con mucosas algo secas, consciente, irritable, sediento. La madre se ve preocupada, receptiva y cooperadora. ¿Cuál es la conducta que se debe iniciar?

- a) Derivación del niño a un hospital para rehidratación intravenosa
- b) Dieta hídrica con variados líquidos (aguas de hierba, Coca-Cola, etc) por 8 horas, seguida de realimentación a concentraciones graduales de leche (que dure 4 a 5 días) y control cada 2 a 3 días
- c) Administración de sales de rehidratación oral según esquema preciso, durante 4 a 6 horas, seguida de realimentación relativamente rápida y control periódico del paciente
- d) Administración de un antibiótico de amplio espectro y sales de rehidratación oral, con seguimiento frecuente del paciente
- e) Dieta hídrica con variados líquidos (aguas de hierba, Coca-Cola, etc) por 8 horas, seguida de realimentación a concentraciones graduales de leche (que dure 4 a 5 días) y control cada 2 a 3 días, además de administración de fármacos opioides que reduzcan la motilidad intestinal (loperamida, por ejemplo)

6) Una vez diagnosticada clínicamente una hernia inguinal no complicada en un lactante, la actitud CORRECTA es:

- a) esperar hasta los 7 años, ya que hay un 50% de resolución espontánea
- b) cirugía de urgencia
- c) control mensual
- d) cirugía electiva lo más pronto posible
- e) solicitar ecografía inguinal para corroborar diagnóstico

7) La etiología más frecuente de la bronquiolitis aguda en lactantes es:

- a) Virus respiratorio sincicial
- b) Mycoplasma pneumoniae
- c) Influenza
- d) Parainfluenza
- e) Adenovirus

8) Para desarrollar un programa de educación en salud dirigido a preescolares, la primera prioridad es prevenir:

- a) sarna y pediculosis
- b) diarreas y enteroparasitosis
- c) enfermedades infecciosas transmisibles
- d) traumatismos y envenenamientos
- e) neumonías y bronconeumonías

9) La madre primípara, de un recién nacido de 15 días de edad, consulta porque desde que salió de la maternidad, el niño presenta deposiciones semilíquidas, explosivas, de olor ácido, en cantidad de 6 a 8 en 24 horas, principalmente después de ser amamantado. No recibe otros alimentos. Al nacer pesó 2.800 grs. al tercer día 2.670 grs. y actualmente 3.200 grs. El examen físico es normal. ¿Cuál de las siguientes conductas es la MAS apropiada?

- a) Hospitalizar al niño
- b) Disminuir el número de veces que el niño mama
- c) Hacer una determinación de pH y sustancias reductoras fecales y, si el pH es menor que 6 y las sustancias reductoras son positivas, cambiar la alimentación de pecho materno a una fórmula sin lactosa
- d) Solicitar exámenes fecales tales como coprocultivo y examen parasitológico
- e) Tranquilizar a la madre explicándole que su niño es totalmente normal y que sus deposiciones son las esperables en un niño que recibe lactancia materna exclusiva

10) La edad óptima para la corrección quirúrgica de la criptorquidia es:

- a) 1 año y 6 meses
- b) en la pubertad
- c) a los 5 años
- d) a los 3 años
- e) al nacimiento

11) Francisca, de 11 meses de edad, nacida en Marzo y que va a la Sala Cuna desde los 3 meses, presentó un cuadro respiratorio febril a los 4 meses de edad, que fue catalogado en un Servicio de Urgencia como "neumonitis" por lo que debió ser hospitalizada durante 5 días. A partir de entonces ha presentado un promedio de un episodio mensual de un cuadro que ha sido catalogado como "síndrome bronquial obstructivo". ¿Cuál de las siguientes secuencias de eventos representa MEJOR lo que esta niña tuvo?

- a) Bronquiolitis por VRS que la dejó con hiperreactividad bronquial que ha sido desencadenada luego por infecciones virales
- b) Infección pulmonar inicial por adenovirus que produjo displasia broncopulmonar, la cual ha sido exacerbada subsecuentemente por otras infecciones
- c) Los episodios son característicos del asma bronquial del lactante, exacerbada por reflujo gastroesofágico
- d) Aspiración de cuerpo extraño con subsecuentes infecciones
- e) Laringotraqueomalacia que ha sido exacerbada por infecciones virales

12) La madre de José de 3 meses, en su supervisión de salud, se manifiesta preocupada porque, al asistir a otro policlínico de atención primaria, le dijeron que su hijo, cuyo peso actual es de 6 kgs. está obeso y que debe ser amamantado con menos frecuencia. El peso al nacer fue de 2.800 grs. y el niño no ha recibido alimentación artificial. Debe usted explicar a la madre que:

- a) el niño no es un obeso genuino y que no hay problema mientras tome pecho
- b) siga el consejo de amamantarlo con menos frecuencia
- c) lo amamante sólo de un pecho por vez, alternando cada lado
- d) cambie la alimentación al pecho por una fórmula láctea pobre en grasa
- e) siga amamantándolo y retrase la incorporación de sólidos hasta después de los 7 meses

13) La convulsión febril benigna:

- a) generalmente no muestra alteraciones al EEG
- b) es más frecuente en el sexo femenino
- c) tiene antecedente familiar de epilepsia
- d) se presenta con mayor frecuencia entre los seis y doce meses
- e) responde bien al tratamiento con fenitoína

14) ¿Cuáles de las siguientes características corresponden al pensamiento de un niño de dos a cuatro años?

- a) Concreto, fundado en la acción
- b) Prelógico, egocéntrico
- c) Objetivo, centrado en la realidad
- d) Social, fundado en la interacción
- e) Preverbal, práctico

15) Durante el primer año de vida, el promedio de aumento en la talla es de alrededor de:

- a) 50 cms.
- b) 25 cms.
- c) 12,5 cms.
- d) 17,5 cms.
- e) 37,5 cms.

16) La causa MAS frecuente de apnea obstructiva del sueño en preescolares es:

- a) Malformaciones craneofaciales
- b) Alteraciones del centro respiratorio
- c) Infección por virus respiratorio sincicial
- d) Hipertrofia adenotonsilar
- e) Todas las opciones que se señalan

17) La estimación precisa del área de superficie de una quemadura requiere conocer las proporciones de cada una de las diversas áreas del cuerpo con el área de superficie corporal total. La diferencia principal entre lactantes y adultos en cuanto al área de superficie consiste en que los lactantes tienen un área proporcionalmente:

- a) mayor para cabeza y cuello
- b) menor para los genitales
- c) mayor para regiones glúteas
- d) menor para manos y pies
- e) menor de tronco

18) Frente a un cuadro de escroto agudo unilateral, cuyo diagnóstico etiológico no es posible precisar, la actitud CORRECTA a seguir es:

- a) colocar suspensión escrotal y analgésicos
- b) efectuar hemograma, VHS y tratamiento con antiinflamatorios
- c) ecografía y evaluación en 12 horas
- d) operar de inmediato (urgencia quirúrgica)
- e) observar por 24 horas y controlar

19) Aunque la vasta mayoría de pacientes con deshidratación sin shock pueden ser tratados exitosamente con rehidratación oral, la terapia de rehidratación oral puede no ser efectiva en pacientes con una de las siguientes situaciones:

- a) Diarrea por E. coli enterotoxigénica
- b) Distensión abdominal progresiva
- c) Vómitos, en promedio de dos por hora
- d) Diarrea por rotavirus
- e) Hipernatremia

20) El hueso que se fractura con MAYOR frecuencia en el niño durante el parto es:

- a) el radio
- b) la tibia
- c) el cráneo
- d) el fémur
- e) la clavícula

21) La tenosinovitis aguda transitoria de cadera se caracteriza porque:

- a) en el hemograma se encuentra leucocitosis marcada y desviación a izquierda
- b) se puede presentar con fiebre baja, cojera reciente y dolor referido a la cadera o rodilla
- c) se presenta habitualmente con fiebre alta, sobre 30°C
- d) la Rx de caderas es de ayuda diagnóstica
- e) la VHS y la PCR están muy elevadas

22) El recién nacido presenta una serie de signos físicos que no tienen significado patológico. ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a este grupo?

- a) Mancha café con leche
- b) Eritema tóxico
- c) Mancha mongólica
- d) Vermix caseoso
- e) Petequias generalizadas

23) ¿Cuál de estas acciones NO se suele presentar en un lactante de 3 meses?

- a) Llorar frente a un extraño
- b) Sonreír frente a un rostro humano
- c) Seguir con la mirada a 180 grados
- d) Producir sonidos bucales
- e) Ser capaz de elevar parte del tórax en prono

24) ¿Cuál de los siguientes porcentajes es el que más se aproxima a la baja fisiológica de peso del RN de término en los primeros 4 a 6 días?

- a) 10% del peso de nacimiento.
- b) No debe bajar de peso.
- c) 150 grs.
- d) 5% del peso de nacimiento.
- e) 15% del peso de nacimiento.

25) Un niño de dos meses de vida, es traído a la Unidad de Emergencia Infantil porque está febril, con 39°C hace 12 horas, sin otros síntomas relevantes. Al examen no se encuentran signos de localización. Entre los exámenes que se realizan para aclarar la causa de la fiebre está una PL, cuyo examen citoquímico muestra: Albúmina 0.8 gr/00; Glucosa 30 mg% con Glicemia de 70 mg%; Recuento celular 150 cel/mm³; Recuento diferencial: PMN 60%, MN 40%; Tinción de Gram: sin gérmenes. El diagnóstico MAS probable es:

- a) Meningoencefalitis aséptica.
- b) Meningitis Bacteriana aguda.
- c) LCR de características normales.
- d) Meningoencefalitis herpética.
- e) Meningoencefalitis por enterovirus.

26) Varón de 13.5 años cuya pubertad se inició hace 1.5 años, consulta por ginecomastia unilateral. En el examen físico se constata desarrollo genital III de Tanner con un tamaño testicular de 4 cm. de diámetro mayor. La PRIMERA posibilidad diagnóstica es:

- a) Síndrome de Klinefelter
- b) Ginecomastia puberal.
- c) Uso de tabaco.
- d) Fibroadenoma mamario.
- e) Tumor feminizante.

27) Señale la etiología MAS frecuente en neumonías adquiridas en la comunidad en escolares:

- a) Staphylococcus aureus
- b) Chlamidia trachomatis
- c) Hemophilus influenzae
- d) Pseudomonas aeruginosa
- e) Streptococcus pneumoniae

28) ¿Cuál es el diagnóstico MAS probable en un paciente de 8 años, de sexo masculino, en buen estado general que consulta por artralgia unilateral de cadera de 2 semanas y cojera progresiva?

- a) Leucemia linfática aguda.
- b) Osteonecrosis de la cabeza femoral (Perthes)
- c) Sinovitis aguda transitoria de la infancia.
- d) Dolor óseo recurrente benigno.
- e) Fractura de cadera.

29) ¿Cuáles son los agentes etiológicos MAS frecuentes en la septicemia neonatal?

- a) Escherichia coli - Streptococo beta hemolítico grupo B.
- b) Escherichia coli - Klebsiella Pneumoniae
- c) Listeria monocytogenes . Pseudomonas aeruginosa
- d) Bacterias anaeróbicas- Estafilococo aureus
- e) Streptococo beta hemolítico grupo A- Pseudomonas

30) Los primeros dientes "de leche" aparecen MAS frecuentemente:

- a) a los 5 años.
- b) entre los 12 y los 15 meses de edad.
- c) entre los 9 y los 12 meses de edad.
- d) entre los 3 y los 5 meses de edad.
- e) entre los 5 y los 9 meses de edad.

31) Pablo de 10 años viene a control con su madre, quien insiste que el niño está flaco. La antropometría revela: P/E en p20; T/E en p/20 y el P/T en el p50 con incrementos adecuados en peso y talla. ¿Cuál es el diagnóstico que representa MAS adecuadamente su estado?

- a) Desnutrido agudo
- b) Desnutrido crónico
- c) Retraso de talla
- d) Sobrepeso
- e) Eutrófico

32) ¿Qué exámenes de laboratorio debe solicitar en forma inmediata a un niño de dos años, con historia de fiebre hasta 39°C, decaimiento y signos inflamatorios a nivel de rodilla derecha?

- a) Radiografía de rodillas y hemograma
- b) Radiografía de rodilla y hemocultivo
- c) Cintigrafía ósea, hemograma y VHS
- d) Examen de líquido articular y radiografía de rodillas
- e) Examen de líquido articular, hemograma y VHS

33) En el síndrome nefrítico, expresión de glomerulonefritis aguda postinfecciosa, el dato de laboratorio de MAYOR utilidad para confirmar el diagnóstico es:

- a) La existencia de hiperpotasemia moderada
- b) El aumento persistente de IgM.
- c) La elevación de la urea en la sangre
- d) La presencia de anemia normocítica y normocrómica
- e) La hipocomplementemia (C3) transitoria

34) El test de Apgar, al minuto de vida permite:

- a) decidir la conducta en la reanimación
- b) determinar riesgo de hemorragia intracraneana
- c) determinar el pronóstico neurológico inmediato
- d) evaluar el grado de acidosis metabólica
- e) evaluar la severidad de la asfisia intrauterina

35) ¿Cuál de estas cardiopatías congénitas no produce cianosis en el recién nacido?

- a) Ventrículo único
- b) Coartación aórtica
- c) Tetralogía de Fallot
- d) Hipoplasia del corazón izquierdo
- e) Transposición de grandes vasos

36) ¿Cuál de las siguientes vacunas que se están usando en Chile, NO es todavía parte del PROGRAMA OFICIAL de vacunación?

- a) Rubéola
- b) Hepatitis B
- c) Hepatitis A
- d) Anti -Hemophyllus
- e) Polio oral

37) La enuresis nocturna en un niño de ocho años es MAS PROBABLEMENTE asociada con:

- a) anormalidades anatómicas genitourinarias
- b) historia de enuresis en la familia
- c) infecciones del tracto urinario
- d) depresión infantil
- e) síndrome de déficit atencional

38) ¿Cuál de los siguientes es el antibiótico de elección para el tratamiento de una otitis media aguda en un lactante de 4 meses?

- a) Cefuroximo
- b) Claritromicina
- c) Amoxicilina
- d) Eritromicina
- e) Amoxicilina/ácido clavulánico

39) La prueba de Hirschberg es una prueba:

- a) de verificación de la visión estereoscópica
- b) audiológica de respuesta al sonido
- c) de observación del reflejo luminoso corneal producido por una luz
- d) de screening del desarrollo psicomotor
- e) consistente en tapar y destapar el ojo no iluminado

40) La faringitis estreptocócica suele caracterizarse por todos los siguientes síntomas, EXCEPTO:

- a) Inicio súbito
- b) Presencia de abundante rinorrea
- c) Enrojecimiento de la faringe, a veces con petequias
- d) Adenopatías cervicales dolorosas
- e) Compromiso del estado general

41) ¿Cuál es el método MAS aconsejable y sencillo para valorar el grado de obesidad en la infancia?

- a) Índice de peso/edad
- b) Índice de masa corporal
- c) Índice de peso/talla
- d) Espesor del pliegue cutáneo
- e) Circunferencia del brazo

42) ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA en relación al Síndrome de dificultad respiratoria (SDR) por aspiración de meconio?

- a) El SDR por aspiración de meconio se presenta en recién nacidos cercanos al término de la gestación, especialmente en el RN postérmino
- b) La hipoxemia induce a que el feto haga esfuerzos respiratorios profundos, produciéndose la aspiración de líquido amniótico con meconio hacia las vías aéreas superiores
- c) En el momento de nacer, como consecuencia de las primeras respiraciones, es cuando se produce el mayor riesgo de aspirar líquido amniótico meconial
- d) El SDR por aspiración de meconio es un cuadro respiratorio principalmente de tipo restrictivo
- e) El atrapamiento de aire es una de las causas de la alta incidencia de neumotórax que presenta el SDR por aspiración de meconio

43) La causa más común de muerte perinatal en Chile es:

- a) Hipoglicemia
- b) Infección
- c) Malformaciones congénitas
- d) Traumatismos
- e) Prematurez

44) Recién nacido de 3 semanas de vida, que presenta bronconeumonía y conjuntivitis. La radiografía de tórax muestra infiltrado intersticial. La etiología más probable es:

- a) *Treponema pallidum*
- b) *Chlamydia trachomatis*
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) *Candida albicans*
- e) *Streptococcus pneumoniae*

45) Lactante de 18 meses de edad, inasistente a controles de salud. Se comprueba inmunizaciones hasta la vacuna de los 6 meses. Se debe vacunar con:

- a) DPT y polio ahora / En 2 meses parotiditis-rubéola-sarampión
- b) Parotiditis-rubéola-sarampión ahora / En 2 meses DPT y polio
- c) DPT y polio ahora / En 1 mes parotiditis-rubéola-sarampión
- d) DPT, polio y parotiditis-rubéola-sarampión, todas ahora
- e) DPT, polio y parotiditis-rubéola-sarampión, todas en 2 meses más

46) La causa más frecuente de anemia en un lactante de 8 meses es:

- a) hemólisis
- b) aplasia medular
- c) hemorragia oculta
- d) bajo aporte de hierro
- e) leucemia

47) Lactante de 7 meses con fiebre de hasta 39.5 C, de 3 días de evolución. En relación a la desaparición de la fiebre, aparece exantema máculo-papular, más intenso en tronco.Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Sarampión
- b) Eritema infeccioso
- c) Rubéola
- d) Mononucleosis
- e) Exantema súbito

48) Lactante de 15 meses que presentó diarrea con mucosidades y sangre hace 5 días, se aprecia muy decaído, pálido y con discreto edema de párpados. No ha orinado en las últimas 12 horas pese a estar con menos diarrea y haber recibido líquidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Deshidratación aguda
- b) Síndrome hemolítico-urémico
- c) Sepsis de foco enteral
- d) Infección urinaria
- e) Enterocolitis complicada

49) La causa más frecuente de ictericia neonatal es:

- a) enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- b) ictericia por lactancia materna
- c) enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh
- d) ictericia fisiológica
- e) poliglobulia

50) Niño de 4 años con fiebre de 4 días y síndrome purpúrico (petequias y equimosis aisladas en el tronco). En la anamnesis surge el dato de dolor óseo en el extremo distal del fémur derecho, que lo hace claudicar. Al examen físico se pesquisa esplenomegalia de 2 cm. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Púrpura trombocitopénico inmune
- b) Lupus eritematoso
- c) Artritis reumatoidea juvenil
- d) Leucemia aguda
- e) Enfermedad de Kawasaki

Prueba 2

1) La causa más frecuente de síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido de término es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Infección por Streptococcus beta hemolítico, grupo B
- c) Cardiopatías congénitas
- d) Síndrome de aspiración de meconio
- e) Enfermedad de membrana hialina

2) Un niño de 2 años, cursando infección respiratoria alta, con fiebre hasta 39°C, presenta una convulsión tónico clónica de 3 minutos de duración, autolimitada, recuperándose completamente. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, hidratado, bien perfundido, sin focalidad neurológica ni signos meníngeos. Sólo destaca eritema y congestión faríngea. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electroencefalograma y decidir manejo según hallazgos
- b) Iniciar anticonvulsivantes a permanencia y antipiréticos durante nuevos episodios febriles
- c) Solicitar RMN de cerebro y decidir manejo según hallazgos
- d) Solicitar hemograma, hemocultivos y punción lumbar e iniciar antibióticos endovenosos
- e) Tranquilizar a la madre y explicarle el carácter benigno del episodio, sin necesidad de mayor estudio ni de anticonvulsivantes

3) ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas NO presenta cianosis?

- a) Ductus arterioso persistente
- b) Tetralogía de Fallot
- c) Atresia tricuspídea
- d) Ventrículo único
- e) Transposición de grandes vasos

4) La causa más frecuente de ginecomastia unilateral en un adolescente de 14 años es:

- a) Ginecomastia puberal
- b) Hiperprolactinemia
- c) Hiperplasia suprarrenal congénita
- d) Tumor testicular
- e) Síndrome de Klinefelter

5) Un niño de 5 años presenta: índice peso/edad: +1,9 DS, índice talla/edad: +1,7 DS, índice peso/talla: +0,7 DS. El diagnóstico nutricional es:

- a) Desnutrición
- b) Eutrofia
- c) Sobrepeso
- d) Obesidad
- e) Obesidad mórbida

6) La dermatitis del pañal se caracteriza por:

- a) Comprometer los pliegues y carecer de lesiones satélites
- b) Comprometer los pliegues y presentar lesiones satélites
- c) Respetar los pliegues y carecer de lesiones satélites
- d) Respetar los pliegues y presentar lesiones satélites
- e) Ser intensamente pruriginosa

7) El tratamiento del síndrome de Kawasaki consiste en:

- a) Tratamiento sintomático con AINEs
- b) Corticoides orales
- c) Corticoides endovenosos e inmunosupresores
- d) Antibióticos y AINEs
- e) Inmunoglobulina endovenosa y aspirina

8) Un recién nacido de 35 semanas de gestación, presenta ictericia hasta los muslos a las 10 horas de vida. No presenta otros síntomas y se observa en buen estado. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar bilirrubina total y directa y decidir manejo según hallazgos
- b) Realizar exangineotransfusión y fototerapia de inmediato
- c) Iniciar fototerapia sola y asegurar una adecuada hidratación y alimentación
- d) Solicitar bilirrubina plasmática, hemograma, prueba de Coombs directo, grupo-Rh y hemocultivos y decidir manejo según resultados
- e) Observar evolución por 24 horas, asegurando una adecuada alimentación e hidratación, sin necesidad de mayor estudio

9) Un lactante es traído a la consulta para ser controlado. Presenta al examen físico: sonrisa social, seguimiento de un objeto hasta la línea media, responde a un sonido y tiene sostén cefálico, mientras se lo deja sentado. ¿Qué edad tiene aproximadamente?

- a) 0 a 2 meses
- b) 2 a 4 meses
- c) 4 a 6 meses
- d) 6 a 8 meses
- e) 8 a 10 meses

10) El hipotiroidismo congénito habitualmente se diagnostica principalmente a través de:

- a) Medición de TSH a todos los recién nacidos
- b) Medición de TSH a los recién nacidos sintomáticos
- c) Medición de T4 a todos los recién nacidos
- d) Medición de T4 a los recién nacidos sintomáticos
- e) El cuadro clínico

11) Un lactante de 10 meses tiene antecedente de cuadro de 4 meses de evolución de aparición de lesiones cutáneas pruriginosas y recurrentes. Al examen físico se aprecian placas agrietadas, ligeramente eritematosas en mejillas y en las zonas extensoras de las extremidades. El cuero cabelludo y la zona del pañal están respetadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis seborreica
- b) Dermatitis atópica
- c) Dermatitis de contacto
- d) Psoriasis infantil
- e) Sarna

12) Un lactante de 10 meses presenta diarrea acuosa abundante y fiebre hasta 38,5°C. Al examen se encuentra afebril, con presión arterial y pulso son normales. Destacan mucosas algo secas y llanto sin lágrimas. El examen físico segmentario no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar hidratación oral con 100cc de sales de rehidratación luego de cada deposición
- b) Iniciar antibióticos e hidratación oral con sales de rehidratación oral, según plan A
- c) Iniciar hidratación oral con 50-100cc/Kg en 4 horas y reevaluar
- d) Iniciar antibióticos e hidratación oral con sales de rehidratación oral, según plan B
- e) Administrar suero fisiológico, como bolo endovenoso de 20cc/Kg y reevaluar en una hora

13) La tasa de mortalidad neonatal precoz tiene como numerador a las muertes producidas entre:

- a) El nacimiento y las 24 horas de vida
- b) El nacimiento y los 7 días de vida
- c) El nacimiento y los 28 días de vida
- d) Las 28 semanas de gestación y los 28 días de vida
- e) Las 28 semanas de gestación y los 7 días de vida

14) Un niño de 7 meses de edad, sin antecedentes de importancia, es traído por su madre ya que presenta dificultad respiratoria. Al examen se aprecia moderadamente taquipneico, con aleteo nasal, retracción intercostal y subcostal y cianosis perioral. Está hidratado, con moderada taquicardia y presión arterial normal. La auscultación pulmonar demuestra sibilancias bilaterales difusas y la auscultación cardíaca es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con broncodilatadores inhalados
- b) Enviar a domicilio con corticoides inhalados y broncodilatadores inhalados
- c) Administrar oxígeno y broncodilatadores nebulizados y evaluar respuesta en 1 hora
- d) Administrar oxígeno, broncodilatadores nebulizados, corticoides sistémicos y antibióticos endovenosos y evaluar respuesta en 1 hora
- e) Hospitalizar en UCI, intubar e iniciar ventilación asistida, iniciar antibióticos de amplio espectro, corticoides endovenosos y broncodilatadores

15) ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un factor de riesgo para presentar poliglobulia neonatal?

- a) Hijo de madre diabética
- b) Recién nacido pretérmino
- c) Recién nacido pequeño para la edad gestacional
- d) Insuficiencia placentaria crónica
- e) Demora en la sección del cordón umbilical

16) Un niño de 6 años es traído por su madre, ya que presenta “incontinencia fecal”. Mancha frecuentemente los calzoncillos y las sábanas con deposiciones. No presentan problemas urinarios. Al examen físico destaca palpación de una masa hipogástrica, con examen neurológico normal. El diagnóstico más probable es

- a) Enfermedad de Hirschsprung
- b) Ascariasis
- c) Polipomatosis adenomatosa familiar
- d) Enfermedad de Cröhn
- e) Fecaloma

17) El agente etiológico del eritema infeccioso o quinta enfermedad es:

- a) Virus herpes 6
- b) Virus Coxsackie (Enterovirus)
- c) Parvovirus B19
- d) Streptococcus pyogenes
- e) Virus herpes simples

18) El agente etiológico más frecuente y el fármaco de elección para el tratamiento de la laringitis obstructiva, son respectivamente:

- a) Haemophilus influenza y ceftriaxona
- b) Adenovirus y salbutamol inhalado
- c) Virus parainfluenza y adrenalina racémica inhalada
- d) Staphylococcus aureus y cloxacilina
- e) Virus respiratorio sincicial y salbutamol inhalado

19) Paciente de 3 años, sin vacunaciones previas, es traída por su madre por presentar convulsiones y fiebre. Al examen se aprecia paciente en regulares condiciones generales, febril, hemodinámicamente estable, con signos meníngeos positivos y parálisis del cuarto nervio craneal derecho. Se realiza punción lumbar que da salida a líquido turbio, con 500 células, 86% de mononucleares, proteínas aumentadas y glucosa de un 20% respecto a la glucosa plasmática. La tinción de Gram y tinta china resultan negativas. El diagnóstico más probable es:

- a) Meningitis bacteriana aguda
- b) Meningoencefalitis viral (enterovirus)
- c) Meningitis tuberculosa
- d) Meningococcemia
- e) Panencefalitis esclerosante subaguda

20) El primer examen que debe solicitarse ante un paciente con un testículo no palpable es:

- a) Testosterona plasmática
- b) TAC de abdomen y pelvis
- c) Cariograma
- d) Ecografía inguinal
- e) Exploración quirúrgica

21) Un paciente de 5 años, sin antecedentes de importancia presenta cuadro de 3 días de evolución de exantema petequial, asociado a sangramiento gingival al cepillarse los dientes. La madre refiere que cursó con una infección respiratoria alta, autolimitada, hace 10 días. Al examen físico se aprecia paciente en buenas condiciones, afebril, con un exantema petequial generalizado. El diagnóstico más probable es:

- a) Leucemia aguda
- b) Enfermedad de Von Willebrand
- c) Púrpura trombocitopénica inmune aguda
- d) Hemofilia
- e) Mononucleosis infecciosa

22) Un niño de 12 años, sin antecedentes de importancia, es traído por su padre, ya que es uno de los niños más bajos de su curso. Al examen físico no ha iniciado su desarrollo puberal y no muestra otras alteraciones. La curva de crecimiento se ha mantenido en el percentil 10 desde hace 4 años. El examen más importante para determinar el pronóstico de la talla final es:

- a) Testosterona plasmática
- b) Niveles plasmáticos de LH y FSH
- c) Radiografía de carpo
- d) Fosfatasas alcalinas
- e) GH plasmática

23) La auscultación cardíaca de un soplo sistólico eyectivo, asociado a un desdoblamiento fijo del segundo ruido es característica de:

- a) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
- b) Válvula aórtica bicúspide
- c) Ductus arterioso persistente
- d) Comunicación interventricular
- e) Comunicación interauricular

24) Un paciente de 7 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución de tos y odinofagia, al que en las últimas 48 horas, se le ha agregado fiebre hasta 38,3°C y disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se observa paciente decaído, eupneico y hemodinámicamente estable. La auscultación pulmonar demuestra crépitos bibasales y en la otoscopia se aprecia miringitis bulosa. El agente etiológico más probable es:

- a) Streptococcus pneumoniae
- b) Mycoplasma pneumoniae
- c) Adenovirus
- d) Virus Influenza
- e) Hantavirus

25) Un lactante de 7 meses es traído por su madre, por un cuadro de dolor abdominal intenso de 2 horas de evolución. El dolor cede espontáneamente dado lugar a deposiciones rojo intenso. Algunos minutos después el dolor reaparece. Al examen físico se aprecia lactante en actitud de dolor, con flexión de las caderas y llora al palpar la fosa ilíaca derecha. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- b) Solicitar colonoscopia
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Iniciar antibióticos, con cobertura para Shigella e hidratación oral
- e) Indicar régimen cero y solicitar radiografía de abdomen simple

26) La primera causa de mortalidad neonatal es (son):

- a) Asfixia
- b) Malformaciones congénitas
- c) Sepsis neonatal
- d) Problemas relacionados con la prematurez
- e) Muerte súbita

27) La causa más frecuente de síndrome nefrótico puro, en los pacientes pediátricos es:

- a) Nefrosis lipoídea
- b) Nefropatía membranosa
- c) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
- d) Enfermedad de Berger
- e) Glomerulonefritis postestreptocócica

28) Un niño de 3 años presenta cojera de 2 días de evolución. Al examen se aprecia en buenas condiciones, afebril, con dolor a la abducción y rotación de la cadera derecha. El resto del examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Enfermedad de Perthes
- c) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- d) Sinovitis transitoria de cadera
- e) Displasia de cadera

29) Un recién nacido prematuro, de 4 días de edad, alimentado con fórmula de inicio, presenta distensión abdominal, vómitos y eliminación de deposiciones sanguinolentas en una oportunidad. Al examen se observa irritable, taquicárdico, con el abdomen distendido y actitud de dolor a la palpación. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Hirschsprung
- b) Invaginación intestinal
- c) Enterocolitis necrotizante
- d) Estenosis hipertrófica del píloro
- e) Alergia a la proteína de la leche de vaca

30) Un niño de 10 años presenta detención del crecimiento y astenia. Se constata que ha bajado 2 kilogramos desde su último control hace 6 meses, a pesar de mantener un apetito normal, incluso aumentado. Consume grandes cantidades de líquidos y orina con mucha frecuencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Insuficiencia renal crónica
- b) Enfermedad celíaca
- c) Acidosis tubular renal
- d) Diabetes mellitus 1
- e) Giardiasis intestinal

31) Según el programa nacional de inmunizaciones, la vacuna anti-hepatitis B se administra:

- a) Al cumplir 2, 4 y 6 meses de edad
- b) Al alcanzar un peso de 2 Kg y luego al cumplir 1 año
- c) Al cumplir 1 y 6 años de edad
- d) Al cumplir 2, 4, 6 y 18 meses de edad y luego se administra un refuerzo a los 4 y 7 años
- e) Sólo a niños hijos de madre portadora de infección crónica por VHB

32) Un lactante de 3 meses de edad, previamente sano, es traído a consultorio por haber presentado hace 2 horas un episodio descrito como de cese de la respiración por unos 20 segundos y palidez intensa, que se recuperó al estimularlo. Al examen, se ve de buen aspecto, afebril, rosado. Llama la atención la presencia de restos de sangre en la boca y nariz del niño.

La principal sospecha diagnóstica que usted debe plantear es:

- a) maltrato infantil
- b) apnea primaria.
- c) apnea secundaria a reflujo gastroesofágico
- d) ALTE (Apparent Life Threatening Event) de causa neurológica
- e) ALTE y sangramiento por reanimación vigorosa

33) ¿Cuál de los siguientes antibióticos es más adecuado para tratar una amigdalitis pultácea?

- a) Amoxicilina
- b) Ciprofloxacino
- c) Ceftriaxona
- d) Cotrimoxazol
- e) Claritromicina

34) Un recién nacido de 48 horas de vida, ha presentado varios episodios de vómitos postprandiales explosivos. La radiografía de abdomen simple muestra imagen de doble burbuja. El diagnóstico más probable es:

- a) Estenosis hipertrófica del píloro
- b) Atresia duodenal
- c) Duplicación intestinal
- d) Reflujo gastroesofágico infantil
- e) Enterocolitis necrotizante

35) Un niño de 8 años, consulta por cuadro de fiebre y odinofagia, con aparición de vesículas dolorosas en la faringe y en las palmas y plantas. El agente etiológico de esta patología es:

- a) Adenovirus
- b) Citomegalovirus
- c) Enterovirus
- d) Virus Ebstein Baar
- e) Virus Varicela Zóster

36) Un escolar de 12 años, deportista, consulta por dolor en ambas rodillas desde hace dos semanas. Hay sensibilidad a la palpación de la tuberosidad anterior en ambas tibias. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Osgood-Schlatter
- b) Osteocondritis de la placa de cartílago de crecimiento
- c) Lesión meniscal
- d) Artritis reumatoídea juvenil
- e) Espondilitis anquilosante

37) Un niño de 6 años consulta por fiebre intermitente de 10 días de evolución, asociado a aparición de un exantema macular rosado, que aparece durante los cuadros febriles, en las zonas laterales del tronco y en la zona proximal de las extremidades y que desaparece al ceder la fiebre. El examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes de laboratorio destaca ferritina muy elevada. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemocromatosis
- b) Anemia sideroblástica
- c) Artritis juvenil idiopática (Enfermedad de Still)
- d) Púrpura de Schönlein-Henoch
- e) Mononucleosis infecciosa

38) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una causa de leucocoria en el lactante?

- a) Glaucoma congénito
- b) Catarata congénita
- c) Persistencia del vítreo primario hiperplásico
- d) Retinoblastoma
- e) Retinopatía del prematuro

39) Un niño de 9 días de vida presenta fiebre hasta 38,7°C, sin otros síntomas. El examen físico resulta normal, apreciándose en buenas condiciones. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos de amplio espectro y antipiréticos
- b) Solicitar hemograma, PCR, hemocultivos, radiografía de tórax, urocultivo, sedimento de orina y decidir conducta según resultados
- c) Solicitar hemograma y sedimento de orina y decidir conducta según resultados
- d) Solicitar exámenes de sangre, exámenes de orina, radiografía de tórax y punción lumbar e iniciar antibióticos de amplio espectro
- e) Iniciar antipiréticos y enviar a domicilio, indicando control en 48 horas o en caso de complicación, sin necesidad de mayor estudio

40) Un recién nacido pretérmino, de 33 semanas de gestación presenta taquipnea, quejido y aleteo nasal, que inició algunos minutos luego del nacimiento y que ha ido en detrimento en las horas siguientes, de modo que requiere altas concentraciones de oxígenos para mantener saturación arterial de oxígeno normal. El examen físico resulta inespecífico. El diagnóstico más probable es:

- a) Taquipnea transitoria
- b) Enfermedad de membrana hialina
- c) Síndrome de aspiración meconial
- d) Persistencia de la circulación fetal
- e) Sepsis neonatal

41) Un niño de 5 años consulta por otalgia intensa y otorrea. La otoscopia demuestra conducto auditivo externo con eritema y secreción purulenta difusa, sin compromiso timpánico. El resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Iniciar amoxicilina oral y analgésicos orales
- b) Iniciar gentamicina intramuscular y analgésicos tópicos
- c) Indicar ciprofloxacino tópico y analgésicos orales
- d) Iniciar cloxacilina oral y analgésicos tópicos
- e) Iniciar clotrimazol tópico y analgésicos orales

42) ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a una contraindicación para la administración de la vacuna DPT?

- a) Alergia a alguno de los componentes
- b) Reacciones adversas graves, en relación a las dosis anteriores
- c) Edad mayor a 6 años
- d) Infección por el virus VIH
- e) Cuadro febril de origen no precisado

43) El principal factor de riesgo para la sepsis neonatal es:

- a) Hijo de madre diabética
- b) Rotura prematura de membranas
- c) Prematurez
- d) Recién nacido pequeño para la edad gestacional
- e) La vía de parto

44) Durante una visita para un control de rutina, usted lleva a una lactante hacia la posición sentada. La cabeza sigue al tronco sin retrasarse y puede mantener la posición sentada con sus brazos apoyados hacia delante sobre la camilla. Es capaz de pasar objetos de una mano a otra ¿Cuál es la edad más probable de aparición de estas habilidades motrices?

- a) 4 meses
- b) 6 meses
- c) 8 meses
- d) 10 meses
- e) 12 meses

45) Un recién nacido de término, de 4 horas de vida, hijo de madre diabética y grande para la edad gestacional, presenta hiporreactividad y convulsiones en una oportunidad. Al examen físico se observa hiporreactivo e hipotónico, sin otros hallazgos. La primera medida a tomar es:

- a) Iniciar oxígeno al 35%
- b) Solicitar hemograma, hemocultivos y punción lumbar
- c) Solicitar ecografía de cerebro por fontanela anterior
- d) Administrar suero fisiológico y antibióticos endovenosos
- e) Realizar hemoglucotest

46) ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para determinar la severidad de la hepatitis A?

- a) Transaminasas
- b) Bilirrubinemia
- c) Albúmina plasmática
- d) Tiempo de protrombina
- e) Proteína C reactiva

47) El tratamiento antibiótico de elección para la meningitis bacteriana aguda, en el recién nacido es:

- a) Ampicilina + cefotaximo
- b) Cefotaximo + metronidazol
- c) Vancomicina + ceftriaxona
- d) Ceftriaxona + cloxacilina
- e) Cloxacilina + gentamicina

48) ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una alternativa válida para la alimentación de un lactante de 8 meses, que no recibe pecho materno?

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3%
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 5%, más cereal al 1,5%
- d) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5%
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 5%, más aceite al 3%

49) Un recién nacido de término, de 3 días de vida, presenta ictericia desde hace 24 horas, que actualmente llega a los muslos. Al nacer pesó 3.420 gramos, se alimenta adecuadamente y actualmente pesa 3.230 gramos. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- c) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo Rh
- d) Ictericia por leche materna
- e) Sepsis neonatal

50) Un niño de 6 años es traído por su madre ya que es muy desobediente y no lo puede controlar. Presenta rabietas con frecuencia cuando no se hace lo que él quiere y en muchas oportunidades hace exactamente lo contrario de lo que se le pide en una actitud insolente y agresiva. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Síndrome de Asperger
- d) Depresión infantil
- e) Síndrome de déficit atencional del niño

Prueba 3

1) Traen a una niña de 4 años a su consultorio porque presenta edema en párpados y piernas. Hace tres semanas padeció fiebre, diarrea sanguinolenta y dolor abdominal que desaparecieron espontáneamente. Los exámenes de laboratorio revelan anemia, trombocitopenia leve, electrolitos normales, urea y creatinina elevadas, y proteinuria.

¿Cuál es la causa más probable de este cuadro?

- a) Síndrome nefrótico de comienzo agudo
- b) Enfermedad de Berger
- c) Síndrome urémico hemolítico
- d) Púrpura de Schölein-Henoch
- e) Glomerulonefritis postestreptocócica

2) ¿Cuál es la causa más frecuente de shock en pediatría?

- a) Séptico
- b) Medular
- c) Hipovolémico
- d) Cardiogénico
- e) Anafiláctico

3) Un neonato nace por cesárea de emergencia a las 41 semanas de gestación por presentar prociencia de cordón umbilical y líquido amniótico meconial. A las 6 horas de vida, tiene una convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Cuál de las siguientes es la explicación más probable para esta convulsión?

- a) Hiponatremia
- b) Encefalopatía hipóxico-isquémica
- c) Hemorragia endocraneana
- d) Meningitis
- e) Hipoglicemia

4) Un lactante de 4 meses presenta lesiones eritematosas exudativas en la zona genital y glútea, con compromiso de los pliegues inguinales y presencia de lesiones satélites. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis del pañal
- b) Candidiasis
- c) Dermatitis de contacto
- d) Dermatitis atópica
- e) Dermatitis seborreica

5) ¿Cuál de las siguientes cardiopatías necesitan que el ductus arterioso permanezca abierto luego del nacimiento, para mantenerse estable?

- a) Comunicación interauricular tipo ostium primum
- b) Drenaje anómalo de las venas pulmonares
- c) Coartación aórtica
- d) Ventrículo único
- e) Transposición de grandes vasos

6) ¿Cuál de los siguientes fármacos es menos útil en el tratamiento de la epilepsia tónico-clónica primaria de los niños?

- a) Fenobarbital
- b) Ácido valproico
- c) Fenitoína
- d) Benzodiazepinas
- e) Lamotrigina

7) La complicación más grave del hipotiroidismo congénito no detectado a tiempo es:

- a) Retraso mental
- b) Epilepsia
- c) Mixedema
- d) Insuficiencia cardíaca
- e) Insuficiencia renal crónica

8) Al cumplir un año de edad, un niño pesa y mide aproximadamente:

- a) 10 Kg y 75 cm
- b) 10 Kg y 100 cm
- c) 16 Kg y 100 cm
- d) 16 Kg y 125 cm
- e) 25 Kg y 125 cm

9) Además de las medidas de soporte ventilatorio y oxígeno terapia, el tratamiento de la enfermedad de membrana hialina requiere de:

- a) Corticoides orales
- b) Corticoides inhalados
- c) Prostaglandina endovenosa
- d) Surfactante endotraqueal
- e) Broncodilatadores nebulizados

10) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es menos probable de encontrar en un niño que cursa con un púrpura trombocitopénico inmune agudo?

- a) Tiempo de sangría prolongado
- b) Exantema petequial
- c) Megacariocitos aumentados en la médula ósea
- d) Recuento de plaquetas disminuido
- e) Esplenomegalia

11) Un niño de 4 meses se puede alimentar con

- a) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5% a razón de 180 ml/kg
- b) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3% a razón de 180 ml/kg
- c) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3% a razón de 120 ml/kg
- d) Leche purita al 7,5%, más azúcar al 2,5%, más aceite al 1,5% a razón de 150 ml/kg
- e) Leche purita al 10%, más azúcar al 2,5%, más cereal al 3% a razón de 100 ml/kg

12) Un lactante de 20 meses de edad presenta un cuadro de tos y dificultad respiratoria de 2 días de evolución, que se ha intensificado en las últimas horas. Al examen físico presenta uso de musculatura intercostal, sin cianosis, con taquipnea leve y auscultación de sibilancias difusas espiratorias. Ha presentado cuadros similares en 2 oportunidades previas. Se inicia tratamiento con corticoides orales y beta-agonistas de acción rápida, con buena respuesta. Usted controla al paciente 5 días después y lo encuentra asintomático, con examen físico normal. La conducta más adecuada es:

- a) Suspender los corticoides orales e indicar salbutamol inhalado en caso de síntomas
- b) Suspender los corticoides orales e indicar salbutamol inhalado en caso de síntomas y corticoides inhalados según horario
- c) Suspender los corticoides orales e indicar salbutamol y corticoides inhalados, ambos en caso de síntomas
- d) Disminuir gradualmente la dosis de corticoides orales, en un tiempo de un mes y asociar salbutamol inhalado en caso de síntomas
- e) Mantener los corticoides orales en la misma dosis, asociados a salbutamol inhalado en caso de síntomas y controlar en un mes

13) El tratamiento de elección de la neumonía comunitaria en el escolar es:

- a) Claritromicina
- b) Amoxicilina
- c) Ceftriaxona
- d) Clindamicina
- e) Amoxicilina + ácido clavulánico

14) Un niño de 5 años sufre caída de la escalera golpeándose la cabeza. Evoluciona con desorientación de 20 minutos, recuperándose totalmente, sin embargo 30 minutos más tarde presenta una convulsión tónico-clónica de 5 minutos de duración autolimitada. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones, con Glasgow 15 y sin alteraciones neurológicas. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con AINEs e indicación de consultar en caso de aparición de signos de alarma
- b) Solicitar radiografía de cráneo y decidir según hallazgos
- c) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- d) Solicitar TAC de cerebro, con ventana ósea
- e) Iniciar anticonvulsivantes y solicitar electroencefalograma

15) Un lactante de 25 días inicia vómitos postprandiales explosivos, asociados a baja de peso. La madre refiere que el niño se encuentra hambriento y que mama varias veces al día, pero casi siempre vomita a los pocos minutos. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Instalar sonda nasogástrica
- d) Iniciar bloqueadores de calcio
- e) Resolver quirúrgicamente

16) Un niño presenta diarrea acuosa abundante, con mala ingesta de líquidos. Se solicitan exámenes de laboratorio que demuestran pH: 7,30; BUN: 60 mg/dl; creatinina: 2,5 mg/dl; Na+: 151 mEq/l; K+: 3,0 mEq/l y Cl: 114 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Deshidratación hipertónica, con acidosis metabólica e hipokalemia
- b) Deshidratación hipotónica, con acidosis respiratoria e hipokalemia
- c) Deshidratación hipertónica, con acidosis metabólica e hiperkalemia
- d) Deshidratación hipotónica, con acidosis respiratoria e hiperkalemia
- e) Deshidratación hipotónica, con acidosis metabólica e hiperkalemia

17) Ante un recién nacido con clínica de dificultad respiratoria, cianosis y excavación abdominal marcada, debe sospecharse el diagnóstico de:

- a) Enfermedad de membrana hialina
- b) Agenesia renal bilateral
- c) Hernia diafragmática
- d) Síndrome de aspiración meconial
- e) Neumotórax

18) ¿Cuál de los siguientes antibióticos debe usarse como profilaxis de infección del tracto urinario en un niño con reflujo vesicoureteral leve?

- a) Ciprofloxacino
- b) Ceftriaxona
- c) Gentamicina
- d) Amoxicilina
- e) Nitrofurantoina

19) ¿Cuál de los siguientes microorganismos producirá infecciones con mayor frecuencia en un niño con inmunodeficiencia por alteración de la producción de inmunoglobulinas?

- a) Candida albicans
- b) Pseudomona aureginosa
- c) Citomegalovirus
- d) Escherichia coli
- e) Streptococcus pneumoniae

20) Un recién nacido pequeño para la edad gestacional, de 3 horas de vida, presenta una convulsión tónico-clónica en una oportunidad. El examen físico no aporta mayor información. El primer examen que debe solicitarse es:

- a) Calcemia
- b) Electrolitos plasmáticos
- c) Hemoglucotest
- d) Ecografía cerebral
- e) Hemograma

21) Un niño de 2 años, que luego de levantarlo bruscamente, traccionando la mano izquierda, presenta inmovilidad de dicha extremidad. Al examen presenta codo derecho extendido en pronación y llora al movilizarlo. El diagnóstico más probable es:

- a) Lesión del nervio mediano
- b) Lesión del plexo braquial
- c) Fractura de antebrazo
- d) Pronación dolorosa
- e) Lesión del nervio radial

22) Un lactante de 4 meses, alimentado con pecho materno exclusivo, presenta las siguientes mediciones antropométricas: índice peso/edad: -2,1 DS; índice talla/edad: -0,4 DS; índice peso talla: -2,0 DS. El diagnóstico más probable es:

- a) Obesidad
- b) Sobrepeso
- c) Eutrofia
- d) Desnutrición
- e) Talla baja

23) Un niño de 4 años presenta cuadro catarral de algunos días de evolución, al que se agrega tos intensa, en accesos, que en algunas ocasiones se acompaña de cianosis. Al examen físico el niño parece en buenas condiciones, eupneico, tose con frecuencia y se observan varias petequias en la cara. El examen cardíaco es normal y la auscultación pulmonar sólo demuestra escasos crépitos difusos bilaterales. La radiografía de tórax es normal. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Iniciar amoxicilina e ibuprofeno
- b) Iniciar claritromicina y paracetamol
- c) Iniciar antitusivos y paracetamol
- d) Solicitar hemograma e inmunofluorescencia directa para Bordetella
- e) Solicitar panel viral e iniciar tratamiento sintomático

24) Un recién nacido de 20 días de vida presenta hematemesis en una oportunidad, sin otros síntomas. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, bien perfundido, con pulso y presión arterial normales para la edad. El examen segmentario es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Iniciar reposición de volumen con cristaloideos por vía venosa periférica gruesa
- c) Solicitar test de Apt-Downey de la sangre emitida
- d) Solicitar hemograma
- e) Administrar omeprazol endovenoso

25) Un niño de 11 meses de edad presenta fiebre e irritabilidad marcada. Al examen físico se observa faringe con varias vesículas y úlceras en el paladar blando. El resto del examen físico es normal. El agente etiológico más probable es:

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Adenovirus
- c) Virus herpes simplex
- d) Enterovirus
- e) Bacteroides fragilis

26) Un recién nacido de término, de 12 horas de vida, presenta ictericia hasta los muslos. No presenta otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información. El grupo sanguíneo de la madre es O (IV), Rh positivo y éste es su segundo parto. El diagnóstico más probable es:

- a) Ictericia fisiológica
- b) Anemia hemolítica por incompatibilidad Rh
- c) Anemia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
- d) Hipotiroidismo congénito
- e) Sepsis neonatal

27) Un niño de 4 años se introduce un poroto en el oído derecho, sin poder retirarlo. Al examen físico el niño se observa en buenas condiciones y a la otoscopia se observa la semilla en el conducto auditivo externo. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con antibióticos orales hasta eliminación espontánea de la semilla
- b) Intentar extracción con pinzas, bajo anestesia con dimecaina tópica
- c) Irrigar con abundante suero fisiológico hasta lograr la salida del cuerpo extraño
- d) Aplicar vaselina, enviar a domicilio e indicar masajes externos y control en 48 horas
- e) Derivar a otorrinolaringólogo, para retiro del cuerpo extraño bajo microscopio

28) Un niño de 5 años ha presentado 6 cuadros de palpitaciones intensas, autolimitadas, de inicio y término súbito de algunos minutos de duración, sin presentar síntomas entre los episodios. Al examen físico no se encuentran alteraciones. Se solicita electrocardiograma, que demuestra acortamiento del segmento PR, con complejo QRS ancho y presencia de onda delta. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de QT largo
- b) Miocardiopatía hipertrófica
- c) Taquicardia paroxística supraventricular por haz paraespecífico
- d) Flutter auricular
- e) Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

29) Un niño presenta baja de peso y esteatorrea, que se confirma con un test de Sudán. Se solicita anticuerpos antiendomiso, que resultan positivos y biopsia duodenal que demuestra atrofia marcada de las vellosidades. Se inicia dieta sin gluten, sin lograr mejoría de los síntomas luego de 4 meses. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nueva endoscopia digestiva alta y biopsia duodenal
- b) Solicitar esteatocrito
- c) Solicitar un TAC de abdomen y pelvis para descartar linfoma
- d) Revisar el cumplimiento de la dieta
- e) Solicitar hemograma y parasitológico de deposiciones

30) ¿En qué período es posible desencadenar el reflejo de moro?

- a) Entre el nacimiento y los 3 meses de edad
- b) Entre el nacimiento y los 6 meses de edad
- c) Entre el nacimiento y los 10 meses de edad
- d) Entre los 3 meses y los 10 meses de edad
- e) Entre los 6 meses y el año de edad

31) ¿A quiénes puede administrarse la vacuna contra la polio, oral (Sabin)?

- a) Mujeres embarazadas
- b) Inmunodeprimidos severos
- c) Contactos cercanos de inmunodeprimidos severos
- d) Pacientes con cuadro concomitante de fiebre y vómitos
- e) Pacientes que reciben concomitantemente la vacuna trivérica

32) Un niño consulta por un cuadro de fiebre, odinofagia y aparición de un exantema eritematoso, solevantado, en piel de gallina, asociado a aparición de petequias lineales en fosas cubitales, descamación cutánea en los pulpejos y lengua saburral con puntos eritematosos. El agente etiológico más probable es:

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Enterovirus
- c) Parvovirus B19
- d) Virus herpes 6
- e) Virus Epstein-Barr

33) Una recién nacida de 15 días de vida, con antecedente de parto por cesárea por presentación podálica presenta signo de Ortolani y Barlow positivo en el examen de control. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución y solicitar radiografía de pelvis al cumplir los 3 meses de edad
- b) Indicar uso de doble pañal
- c) Solicitar radiografía AP de pelvis
- d) Solicitar ecografía de caderas
- e) Derivar para resolución quirúrgica

34) La complicación más importante de la intoxicación por hidrocarburos, como la bencina, es:

- a) Neumonitis
- b) Hepatitis
- c) Convulsiones
- d) Hemorragia digestiva
- e) Arritmias

35) El tratamiento de primera línea de la leucemia linfática aguda suele ser:

- a) Quimioterapia de inducción y radioterapia posterior a los huesos esponjosos
- b) Trasplante de médula ósea
- c) Quimioterapia combinada de inducción y luego de mantención
- d) Quimioterapia combinada de inducción sola
- e) Exanguíneotransfusión y radioterapia

36) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos orienta más a un diagnóstico de atresia biliar primaria?

- a) Niño de 4 años con astenia, fiebre y aparición de ictericia, asociada a coluria y acolia
- b) Lactante de 20 días con ictericia de predominio indirecto
- c) Recién nacido de 12 horas de vida, con ictericia marcada, hepatoesplenomegalia e hiporreactividad
- d) Lactante de 35 días de vida, con ictericia, coluria y acolia de 2 semanas de evolución
- e) Recién nacido de 2 días de vida, con ictericia hasta los muslos

37) La causa más frecuente de constipación en la edad pediátrica es:

- a) Enfermedad de Hirschsprung
- b) Síndrome de intestino irritable
- c) Parasitosis intestinales
- d) Malos hábitos de defecación
- e) Pólipos juveniles

38) Un niño de 5 años presenta un aumento de volumen indoloro en la zona inguinal izquierda. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, de contenido blando, que aumenta de tamaño con la tos y disminuye a la compresión, logrando incluso reducirse completamente, palpándose un anillo en la pared abdominal de 1 centímetro. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución y controlar en caso de crecimiento o dolor
- b) Solicitar ecografía de pared abdominal y decidir manejo según hallazgos
- c) Aplicar corticoides locales y controlar en 3 meses
- d) Derivar para cirugía electiva
- e) Resolver quirúrgicamente de manera inmediata

39) Un niño de 10 años cursando una faringitis aguda de 2 días de evolución, presenta hematuria macroscópica en 2 oportunidades. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, sin edema ni hipertensión y sólo destaca faringe eritematosa, sin otros hallazgos. Se solicita un sedimento de orina que demuestra hematuria con 25% de eritrocitos dismórficos. El diagnóstico más probable es:

- a) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
- b) Nefrosis lipoídea
- c) Enfermedad de Berger
- d) Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
- e) Síndrome hemolítico urémico

40) La anemia fisiológica del lactante se caracteriza por presentar hemoglobinas cercanas a 10 mg/dl y ser generalmente asintomática. La edad de aparición de esta anemia es:

- a) Durante el primer mes de vida
- b) Entre los 3 y los 6 meses de edad
- c) Entre los 6 y los 9 meses de edad
- d) A fines del primer año de vida
- e) A mediados del segundo año de vida

41) Un lactante de 6 meses presenta fiebre hasta 38,7°C, sin otros síntomas y con examen físico normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos, solicitar hemograma y sedimento de orina y decidir conducta según resultados
- b) Iniciar cefadroxilo oral y antipiréticos, sin necesidad de exámenes
- c) Iniciar antipiréticos y controlar en 48 horas o en caso de empeoramiento, sin necesidad de mayor estudio
- d) Hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos y solicitar hemograma, VHS, sedimento de orina, urocultivo, radiografía de tórax y punción lumbar, decidiendo manejo según resultados
- e) Iniciar antipiréticos y claritromicina, controlando en 48 horas o en caso de empeoramiento

42) Un niño con clínica sugerente de meningitis se realiza punción lumbar, con salida de líquido céfalo-raquídeo turbio, con proteínas: 185 mg/dl, glucosa: 30 mg/dl, leucocitos: 1000 cell/mm³, con 94% de polimorfonucleares. A la tinción de Gram se observan diplococos gram negativos. El agente etiológico más probable es:

- a) Haemophilus influenza
- b) Neumococo
- c) Listeria
- d) Meningococo
- e) Estafilococo dorado

43) ¿Cuál de las siguientes opciones es una contraindicación absoluta de la lactancia materna?

- a) Hepatitis B
- b) Mastitis
- c) Infección maternal por virus influenza
- d) Galactosemia
- e) Tabaquismo materno

44) Para diagnosticar una infección urinaria en un lactante se prefiere:

- a) Sedimento de orina y urocultivo de orina de segundo chorro
- b) Urocultivo con muestra obtenida por cateterismo o punción
- c) Urocultivo con muestra obtenida por recolector
- d) Orina completa de segundo chorro
- e) Cintigrafía renal estática

45) Un niño de 6 años presenta compromiso del estado general, odinofagia intensa y fiebre de 1 día de evolución, sin otros síntomas. Al examen se aprecia paciente en buenas condiciones, eupneico, bien perfundido y febril hasta 39°C. La faringe se ve eritematosa, edematosa, con petequias en el paladar blando y exudado amigdalino grisáceo, adherente. Además se palpan varias adenopatías cervicales bilaterales y sensibles. El examen pulmonar es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar tratamiento sintomático con AINES
- b) Iniciar amoxicilina oral y AINES
- c) Iniciar cefuroximo oral
- d) Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
- e) Solicitar cultivo faríngeo y decidir conducta según hallazgos

46) Un niño es capaz de correr sin caerse, forma una torre de 7 cubos, se desviste con habilidad y puede vestirse con ropa sencilla. Dice frases de 2 a 3 palabras y es capaz de expresar lo que desea a sus padres y a los adultos que ve con frecuencia. La edad del niño es aproximadamente:

- a) 12 meses
- b) 18 meses
- c) 24 meses
- d) 36 meses
- e) 48 meses

47) Un niño de 7 años con buen rendimiento escolar previo, presenta baja considerable en sus notas, asociado a una actitud irrespetuosa frente a sus padres, quienes estarían pasando por un quiebre matrimonial. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno oposicionista desafiante
- b) Trastorno por déficit atencional
- c) Depresión infantil
- d) Autismo
- e) Trastorno por ansiedad de separación

48) La presentación clínica más habitual del síndrome nefrótico, secundario a una enfermedad glomerular de cambios mínimos es:

- a) Edema, hipertensión y hematuria
- b) Edema, orinas espumosas e hipertensión
- c) Orinas espumosas, hematuria y oliguria
- d) Hematuria, oliguria e hipertensión
- e) Edema, lipiduria y orinas espumosas

49) Usted atiende un niño con síndrome de Down, con adecuado desarrollo psicomotor y crecimiento, para su condición. La madre de 30 años, tiene deseos de un nuevo embarazo. La probabilidad de que tenga un nuevo hijo con síndrome de Down es aproximadamente:

- a) 50%
- b) 33%
- c) 25%
- d) 5%
- e) 1%

50) Un recién nacido prematuro, de 3 días de evolución presenta irritabilidad, vómitos, distensión abdominal y hematoquezia en una oportunidad. Al examen físico se observa irritable, en buenas condiciones con el abdomen distendido, blando. Se solicita radiografía de abdomen simple que demuestra neumatosis intestinal, sin aire en la cavidad peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar colonoscopia
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis e iniciar antibióticos endovenosos
- c) Hidratar por vía oral, iniciar antibióticos orales, suspender la lactancia materna y alimentar con fórmula
- d) Administrar hidratación por vía endovenosa, instalar sonda nasogástrica, suspender la alimentación oral e iniciar antibióticos de amplio espectro
- e) Resolver quirúrgicamente a la brevedad

Prueba 4

Ver COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRUEBAS GRANDES Prueba 1

Prueba 5

Ver COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRUEBAS GRANDES Prueba 2

Prueba 6

Ver COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRUEBAS GRANDES Prueba 4

Prueba 7

Ver COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRUEBAS GRANDES Prueba 5

Prueba 8

Ver COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRUEBAS GRANDES Prueba 6

Prueba 9

Ver COMPILADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PRUEBAS GRANDES Prueba 7

RESPUESTAS PEDIATRÍA PRUEBAS GRANDES

Prueba 1		Prueba 2		Prueba 3	
1 B	27 E	1 A	27 A	1 C	27 E
2 C	28 B	2 E	28 D	2 C	28 C
3 E	29 A	3 A	29 C	3 B	29 D
4 E	30 E	4 A	30 D	4 B	30 B
5 C	31 E	5 B	31 A	5 E	31 E
6 D	32 E	6 C	32 A	6 C	32 A
7 A	33 E	7 E	33 A	7 A	33 D
8 D	34 A	8 D	34 B	8 A	34 A
9 E	35 B	9 B	35 C	9 D	35 C
10 A	36 C	10 A	36 A	10 E	36 D
11 A	37 B	11 B	37 C	11 D	37 D
12 A	38 C	12 C	38 A	12 B	38 D
13 A	39 C	13 B	39 D	13 B	39 C
14 B	40 B	14 C	40 B	14 D	40 B
15 B	41 C	15 B	41 C	15 B	41 C
16 D	42 D	16 E	42 D	16 A	42 D
17 A	43 E	17 C	43 C	17 C	43 D
18 D	44 B	18 C	44 B	18 E	44 B
19 B	45 D	19 C	45 E	19 E	45 B
20 E	46 D	20 D	46 D	20 C	46 C
21 B	47 E	21 C	47 A	21 D	47 C
22 E	48 B	22 C	48 B	22 D	48 E
23 A	49 D	23 E	49 A	23 D	49 E
24 A	50 D	24 B	50 B	24 C	50 D
25 B		25 C		25 D	
26 B		26 D		26 C	